

Méthodologie phénoménologie / analyse existentielle

Support CM

PHILIPPE SPOLJAR

Courriel : philippe.spoljar@u-picardie.fr

Sommaire

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I. LA DÉMARCHE EN CLINIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE PHÉNOMÉNOLOGIQUES

Présentation

- 1. L'expérience vécue*
- 2. Les dimensions de l'existence*
- 3. Les tensions structurantes*
- 4. La structure de vécu*
- 5. Résumé de la méthode d'analyse phénoménologique*

II. EXEMPLES (CORPUS D'OBSERVATIONS ET D'ANALYSES)

- 1. Observations cliniques*
- 2. Textes narratifs*
- 3. Œuvres non narratives*
- 4. Clinique du travail*

III. DE LA CLINIQUE À LA PSYCHOPATHOLOGIE

- 1. Présentation*
- 2. Marine, 36 ans*
- 3. Léo, 27 ans*
- 4. Chris, 31 ans*
- 5. M. Wolfe*
- 6. Synthèse épistémologique et méthodologique*
- 7. Prolongement clinique : de l'entretien à la formulation du cas*

ANNEXES

Bibliographie

Glossaire

Psychopathologie neuro-phénoménologique et cognition incarnée

Table des matières

Introduction

Ce cours présente :

- une méthodologie progressive et opératoire
- pour l'analyse de cas cliniques à partir d'une perspective phénoménologique et existentielle.

L'objectif global est d'apprendre à décrire et à comprendre le vécu tel qu'il apparaît dans un matériau clinique :

- non comme une juxtaposition de signes ou de catégories diagnostiques
- mais comme l'expression d'un mode d'existence singulier.

L'étude de cas sera travaillée à partir de différents matériaux d'observation :

- des vignettes cliniques et des descriptions de situations
- des extraits d'entretiens
- des récits écrits ou notes cliniques

mais également :

- extraits de textes littéraires
- voire des supports visuels

Dans ce cours, l'expression de phénoménologie clinique est utilisée dans un sens large, qui désigne en réalité une approche phénoménologico-existentielle :

- La phénoménologie fournit la méthode descriptive : elle consiste à prendre au sérieux l'expérience vécue telle qu'elle se donne, en suspendant provisoirement les hypothèses explicatives.
- L'analyse existentielle prolonge cette démarche en décrivant les grandes dimensions de l'existence humaine

La clinique articule ainsi :

- une méthode de *description du vécu*
- et des cadres *d'analyse de l'existence*

afin de comprendre :

- *comment une personne habite le monde*
- et *comment elle se maintient dans son existence.*

Elle invite ainsi à déplacer le regard clinique :

- non plus partir de ce que le sujet « a », en termes de diagnostic
- ni même ce qu'elle « est » (au sens d'une entité définissable)
- > mais ce qu'elle « vit » et ce qu'est son existence

Examen terminal (1h) QCM méthodologique (même format qu'en L2) : le TD5 sera spécifiquement consacré à sa préparation.

I. La démarche en clinique et psychopathologie phénoménologiques

Présentation

De la démarche à la méthode

La méthodologie de l'étude de cas opérationnalise la démarche clinique

- en suivant une progression en quatre étapes
- qui correspondent aux quatre chapitres suivants de la première partie :
- décrire le vécu brut
- organiser ce vécu selon les dimensions de l'existence
- dégager les tensions qui structurent l'expérience
- puis à formuler une structure de vécu susceptible d'éclairer la compréhension clinique

Mise en place :

Ce qui va permettre, dans un second temps

- une discussion psychopathologique
- et disposer d'un cadre pour un accompagnement psychologique, voire thérapeutique

Ce passage du vécu brut vers une organisation, puis vers une structure, doit toujours se faire avant toute lecture explicative, causale ou diagnostique.

Le principe directeur est le suivant : partir du comment (pas du pourquoi).

On ne cherche pas d'abord à expliquer :

- pourquoi le sujet vit les choses ainsi
- ni à poser *immédiatement* un diagnostic

> Mais on fait émerger l'expérience vécue d'un sujet, comment le monde apparaît

Selon le type de matériau, la question descriptive se précise :

- lorsque le matériau est clinique, on s'intéresse à la manière dont le sujet parle, se présente et habite son expérience ;
- lorsque le matériau est littéraire ou visuel, on décrit la manière dont l'œuvre configure une expérience du monde ;
- dans tous les cas, on examine comment le temps, l'espace, le corps, les autres, le soi et le monde apparaissent dans le matériau.

Le cas de Louise : fil rouge

Louise servira de cas fil rouge, avec trois fonctions :

- 1/ Illustrer une démarche (pédagogique)
- 2/ Fournir un matériau clinique (phénoménologique)
- 3/ Montrer une élaboration structurale (modélisante)

Louise, 24 ans, vient consulter six mois après l'obtention de son diplôme de Master.
Premier extrait (première consultation) :

"Louise arrive avec quinze minutes d'avance. Elle attend dans la salle d'attente en consultant son téléphone. Quand on l'appelle, elle range soigneusement ses affaires avant d'entrer. Elle s'assoit au bord de la chaise, sac sur les genoux.

Quand je lui demande ce qui l'amène, elle commence : « Je ne sais pas trop... Enfin, je vais bien, je n'ai pas de problème grave, mais... » Long silence. « C'est juste que depuis que j'ai fini mes études, j'ai l'impression que... que les journées sont vides. Je cherche du travail, mais c'est long. Mes amis ont tous déménagé, pris des postes ailleurs. Moi je suis restée ici, chez mes parents. »

Elle décrit ses journées : « Je me lève tard, vers 10h. Pas la peine de se lever plus tôt. Je regarde les offres d'emploi, j'envoie des CV. L'après-midi, je ne sais pas trop quoi faire. Je lis, je regarde des séries. Le soir, mes parents rentrent, on dîne, je remonte dans ma chambre. Et le lendemain, pareil. »

Silence.

« Avant, j'avais toujours quelque chose : les cours, les examens, les rendus. Il y avait un rythme. Là, il n'y a plus rien qui structure. J'attends, mais je ne sais même pas quoi. »

1. L'expérience vécue

1.1. Décrire le vécu

Le point de départ c'est la première *réalité* du sujet : *ce qu'il vit*, c'est-à-dire :

- ce qu'il ressent
- comment il perçoit
 - ce qu'il ressent
- ce qui fait sens pour lui
- la manière dont le monde se présente
- la façon dont les autres sont éprouvés
- et comment il se rapporte à lui-même

Chaque individu n'est pas simplement *dans* le monde :

- il *habite* un monde
- un monde qui est (déjà) chargé de *significations*, de *valeurs*, de *menaces* et de *possibilités*

Donc : la première étape de l'analyse consiste à extraire du texte le matériau phénoménologique brut :

- > il s'agit de repérer ce qui, dans le document, donne accès à l'expérience vécue du sujet, avant toute interprétation explicative ou diagnostique.
- > À ce stade, on ne cherche pas encore à comprendre l'ensemble du cas.

La question directrice est la suivante : Comment la personne vit-elle ce qu'elle vit ?

Principe de l'« epochè »

La démarche clinique en phénoménologie s'appuie sur une posture de suspension, inspirée de ce que Husserl a nommé l'« epochè ». Ceci consiste à :

- mettre provisoirement entre parenthèses certains présupposés
- laisser apparaître le phénomène tel qu'il se donne

En clinique, on en retient surtout le geste pratique de suspension (sans reprendre tout l'appareil philosophique), pour :

Cette suspension initiale permet :

- d'éviter les interprétations trop rapides ;
- de limiter les erreurs de perspective ;
- de réduire les effets négatifs des étiquettes diagnostiques ;
- d'ouvrir l'accès à une compréhension plus fine du vécu.

Il ne s'agit pas de renoncer à l'étude sémiologique et au diagnostic, mais de les *suspendre provisoirement*.

On repère les paroles, les gestes, les silences, les images, les affects, les rythmes et les formulations subjectives, sans les traduire immédiatement dans un langage théorique ou psychopathologique.

Lorsque la phénoménologie clinique affirme analyser l'expérience vécue « sans explicitation psychologique prématurée », cela ne signifie :

- ni l'absence de sujet
- ni l'absence d'affects, de désir ou de conflits.
- > cela signifie plus précisément : sans *présupposer d'emblée tel ou tel modèle explicatif psychologique*.

La phénoménologie suspend cette question *explicative* pour poser une question plus primitive, et plus fondamentale :

- comment l'expérience est-elle vécue ?
- quelle est sa forme, sa texture, et sa structure ?

La phénoménologie travaille donc

- sur la manière dont le vécu se donne et s'organise
- et non sur son origine causale

Ce que l'on relève dans le texte

On est donc attentif à tout ce qui donne accès au vécu du sujet, dans le contenu comme dans la forme de l'expression. J'ai indiqué un petit ensemble d'éléments récurrents :

- les descriptions de sensations, d'émotions ou de perceptions
- les formulations subjectives
- les images, comparaisons et métaphores
- les répétitions, les hésitations, les contradictions ...

Et une liste d'indices qui se situe dans les différentes dimensions de l'existence (que je développe dans la partie suivante) :

- les indices temporels
- les indices spatiaux
- les indices corporels : fatigue, tension, immobilité, agitation, lourdeur, effacement, hyper-présence -
- les indices relationnels
- les ruptures, accélérations, ralentissements ou stases dans le récit.

Et il est également important de relever la forme du discours, et non seulement son contenu.

- les ruptures, accélérations, ralentissements ou stases dans le récit.
- de même un silence, une hésitation, une répétition ou une difficulté à formuler une demande peuvent être cliniquement significatifs, sans qu'il faille leur attribuer immédiatement une cause.

Ce que l'on écarte provisoirement

A cette étape, certains éléments doivent être mis entre parenthèses, même s'ils pourront être repris plus tard :

- les hypothèses diagnostiques

- les explications causales
- les interprétations qu'elles soit psychodynamiques, cognitives ou comportementales
- les jugements normatifs
- les conclusions générales sur la personnalité du sujet
- les formulations du type : « il évite », « elle refuse », « il est dépendant », etc.

L'objectif n'est pas encore de dire ce que le sujet « a », ni même pourquoi il vit les choses ainsi. Il s'agit de décrire comment l'expérience se présente pour lui.

À ce stade, l'enjeu est de constituer un matériau descriptif suffisamment précis pour permettre l'étape suivante : l'organisation du vécu selon les dimensions de l'existence.

1.2. Le cas de Louise

On pose la question : *comment Louise existe-t-elle, ici et maintenant, dans ce qu'elle dit et dans la manière dont elle est présente lors de cette première consultation ?*

Le vécu brut correspond à ce qui est *donné immédiatement* :

- Il ne s'agit pas de dire ce que Louise a :
- > mais de décrire *comment elle est là* :
 - . comment *elle existe actuellement*
 - . dans la situation telle qu'elle se donne
 - . et avant toute organisation conceptuelle

Et dans cet extrait, rien ne se présente d'abord sur un mode spectaculaire ou dramatique. Ce qui apparaît est plus discret :

- Louise ne dit pas qu'elle va mal
- > Elle dit plutôt qu'elle ne sait pas exactement ce qui ne va pas :
 - « Je vais bien, je n'ai pas de problème grave, mais... »
 - > Le malaise n'est pas immédiatement nommé
 - > il se manifeste dans une impression de vide, d'attente et de perte de rythme.

Plusieurs éléments peuvent alors être relevés sans être encore interprétés :

- une arrivée en avance
- une attitude retenue
- un sac gardé sur les genoux
- une présence corporelle discrète et peu expansive
- une difficulté à formuler la demande
- des silences qui scandent le récit
- une expérience de journées répétitives
- la disparition des repères antérieurs liés aux études
- un avenir évoqué sur le mode de l'attente indéterminée
 - un espace quotidien resserré autour du domicile parental et de la chambre
 - des relations maintenues, mais apparemment peu mobilisatrices.

On évitera de formuler immédiatement :

- *Louise présente une perte de motivation.* Cette formulation est déjà interprétative. Elle peut être discutée plus tard, mais elle ne correspond pas au premier niveau de description.
- Louise est incapable de se projeter. Elle dit bien « J'attends, mais je ne sais même pas quoi. », mais elle exprime seulement pour l'instant une attente indéterminée, sans objet clairement identifié.

La suite du travail consistera à reprendre ces indices pour les examiner selon les "dimensions de l'existence"

2. Les dimensions de l'existence

Nous entrons maintenant dans la partie la plus opérative : celle qui va structurer l'étude de cas à partir des éléments cliniques « bruts ».

Dans une perspective phénoménologique et existentielle, l'expérience vécue d'un sujet peut être décrite à partir de grandes dimensions fondamentales de l'existence. Ces dimensions sont appelées des *existenciaux*.

Ces existenciaux ne sont :

- ni des symptômes
- ni des traits de personnalité
- ni des catégories diagnostiques

> Ce sont des *axes de description du vécu* qui vont permettre d'organiser la clinique.

Dans ce cours, nous retiendrons six dimensions : ce ne sont pas les seules, mais ce sont les plus simples et les plus générales, qui sont essentielles pour l'analyse clinique, avec le lexique usuel :

- le rapport au temps : la *temporalité* ;
- le rapport à l'espace : la *spatialité* ;
- le rapport au corps : la *corporéité* ;
- le rapport à soi : l'*ipséité* ;
- le rapport à l'autre : l'*altérité* ;
- le rapport au monde : la *mondanéité*.

Ces dimensions ne doivent pas être comprises comme des rubriques séparées que l'on remplirait mécaniquement.

Dans l'expérience concrète d'un sujet, elles sont toujours liées entre elles :

- le rapport au temps peut modifier le rapport à soi
 - le rapport au corps peut transformer le rapport aux autres
 - le rapport à l'espace peut exprimer une certaine manière d'habiter le monde. Etc.
- > on va le voir systématiquement dans les exemples

L'intérêt clinique des existenciaux tient précisément à leur articulation. En les examinant ensemble, on pourra commencer à repérer la cohérence globale d'un mode d'existence :

- ce qui se répète
- ce qui se maintient
- ce qui entre en tension
- et ce qui organise progressivement l'expérience du sujet.

Ces croisements sont cliniquement importants, car

- ils indiquent que l'on ne se contente pas d'un simple classement descriptif.
- > On commence déjà à voir apparaître des convergences dans l'expérience du sujet.

Attendu de l'étape 2 :

À la fin de cette étape, on doit obtenir une structuration du matériau selon les existenciaux.

L'attendu minimal est le suivant :

- pour chaque dimension présente dans le matériau, relever deux ou trois indices précis ;

- formuler brièvement ce que ces indices indiquent du rapport au temps, à l'espace, au corps, aux autres, à soi ou au monde ;
- repérer les dimensions qui semblent les plus centrales dans le cas étudié ;
- signaler les éléments qui traversent plusieurs dimensions.

L'analyse doit donc éviter deux erreurs :

- isoler artificiellement les dimensions comme si elles étaient indépendantes ;
- attribuer à une dimension des éléments qui ne sont pas soutenus par le texte.

Cette organisation préparera ensuite :

- l'identification des tensions structurantes (étape 3)
- et la formulation d'une *structure de vécu* (étape 4)

On examine plus en détail chacun de ces six existentiels.

2.1. Le rapport au temps : temporalité

En phénoménologie clinique, le temps ne désigne pas seulement le temps objectif, mesurable par l'horloge ou le calendrier. Il désigne essentiellement le temps vécu, c'est-à-dire la manière dont le sujet éprouve le passage du temps, son présent, son passé et son avenir.

Le temps vécu

Le temps vécu est rarement neutre. Il peut être éprouvé par exemple comme :

- rapide, ralenti, suspendu
- répétitif, instable, menaçant ou bloqué
- peut donner au sujet le sentiment d'avancer, d'attendre, de tourner en rond, de revenir sans cesse en arrière, ou de ne plus pouvoir se projeter., etc.

La temporalité constitue une dimension centrale de l'expérience, car elle participe à la continuité du vécu. Elle engage à la fois :

- le *rapport au passé* : ce qui est retenu, oublié, figé, réactivé ou fragmenté ;
- le *rapport au présent* : ce qui est vécu comme stable, urgent, saturé, ou sans consistance ;
- le *rapport à l'avenir* : ce qui apparaît comme possible, impossible, incertain, catastrophique, absent ou indéterminé.

Le temps vécu constitue une dimension centrale de toute expérience, parce qu'il conditionne :

- la continuité de l'existence
- la capacité de projection
- et le sentiment d'identité

Indices cliniques de la temporalité

Dans une observation clinique ou un entretien, le rapport au temps peut apparaître de plusieurs manières. On sera attentif notamment :

- à la *manière dont le sujet parle de son passé* : passé traumatique, flou, idéalisé, saturé, absent, fragmenté ;
- à la *qualité du présent* : présent vide, urgent, instable, menaçant, répétitif, suspendu ;
- à la *manière dont l'avenir se dessine* : avenir ouvert, incertain, impossible, catastrophique, indéterminé ou absent ;
- au *rythme du discours* : accélérations, ralentissements, hésitations, ruptures ;

- aux *répétitions narratives* : retours circulaires, scènes qui reviennent, impossibilité de passer à autre chose ;
- aux *transitions dans le récit* : avec des passages fluides ou au contraire ruptures entre les moments de l'existence, par exemple

! Ces indices ne doivent pas être considérés isolément. Ils permettent de comprendre

- comment le sujet habite le temps
- et comment cette manière d'habiter le temps organise son expérience.

Temporalité et organisation du vécu

Dans l'organisation du matériau clinique, le rapport au temps permet de repérer plusieurs éléments essentiels :

- la continuité ou la discontinuité du vécu ;
- l'orientation dominante vers le passé, le présent ou l'avenir
- la capacité ou la difficulté à se projeter
- la présence ou l'absence de rythmes structurants ;
- la possibilité ou l'impossibilité de passer d'un moment de l'existence à un autre.

> Le temps apparaît ainsi comme un organisateur majeur de la cohérence du vécu :

- il ne donne pas seulement une succession d'événements
- il indique la manière dont l'existence se déploie, se répète, se suspend ou se fragilise.

Tensions temporelles

Certaines tensions structurantes se manifestent fréquemment dans la temporalité. On peut par exemple rencontrer des tensions entre :

- urgence et stagnation
- continuité et rupture
- attente et impossibilité d'agir
- anticipation et impossibilité d'avenir
- répétition et transformation
- stabilité et bascule

Ces tensions temporelles traversent souvent d'autres dimensions du vécu. Elles peuvent concerner

- le rapport à soi, lorsque la continuité identitaire est menacée
- le rapport aux autres, lorsque l'attente ou la séparation deviennent centrales
- ou encore le rapport au monde, lorsque celui-ci apparaît trop rapide, trop figé, trop vide ou impossible à rejoindre.

La temporalité contribue donc directement à la formulation de la structure de vécu. Elle donne une indication centrale sur

- la manière dont le sujet se maintient dans le temps
- sur ce qui rend le devenir possible
- ou au contraire sur ce qui le bloque.

Situation clinique : Louise

Chez Louise, à partir d'indications telles que :

| « *Je me lève tard... pas la peine de se lever plus tôt* »

> on constate :

- un temps devenu homogène, sans rythme imposé de l'extérieur
 - une perte de la structure temporelle auparavant imposée par les cours et les examens
 - un temps vaguement orienté vers un avenir indéterminé : « *J'attends, mais je ne sais pas quoi* »
- > qui mène à la formulation d'un temps vidé de ses repères, étiré, sans urgence ni projet clair

On peut donc formuler ainsi le rapport au temps chez Louise :

[Indices] Louise décrit des journées répétitives, peu rythmées par des contraintes ou des événements marquants. Elle souligne la disparition du rythme imposé par les études et l'absence d'une projection claire vers l'avenir. L'attente est présente, mais elle demeure indéterminée : « j'attends, mais je ne sais même pas quoi ».

[Organisation du vécu] Le rapport au temps apparaît organisé autour d'un présent homogène et étiré, faiblement structuré par des repères externes et difficilement orienté vers un devenir explicite. Le temps n'est pas vécu comme brutalement arrêté, mais comme vidé de ses prises habituelles : il se maintient, se répète, sans ouvrir clairement vers une transformation.

2.2. Le rapport à l'espace : spatialité

L'espace vécu

En phénoménologie clinique, l'espace ne se réduit pas à un cadre objectif, géométrique ou matériel.

Il renvoie à l'espace vécu, c'est-à-dire à la manière dont le sujet

- se situe dans le monde
- circule, s'oriente
- investit certains lieux
- en évite d'autres
- et s'autorise, ou ne s'autorise pas, à être quelque part.

L'espace vécu constitue une dimension existentielle fondamentale. Il engage la manière dont le sujet prend place dans le monde, règle la distance avec autrui, éprouve les limites, les frontières, la proximité ou l'exposition.

Un même lieu peut ainsi être vécu de manières très différentes, comme

- un refuge
- un espace d'ouverture
- un lieu menaçant
- un espace trop vaste
- un lieu d'enfermement
- ou encore un espace impersonnel dans lequel le sujet ne parvient pas à s'installer.

L'espace vécu renseigne donc sur la manière dont le sujet habite le monde, ou au contraire sur la manière dont il le subit.

Indices cliniques de la spatialité

Dans une observation clinique ou un entretien, le rapport à l'espace peut apparaître à travers plusieurs types d'indices.

On sera attentif notamment :

- la perception de l'espace comme ouvert ou fermé, accueillant ou menaçant, familiers ou étrangers
- le sentiment d'être à l'étroit, envahi, exposé, ou au contraire perdu dans un espace trop vaste
- la capacité ou la difficulté à investir certains lieux (domicile, espace public, lieux de travail, lieux sociaux)
- les mouvements d'approche, d'évitement ou de repli
- le besoin important de frontières et de refuges, ou au contraire la peur de l'enfermement, etc.

Un espace vécu altéré peut se manifester par :

- un besoin excessif de contrôle de l'environnement
- une intolérance à la proximité ou à la promiscuité
- une sensation d'irréalité ou de dé-familiarisation des lieux
- une difficulté à « prendre place » dans le monde.

Spatialité et organisation du vécu

Dans l'organisation du matériau clinique, le rapport à l'espace permet de repérer la manière dont le sujet prend place dans le monde.

Il permet notamment d'observer :

- si l'espace est vécu comme ouvert ou fermé ;
- si le sujet s'y déploie ou s'y replie ;
- s'il parvient à s'installer dans certains lieux ou s'il ne fait que les traverser ;
- s'il recherche des espaces de protection ou évite des espaces d'exposition ;
- s'il règle la distance à autrui par le retrait, le contrôle, la fuite ou la mise à distance.

La spatialité est étroitement liée aux autres dimensions de l'expérience vécue. Elle est liée :

- au corps, par la posture, l'orientation, le mouvement ou l'immobilité.
- au rapport à l'autre, par la proximité, l'intrusion, l'évitement ou la distance.
- elle est également liée au rapport au monde, selon que l'environnement apparaît hospitalier, menaçant, vide, saturé, facilement ou difficilement habitable.

Tensions spatiales

Certaines tensions structurantes prennent fréquemment une forme spatiale. On peut par exemple rencontrer des tensions entre :

- l'exposition et la protection. On peut dire de la même façon : ouverture et retrait ;
- proximité et distance
- envahissement et vide
- installation et impossibilité de prendre place
- occupation de l'espace et effacement
- ou encore : refuge et enfermement.

Ces tensions spatiales ne décrivent pas seulement des déplacements ou des lieux. Elles expriment une manière de régler la présence au monde :

- jusqu'où le sujet peut-il s'exposer ?
- de quoi doit-il se protéger ?
- quels lieux peut-il investir ?
- quels espaces deviennent impossibles à habiter ?

- ou s'il tente de préserver une limite par le contrôle, l'évitement ou le refuge.

Situation clinique : Louise

Dans le cas de Louise, le rapport à l'espace apparaît à partir de plusieurs indications simples :

« je suis restée ici, chez mes parents »
« le soir, mes parents rentrent, on dîne, je remonte dans ma chambre »

> Chez Louise, l'espace vécu s'organise autour d'une bipolarité marquée entre :

- l'espace parental commun (notamment la salle à manger), vécu comme lieu de passage obligé, porteur d'une fonction relationnelle implicite
- la chambre, qui fonctionne comme lieu de repli et de retrait, mais dont l'investissement n'apparaît pas comme un espace choisi ou approprié.

La chambre constitue un refuge, mais un refuge par défaut :

elle protège de l'exposition au monde et aux interactions familiales
sans pour autant être investie comme un véritable « chez-soi ».

> Louise n'habite pas cet espace au sens d'une *appropriation subjective* :

- elle s'y retire
- mais elle ne s'y installe pas.

L'ensemble de l'espace vécu prend ainsi la forme d'un espace « entre-deux » :

- ni celui de l'enfance ou de l'adolescence (auquel elle ne s'identifie plus)
- ni celui de l'autonomie adulte (qui n'est pas encore advenu).

> Il ne s'agit pas d'un espace de transition dynamique :

- mais d'un entre-deux figé
- sans mouvement d'appropriation ni projection

La formulation existentielle peut être la suivante :

[Indices] : Louise vit chez ses parents depuis la fin de ses études. Elle évoque principalement deux espaces : les espaces communs du domicile parental, investis de manière fonctionnelle (repas), et sa chambre, où elle se retire le reste du temps. Elle ne mentionne pas d'autres lieux investis régulièrement (lieux sociaux, professionnels ou personnels).

[Organisation du vécu] : Le rapport à l'espace est structuré autour d'un usage restreint et peu différencié des lieux, avec une alternance entre des espaces communs traversés sans appropriation et un espace de retrait servant avant tout de refuge, sans investissement subjectif marqué.

2.3. Le rapport au corps : corporéité

Le corps vécu

En phénoménologie clinique, le corps n'est pas appréhendé comme un simple support biologique :

- il est le lieu premier de l'expérience
- c'est-à-dire la manière concrète dont le sujet est présent au monde.

Le corps vécu donne accès à l'expérience avant même qu'elle ne soit pensée ou formulée :

- il constitue souvent le premier indicateur d'une modification du vécu
- parfois avant que le sujet ne puisse la dire.

Indices cliniques de la corporéité

L'analyse du corps vécu porte notamment sur :

- la manière dont le sujet habite son corps : présence, retrait, lourdeur, tension, effacement, agitation, hyper-présence, étrangeté ;
- la qualité des sensations corporelles : vide, trop-plein, nervosité, engourdissement, tension, fatigue, hyperréactivité ;
- la continuité ou à la discontinuité du vécu corporel ;
- la manière dont les affects sont incarnés ou, au contraire, semblent tenus à distance du corps ;
- la posture, aux gestes, à l'immobilité ou à l'agitation ;
- le rythme corporel : lenteur, précipitation, inhibition, relâchement, crispation ;
- la manière dont le corps s'oriente dans l'espace et dans la relation ;
- les plaintes somatiques, mais aussi à leur absence lorsque le corps semble pourtant peu mobilisé ou peu investi.

Ces indices ne doivent pas être réduits à des signes objectifs :

- une posture, un geste ou une fatigue ne « signifient » pas immédiatement quelque chose par eux-mêmes.
- > ils doivent être replacés dans l'ensemble du vécu du sujet et articulés aux autres dimensions de l'existence.

Corporéité et organisation du vécu

Dans l'organisation du matériau clinique, le corps permet de repérer des modes d'engagement ou de retrait dans l'existence.

Il peut indiquer :

- comment le sujet supporte la situation ;
- comment il s'y engage ou s'en protège ;
- comment l'affectivité se manifeste ou se trouve contenue ;
- comment le sujet se sent présent, absent, étranger ou exposé dans son propre corps ;
- comment il occupe l'espace et règle la distance avec autrui ;
- comment l'action est rendue possible, empêchée ou suspendue.

Le corps apparaît ainsi comme un fil conducteur entre plusieurs dimensions du vécu. Il relie :

- l'affectivité
- le rapport à soi
- le rapport à l'espace
- le rapport à l'autre
- et le rapport au monde.

> Une modification du vécu corporel peut donc révéler une modification plus générale de la manière d'exister.

Tensions corporelles

Certaines tensions structurantes se manifestent directement dans la corporéité. On peut par exemple rencontrer des tensions entre :

- le contrôle et le débordement ;
- la rigidité et l'effondrement ;

- la retenue et l'envahissement ;
- la présence et l'effacement ;
- la mobilisation et l'inhibition ;
- la tension et le relâchement ;
- l'exposition corporelle et la protection de soi.

Ces tensions ne concernent pas seulement le corps comme objet :

- elles indiquent la manière dont le sujet tente de tenir dans l'existence
- le corps peut devenir le lieu :
 - d'un effort de maîtrise
 - d'une fatigue d'être présent
 - d'une impossibilité à agir
 - ou au contraire d'un excès d'intensité difficile à contenir

Dans la formulation de la structure de vécu, le rapport au corps donne donc des indications importantes sur la manière dont l'existence est :

- incarnée
- supportée
- engagée
- ou au contraire tenue à distance.

Situation clinique (Louise)

Dans le cas de Louise, le corps vécu se lit dans les énoncés tels que :

| « *Je me lève tard... je lis, je regarde des séries* »...

Ce qui manifeste :

- un corps peu sollicité, activité minimale
- et pas de plainte somatique particulière
- > qui se formule comme un corps en attente, peu engagé

On resserre ceci dans une formulation existentielle :

[Indices] : Louise décrit des journées marquées par une activité physique minimale : lever tardif, activités essentiellement sédentaires (lecture, séries), peu de déplacements. Lors de la consultation, sa posture est discrète, peu expansive, et son corps apparaît peu engagé dans l'action.

[Organisation du vécu] : Le rapport au corps est caractérisé par une faible mobilisation corporelle, où le corps fonctionne principalement comme support du quotidien, sans être investi comme lieu d'expression affective ni comme vecteur d'engagement actif.

2.4. Le rapport à l'autre : altérité

L'altérité vécue

Le rapport à l'autre constitue un pilier central de l'étude de cas phénoménologique.

L'existence humaine est toujours déjà intersubjective. Elle se déploie dans :

- la rencontre
- l'adresse
- l'attente
- l'exposition à autrui, etc.

Le monde intersubjectif est un *espace d'épreuve*, où se jouent la reconnaissance, la sécurité, la limite, la vulnérabilité. L'analyse phénoménologique cherche donc à :

- décrire les régularités de ses relations
- telles qu'elles se manifestent dans l'expérience vécue

Indices cliniques de l'altérité

L'analyse du rapport à l'autre porte notamment sur :

- la manière dont le sujet s'adresse à autrui, y compris au clinicien lorsque celui-ci est présent dans le matériau ;
- la façon dont les autres sont évoqués : présents, absents, menaçants, indifférents, nécessaires, intrusifs, idéalisés ou dévalorisants ;
- ce que le sujet attend de l'autre : soutien, reconnaissance, protection, validation, distance, présence, réponse ;
- ce qu'il redoute de l'autre : abandon, intrusion, rejet, jugement, dévalorisation, dépendance, emprise ;
- sa manière de régler la proximité et la distance ;
- les modalités relationnelles dominantes : retrait, fusion, dépendance, méfiance, évitement, recherche d'approbation, mise à distance ;
- les ruptures, répétitions ou stabilités dans les liens ;
- la manière dont le sujet peut être affecté par la présence, l'absence ou la parole d'autrui.

Dès la description initiale, ces éléments apparaissent :

- dans la manière dont l'autre est évoqué dans le discours
- dans les attentes, craintes et projections exprimées
- dans le réglage (ou le dérèglement) de la distance relationnelle

Altérité et organisation du vécu

Dans l'organisation du matériau clinique, le rapport à l'autre permet de :

- repérer les modes relationnels dominants
- et les régularités dans la manière dont le sujet entre en relation, maintient le lien, s'en protège ou le rompt.

> il s'agit de comprendre :

- comment l'autre apparaît dans son expérience
- et quelle fonction prend autrui dans son monde vécu.

> Et Autrui peut par exemple apparaître comme :

- un appui nécessaire à la continuité du sujet ;
- une présence menaçante ou intrusive ;
- une source de reconnaissance attendue ;
- une instance de jugement ;
- un repère organisateur du quotidien ;
- une présence fonctionnelle mais peu investie ;
- une absence qui désorganise l'expérience ;
- un horizon relationnel recherché mais difficilement habitable.

Tensions relationnelles

Certaines tensions structurantes apparaissent fréquemment dans le registre intersubjectif, par exemple entre :

- dépendance et autonomie ;
- proximité et distance ;
- fusion et retrait ;
- reconnaissance et menace de jugement ;
- besoin d'appui et crainte d'intrusion ;
- attente de l'autre et intolérance à l'attente ;
- ouverture relationnelle et protection de soi ;
- maintien du lien et impossibilité de s'y engager pleinement, etc.

Ces tensions relationnelles traversent souvent *d'autres dimensions* du vécu, notamment :

Elles concernent le *rapport à soi*, lorsque l'estime ou la continuité identitaire dépendent fortement du regard d'autrui.

Elles concernent le *rapport au temps*, lorsque l'attente, l'abandon ou la séparation organisent l'expérience.

Elles concernent aussi le *rapport à l'espace*, lorsque la proximité, l'intrusion ou le retrait deviennent des manières de régler la relation.

Situation clinique : Louise

Dans le cas de Louise, le rapport à l'autre apparaît d'abord de manière discrète. Il n'est pas :

- marqué par un conflit relationnel explicite
- ni par une rupture brutale du lien
- > les autres sont présents, mais ils semblent peu mobilisateurs.

Dans le cas de Louise, on trouve par exemple :

« Mes amis ont tous déménagé, pris des postes ailleurs »,
« mes parents rentrent, on dîne, je remonte dans ma chambre »

On constate rapidement :

- la perte du réseau amical structurant (études)
- un rapport aux parents qui ressemble à :
 - . cohabitation présentée comme un fait plus que comme un choix
 - . et des échanges assez purement fonctionnels
- une solitude qui semble non dramatisée mais pesante dans son quotidien
- Ce qui oriente vers une formulation autour du retrait relationnel, et des liens distendus

[Indices] : Louise évoque l'éloignement de ses amis depuis la fin des études, sans exprimer de conflit relationnel explicite. Les relations avec ses parents sont décrites de manière factuelle et fonctionnelle (cohabitation, repas partagés). Elle ne mentionne ni isolement radical ni recherche active de nouveaux liens.

[Organisation du vécu] : Le rapport à l'autre apparaît organisé autour de liens distendus mais maintenus. Les autres restent présents dans l'environnement de Louise, mais leur présence semble faiblement mobilisatrice. L'altérité ne prend pas ici la forme d'une menace ou d'une rupture, mais celle d'une présence relationnelle peu investie comme espace de transformation, de reconnaissance ou de projection.

2.5. Le rapport à soi : ipsité

L'ipsité constitue une dimension centrale de la clinique phénoménologique, car elle permet de comprendre *comment le sujet se maintient comme unité au sein des variations du vécu*.

Le soi vécu

> Le rapport à soi renvoie à la manière dont le sujet se vit comme soi dans l'expérience, ce qui ne se réduit pas à :

- son identité sociale,
- son histoire personnelle
- ou l'image qu'il donne de lui-même :
- mais de la manière concrète dont le sujet *habite son expérience*
- se *reconnaît* dans ce qu'il vit : « je me reconnais dans ce que je fais », ou au contraire : « je ne me reconnais plus »,
- et se *maintient comme présence* à travers le temps : « je ne sais plus où j'en suis », « ce que je fais me paraît étranger ».

Indices cliniques de l'ipséité

Dans une observation clinique ou un entretien, le rapport à soi peut apparaître à travers plusieurs types d'indices.

On sera attentif notamment :

- le rapport du sujet à ses propres actes : appropriation, étrangeté, sentiment d'être auteur ou non
- aux fluctuations du sentiment d'exister : impression de présence, d'effacement, de vide, de dispersion, de perte de consistance ;
- la cohérence interne du vécu
- à la continuité ou à la discontinuité identitaire ;
- à la stabilité ou à la fragilité du sentiment d'être soi ;
- à la manière dont le sujet se reconnaît, ou non, dans ses actes, ses choix, ses affects ou ses pensées ;
- = c'est-à-dire au sentiment d'être l'auteur de ce qu'il fait, ou au contraire à l'impression de subir, l'appropriation ou le sentiment d'être agi, de ne plus se reconnaître (ce qu'on appelle souvent l'*agentivité*)
- et en particulier les formulations d'étrangeté à soi : « je ne suis plus moi-même », « je ne me reconnais pas », « ce n'est pas moi » ;
- à la manière dont le sujet se situe dans son histoire : continuité biographique, rupture, bascule, avant/après ;
- à la cohérence interne du vécu : ce qui tient ensemble, ce qui se fragmente, ce qui se contredit ou se disperse.

Ces indices permettent donc d'accéder à la manière

- dont le sujet se rapporte à lui-même dans son propre monde
- et non simplement à ce qu'il pense de lui ou raconte de son identité.

Ipséité et organisation du vécu

Dans l'organisation du matériau clinique, l'ipséité permet de relier :

- les variations temporelles : continuité, rupture, bascule, impossibilité de se projeter ;
- les fluctuations affectives : stabilité, débordement, vide, étrangeté, effacement ;
- les modalités relationnelles : dépendance, retrait, attente de reconnaissance, menace du regard d'autrui ;
- le rapport au corps : appropriation corporelle, étrangeté, tension, effacement ou hyper-présence ;
- le rapport au monde : sentiment d'avoir ou non une place, d'être orienté, soutenu, menacé ou dispersé.

Le rapport à soi permet ainsi de comprendre comment le sujet tente de se maintenir comme unité dans une expérience :

- parfois instable
- contradictoire
- ou difficilement habitable.

Tensions du rapport à soi

Les tensions structurantes concernent fréquemment le rapport à soi, par exemple entre :

- cohérence et dispersion ;
- continuité et rupture ;
- maîtrise et perte de soi ;
- appropriation et étrangeté de l'expérience ;
- affirmation de soi et effacement ;
- stabilité identitaire et indétermination ;
- maintien de soi et transformation impossible.

Ces tensions ne doivent pas être comprises comme de simples conflits psychologiques internes.

- elles indiquent la manière dont le sujet tente de préserver un sentiment d'être soi,
 - parfois au prix d'un retrait, d'un contrôle, d'une rigidification, d'un effacement ou d'une limitation des possibles.
- > on a bien sûr là une source d'entrée dans la psychopathologie (beaucoup plus large qu'une simple sémiologie)

Situation clinique : Louise

Dans le cas de Louise, le rapport à soi apparaît sous la forme d'une indétermination plutôt que d'une rupture manifeste entre deux époques de sa vie.

Sa formulation initiale est importante : « je vais bien, je n'ai pas de problème grave, mais... ».

- elle se maintient dans le quotidien.
- mais, quelque chose de son rapport à elle-même semble suspendu : elle ne parvient pas à nommer précisément ce qui fait difficulté, ni à définir ce vers quoi elle se dirige.

> Le rapport à soi peut donc être décrit comme :

- une continuité minimale
- mais faiblement orientée

On peut alors formuler ainsi le rapport à soi chez Louise :

[Indices] : Louise ne parvient pas à formuler ce qu'elle souhaite ou ce vers quoi elle se dirige. Elle souligne le contraste entre la période étudiante, structurée par des rôles et des attentes claires, et la période actuelle, marquée par une indétermination. Elle se décrit comme allant « plutôt bien », sans plainte subjective intense, mais sans repères identitaires explicites.

[Organisation du vécu] : Le rapport à soi apparaît marqué par une continuité minimale, suffisante pour assurer le maintien du quotidien, mais accompagnée d'une indétermination quant à l'orientation de soi et à la définition de projets ou de positions subjectives investies.

2.6. Le rapport au monde : mondanéité

Le monde vécu

Le rapport au monde, ou *mondanéité*, occupe une place particulière parmi les existentiels, c'est pourquoi il apparaît en dernier :

- D'un côté, il constitue une dimension de l'expérience vécue parmi les autres : au même titre que le rapport au temps, au corps, à l'espace, à soi ou à autrui, il peut être décrit comme un axe spécifique de l'analyse clinique.

D'un autre côté, il peut aussi jouer un rôle de synthèse, dans la mesure où le monde vécu exprime souvent la tonalité globale de l'existence.

> Il permet alors de mieux situer les différentes dimensions entre elles.

Cette double fonction est importante, puisque :

- le monde ne doit pas être compris seulement comme un contenu, c'est-à-dire comme l'ensemble des choses, des lieux, des personnes ou des situations qui entourent le sujet.

> Et en phénoménologie clinique, le monde désigne surtout la *manière dont ce monde se donne /se manifeste, au sujet* :

- comme accueillant ou hostile
- comme ouvert ou fermé
- comme porteur de sens ou bien vidé de signification
- comme mobilisateur ou au contraire sans prise pour le sujet.

Le monde n'est donc pas seulement « là » devant le sujet. Il peut

- soutenir
- solliciter
- appeler à l'action
- inquiéter
- saturer
- écraser
- ou au contraire laisser le sujet sans appui.

= Il constitue l'horizon dans lequel les expériences prennent forme et deviennent plus ou moins habitables.

Indices cliniques de la mondanéité

Dans une observation clinique ou un entretien, le rapport au monde peut apparaître à travers la tonalité générale du vécu.

On sera attentif notamment :

- à la manière dont le monde est globalement éprouvé : hospitalier, hostile, indifférent, menaçant, vide, saturé, confus, exigeant ;
- à la présence ou à l'absence de significations : monde porteur de sens, monde vidé de sens, monde trop chargé de significations ;
- à ce qui soutient le sujet, l'apaise ou lui offre des appuis ;
- à ce qui le déborde, l'envahit, l'écrase ou lui échappe ;
- à ce qui lui paraît possible ou impossible ;
- à ce qui l'appelle à agir, ou au contraire ne parvient plus à le mobiliser ;
- à la manière dont le monde offre — ou n'offre plus — des prises pour l'engagement, l'orientation ou la projection.

Un indicateur central de la mondanéité est donc la *capacité du monde à susciter ou non l'engagement*. Le monde vécu peut apparaître :

- comme un monde qui appelle le sujet, lui offre des possibilités, lui donne une direction

- ou au contraire comme un monde qui se ferme, se vide, devient trop intense, trop confus ou trop peu mobilisateur.

Mondanité et organisation du vécu

Dans l'organisation du matériau clinique, le rapport au monde permet de repérer l'orientation globale de l'expérience. Il aide notamment à comprendre :

- si le monde soutient ou fragilise l'unité du vécu ;
- si l'expérience est organisée autour de l'ouverture, du retrait, de la saturation, du vide ou de la menace ;
- si les différentes dimensions du vécu convergent vers une même tonalité ;
- si le sujet trouve encore des prises dans le monde pour agir, se projeter ou se transformer ;
- si le monde est habité, subi, évité, contrôlé ou difficilement rejoint.

La mondanité articule d'autant plus les autres existentiels qu'elle en constitue également, bien souvent, la synthèse. Par exemple :

- un temps ralenti, un espace restreint, un corps peu mobilisé, des relations distendues et un rapport à soi indéterminé peuvent, par exemple, converger vers l'expérience d'un monde faiblement sollicitant.
- à l'inverse, un corps en tension, un espace vécu comme intrusif, une relation à l'autre menaçante et un avenir catastrophique peuvent organiser l'expérience d'un monde saturé ou dangereux.

Tensions globales du monde vécu

On peut par exemple rencontrer des tensions entre :

- monde trop présent et monde trop absent
- excès de signification et défaut de signification
- monde mobilisateur et monde qui ne sollicite plus
- monde ouvert et monde fermé
- monde habitable et monde menaçant ;
- monde soutenant et monde écrasant
- engagement possible et retrait nécessaire.

Ces tensions ne décrivent pas simplement l'environnement du sujet. Elles décrivent la manière dont le monde se présente dans son expérience, et la manière dont le sujet peut ou non y trouver une place, une orientation et des possibilités d'action.

Tonalité existentielle

La formulation de la structure de vécu dans cette dimension globale du rapport au monde :

- permet de dégager la tonalité existentielle dominante
- > on la désigne par la notion d'*ambiance*.

Elle ne correspond pas seulement à une émotion interne :

- elle désigne la manière globale dont le sujet se trouve accordé ou désaccordé avec le monde.
- elle indique si le monde apparaît comme porteur, menaçant, vide, trop intense, lointain, fermé, ouvert, familier ou étrange.

Même lorsque cette ambiance est difficile à verbaliser, elle est cliniquement décisive :

- elle permet de comprendre comment l'existence est globalement habitée :
- < comment elle est rendue possible, soutenue, suspendue, appauvrie, menacée ou débordée.

La mondanéité devient donc centrale :

- lorsque l'analyse ne porte plus seulement sur ce que le sujet ressent, mais sur la manière dont le monde lui apparaît.
- > elle ne décrit pas ce que « fait » objectivement le monde, mais la manière dont il se donne dans l'expérience du sujet.

Situation clinique : Louise

Dans le cas de Louise, l'expression centrale est celle des « journées vides » :

- ce vide ne renvoie pas seulement à l'absence d'activités après la disparition du cadre fort qui soutenait sa vie d'étudiante
- > il indique une transformation du monde vécu : les journées existent, les lieux sont là, les démarches sont accomplies, mais l'ensemble est assez peu porteur de sens et faiblement mobilisateur.

On peut alors formuler ainsi le rapport au monde chez Louise :

[Indices] : Louise décrit des journées qu'elle qualifie de « vides » et l'absence d'activités perçues comme réellement engageantes. Elle évoque la disparition des cadres structurants antérieurs (études, examens, réseau amical) et l'absence actuelle de sollicitations ou d'exigences externes claires.

[Organisation du vécu] : Le rapport au monde est caractérisé par un environnement perçu comme globalement habitable mais faiblement sollicitant, offrant peu de prises pour l'engagement, l'orientation ou la projection, sans être vécu comme hostile ou menaçant.

2.7. Le cas de Louise : première synthèse clinique

Vous trouverez dans le support quelques éléments synthétiques :

- sur la méthodologie en général
- et sur le cas de Louise en particulier

> Je ne reprends pas le détail (déjà vu de manière dispersée) et je passe directement à la conclusion >

Remarque méthodologique (rappel)

Les six dimensions présentées — temporalité, spatialité, altérité, corporéité, ipséité et mondanéité — ne constituent pas une grille à remplir mécaniquement.

Elles doivent être utilisées comme des axes d'observation. Selon les cas, certaines dimensions seront plus centrales que d'autres. Il est cependant fréquent que chacune permette de repérer quelque chose du vécu du sujet, même de manière discrète.

L'objectif n'est donc pas de produire six rubriques séparées, mais de comprendre comment ces dimensions s'articulent. C'est leur convergence, leurs tensions et leurs écarts qui permettront ensuite de formuler une compréhension plus structurée de l'expérience vécue.

Synthèse des descriptions existentielles (rappel)

À partir des six dimensions étudiées — temporalité, spatialité, altérité, corporéité, ipséité et mondanéité — il est maintenant possible de proposer une première synthèse clinique du cas de Louise :

- elle ne constitue pas encore une formulation complète de la structure de vécu
- elle vise d'abord à articuler les différentes dimensions de l'expérience, afin de dégager une cohérence provisoire du vécu.
- > les tensions structurantes seront formulées dans un second temps.

Le monde vécu

Cette synthèse reste intermédiaire. Elle ne constitue pas encore une formulation complète de la structure de vécu. Elle vise d'abord à articuler les différentes dimensions de l'expérience, afin de dégager une cohérence provisoire du vécu. Les tensions structurantes seront formulées dans un second temps.

Chez Louise, le monde n'apparaît ni hostile, ni menaçant, ni désorganisé. Il n'est pas vécu comme persécuteur, intrusif ou impossible à habiter. En revanche, il semble avoir perdu une partie de sa capacité à orienter, solliciter et mobiliser l'existence.

Les journées sont décrites comme « vides ». Ce vide ne correspond pas simplement à une absence d'activités. Louise accomplit encore certaines démarches : elle consulte des offres d'emploi, envoie des CV, lit, regarde des séries, partage les repas avec ses parents. Mais ces activités semblent faiblement investies subjectivement. Elles maintiennent le quotidien sans ouvrir véritablement vers une transformation ou un devenir explicite.

Les repères qui structuraient auparavant son existence — le rythme des études, les cours, les examens, les rendus, l'environnement social étudiant — ne sont plus disponibles. Ils donnaient à la fois une organisation temporelle, des lieux à investir, des relations régulières et une position identifiable. Avec la fin du Master, ce monde familial s'est défait, sans qu'un nouveau cadre existentiel soit encore approprié.

Articulations avec les existentiels

Cette transformation du monde vécu entre en résonance avec les autres dimensions de l'expérience.

- Sur le plan *temporel* : le présent apparaît homogène et étiré, peu structuré par des repères externes et faiblement orienté vers l'avenir. L'attente est présente, mais elle reste indéterminée : « j'attends, mais je ne sais même pas quoi ».

- Sur le plan *spatial* : l'existence de Louise se resserre autour du domicile parental et de la chambre. L'espace n'est pas menaçant, mais il est peu approprié. Il prend la forme d'un entre-deux : Louise n'est plus dans l'espace étudiant, sans être encore installée dans un espace d'autonomie adulte.

- Sur le plan *relationnel* : les liens ne sont pas rompus, mais ils apparaissent distendus et peu mobilisateurs. Les amis se sont éloignés, les relations avec les parents sont maintenues sur un mode fonctionnel, et aucun lien actuel ne semble véritablement relancer l'expérience.

- Sur le plan *corporel* : le corps est peu engagé dans l'action. Les journées sont marquées par des activités sédentaires, peu de déplacements, une présence corporelle discrète et retenue. Le corps soutient le maintien du quotidien, mais il ne fonctionne pas comme vecteur d'élan ou d'engagement.

- Sur le plan de *l'ipséité* : Louise ne présente pas une rupture manifeste du rapport à soi. Elle se maintient dans une continuité minimale. Cependant, cette continuité est accompagnée d'une indétermination : elle ne parvient pas clairement à dire ce qu'elle veut, ce qu'elle attend, ni vers quoi elle pourrait s'orienter.

L'ensemble de ces dimensions converge vers une même tonalité existentielle : Louise habite un monde globalement soutenable, mais faiblement sollicitant. L'expérience n'est pas désorganisée ; elle n'est pas non plus traversée par une crise aiguë. Elle se maintient, mais sans ouverture claire vers une transformation.

Cette configuration constitue donc une forme de cohérence, mais non une harmonie. Les différentes dimensions du vécu s'accordent autour d'une même orientation :

- un temps étiré
- un espace peu approprié
- un corps peu mobilisé
- des liens maintenus mais peu transformateurs
- une ipséité continue mais indéterminée
- et un monde qui n'offre pas suffisamment de prises pour l'engagement.

On peut alors formuler une première synthèse clinique :

L'expérience de Louise s'organise autour d'un maintien en latence : le monde reste habitable, mais il ne sollicite plus suffisamment l'action, l'orientation et la projection. Louise continue à tenir dans le quotidien, sans rupture manifeste, mais sans dynamique claire de transformation ou de devenir.

Cette synthèse ne constitue pas encore une structure de vécu au sens strict. Elle permet néanmoins de dégager une cohérence existentielle provisoire. À partir de celle-ci, il sera possible d'identifier les tensions structurantes qui organisent cette manière d'exister.

3. Les tensions structurantes

La troisième étape consiste à passer :

- de l'organisation descriptive du vécu
- > à une première logique existentielle.

Il ne s'agit :

- plus maintenant de décrire séparément ces dimensions
- mais de repérer les *tensions transversales* qui les traversent et leur donnent une cohérence.

3.1. Définition

Ce qu'on appelle « tension structurante » correspond à la perspective dynamique du vécu et de l'existence : ce sont en quelques sorte *les lignes de force de cette existence*

Une tension structurante est dite « existentielle » parce qu'elle concerne la manière dont le sujet habite son existence. C'est une polarité dynamique qui organise l'expérience du sujet à travers plusieurs dimensions du vécu.

Elle rend compte à la fois :

- de ce que cette organisation permet au sujet
- et de ce qu'elle limite dans son champ de possibilités

Une tension structurante ne correspond pas à une difficulté locale, limitée à une seule dimension du vécu.

Ainsi, une tension existentielle ne décrit :

- ni un défaut quelconque
- ni un trait de personnalité
- ni directement un symptôme
- ni même un conflit intrapsychique
- elle ne formule pas une cause
- mais décrit une dynamique globale/transversale du vécu

Par exemple, une tension entre l'engagement (dans le monde) et le retrait (du monde) peut apparaître à la fois :

- dans le rapport au monde
- dans le rapport au temps
- dans le rapport aux autres
- et dans le rapport à soi

> Elle n'est donc pas simplement un comportement observable = elle exprime une manière pour le sujet de se *maintenir dans le monde*

3.2. Identification

Pour identifier/dégager une tension structurante, on s'appuie sur trois critères.

1 - Une tension n'est structurante que si elle traverse *plusieurs dimensions du vécu*. Si elle ne concerne qu'un seul registre, elle reste une observation locale.

Par exemple, une difficulté à sortir de chez soi peut relever de la spatialité. Mais si elle engage aussi le corps, le rapport aux autres, le rapport au monde et le rapport à soi, elle peut participer à une tension plus générale entre protection et exposition.

2 - Une tension structurante doit être formulée comme une *polarité*. Elle ne dit pas seulement :

- « le sujet est en retrait » ou « le sujet est débordé ».
- > elle cherche à décrire une dynamique entre deux pôles.

Par exemple entre :

- continuité et rupture
- appartenance et autonomie
- maîtrise de la situation et débordement
- protection et exposition, etc.

La polarité permet d'éviter de réduire le vécu à une caractéristique fixe. Elle montre que le sujet se tient :

- dans un mouvement, une oscillation ou un équilibre plus ou moins stable instable
- entre plusieurs exigences existentielles

3 - Une tension structurante doit rendre compte à la fois :

- *de ce qu'elle permet*
- *et de ce qu'elle entrave*

Par exemple, une tension entre *protection et exposition*

- peut permettre au sujet de rester en lien avec le monde sans se sentir trop vulnérable
- mais elle peut aussi limiter la profondeur des relations

De même, une tension entre continuité et rupture :

- peut permettre de préserver une stabilité existentielle
- mais elle limite l'ouverture à l'imprévu, au changement ou à la transformation.

C'est un *point essentiel* : une tension structurante ne doit pas être formulée uniquement comme un déficit () :

- la tension indique toujours une modalité de maintien
- > elle montre comment le sujet parvient à tenir, à se protéger, à préserver une continuité ou à maintenir un lien avec le monde
- < même lorsque cette modalité limite en même temps ses possibilités d'engagement, de transformation ou de projection.

Cf. en patho (psychodynamique), c'est exactement là l'idée de formation de compris et de bénéfice secondaire du symptôme

Pour vérifier qu'une tension reste bien au niveau existentiel, on peut utiliser le tableau simple qui est placé ici dans le support :

Question

La tension traverse-t-elle plusieurs dimensions du vécu ?
Est-elle formulée comme une polarité dynamique ?
Que permet-elle au sujet ?
Que limite-t-elle dans l'existence du sujet ?
Est-elle fondée sur des indices du texte ?
Se distingue-t-elle des autres tensions repérées ?

Fonction méthodologique

Vérifier la transversalité
Éviter les descriptions figées
Identifier sa fonction de maintien
Identifier le coût existentiel
Éviter l'interprétation non soutenue
Éviter les redondances

Il arrive qu'une analyse fasse apparaître une seule tension structurante forte. C'est parfaitement recevable.

À l'inverse, si l'on identifie trois ou quatre tensions :

- > il faut se demander si elles ont toutes le même statut.
- > certaines peuvent être secondaires, ou constituer des déclinaisons d'une tension plus centrale.

Par exemple, dans un cas donné, les tensions suivantes peuvent apparaître :

- protection et exposition
- proximité et distance
- maîtrise et débordement

> Mais elles peuvent aussi être comprises comme trois formes d'une tension plus générale autour de la régulation de l'exposition au monde et à autrui.

> L'objectif n'est donc pas de multiplier les tensions, mais de dégager celles qui organisent réellement l'expérience du sujet. Une bonne formulation de tension doit

- permettre de mieux comprendre la cohérence du vécu
- < et non d'ajouter une liste de catégories.

3.3. Tensions structurantes et conflits psychiques organisateurs

Il est important de distinguer

- les *tensions structurantes*, telles qu'elles sont utilisées en phénoménologie clinique
- des *conflits psychiques organisateurs*, tels qu'ils peuvent être pensés dans une perspective psychodynamique ou psychanalytique.

Ces deux notions peuvent sembler proches, car elles décrivent toutes deux des dynamiques qui organisent l'expérience ou le fonctionnement du sujet. Mais elles n'ont pas le même statut théorique.

Les tensions structurantes désignent des dynamiques immanentes au vécu. Elles sont repérables dans la manière dont le sujet habite le temps, l'espace, le corps, les autres, soi-même et le monde.

Elles ne sont pas posées comme inconscientes au sens psychodynamique. Elles sont structurantes parce qu'elles organisent l'expérience telle qu'elle se donne.

Elles sont donc :

- descriptives
- transversales
- non causales
- non localisées dans une instance psychique
- repérables dans le discours, le style de présence et l'organisation du monde vécu.

Les conflits psychiques organisateurs désignent, dans une perspective psychodynamique, des oppositions intrapsychiques généralement inconscientes, entre désirs, défenses, identifications, interdits ou motions pulsionnelles.

Ils sont structurants parce qu'ils participent à l'organisation de l'appareil psychique et à ses modes de régulation.

Ils sont donc :

- explicatifs
- génétiques
- fondés sur une métapsychologie
- localisés dans une économie psychique
- inférés à partir des formations de l'inconscient, des défenses, des répétitions transférentielles ou des symptômes.

Une tension existentielle n'est donc pas un conflit psychique :

- elle peut toutefois en constituer la forme vécue
(c'est-à-dire la manière dont une dynamique psychique éventuelle se manifeste dans l'existence concrète du sujet.

On peut parler d'un rapport *d'homologie, mais non d'identité* :

Cela signifie :

- qu'il peut y avoir correspondance entre les deux niveaux ;
- mais qu'il n'y a pas de traduction automatique ;
- qu'une tension existentielle ne permet pas, à elle seule, d'inférer un conflit inconscient ;
- et qu'une analyse phénoménologique ne valide pas, par elle-même, une hypothèse psychodynamique.

Phénoménologie clinique	Psychodynamique / Psychanalyse
Tension existentielle	Conflit intrapsychique
Description du vécu	Interprétation explicative
Monde vécu	Appareil psychique
Sens immanent à l'expérience	Sens inféré
Modalité d'être-au-monde	Organisation défensive
Non causal	Causal ou génétique
Décrit comment cela se vit	Cherche pourquoi cela se structure ainsi

Une tension existentielle peut donc être comprise :

- comme la forme phénoménale que prend une organisation psychique dans l'existence, éventuellement,
- mais cette correspondance ne peut pas être posée automatiquement dans le cadre de l'analyse phénoménologique

Autrement dit (je résume) :

- une tension existentielle n'est pas un conflit psychique déguisé
- nommer une tension ne permet pas d'inférer un conflit inconscient
- la phénoménologie clinique décrit la forme vécue de l'expérience
- alors que la psychodynamique cherche à expliquer son organisation interne et son histoire.

3.4. Exemples

Je propose ensuite plusieurs exemples, assez largement rédigés. Je lis le premier avec vous, les autres sont là pour consultation si souhaité

Engagement / Retrait

« Quand on me confie une nouvelle tâche, je m'y investis rapidement : je prends des initiatives, je veux bien faire, je m'implique. Mais au bout d'un moment, je me sens saturé, comme si le travail prenait trop de place. Je ralentis alors, je fais le strict nécessaire. Puis, quand la pression retombe, j'ai l'impression de m'être mis à l'écart et de devoir repartir de zéro. »

Premiers indices phénoménologiques :

- Le sujet décrit d'abord un mouvement d'entrée rapide dans l'activité : il s'investit, prend des initiatives, veut bien faire et s'implique.
- Cet engagement initial est ensuite suivi d'un vécu de saturation : le travail « prend trop de place » et devient difficile à soutenir.
- Le ralentissement apparaît alors comme une manière de réduire l'intensité de l'engagement. Le sujet « fait le strict nécessaire », puis a l'impression de s'être mis à l'écart.
- Enfin, lorsque la pression retombe, il éprouve le sentiment de devoir « repartir de zéro », comme si la continuité de l'engagement avait été interrompue.

Dimensions :

- Dans le *rapport au temps*, les engagements sont amorcés avec intensité, puis suspendus ou ralentis. L'expérience prend la forme d'un cycle : implication initiale, saturation, retrait, puis sentiment de devoir recommencer.
- Dans le *rapport à l'espace*, l'activité nouvelle prend d'abord de la place dans l'existence du sujet. Mais lorsque le travail « prend trop de place », l'espace vécu devient saturant. Le retrait secondaire peut alors être compris comme une mise à distance, une manière de se replacer à l'écart pour préserver un espace propre.
- Dans le *rapport au corps*, l'engagement semble d'abord porté par un élan. Mais cet élan se transforme progressivement en fatigue ou en saturation. Le ralentissement n'est donc pas seulement organisationnel : il indique une limite corporelle et affective dans la capacité à soutenir l'intensité de l'activité.
- Dans le *rapport à l'autre*, l'activité confiée engage aussi une attente professionnelle. Le sujet veut bien faire, répondre à ce qui lui est demandé, être à la hauteur de la tâche. Mais cette attente peut devenir pesante lorsque l'implication se prolonge. La relation professionnelle reste possible, mais elle devient plus coûteuse dès qu'elle implique une pression ou une exigence durable.
- Dans le *rapport à soi*, le sujet ne se décrit pas comme indifférent ou désengagé d'emblée. Au contraire, il se reconnaît d'abord dans l'investissement, l'initiative et le désir de bien faire. Le retrait secondaire produit ensuite un sentiment d'écart à soi : il a l'impression de s'être mis à l'écart et de devoir repartir de zéro.
- Dans le *rapport au monde* : certaines activités sont d'abord fortement investies. Le monde du travail apparaît comme mobilisateur, porteur d'appel et d'initiative. Mais cet investissement ne se maintient pas durablement : lorsque l'activité devient trop prenante, le sujet se retire partiellement.

Ce que cela permet :

- Cette organisation permet de maintenir un contact avec le monde professionnel sans se laisser envahir par lui.
- L'engagement initial permet de répondre à la tâche, de prendre place dans l'activité et de se sentir impliqué.
- Le retrait secondaire permet de réduire la saturation et de préserver une limite lorsque le travail prend trop de place.

Ce que cela limite :

- Cette organisation limite la possibilité d'un engagement durable.

- Elle peut produire une discontinuité dans les projets, un sentiment de recommencement permanent et une difficulté à maintenir une place stable dans l'activité.
- Elle peut également fragiliser le rapport à soi, puisque le sujet passe d'un moment où il se sent impliqué à un moment où il se sent en retrait ou à distance de ce qu'il avait commencé.

Formulation possible :

Le vécu du sujet est traversé par une tension entre ouverture et retrait. L'activité nouvelle suscite d'abord un élan d'engagement, d'initiative et d'implication. Mais lorsque cet engagement devient trop intense ou trop durable, il se transforme en vécu de saturation, appelant un mouvement de ralentissement et de mise à distance.

Cette polarité traverse le rapport au monde, où les activités sont investies de manière intermittente ; le rapport au temps, marqué par des projets amorcés puis suspendus ; le rapport à l'espace, où le travail prend progressivement trop de place et appelle une mise à distance ; le rapport au corps, où l'élan initial se transforme en saturation ; le rapport à l'autre, où l'attente professionnelle devient coûteuse ; et le rapport à soi, où le retrait secondaire produit un sentiment de décalage et de recommencement.

À éviter : « Le sujet a du mal à gérer la pression professionnelle. »

- Cette formulation est trop fonctionnelle et trop explicative.
- Elle réduit la dynamique existentielle à une difficulté de « gestion ». Elle fait disparaître la polarité ouverture / retrait, ainsi que la manière dont le sujet tente de maintenir un lien au travail sans se laisser envahir par lui.
- Elle ne décrit pas non plus la fonction du retrait : celui-ci n'est pas seulement un échec de l'engagement, mais une manière de préserver une limite lorsque l'activité devient trop saturante.

Maîtrise / Débordement

« Dans les situations un peu tendues, je fais très attention à ce que je montre. Je pèse mes paroles, je contrôle mes gestes, je reste calme en apparence. J'évite les endroits trop chargés ou imprévisibles. À la fin de la journée, je me sens souvent épuisé, comme si tenir tout ça demandait un effort permanent, mais je préfère ça plutôt que de perdre pied. »

Premiers indices phénoménologiques :

- Le sujet décrit d'abord une vigilance importante dans les situations tendues : il fait attention à ce qu'il montre, pèse ses paroles et contrôle ses gestes.
- Le calme apparent apparaît comme le résultat d'un effort actif de maîtrise plutôt que comme une tranquillité spontanée.
- L'évitement des endroits trop chargés ou imprévisibles indique que certaines situations sont vécues comme difficiles à contenir.
- La fin de journée est marquée par un épuisement, comme si le maintien de cette maîtrise demandait un effort permanent.
- L'expression « perdre pied » indique que ce contrôle vise à éviter une forme de débordement ou de désorganisation de la présence.

Dimensions existentielles :

- Dans le *rapport au temps*, l'expérience se déploie sur le mode d'un effort prolongé. Le sujet tient dans la journée, mais ce maintien s'accumule et se paie après coup par l'épuisement. Le temps vécu apparaît donc marqué par une tension continue entre tenue immédiate et fatigue différée.
- Dans le *rapport à l'espace*, le sujet évite les « endroits trop chargés ou imprévisibles ». L'espace est donc vécu différemment selon son degré d'intensité, de densité ou de prévisibilité. Certains lieux peuvent rester habitables, tandis que d'autres deviennent difficiles à supporter parce qu'ils rendent la maîtrise plus fragile.

- Dans le *rapport au corps*, la maîtrise passe par le contrôle des gestes, de la posture et de l'apparence. Le corps est surveillé, retenu, contenu. Il ne s'exprime pas librement : il devient le lieu d'un effort de régulation visant à éviter que quelque chose ne déborde.
- Dans le *rapport à l'autre*, le sujet fait attention à ce qu'il montre. Autrui apparaît donc comme un témoin possible de ce qui pourrait échapper au contrôle. La relation n'est pas absente, mais elle est traversée par une vigilance portant sur l'image donnée, les paroles prononcées et les réactions visibles.
- Dans le *rapport à soi*, le sujet semble constamment attentif à ses propres réactions internes. Il cherche à rester calme, à ne pas se laisser envahir et à préserver un sentiment de continuité. La maîtrise devient ainsi une manière de se maintenir comme sujet stable dans des situations vécues comme potentiellement déstabilisantes.

En disant ça, on va déjà apparaître les bénéfices de cette organisation

- Dans le *rapport au monde*, certains environnements sont vécus comme trop chargés ou imprévisibles. Le monde n'est pas entièrement menaçant, mais il devient difficilement habitable lorsqu'il est trop intense, trop dense ou insuffisamment cadré. Le sujet privilégie alors des situations plus prévisibles, où la maîtrise reste possible.

Ce que cela permet :

- Cette organisation permet au sujet de rester présent dans des situations qui pourraient autrement être vécues comme trop intenses ou désorganisantes.
- Le contrôle des gestes, des paroles et de l'apparence permet de maintenir une forme de calme et de continuité.
- L'évitement des environnements trop chargés ou imprévisibles permet de préserver une limite et de réduire le risque de débordement.
- La maîtrise fonctionne donc comme une condition de stabilité de la présence.

Ce que cela limite :

- Cette organisation entraîne une fatigue importante, liée à l'effort constant de contrôle.
- Elle limite la spontanéité du rapport au corps, à la parole et à la relation.
- Elle peut réduire l'ouverture aux situations nouvelles, imprévisibles ou plus intenses.
- Elle peut également appauvrir l'expérience vécue, puisque le sujet doit rester dans une position de surveillance de soi plutôt que dans un engagement plus libre.

Formulation possible :

Le vécu du sujet est traversé par une tension entre maîtrise et débordement. Dans les situations tendues, il cherche à maintenir une présentation contrôlée de lui-même : paroles pesées, gestes retenus, calme apparent. Mais cette maîtrise demande un effort permanent, car certaines situations sont vécues comme susceptibles de devenir trop chargées, trop imprévisibles ou désorganisantes.

Cette polarité traverse le rapport au temps, marqué par un effort de tenue prolongé et un épuisement différé ; le rapport à l'espace, où certains lieux trop chargés ou imprévisibles fragilisent la maîtrise ; le rapport au corps, où les gestes et l'apparence sont contenus ; le rapport à l'autre, où le sujet surveille ce qu'il montre ; le rapport à soi, où la stabilité dépend d'une vigilance constante ; et le rapport au monde, où les environnements trop intenses ou insuffisamment cadrés deviennent difficiles à habiter.

À éviter : « Le sujet est anxieux et a besoin de contrôler ses émotions pour ne pas se laisser envahir. »

- Cette formulation introduit trop vite une catégorie psychologique ou psychopathologique.
- Elle réduit la dynamique existentielle à un état interne d'anxiété et à une difficulté de gestion émotionnelle.
- Elle fait disparaître la tension organisatrice entre maîtrise et débordement, ainsi que la manière dont le sujet tente de maintenir une présence stable dans des situations vécues comme trop intenses ou imprévisibles.

- Elle ne décrit pas non plus la fonction de la maîtrise : celle-ci n'est pas seulement un symptôme de contrôle, mais une manière de préserver une continuité de soi et de rester présent sans perdre pied.

Continuité / Menace de rupture

« J'ai besoin que mes journées se ressemblent un peu. Je fais les choses dans le même ordre, aux mêmes heures. Quand un imprévu arrive ou qu'on me propose un changement, je me sens rapidement déstabilisé, comme si tout devenait flou. Je préfère alors m'en tenir à ce que je connais, même si ça me donne parfois l'impression de tourner en rond. »

Premiers indices phénoménologiques :

- Le sujet décrit un besoin de régularité dans l'organisation de ses journées.
- Les actions sont réalisées dans le même ordre et aux mêmes heures, ce qui donne au quotidien une forme stable et prévisible.
- L'imprévu ou le changement provoque rapidement une déstabilisation, décrite comme un flou.
- Le sujet préfère alors revenir à ce qu'il connaît, même si cette continuité produit parfois une impression de répétition ou de stagnation.

Dimensions existentielles :

- Dans le *rapport au temps*, les journées sont organisées par des routines, des séquences régulières et des repères horaires. Le temps devient plus soutenable lorsqu'il se répète.
- Dans le *rapport à l'espace*, les journées semblent organisées dans un cadre familier et prévisible. Le changement ou l'imprévu modifie ce cadre et rend l'espace vécu moins stable, moins lisible. Le sujet préfère alors s'en tenir à ce qu'il connaît, c'est-à-dire à des lieux, des gestes ou des situations déjà repérés.
- Dans le *rapport au corps*, le changement produit une déstabilisation immédiate. Le corps n'est pas décrit directement, mais l'expression « je me sens rapidement déstabilisé » indique une fragilisation de l'assise corporelle vécue.
- Dans le *rapport à l'autre*, la proposition de changement venant d'autrui peut introduire une rupture dans l'organisation habituelle. L'autre n'est pas menaçant en lui-même, mais il peut être porteur d'imprévu.
- Dans le *rapport à soi*, la répétition soutient une forme de stabilité. Le sujet se maintient plus facilement lorsqu'il peut s'appuyer sur des habitudes connues.
- Dans le *rapport au monde*, les situations nouvelles ou imprévues rendent le monde moins lisible. Le monde familier est privilégié parce qu'il reste plus prévisible et plus habitable.

Ce que cela permet :

- Cette organisation permet de maintenir une continuité dans le quotidien.
- Les routines donnent des repères et rendent le monde plus lisible.
- Le recours à ce qui est connu permet de limiter le sentiment de flou ou de désorganisation.
- La répétition fonctionne ainsi comme un appui de stabilité.

Ce que cela limite :

- Cette organisation limite l'ouverture à l'imprévu et aux situations nouvelles.
- Elle peut réduire la capacité à accueillir le changement ou à transformer ses habitudes.
- Elle peut produire une impression de tourner en rond.
- Elle peut également restreindre le champ des possibles en privilégiant ce qui est déjà connu.

Formulation possible :

Le vécu du sujet est traversé par une tension entre continuité et menace de rupture. Les routines, les horaires et les séquences familiales permettent de maintenir un monde stable et lisible. Mais lorsqu'un imprévu survient ou qu'un changement est proposé, cette continuité se fragilise et l'expérience devient rapidement floue ou déstabilisante.

Cette polarité traverse le rapport au temps, organisé par la répétition et la prévisibilité ; le rapport à l'espace, où les cadres familiers rendent l'expérience plus stable et plus habitable ;

le rapport au corps, où le changement se manifeste comme déstabilisation ; le rapport à l'autre, lorsque l'autre introduit une modification possible du cadre habituel ; le rapport à soi, où les habitudes soutiennent la stabilité ; et le rapport au monde, où le familier apparaît plus habitable que le nouveau.

À éviter : « Le sujet a peur du changement et reste accroché à ses habitudes. »

- Cette formulation transforme une dynamique existentielle en trait personnel
- Elle fait disparaître la polarité entre continuité et menace de rupture, ainsi que la fonction stabilisante des routines
- Elle attribue arbitrairement une peur au sujet
- Elle ne décrit pas non plus la manière dont le changement est vécu : non comme une simple nouveauté, mais comme une fragilisation de la lisibilité du monde et du maintien de soi

Protection / Exposition

« Je fais attention à ce que je montre de moi. Je parle facilement de choses générales, mais je reste réservé sur ce qui me touche vraiment. Je choisis avec qui je passe du temps et j'évite les situations trop intenses ou imprévisibles. Être présent aux autres est important pour moi, mais seulement jusqu'à un certain point, pour ne pas me sentir trop exposé. »

Premiers indices phénoménologiques :

- Le sujet décrit une attention portée à ce qu'il montre de lui-même.
- Il peut parler facilement de choses générales, mais reste réservé sur ce qui le touche vraiment.
- Il choisit avec qui il passe du temps, ce qui indique une sélection des situations relationnelles.
- Il évite les situations trop intenses ou imprévisibles.
- La présence aux autres est importante pour lui, mais elle doit rester limitée « jusqu'à un certain point ».
- L'expression « pour ne pas me sentir trop exposé » indique que la relation à autrui suppose une régulation de l'exposition.

Dimensions existentielles :

- Dans le *rapport au temps*, l'engagement relationnel semble devoir rester mesuré et progressif. Le sujet ne se ferme pas aux autres, mais il ne s'expose pas immédiatement ni sans limite.
- Dans le *rapport à l'espace*, le sujet règle la distance aux situations et aux personnes. Il choisit avec qui il passe du temps et évite les situations trop intenses ou imprévisibles. L'espace relationnel doit donc rester suffisamment délimité et prévisible pour ne pas devenir trop exposant.
- Dans le *rapport au corps*, l'exposition de soi est indirectement engagée : ce qui est montré, ce qui touche vraiment, ce qui devient trop intense ou trop exposant. Le corps propre n'est pas décrit directement, mais la présence à autrui suppose une limite à préserver.
- Dans le *rapport à l'autre*, la relation est importante, mais elle doit être réglée. Le sujet choisit avec qui il passe du temps et limite l'intensité ou l'imprévisibilité des situations relationnelles.
- Dans le *rapport à soi*, le sujet préserve une zone personnelle plus intime : il parle de choses générales, mais reste réservé sur ce qui le touche vraiment.
- Dans le *rapport au monde*, les situations sociales sont habitables lorsqu'elles restent suffisamment prévisibles et contenues. Lorsqu'elles deviennent trop intenses ou imprévisibles, elles sont évitées.

Ce que cela permet :

- Cette organisation permet de maintenir une présence aux autres sans exposition excessive.
- La réserve protège ce qui touche le sujet plus intimement.
- Le choix des relations et des situations permet de préserver une limite personnelle.
- L'évitement des situations trop intenses ou imprévisibles permet de rester en lien tout en réduisant le risque de débordement ou d'exposition excessive.

Ce que cela limite :

- Cette organisation peut limiter la spontanéité relationnelle.
- Elle peut réduire l'ouverture à certaines rencontres ou situations nouvelles.
- Elle peut maintenir une distance dans les liens, en particulier lorsque ceux-ci deviennent plus personnels.
- Elle peut aussi restreindre le champ des expériences partagées lorsque l'intensité ou l'imprévisibilité sont trop rapidement évitées.

Formulation possible :

Le vécu du sujet est traversé par une tension entre protection et exposition. Être présent aux autres est important pour lui, mais cette présence doit rester réglée par une limite : il peut parler, choisir ses relations et participer aux échanges, à condition de ne pas se sentir trop exposé.

Cette polarité traverse le rapport au monde, où les situations trop intenses ou imprévisibles sont évitées ; le rapport au temps, où l'engagement relationnel doit rester mesuré ; le rapport à l'espace, où la distance aux situations et aux personnes doit rester réglée ; le rapport au corps, où la présence à autrui suppose une limite à préserver ; le rapport à l'autre, où la relation est choisie et régulée ; et le rapport à soi, où ce qui touche vraiment demeure plus réservé.

À éviter : « Le sujet est réservé parce qu'il a peur du regard des autres. »

- Cette formulation réduit la dynamique de régulation de l'exposition à un trait de caractère et à une émotion internalisée.
- Elle psychologise trop vite le vécu en parlant de « peur », alors que le matériau indique surtout une régulation de ce qui est montré et de ce qui expose.
- Elle fait disparaître la polarité protection / exposition.
- Elle ne rend pas compte de la manière dont le sujet règle la distance au monde et à autrui.
- Elle ne décrit pas non plus la fonction de la réserve : celle-ci n'est pas seulement une fermeture, mais une manière de maintenir une présence aux autres sans se sentir trop exposé.

Engagement / Dispersion

« Quand je commence quelque chose, je suis souvent très partant. Je m'implique, j'y pense beaucoup, j'ai des idées. Mais au bout d'un moment, l'élan retombe. Je continue un peu, puis je me détache sans vraiment décider d'arrêter. J'ai souvent plusieurs choses commencées, sans savoir laquelle poursuivre vraiment. »

Premiers indices phénoménologiques :

- Le sujet décrit d'abord un élan initial important : il est « très partant », s'implique, pense beaucoup à ce qu'il commence et a des idées.
- Cet engagement ne disparaît pas immédiatement, mais il se transforme progressivement : « au bout d'un moment, l'élan retombe ».
- Le détachement ne prend pas la forme d'un arrêt clairement décidé. Il s'installe progressivement, sans décision explicite.
- Le sujet se retrouve avec plusieurs choses commencées, sans parvenir à déterminer laquelle poursuivre vraiment.
- L'expérience est donc marquée par une difficulté à transformer l'élan initial en continuité durable.

Dimensions existentielles :

- Dans le rapport au temps, les projets sont amorcés avec intensité, mais peinent à se stabiliser. Le temps de l'engagement reste discontinu : commencement, retombée de l'élan, poursuite minimale, puis détachement progressif.

- Dans le *rapport à l'espace*, plusieurs activités semblent ouvertes en même temps, sans qu'un espace d'engagement principal se stabilise. Le sujet passe d'un champ d'activité à un autre, sans parvenir à habiter durablement l'un d'eux. L'espace vécu apparaît donc dispersé entre plusieurs possibles commencés.
- Dans le *rapport au corps*, l'élan initial semble porter l'activité, mais cette mobilisation ne se maintient pas. Le corps n'est pas décrit directement, mais l'engagement paraît perdre progressivement sa force d'entraînement.
- Dans le *rapport à l'autre*, aucune relation n'est explicitement mentionnée. Cependant, la difficulté à poursuivre peut avoir des effets sur les engagements pris, les attentes éventuelles ou la continuité des activités partagées.
- Dans le *rapport à soi*, le sujet ne se décrit pas comme indifférent. Il éprouve au contraire un intérêt initial réel, mais se trouve ensuite en difficulté pour choisir, poursuivre et soutenir une trajectoire.
- Dans le *rapport au monde*, plusieurs activités sont ouvertes en même temps, mais aucune ne parvient à s'imposer durablement comme axe principal. Le monde apparaît riche en possibles, mais difficile à hiérarchiser.

Ce que cela permet :

- Cette organisation permet de rester ouvert à plusieurs possibilités.
- L'élan initial permet d'entrer dans des activités nouvelles et de se sentir mobilisé.
- Le détachement progressif évite de rester enfermé dans un engagement devenu moins porteur.
- La dispersion maintient une certaine liberté face aux contraintes d'un choix définitif.

Ce que cela limite :

- Cette organisation limite la possibilité de construire une trajectoire durable.
- Elle peut produire une dispersion des activités et une difficulté à hiérarchiser les possibles.
- Elle peut empêcher certains projets d'aboutir ou de prendre forme dans le temps.
- Elle peut également fragiliser le rapport à soi, puisque le sujet commence plusieurs choses sans savoir laquelle poursuivre vraiment.

Formulation possible :

Le vécu du sujet est traversé par une tension entre engagement et dispersion. Les activités nouvelles suscitent d'abord un élan réel, fait d'implication, d'idées et de mobilisation. Mais cet élan retombe progressivement, sans que l'arrêt soit véritablement décidé, laissant plusieurs commencements ouverts sans trajectoire clairement poursuivie.

Cette polarité traverse le rapport au temps, où les projets sont amorcés puis se défont progressivement ; le rapport à l'espace, où plusieurs champs d'activité restent ouverts sans se stabiliser ; le rapport au corps, où la mobilisation initiale perd sa force d'entraînement ; le rapport à l'autre, lorsque la continuité des engagements peut devenir difficile à maintenir ; le rapport à soi, où le sujet reste en suspens entre plusieurs possibles ; et le rapport au monde, où les activités sont nombreuses mais peu hiérarchisées.

À éviter : « Le sujet manque de motivation. »

- Cette formulation est trop vague et déficitaire.
- Elle efface l'élan initial, pourtant explicitement présent dans le matériau.
- Elle réduit la dynamique existentielle à un manque interne.
- Elle ne décrit pas la tension engagement / dispersion, ni la difficulté à transformer un commencement en trajectoire durable.
- Elle ne rend pas compte de la manière dont le sujet reste ouvert à plusieurs possibles sans parvenir à en soutenir un dans la durée.

Appartenance / Autonomie

« J'aime faire partie d'un groupe, me sentir inclus, savoir où est ma place. En même temps, j'ai besoin de garder mon indépendance et de ne pas trop dépendre des

autres. Quand le lien devient trop serré, je prends de la distance. Mais si je m'éloigne trop, je me sens vite à l'écart. Je cherche sans cesse un juste milieu. »

Premiers indices phénoménologiques :

- Le sujet décrit un besoin d'appartenance : faire partie d'un groupe, se sentir inclus, savoir où est sa place.
- Ce besoin d'inscription relationnelle coexiste avec une exigence d'indépendance.
- Lorsque le lien devient trop serré, le sujet prend de la distance.
- Mais lorsque la distance devient trop grande, il se sent rapidement à l'écart.
- L'expérience est donc marquée par une recherche continue d'ajustement entre proximité et distance.

Dimensions existentielles :

- Dans le *rapport au temps*, l'appartenance semble devoir être constamment réajustée. Le lien n'est pas stabilisé une fois pour toutes : il se resserre, devient trop proche, appelle une distance, puis cette distance peut elle-même devenir trop grande.
- Dans le *rapport à l'espace*, l'appartenance est éprouvée comme une question de place et de distance. Le sujet cherche à savoir où est sa place dans le groupe, tout en gardant une marge d'indépendance. Lorsque le lien devient trop serré, il prend de la distance ; lorsqu'il s'éloigne trop, il se sent à l'écart.
- Dans le *rapport au corps*, aucune expérience corporelle directe n'est décrite. Mais les expressions « trop serré » et « à l'écart » indiquent une manière spatiale et sensible d'éprouver la proximité ou l'éloignement relationnel.
- Dans le *rapport à l'autre*, la proximité est recherchée, mais elle doit rester régulée. Autrui est nécessaire pour se sentir inclus, mais il peut aussi devenir trop présent lorsque le lien menace l'indépendance.
- Dans le *rapport à soi*, le sujet cherche à maintenir une identité distincte au sein du lien. Il veut appartenir sans se perdre dans le groupe, et rester autonome sans se retrouver isolé.
- Dans le *rapport au monde*, l'inscription dans les groupes est importante, mais elle doit rester ajustable. Le monde social est habitable lorsqu'il permet à la fois une place partagée et une marge d'autonomie.

Ce que cela permet :

- Cette organisation permet de participer au monde commun sans renoncer à son indépendance.
- L'appartenance permet de se sentir inclus et situé.
- La distance permet de préserver une autonomie subjective.
- La recherche d'un juste milieu permet de rendre le lien plus habitable.

Ce que cela limite :

- Cette organisation peut rendre les appartenances instables ou difficiles à stabiliser.
- Elle peut produire une oscillation entre rapprochement et éloignement.
- Elle peut rendre le lien partiellement précaire, toujours à réajuster.
- Elle peut aussi fragiliser le sentiment de place, puisque le sujet se sent menacé à la fois par un lien trop serré et par une distance trop grande.

Formulation possible :

Le vécu du sujet est traversé par une tension entre appartenance et autonomie. Faire partie d'un groupe, se sentir inclus et savoir où est sa place soutiennent son inscription dans le monde commun. Mais lorsque le lien devient trop serré, il menace son indépendance et appelle une prise de distance ; inversement, lorsque l'éloignement devient trop important, le sujet se sent rapidement à l'écart.

Cette polarité traverse le rapport au temps, où le lien doit être sans cesse réajusté ; le rapport à l'espace, où la place dans le groupe et la distance relationnelle doivent rester équilibrées ; le rapport au corps, où la proximité et l'éloignement sont éprouvés comme des variations de distance ; le rapport à l'autre, marqué par une proximité recherchée mais régulée ; le rapport à soi, où l'autonomie doit être préservée dans l'appartenance ; et le

rapport au monde, où l'inscription sociale reste nécessaire mais doit demeurer ajustable.

À éviter : « Le sujet est dépendant des autres mais a peur de perdre son indépendance. »

- Cette formulation psychologise immédiatement la tension.
- Elle réduit une modalité d'existence à des traits internes : dépendance et peur.
- Elle fait disparaître la polarité appartenance / autonomie.
- Elle ne décrit pas la manière dont le lien est vécu, régulé et rendu habitable.
- Elle ne rend pas compte de la fonction de l'ajustement : permettre au sujet d'appartenir sans se perdre, et de rester autonome sans se retrouver à l'écart.

Intensité / Neutralisation

« Il m'arrive d'être très touché par certaines situations : je m'enthousiasme, je ressens les choses fortement. Mais cela ne dure jamais longtemps. Très vite, je reviens à quelque chose de plus plat, comme si je mettais à distance ce que j'ai ressenti. Je passe alors à autre chose, sans que cela laisse vraiment de trace. »

Premiers indices phénoménologiques :

- Le sujet décrit des moments où il est fortement touché par certaines situations.
- L'enthousiasme et l'intensité affective sont explicitement présents dans le matériau.
- Cette intensité ne se maintient pas dans la durée : « cela ne dure jamais longtemps ».
- Le sujet revient rapidement à « quelque chose de plus plat ».
- Ce retour à une tonalité plus neutre est décrit comme une mise à distance de ce qui a été ressenti.
- Le passage à autre chose empêche l'expérience de laisser une trace durable.

Dimensions existentielles :

- Dans le *rapport au temps*, l'intensité apparaît de manière ponctuelle, puis retombe rapidement. L'expérience ne s'inscrit pas durablement : elle émerge, se neutralise, puis laisse peu de trace.
- Dans le *rapport à l'espace*, les situations touchent d'abord le sujet comme des lieux d'intensité possible. Mais cette intensité ne se maintient pas : l'expérience est rapidement mise à distance, comme si le sujet se déplaçait hors de ce qui l'avait affecté. L'espace vécu passe ainsi d'une proximité affective à une distance neutralisée.
- Dans le *rapport au corps*, l'enthousiasme et le fait de ressentir fortement indiquent une activation affective. Mais cette activation est suivie d'un retour à une tonalité plus plate, comme si le corps et l'affect se retiraient rapidement de l'expérience.
- Dans le *rapport à l'autre*, aucune relation n'est explicitement mentionnée. Toutefois, les situations qui touchent le sujet peuvent impliquer autrui, et la mise à distance peut limiter la résonance relationnelle lorsqu'une expérience partagée devient trop intense.
- Dans le *rapport à soi*, le sujet ne se décrit pas comme dépourvu d'émotions. Il se reconnaît au contraire capable d'être touché, mais cette intensité semble difficile à maintenir et à intégrer dans une continuité personnelle.
- Dans le *rapport au monde*, certaines situations apparaissent d'abord comme fortement mobilisatrices. Mais leur portée s'atténue rapidement, et le monde retrouve une tonalité plus plate, moins résonante.

Ce que cela permet :

- Cette organisation permet de ne pas rester pris dans une intensité affective trop durable.
- Le retour à une tonalité plus plate peut préserver une forme de stabilité.
- La mise à distance permet de passer à autre chose sans être trop longtemps affecté.
- La neutralisation fonctionne ainsi comme une manière de limiter le débordement ou l'envahissement affectif.

Ce que cela limite :

- Cette organisation limite la possibilité d'habiter pleinement les situations qui touchent le sujet.
- Elle réduit l'inscription durable des expériences dans le temps.
- Elle peut empêcher certaines situations de prendre une valeur personnelle ou relationnelle plus profonde.
- Elle peut aussi appauvrir la continuité du vécu, puisque ce qui touche fortement ne laisse pas vraiment de trace.

Formulation possible :

Le vécu du sujet est traversé par une tension entre intensité et neutralisation. Certaines situations le touchent fortement, suscitent de l'enthousiasme et une résonance affective réelle. Mais cette intensité retombe rapidement, laissant place à une tonalité plus plate et à

une mise à distance de ce qui a été ressenti.

Cette polarité traverse le rapport au temps, où l'expérience intense ne s'inscrit pas durablement ; le rapport à l'espace, où la proximité affective avec la situation est rapidement suivie d'une mise à distance ; le rapport au corps, où l'activation affective est suivie d'un retrait ; le rapport à l'autre, lorsque la résonance relationnelle peut être limitée par la mise à distance ; le rapport à soi, où l'intensité est vécue sans toujours être intégrée ; et le rapport au monde, où les situations touchent le sujet sans laisser de trace durable.

À éviter : « Le sujet ressent peu d'émotions. »

- Cette formulation est inexacte et plate.
- Elle efface l'intensité pourtant explicitement présente dans le matériau.
- Elle transforme une dynamique temporelle en caractéristique figée.
- Elle ne décrit pas la polarité intensité / neutralisation, ni la manière dont le sujet passe rapidement d'un vécu fortement ressenti à une mise à distance.
- Elle ne rend pas compte de la fonction de la neutralisation : limiter la durée et l'impact d'une intensité affective potentiellement envahissante.

3.5. Le cas de Louise

À partir de la synthèse clinique du cas de Louise, on peut maintenant identifier les tensions structurantes qui organisent sa manière de se maintenir dans l'existence.

Pour mémoire :

- ces tensions ne décrivent ni des traits psychologiques, ni des conflits intrapsychiques, ni des intentions conscientes.
- > elles correspondent à des modalités d'organisation de l'existence, à la fois comme ressources de maintien et comme limitations du champ des possibles.

Dans le cas de Louise, deux tensions peuvent être formulées.

Tension 1 : Engagement / Retrait

La première tension structurante s'organise autour d'une polarité entre l'engagement et le retrait.

D'un côté, l'engagement dans le monde demeure possible :

- Louise recherche un emploi, consulte des offres, envoie des CV, maintient des liens familiaux et ne se coupe pas radicalement de son environnement.
- Le monde n'est pas rejeté.
- Il n'est pas vécu comme hostile ou impossible à habiter.

De l'autre côté, cet engagement reste peu soutenu :

- il ne se transforme pas encore en orientation durable, en choix assumé ou en inscription dans une nouvelle trajectoire.
- > les situations qui exigeraient une prise de position plus claire — comme un choix professionnel, le départ du domicile parental, l'investissement d'un espace propre, la relance de liens sociaux — ne trouvent pas encore de prise suffisante dans l'expérience actuelle.

Cette tension traverse plusieurs dimensions du vécu :

- rapport au temps : l'avenir est présent sous forme d'attente, mais sans projection claire ;
- rapport à l'espace : Louise demeure dans un entre-deux peu approprié ;
- rapport au corps : le corps soutient le maintien quotidien, mais il est peu mobilisé comme vecteur d'engagement actif ;

- rapport aux autres : les liens sont maintenus, mais peu transformateurs.
- rapport à soi : l'orientation subjective reste indéterminée ;
- rapport au monde : le monde reste habitable, mais faiblement mobilisateur ;

Cette organisation (dynamique) de son existence permet à Louise :

- de maintenir un lien minimal avec le monde
- sans rupture
- sans isolement radical
- et sans effondrement manifeste

Le retrait n'est donc pas une disparition du monde : il constitue une manière de limiter l'exposition à des engagements qui ne sont pas encore subjectivement appropriables.

Cette tension limite cependant la possibilité d'une évolution engagement transformateur, pour l'instant du moins.

L'existence reste au seuil de l'action : elle se maintient, mais peine à s'inscrire dans une trajectoire orientée.

Formulation possible :

L'expérience de Louise est traversée par une tension entre la possibilité de rester engagée dans le monde et un mouvement de retrait lorsque cet engagement devrait se transformer en choix durable.

Cette polarité se manifeste dans un monde habitable mais peu mobilisateur, un avenir indéterminé, un espace d'entre-deux, un corps peu engagé, des liens maintenus mais peu transformateurs et un rapport à soi insuffisamment orienté.

À éviter : « Louise est démotivée et se replie sur elle-même. »

- cette formulation est trop psychologique et trop déficitaire.
- elle transforme une dynamique existentielle en trait personnel.
- elle fait disparaître le fait que Louise reste engagée minimalement dans le monde : elle cherche tout de même un emploi, envoie des CV, maintient des relations familiales et poursuit des activités ordinaires.
- elle ne décrit pas non plus la fonction du retrait : celui-ci n'est pas une rupture avec le monde, mais une manière de rester à distance d'engagements qui ne sont pas encore subjectivement appropriables.

Tension 2 : Continuité / Transformation

Une seconde tension structurante peut être formulée entre continuité et transformation.

L'expérience de Louise présente une continuité suffisante pour assurer le maintien du quotidien :

- il n'y a pas de désorganisation manifeste
- pas d'effondrement aigu
- pas de rupture radicale des liens ni du rapport au monde.
- > Les routines quotidiennes, les repas avec les parents, les démarches de recherche d'emploi et les activités ordinaires assurent une stabilité minimale.

Mais cette continuité ne s'ouvre pas encore vers une véritable transformation :

- le passage entre l'ancien monde étudiant et une nouvelle configuration adulte, professionnelle ou autonome reste différé.

= Louise continue, mais sans que cette continuité devienne une trajectoire nouvelle.

Cette tension traverse plusieurs dimensions du vécu :

- rapport au temps : présent prolongé, attente indéterminée, avenir peu configuré
- rapport à l'espace : maintien dans le domicile parental, sans appropriation d'un espace propre
- rapport au corps : corps peu mobilisé, soutenant le quotidien davantage qu'un engagement actif
- rapport à soi : continuité minimale de soi, mais orientation subjective indéterminée
- rapport aux autres : les liens sont maintenus, mais ils soutiennent surtout la continuité du quotidien sans ouvrir clairement vers une nouvelle trajectoire
- rapport au monde : monde stable mais peu porteur de transformation.

Ce que cette tension permet : **préserve une cohérence de l'expérience, sans crise ni rupture**

= La continuité fonctionne donc comme une ressource :

- elle évite l'effondrement
- conserve des repères
- et soutient une forme minimale de stabilité.

Limitation existentielle : **peu de possibilités de transformation**

= Le maintien du quotidien ne devient pas encore un passage vers autre chose.

Formulation possible :

L'expérience de Louise s'organise autour d'une tension entre continuité et transformation. La continuité du quotidien permet de préserver une stabilité minimale, mais elle ne s'ouvre pas encore vers une nouvelle trajectoire existentielle.

Cette polarité traverse le rapport au temps, marqué par un présent prolongé ; le rapport à l'espace, marqué par le maintien dans un entre-deux résidentiel ; le rapport au corps, peu mobilisé comme vecteur d'engagement ; le rapport à soi, marqué par une orientation indéterminée ; le rapport aux autres, où les liens restent présents mais peu transformateurs ; et le rapport au monde, qui demeure stable mais faiblement porteur de transformation.

À éviter : **« Louise est bloquée dans sa vie et n'arrive pas à devenir adulte. »**

- Cette formulation est trop normative et trop interprétative.
 - Elle introduit un jugement développemental qui dépasse le matériau clinique disponible : elle transforme une difficulté de transformation en échec personnel ou en incapacité.
 - Elle ne rend pas compte de la fonction de la continuité quotidienne : Louise ne s'effondre pas, elle conserve des repères, des routines, des liens et des démarches.
- > Le problème n'est donc pas une absence totale de fonctionnement, mais une difficulté à faire de cette continuité minimale le support d'une transformation existentielle.

Articulation des deux tensions

Ces deux tensions ne doivent pas être comprises comme deux mécanismes séparés. Elles se répondent.

La tension entre engagement et retrait décrit la manière dont Louise reste en lien avec le monde sans parvenir encore à s'y engager pleinement

La tension entre continuité et transformation décrit la manière dont cette présence se maintient dans le temps

Autrement dit

- la première tension concerne surtout le mode d'engagement dans le monde,
- tandis que la seconde concerne le devenir de cette existence dans le temps.

Ensemble, elles permettent de comprendre une existence qui ne s'effondre pas, mais qui demeure en latence : Louise tient dans le quotidien, sans parvenir encore à transformer cette continuité en nouvelle trajectoire

Elles constituent un niveau intermédiaire entre :

- l'organisation descriptive du vécu
- et la formulation de la structure de vécu
- > qui fera l'objet de l'étape suivante.

4. La structure de vécu

La quatrième étape consiste à formuler une structure de vécu.

La structure de vécu correspond à une compréhension clinique synthétique du mode d'exister du sujet, tel qu'il apparaît dans le matériau étudié.

Elle ne désigne pas une réalité cachée derrière les manifestations cliniques.

Elle ne constitue pas non plus un diagnostic.

Elle vise à rendre intelligible la cohérence interne du vécu.

Elle répond à la question : *Comment l'expérience du sujet s'organise-t-elle, à travers les différentes dimensions du vécu et les tensions qui les traversent ?*

La structure de vécu n'est pas une "entité" ni un "diagnostic", mais une formulation clinique de cohérence.

La structure de vécu prend généralement la forme de quelques phrases synthétiques, suivies de quelques lignes d'appui.

Elle doit.

- rester strictement ancrée dans le matériau clinique
- articuler plusieurs dimensions du vécu : temps, espace, corps, autres, soi, monde
- intégrer les tensions structurantes repérées à l'étape précédente
- rendre compte d'une cohérence interne
- montrer ce que cette organisation permet au sujet
- indiquer ce qu'elle limite dans son champ de possibilités
- éviter toute réduction diagnostique ou explicative prématurée

La structure de vécu n'est donc pas une étiquette. Elle ne doit pas dire simplement : « le sujet est anxieux », « le sujet est dépressif », « le sujet évite », « le sujet manque de motivation ».

> Elle doit décrire

- une *manière d'habiter le monde*
- une manière de se maintenir dans l'existence et de composer avec certaines tensions.

Travail de synthèse

Pour y parvenir, on peut s'appuyer sur les questions suivantes :

- Quelles dimensions du vécu sont les plus centrales dans le cas étudié ?
- Quelles tensions structurantes traversent plusieurs dimensions ?
- Que permet cette organisation au sujet ?
- Que limite-t-elle dans son existence ?
- Quelle tonalité globale se dégage du rapport au monde ?
- Comment le sujet se maintient-il dans son existence ?
- Quel est le coût existentiel de ce maintien

Il faut donc trouver un équilibre entre deux exigences :

- rester au plus près du matériau
- dégager une organisation d'ensemble.

> et donc problématiser au bon niveau

Sachant qu'une bonne problématique existentielle exprime une tension, et non seulement un thème

> Vous avez un petit tableau avec trois niveaux de formulation, dont seulement le dernier correspond à une problématique existentielle

Niveau de formulation	Exemple	Limite
Problématique faible	« Comment comprendre les troubles anxieux de X ? »	Entrée diagnostique trop rapide
Problématique moyenne	« Comment la peur impacte-t-elle la vie de X ? »	Thème psychologique général
Problématique existentielle	« Comment X tente-t-il de maintenir une continuité de soi face à un devenir vécu comme menaçant ? »	Formulation dynamique et structurante

Une structure de vécu doit donc être à la fois descriptive, synthétique et problématisée.

Vous trouverez ensuite une petite liste d'erreurs à éviter, déjà plus ou moins indiquées précédemment :

Erreurs fréquentes à éviter :

- entrer immédiatement par le diagnostic
- utiliser un jargon théorique sans appui textuel
- confondre récit biographique et description du vécu
- juxtaposer les dimensions du vécu sans les articuler
- rester au niveau descriptif sans dégager de tension
- multiplier les tensions sans les hiérarchiser
- omettre les dimensions corporelle, temporelle ou spatiale
- formuler un thème général plutôt qu'une problématique structurante
- transformer une tension existentielle en trait de personnalité
- conclure à une cause psychologique sans l'avoir méthodologiquement établie.

Le cas de Louise

Dans le cas de Louise, les étapes précédentes ont permis :

- de décrire les dimensions de l'existence
- de repérer deux tensions principales :
 - engagement / retrait ;
 - continuité / transformation.

> qui permettent maintenant de formuler une structure de vécu.

L'expérience de Louise s'organise autour d'une existence maintenue en latence. Cette existence conserve une continuité suffisante pour éviter l'effondrement ou la désorganisation, mais elle demeure insuffisamment orientée pour soutenir une transformation. Le monde reste habitable, mais il n'offre plus de prises suffisamment fortes pour engager Louise dans une trajectoire nouvelle.

Cette structure ne relève pas d'une fermeture défensive massive, ni d'un retrait radical du monde. Elle correspond plutôt à une modalité de maintien : la mise en retrait partielle permet

à Louise de préserver une stabilité minimale, mais au prix d'un appauvrissement de l'ouverture au possible.

L'engagement n'est donc pas impossible. Il demeure fragile et difficile à soutenir dans la durée. Les situations qui impliqueraient un choix structurant — entrer dans un projet professionnel, quitter le domicile parental, investir un espace propre, redéfinir une position adulte — ne trouvent pas encore actuellement de prise suffisante.

Ainsi, l'existence de Louise ne se déploie ni dans la crise, ni dans le conflit manifeste, ni dans la désorganisation. Elle se maintient dans une stabilité sans élan, où l'attente remplace la décision, et où la continuité du présent ne s'ouvre pas encore vers une transformation appropriée.

Portée clinique de la formulation : éviter certaines conclusions potentiellement fausses

Si l'on s'en tient aux manifestations apparentes — lever tardif, journées peu différenciées, activités peu investies, absence de projet clair —

> on pourrait être tenté de conclure immédiatement à une dépression, à un manque de motivation ou à une conduite d'évitement.

> Ce qui apparaît chez Louise n'est pas seulement qu'elle « ne fait rien » ou qu'elle « manque d'énergie ».

Elle fait encore certaines choses : elle cherche un emploi, envoie des CV, maintient des liens familiaux.

> Mais ces actions ne s'inscrivent pas dans une orientation vécue comme suffisamment porteuse.

De même, il ne s'agit pas simplement de dire qu'elle « évite » l'autonomie ou qu'elle « refuse » d'avancer.

> Le matériau suggère plutôt que le passage vers une nouvelle configuration d'existence ne trouve pas encore de prises suffisamment signifiantes pour soutenir un engagement transformateur.

La structure de vécu permet donc de déplacer la compréhension clinique :

Formulation à éviter	Reformulation phénoménologique
« Louise manque de motivation »	« Le monde lui apparaît faiblement mobilisateur »
« Louise évite de devenir adulte »	« Louise ne trouve pas encore comment s'engager dans une nouvelle étape de son existence »
« Louise ne fait rien »	« Louise continue certaines démarches, mais sans direction suffisamment claire pour elle »

Cette compréhension ouvre aussi des pistes pour l'accompagnement

> explorer les conditions d'une relance existentielle :

Il ne s'agirait pas de prescrire des activités, de demander à Louise de « se motiver » ou de faire de la gestion (du temps ou d'autre chose).

L'accompagnement pourrait plutôt viser à explorer les conditions d'une relance existentielle :

- qu'est-ce qui pourrait faire sens pour Louise ?
- quelles formes d'engagement pourraient être progressivement appropriées ?
- quels appuis pourraient l'aider à passer d'un monde structuré de l'extérieur à un monde habité de manière plus personnelle ?
- comment soutenir une transition sans la précipiter ?

- comment reconnaître la suspension actuelle sans la figer ?

L'enjeu n'est donc pas de traiter la situation comme un simple problème à résoudre rapidement :

Il s'agit de comprendre une transition existentielle : Louise est sortie d'un monde structuré par les études, sans être encore entrée dans une nouvelle forme d'existence suffisamment investie.

Cette élaboration ne peut être entièrement prescrite de l'extérieur. Elle suppose un temps, un espace et une reconnaissance de la suspension actuelle comme moment existentiel à part entière.

5. Résumé de la méthode d'analyse phénoménologique

L'analyse phénoménologique d'un cas clinique vise à comprendre comment une existence se tient, à partir de la manière dont elle est vécue. Elle repose sur quatre étapes successives, qui doivent rester distinctes.

1. Décrire le vécu (repérage phénoménologique)

Question directrice : *Comment cette personne vit-elle ce qu'elle vit ?*

On relève uniquement :

- les formulations subjectives
- les affects, perceptions, images
- les rythmes, bascules, répétitions
- les indices cliniques temporels, spatiaux, corporels
 - > Sans interpréter, sans diagnostiquer, sans expliquer

2. Organiser selon les dimensions de l'existence (existenciaux), selon les dimensions suivantes :

- Corps (corporéité)
- Temps (temporalité)
- Espace (spatialité)
- Soi (ipséité)
- Autre (altérité)
- Monde (mondanéité)

> Objectif : donner une lisibilité structurée au vécu, sans réduire ni découper artificiellement

3. Dégager les tensions structurantes

Une tension structurante est : une polarité dynamique, transversale (présente dans plusieurs dimensions) qui exprime à la fois :

- ce que cette organisation permet
- et ce qu'elle limite

4. Formuler la structure de vécu, de manière synthétique, qui rend compte :

- de la cohérence du vécu
- de sa logique existentielle
- de la manière dont le sujet se maintient dans l'existence
 - en articulant plusieurs dimensions (sans diagnostic, sans causalité, sans jugement)

Principe directeur : on ne cherche pas ce que le sujet a, mais comment il existe.

II. Exemples (corpus d'observations et d'analyses)

Le travail phénoménologique s'appuie d'abord sur des observations cliniques : vignettes, extraits d'entretien, récits de situations ou descriptions de moments cliniques.

D'autres supports sont également être utilisés pour s'entraîner à l'époche et à la description du vécu, sans passer trop vite par une lecture psychologique ou diagnostique. L'objectif restera le même :

- repérer comment une expérience vécue se donne,
- comment elle s'organise
- puis quelles tensions structurantes peuvent être formulées.

1. Observations cliniques

La première série d'observations propose plusieurs variations autour de formes d'instabilité du lien et de la distance relationnelle.

1.1. Observation 1

« Quand je rencontre quelqu'un, je m'attache très vite, j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui me comprend. Mais au bout de quelques jours, je deviens nerveux, je me demande si je n'en fais pas trop. J'ai peur d'être trop présent. Alors je me retiens, j'envoie moins de messages. Puis quand l'autre s'éloigne, je panique. Je ne sais jamais comment doser. »

Étape 1 : repérage du vécu

Le vécu exprimé est marqué par :

- un attachement très rapide : « très vite », « enfin trouvé quelqu'un » ;
- une montée rapide de tension et de nervosité ;
- une inquiétude liée à la présence : « peur d'être trop présent » ;
- des mouvements de retenue : « je me retiens », « j'envoie moins de messages » ;
- une panique lorsque l'autre s'éloigne ;
- un sentiment d'incertitude : « je ne sais jamais comment doser ».

Le récit décrit une alternance récurrente : *rapprochement* → *retenue* → *panique*.

Étape 2 : organisation selon les dimensions du vécu

Temporalité

La temporalité est accélérée. Le récit est marqué par des bascules rapides :

- attachement immédiat
- montée de nervosité : « au bout de quelques jours » nous dit-on
- mouvement de retenue
- puis la panique lorsque l'autre s'éloigne.

Le temps relationnel ne semble pas se déployer progressivement. Il prend plutôt la forme d'une succession rapide de phases, avec peu de transitions intermédiaires.

Spatialité

La spatialité apparaît ici sous la forme d'un espace relationnel. Le sujet cherche d'abord la proximité, mais cette proximité devient rapidement problématique : il craint d'être « trop présent ».

Le mouvement de retenue vise alors à rétablir une distance. Mais lorsque l'autre s'éloigne, cette distance devient à son tour insécurisante.

> L'espace relationnel semble donc difficile à régler :

- trop proche, le sujet craint d'envahir
- trop loin, il panique.

Corporéité

Le corps apparaît à travers des indices de *tension* et de *débordement* : « je deviens nerveux », « je panique ». Le vécu relationnel s'accompagne donc d'une activation corporelle rapide.

On observe également un effort de retenue : « je me retiens », « j'envoie moins de messages ». Le corps et l'expression semblent alors contenus, comme si le sujet devait limiter sa présence pour ne pas devenir « trop » présent pour l'autre.

On peut donc décrire une alternance corporelle entre :

- une tension relationnelle
- un effort de retenue
- et un débordement anxieux.

Le texte ne permet pas encore de conclure à une organisation corporelle générale, mais il montre que la relation engage fortement le corps comme ce lieu d'alerte, de retenue et de panique.

Ipséité

Le rapport à soi est marqué par une incertitude sur la juste manière d'être en relation : « je ne sais jamais comment doser » dit-il.

Le sujet doute de sa propre présence auprès de l'autre. Il ne sait pas

- s'il en fait trop
- s'il doit se retenir
- s'il doit être plus présent ou moins présent.

L'ipséité apparaît donc fragilisée dans le registre relationnel : le sujet peine à se faire confiance dans sa manière d'occuper une place auprès de l'autre.

Altérité

L'autre apparaît d'abord comme une figure fortement investie : le sujet a l'impression d'avoir « enfin trouvé quelqu'un » qui le comprend. La relation est donc vécue comme immédiatement porteuse.

Mais cette intensité devient rapidement instable. L'autre est à la fois

- recherché comme appui
- et redouté comme pouvant être envahi ou s'éloigner.

Le lien se structure ainsi autour d'une alternance entre

- rapprochement
- retenue
- et panique face à l'éloignement

Mondanité

Le monde vécu apparaît fortement polarisé par la relation :

- Lorsque le lien se noue, le monde semble devenir porteur : le sujet a l'impression d'avoir « enfin trouvé quelqu'un » qui le comprend.
- Mais lorsque la distance apparaît, le monde relationnel devient instable et inquiétant.

Le monde n'est donc pas décrit comme globalement hostile ou vide. Il apparaît plutôt dépendant de la stabilité du lien :

- il devient rassurant lorsque la proximité est possible,
- puis insécurisant lorsque l'éloignement se manifeste.

Étape 3 : tension structurante centrale

Ces différents axes convergent vers une même difficulté : soutenir une distance relationnelle stable.

Le problème n'est pas seulement l'intensité de l'attachement :

- il concerne la difficulté à trouver une juste mesure entre présence et distance.
- la proximité est recherchée, mais elle devient rapidement inquiétante lorsqu'elle risque d'être « trop » présente.
- la distance, qui devait protéger le lien, devient à son tour insécurisante lorsque l'autre s'éloigne.

La tension centrale se situe donc entre proximité et éloignement :

Elle articule :

- un désir intense de proximité ;
- une inquiétude d'être trop présent pour l'autre ;
- un mouvement de retenue ;
- une panique lorsque l'autre s'éloigne. On s'autorise une interprétation, la seule, en parlant d'« angoisse d'abandon » > il y a bien le terme "panique" qui est une forme d'angoisse

Cette tension traverse :

- le rapport à l'autre : attachement rapide, inquiétude, panique face à l'éloignement ;
- le rapport à l'espace : difficulté à régler la distance relationnelle ;
- le rapport au temps : enchaînement rapide des phases ;
- le rapport à soi : incertitude sur la juste manière d'être présent.

Étape 4 : structure de vécu

On peut formuler la structure de vécu de la manière suivante :

Formulation possible :

« L'existence relationnelle s'organise autour d'une difficulté à soutenir une modalité stable de distance : la proximité est d'abord recherchée de manière intense, puis se transforme

rapidement en vécu de menace lorsque le sujet craint d'être « trop » présent. L'éloignement qui s'ensuit est alors éprouvé comme insécurisant, relançant un mouvement de rapprochement. La relation prend ainsi la forme d'une oscillation rapide entre exposition et retrait, sans possibilité d'installation intermédiaire durable. »

« Mauvaise réponse typique » :

« Cette vignette montre que le patient a un trouble de l'attachement. On observe une dépendance affective importante, avec une peur de l'abandon et une anxiété relationnelle. Il a du mal à gérer ses émotions et passe rapidement de l'idéalisation à la dévalorisation de l'autre. On peut penser à un fonctionnement borderline, avec une instabilité relationnelle marquée. Le patient n'arrive pas à se contrôler et adopte des comportements excessifs comme : envoyer trop de messages, puis se retirer. Un travail thérapeutique serait nécessaire pour l'aider à mieux gérer ses relations. »

- Entrée immédiate par le diagnostic : « trouble de l'attachement », « borderline »
- > aucune description préalable.

La description du vécu est insuffisante, voire quasi absente :

- rien n'est repris dans les paroles du sujet.
- aucune attention n'est portée au "comment" (rythme, bascule, vécu de la distance).

Il y a une confusion entre le thème et la structure :

- le thème est nommé : c'est « dépendance affective »
- mais aucune tension structurante n'est formulée.

Et on oublie des dimensions essentielles :

- le temps (rapidité, bascule) est à peine évoqué.
- l'espace relationnel (trop proche / trop loin) n'est pas pensé comme tel.

Conclusion thérapeutique plaquée :

- « Un travail thérapeutique serait nécessaire »
- banalité qui ne découle pas d'une compréhension structurée.

= Il s'agit :

- d'un commentaire sur le comportement
- au lieu d'une description l'expérience vécue
- < qui permettrait d'en dégager une tension structurante.

> Nommer une catégorie ne remplace pas une analyse.

Et en phénoménologie clinique, on ne cherche pas d'abord ce que c'est, mais comment c'est vécu

1.2. Observation 2

Il dit qu'il a « explosé » hier soir avec sa partenaire, pour un détail ridicule. Après la dispute, il a senti une montée de vide, comme si tout se dégonflait d'un coup. Il dit : « *je ne sais plus si c'était important ou pas, tout s'est mélangé* ». Le lendemain, il a appelé plusieurs fois pour essayer de réparer, puis il a coupé le téléphone d'un coup parce qu'il n'en pouvait plus d'attendre une réponse.

1. Repérage du vécu

Le vécu exprimé est marqué par :

- une réaction émotionnelle intense et soudaine (« explosé ») ;
- une perte rapide de repères sur l'importance de la situation (« détail ridicule », « je ne sais plus si c'était important ») ;
- un vide brutal (« comme si tout se dégonflait d'un coup ») ;
- une confusion du sens (« tout s'est mélangé ») ;
- une alternance entre recherche de contact (appels répétés) et rupture nette (couper le téléphone).

Le récit est organisé autour d'une succession rapide de phases émotionnelles et relationnelles contrastées.

2. Organisation selon les dimensions du vécu

Altérité

Relation marquée par une forte réactivité émotionnelle

Mouvement immédiat de réparation après le conflit

Intolérance à l'attente et rupture brutale du lien

Ipsité

Continuité du ressenti et du jugement difficile à maintenir

Fragilité du sentiment de cohérence après l'intensité émotionnelle

Passage rapide de la colère à un vide désorganisant

A noter que la formulation "*fragilité du sentiment de cohérence*" est "limite", déjà sensiblement interprétative.

> on pourrait rester plus proche du phénomène et dire par exemple : "*difficulté à maintenir une continuité du ressenti et du jugement après l'intensité émotionnelle*", mais c'est un peu plus ampoulé.

Temporalité

C'est sans doute la dimension la plus importante :

Temporalité précipitée et discontinue

Bascule brutale du sens ("*je ne sais plus si c'était important*")

Succession rapide : explosion → vide → tentative de réparation → coupure

Difficulté à tolérer la durée de l'attente

Spatialité

Espace relationnel vécu sur un mode extrême :

- proximité "intrusive" (appels répétés)

"intrusif" est peut-être déjà trop interprétatif

- puis coupure radicale (couper le téléphone)

Absence d'espace intermédiaire permettant une stabilisation de la relation

Mondanité

Le monde apparaît comme dépendant des variations affectives immédiates :

- il devient intense et saturé lors de la montée émotionnelle, puis se vide rapidement de sa signification après l'explosion.
- entre ces deux pôles, il ne se stabilise pas : l'attente devient insoutenable et le monde perd sa consistance.

3. Tension structurante centrale

Tension centrale : *intensité / effondrement*

- Intensité émotionnelle très élevée (« explosé »)
- Effondrement rapide en vide et confusion
- Tentative de réparation suivie d'une rupture pour échapper à l'attente

Cette tension traverse :

- le rapport à l'autre (explosion / réparation / coupure)
- le rapport au temps (immédiateté / intolérance à la durée)
- le rapport à l'espace (intrusion / coupure radicale)

4. Structure de vécu (formulation synthétique)

« L'existence relationnelle se structure autour d'une oscillation marquée dans l'intensité du vécu : les moments de contact prennent rapidement une forme envahissante, puis basculent vers un sentiment de vide et de désorientation. »

L'attente qui s'installe entre ces phases apparaît comme difficilement soutenable, relançant des mouvements urgents de rapprochement qui deviennent à leur tour éprouvants dès qu'ils se prolongent.

La relation se déploie ainsi sans espace intermédiaire stabilisable, ne permettant pas l'inscription d'une continuité relationnelle durable. »

« Mauvaise réponse typique »

« Cette vignette montre un patient impulsif avec des difficultés de gestion de la colère. Il explose pour un détail ridicule, puis il devient vide, ce qui montre une instabilité émotionnelle. On peut penser à un trouble borderline avec une peur de l'abandon et des comportements excessifs comme appeler plusieurs fois puis couper le téléphone. Le patient ne sait pas gérer ses émotions et agit de manière excessive dans la relation. Une prise en charge psychothérapeutique serait nécessaire pour travailler la régulation émotionnelle. »

- diagnostic immédiat : « trouble borderline », « impulsif »
- confusion entre comportement et vécu : le comportement est jugé (« excessif »), mais le vécu n'est pas décrit
- absence d'analyse temporelle : rien sur la bascule rapide, l'intolérance à l'attente, la discontinuité
- absence de lecture spatiale : appels répétés / coupure = non pensés comme régulation de la distance.
- conclusion thérapeutique banale « travailler la régulation émotionnelle » sans lien avec une structure de vécu

→ Ce n'est pas parce qu'un comportement est intense qu'il est "impulsif" ;

> il faut d'abord comprendre :

- comment l'intensité est vécue
- et ce qu'elle fait à la continuité de l'existence.

5. Comparaison observations 1 et 2

Ces deux vignettes peuvent sembler proches en surface (instabilité relationnelle)

- mais elles ne relèvent pas du même mode d'être-au-monde
- c'est précisément ce que la démarche phénoménologique permet de montrer

N.B. On pourrait dire que les termes d'*intrusion relationnelle* dans la spatialité de l'observation 2 est un peu trop interprétatif, et se contenter de "*rapprochement incessant* (avec les appels répétés)"

Malgré une apparence commune d'instabilité relationnelle, ces deux observations relèvent de structures de vécu différentes :

Observation 1 : difficulté à habiter la distance relationnelle

> le problème est : *comment être à bonne distance de l'autre ?*

Observation 2 : organisation autour de la régulation de l'intensité affective et de son après-coup

> le problème est : *comment supporter l'intensité émotionnelle ?*

> On peut donc distinguer ces formes d'existence au-delà des comportements similaires.

> Deux patients peuvent :

- envoyer beaucoup de messages
- paniquer dans la relation
- couper le lien

> mais pour des raisons phénoménologiques différentes :

Comportement	structure 1	structure 2
appels répétés	peur de perdre la relation	tentative de réparer après explosion
retrait	peur d'envahir	fuite de l'intensité
rupture	panique d'abandon	arrêt de la tension

C'est exactement ce que la phénoménologie cherche à révéler.

1.3. Observation 3

« Depuis quelques semaines, je me lève chaque matin avec une sensation d'être en retard sur quelque chose, mais je ne sais pas quoi. [...] Je regarde mon téléphone, j'ai l'impression que les messages ne veulent rien dire, ou qu'ils cachent quelque chose que je devrais comprendre. Quand je pars au travail, tout me semble trop rapide, comme si le monde avançait sans moi. Je me sens spectateur. Au bureau, je souris, je parle, mais j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment moi qui agit. Le soir, tout ralentit d'un coup et je me sens vide. »

1. Repérage du vécu

Cette présentation du matériau brut procède déjà à une petite mise en ordre, qui n'a normalement pas lieu, mais qui n'est pas non plus scandaleuse :

Affectif / tonalité :

- « sensation d'être en retard sur quelque chose » → "climat d'urgence" sans objet identifié
- « je ne sais pas quoi » → indétermination, inquiétude diffuse
- « je me sens vide » → vacuité en fin de journée

Cognitif-perceptif :

- « les messages ne veulent rien dire » → perte d'évidence du sens
- « ils cachent quelque chose » → impression qu'un sens caché devrait être compris

Rapport au monde :

- « tout me semble trop rapide »
- « le monde avançait sans moi » → décalage, désaccordage

Rapport à soi / agentivité :

- « pas vraiment moi qui agit » → désappropriation de l'action

Parler ici de "perte d'agentivité" est prématuré puisqu'il s'agit d'un concept

Position subjective :

- « je me sens spectateur » → présence distanciée

Indices narratifs de présence :

- récit structuré en séquences temporelles (matin / travail / soir)
 - usage d'images globales (« spectateur », « monde avance »)
 - sujet présent grammaticalement, mais non coïncident avec l'action
- À ce stade : aucune hypothèse diagnostique, aucune causalité.

2. Organisation selon les dimensions du vécu

Rapport au temps

- Installation progressive (« depuis quelques semaines »)
 - Urgence quotidienne sans objet
 - Accélération diurne / ralentissement brutal "vespéral"
 - Désynchronisation temporelle avec le monde ("le monde avançait sans moi")
- Temporalité instable et polarisée

Rapport au monde

- Monde trop rapide
 - Monde dont le sens devient opaque
- Altération de l'évidence et du rythme du monde

Rapport à soi

- Fragilité du sentiment d'être l'auteur de ses actes (agentivité)
- Position de spectateur
- Affaiblissement de la continuité du soi dans l'action

Rapport à l'espace

- Images de retrait (« avance sans moi », « spectateur »)
- Espaces sociaux investis sur un mode fonctionnel
- Difficulté à prendre place dans le monde social

L'espace est moins important que les trois dimensions précédentes

Rapport aux autres

- Présence sociale sans appropriation subjective
- Relation médiatisée par les rôles, non habitée

3. Tension structurante centrale

La tension entre *continuité et déliaison (ou désynchronisation)* traverse :

- le temps (bascule accélération / ralentissement)
- le sens (messages devenus opaques)
- le soi (agir sans se sentir auteur)

→ L'existence paraît difficile à maintenir comme processus continu, tant sur le plan temporel que subjectif.
(La polarité implication / distance peut être mentionnée comme modalité secondaire, mais non structurante)

4. Structure de vécu (formulation synthétique)

« Le vécu est marqué par un décalage temporel net avec le monde : la journée se déroule sur le mode de l'urgence, dans un monde éprouvé comme trop rapide, tandis que le soir s'accompagne d'un ralentissement brutal et d'un sentiment de vide.

Ce désaccordage temporel (décalage avec le rythme du monde) s'accompagne d'une altération de l'évidence du sens et d'une agentivité fragilisée : le sujet agit et interagit socialement, mais sans se reconnaître pleinement comme auteur de ses actes.

L'ensemble dessine une modalité de présence distanciée, dans laquelle la coïncidence avec le rythme du monde et la possibilité d'y prendre place ne se stabilisent pas durablement. »

> Cette vignette illustre :

- une altération progressive de la continuité existentielle
- sans rupture massive du temps ni délire interprétatif
- mais avec un désaccordage progressif entre sujet, monde et action

La désynchronisation entre le sujet et le monde a été décrite

- de manière particulièrement claire par Eugène Minkowski
- qui parle de la perte de « syntonie vitale » dans *Le Temps vécu* (1933)
- puis repris et développé par des auteurs contemporains comme Thomas Fuchs et Giovanni Stanghellini.

> c'est un des signes précoces de la schizophrénie les plus étudiés aujourd'hui

1.4. Observation 4

« Quand quelqu'un compte vraiment pour moi, j'ai l'impression que tout dépend de lui. S'il est là, je me sens vivant, sûr de moi. S'il met du temps à répondre ou s'il change de ton, tout s'effondre. Je passe très vite de "c'est la personne la plus importante de ma vie" à "je ne compte pour personne".

À ce moment-là, j'ai envie de tout casser ou de disparaître. Après, j'ai honte, et j'essaie de réparer comme je peux. Mais ça recommence. »

1. Repérage du vécu

Le vécu exprimé est marqué par :

- un sentiment d'exister fortement/entièrement soutenu par la présence de l'autre (« tout dépend de lui ») ;
 - une variation extrême du sentiment de soi selon la présence de l'autre (« je me sens vivant / tout s'effondre ») ;
 - une forte réactivité aux variations du lien relationnel (« change de ton », « met du temps à répondre ») ;
 - des bascules rapides entre idéalisation et dévalorisation (« la personne la plus importante » / « je ne compte pour personne ») ;
 - des vécus de débordement intense (« envie de tout casser ») ou d'anéantissement subjectif (« disparaître ») ;
 - une phase secondaire de honte et de tentative de réparation ;
 - un caractère répétitif et circulaire de l'expérience (« mais ça recommence »).
- > Le récit est organisé autour d'une succession de bascules affectives et identitaires rapides, déclenchées par la relation.

2. Organisation selon les dimensions du vécu

Altérité

- L'autre est investi comme support central de l'existence : il apparaît comme condition immédiate du sentiment d'exister.
- Présence de l'autre = sécurité, vitalité.
- Distance ou variation perçue > effondrement immédiat.
- Relation vécue sur un mode absolu, sans gradation

Ipséité

- Sentiment de soi fortement dépendant du regard et de la réponse de l'autre.
- Bascule rapide entre valorisation intense de soi et dévalorisation radicale.
- Continuité du sentiment d'exister fortement dépendante du lien
- Honte secondaire après les débordements
- Volonté de réparer

Temporalité

- Temporalité discontinue, en ruptures brutales
- Absence de durée intégrative entre les états affectifs
- L'instant relationnel détermine entièrement l'expérience du moment
- Le passé et l'avenir ne stabilisent pas le vécu

Spatialité

- Espace relationnel polarisé :
 - . fusion subjective lorsque l'autre est présent,
 - . chute dans un vide relationnel dès qu'une distance apparaît.

- Absence d'espace intermédiaire sécurisant.
- La distance est vécue comme un effondrement, non comme un intervalle

Mondanité

- Le monde apparaît comme entièrement polarisé par la relation centrale
- Hors de cette relation, il perd sa consistance et ne soutient plus l'existence.
- L'environnement n'offre pas d'appui autonome : il devient vide dès que le lien vacille

3. Tension structurante centrale

Tension centrale : soutien relationnel / effondrement du sentiment d'exister

- *polarité 1* : sentiment d'exister soutenu par la présence de l'autre
 - *polarité 2* : effondrement subjectif immédiat dès que le lien vacille
- > tentatives de réparation après coup, suivies de la répétition du cycle

Cette tension *traverse* :

- le rapport à l'autre (l'autre comme support vital)
- le rapport à soi (identité instable et réactive)
- le rapport au temps (bascule instantanée, sans continuité)
- le rapport à l'espace (fusion / chute dans le vide)

Ce qu'elle *permet* :

L'idée est de montrer que toute structure de vécu n'est pas seulement limitante : elle rend aussi certaines formes d'existence possibles. C'est une règle importante en phénoménologie clinique.

- une intensité relationnelle élevée : la relation est vécue comme profondément signifiante et existentiellement engageante
- une forte capacité d'investissement affectif dans le lien
- une sensibilité aiguë aux variations relationnelles, qui permet de percevoir finement les changements dans la relation
- la possibilité de vivre certains moments de proximité comme hautement vivants et sécurisants.

Ce qu'elle *entrave* :

- la continuité du sentiment d'exister indépendamment du lien
- la possibilité de maintenir une stabilité identitaire lorsque la relation se modifie
- la capacité à tolérer les variations ordinaires de distance relationnelle (retards, changements de ton, indisponibilité)
- l'inscription temporelle de la relation dans une durée stable, les états affectifs basculant rapidement d'un pôle à l'autre

4. Structure de vécu

Formulation synthétique possible :

« L'existence relationnelle s'organise autour d'un lien vécu comme central et immédiatement engageant : la présence de l'autre soutient le sentiment de continuité de l'existence, tandis que toute variation du lien est éprouvée comme une menace immédiate.

Ces variations s'accompagnent de bascules rapides du vécu, marquées par une perte de continuité du sentiment d'exister et par une intensification affective difficilement soutenable.

L'ensemble dessine une modalité relationnelle sans espace intermédiaire stabilisable, où les

transitions entre proximité et éloignement ne trouvent pas de forme durable d'inscription temporelle et identitaire. »

Cette vignette illustre :

- une instabilité profonde du sentiment de soi, dépendant de l'autre ;
- une intolérance majeure à la distance relationnelle ;
- une organisation du vécu par bascules extrêmes, sans continuité intégrative ;
- une mondanéité appauvrie, subordonnée à la relation centrale.

« Ce patient présente clairement un fonctionnement borderline avec une dépendance affective, une peur de l'abandon, une instabilité émotionnelle et des passages à l'acte. On observe une idéalisation puis une dévalorisation de l'autre, ainsi qu'une impulsivité et une mauvaise régulation émotionnelle. Une psychothérapie serait nécessaire pour travailler la stabilité émotionnelle et relationnelle. »

Pourquoi c'est une mauvaise réponse :

- Diagnostic immédiat (« borderline ») → aucune suspension phénoménologique.
- Catégories plaquées (« dépendance », « impulsivité ») → le vécu n'est pas décrit, seulement classé.
- Absence de dimensions → ni temps, ni espace, ni mondanéité.
- Confusion thème / structure → les comportements sont nommés, mais la logique existentielle est absente.
- Conclusion thérapeutique automatique → banalité, sans compréhension de la structure de vécu.
- Nommer un fonctionnement ne permet pas de comprendre comment l'existence tient, ou ne tient pas, pour le sujet.

1.5. Comparatif des observations

Les quatre observations proposent des formes proches en surface (instabilité, variations rapides, difficulté dans le lien), mais elles ne renvoient pas au même mode d'organisation du vécu.

L'enjeu de la démarche phénoménologico-existentielle est précisément de décrire ces différences sans entrer d'emblée par des catégories diagnostiques (qui seront insuffisamment fondées).

Repères comparatifs : ce qui organise principalement le vécu dans chaque observation :

- Observation 1 : difficulté à ajuster la distance relationnelle
 - tension dominante : proximité / éloignement
 - le sujet oscille entre élan de rapprochement, retenue anxieuse, puis panique face à l'éloignement.
- Observation 2 : difficulté à soutenir l'après-intensité affective
 - tension dominante : intensité / effondrement
 - l'expérience bascule rapidement d'un pic émotionnel vers un vide et une désorientation, puis vers des tentatives urgentes de réparation.
- Observation 3 : désaccordage progressif entre soi, monde et temps
 - tension dominante : continuité / déliaison
 - le sujet reste présent socialement, mais se vit comme spectateur, dans un monde devenu trop rapide et moins évident, avec une agentivité fragilisée.
- Observation 4 : dépendance existentielle au lien et effondrement du soi en cas de vacillement
 - tension dominante : dépendance / effondrement
 - la relation n'est pas seulement source de sécurité : elle soutient directement la continuité du sentiment d'exister. Sa variation déclenche une chute identitaire et une intensification débordante.

Point important :

- les comportements peuvent se ressembler, mais les structures de vécu diffèrent.
- ce n'est pas l'intensité en soi qui discrimine, mais la manière dont le lien affecte la continuité du soi, la tenue du temps, la consistance du monde et la possibilité d'une stabilité.

Principe méthodologique (rappel) :

Dans une perspective phénoménologique, on ne distingue pas d'abord des entités cliniques, mais des modes d'organisation du vécu.

> ce qui distingue ces vécus n'est pas l'intensité de l'angoisse ou de l'affect, mais ce que la relation fait à la continuité de l'existence.

Donc on évite de conclure par des étiquettes (borderline, état-limite, angoisse de séparation) et on décrit plutôt :

- la fonction du lien (que fait la relation dans l'existence ?)
- la continuité du soi (exister hors du lien ?)
- la tolérance à la distance (que produit l'éloignement ?)
- la temporalité (continuité, bascule, rupture, cycles)
- la mondanéité (le monde reste-t-il habitable sans la relation ?)

Questions simples pour différencier les observations :

- Fonction du lien : sécuriser ? réguler ? faire exister ? rendre visible ?

- Continuité du soi : stable ? fragilisée ? suspendue ? dépendante ?
- Distance : inquiétude ? tension ? désorganisation ? effondrement ? effacement ?
- Temporalité : états reliés dans le temps ? bascules ? discontinuités ? cycles rapides ?
- Monde hors lien : porteur ? appauvri ? opaque ? vide ? en attente d'un appel ?

Erreurs fréquentes à éviter (rappel) :

- Confondre intensité et structure : "c'est intense donc c'est X"
- « Psychologiser » trop vite : "peur de l'abandon", "manque de confiance" comme explication au lieu d'une description
- Rester au niveau de la conduite : appeler / couper / exploser sans comprendre ce que cela régule (temps, distance, continuité du soi)
- Oublier certaines dimensions présentes dans le texte : analyser seulement la relation, sans temps / espace / corps / monde
- Remplacer la tension par un thème : "dépendance affective" (contenu) au lieu d'une polarité dynamique (organisation)

Conclusion synthétique : les observations 1 à 4 montrent que des difficultés relationnelles comparables en apparence peuvent relever de logiques existentielles distinctes :

- réglage de la distance
 - régulation de l'après-coup
 - désaccordage de la continuité, dépendance existentielle
- > ce sont ces logiques — et non des catégories — que l'analyse phénoménologique vise à mettre au jour.

2. Textes narratifs

2.1. *Le Horla* - Guy de Maupassant (1887)

12 août, dix heures du soir. — Tout le jour j'ai voulu m'en aller ; je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile, si simple — sortir — monter dans ma voiture pour gagner Rouen — je n'ai pas pu. Pourquoi ?

13 août. — Quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique semblent brisés, toutes les énergies anéanties, tous les muscles relâchés, les os devenus mous comme la chair et la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral d'une façon étrange et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi, aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté.

Je ne peux plus vouloir ; mais quelqu'un veut pour moi ; et j'obéis.

14 août. — Je suis perdu ! Quelqu'un possède mon âme et la gouverne ! Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi, rien qu'un spectateur esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis.

Je désire sortir. Je ne peux pas. Il ne veut pas ; et je reste, éperdu, tremblant, dans le fauteuil où il me tient assis. Je désire seulement me lever, me soulever, afin de me croire maître de moi. Je ne peux pas ! Je suis rivé à mon siège, et mon siège adhère au sol, de telle sorte qu'aucune force ne nous soulèverait.

Puis, tout à coup, il faut, il faut, il faut que j'aille au fond de mon jardin cueillir des fraises et les manger. Et j'y vais. Je cueille des fraises et je les mange !

Oh ! mon Dieu ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Est-il un Dieu ? S'il en est un, délivrez-moi, sauvez-moi !

15 août. — Certes, voilà comment était possédée et dominée ma pauvre cousine, quand elle est venue m'emprunter cinq mille francs. Elle subissait un vouloir étranger entré en elle, comme une autre âme, comme une autre âme parasite et dominatrice.

Est-ce que le monde va finir ? Celui qui me gouverne, quel est-il, cet invisible, cet inconnaissable, ce rôdeur d'une race nouvelle ?

[...]

Je désire fuir, partir, ne pas revenir. Je serais sauvé. Mais je ne peux pas.

Je ne suis plus maître de rien. Il est le plus fort.

Cf. Pierre Bayard, *Maupassant, juste avant Freud*, Paris, Minuit, coll. "Paradoxe", 1994, 229 p.

1. Matériau clinique

Le vécu exprimé est marqué par :

- une *impossibilité d'agir* malgré une intention explicite (« j'ai voulu m'en aller... je n'ai pas pu » ; « sortir... je n'ai pas pu ») ;
- une *contradiction entre volonté et action*, avec incapacité à réaliser des actes simples (« acte de liberté... sortir... je n'ai pas pu ») ;
- une expérience de *perte de force globale*, décrite sur un mode corporel et existentiel (« tous les ressorts... brisés », « aucune force, aucun courage ») ;
- une *impuissance à initier la volonté* elle-même (« aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté » ; « je ne peux plus vouloir ») ;
- l'apparition d'un *vouloir étranger* (« quelqu'un veut pour moi ; et j'obéis ») ;
- un sentiment d'être *gouverné de l'extérieur* (« quelqu'un possède mon âme et la gouverne ») ;
- une *perte de maîtrise* des actes, mouvements et pensées (« ordonne tous mes actes... toutes mes pensées ») ;
- une position de *spectateur de soi-même* (« spectateur esclave et terrifié ») ;
- une expérience de *contrainte corporelle intense* (« je suis rivé à mon siège », « aucune force ne nous soulèverait ») ;
- des *mouvements imposés*, sans décision propre (« il faut que j'aille... et j'y vais ») ;
- une *discordance entre désir et action* (« je désire sortir... je ne peux pas ») ;
- une *alternance entre inhibition et action contrainte* (impossibilité de sortir / obligation d'aller cueillir des fraises) ;
- une *intensité émotionnelle* marquée, avec *peur et détresse* (« terrifié », « éperdu », « Mon Dieu ! ») ;
- une *interrogation angoissée* sur l'origine de l'expérience (« Quelqu'un... cet invisible, cet inconnaissable ») ;
- une *mise en relation* avec une expérience similaire chez autrui (la cousine « possédée et dominée ») ;
- une *impossibilité de fuite* malgré le désir de partir (« je désire fuir... je ne peux pas ») ;
- une *perte globale du sentiment de maîtrise de soi* (« je ne suis plus maître de rien ») ;
- une expérience de *domination par une instance plus forte* (« il est le plus fort »).

2. Dimensions

Temporalité

- Continuité temporelle globale (journal daté, succession des jours)
- Installation progressive du trouble : « peu à peu » (en continuité avec extrait précédent)
- Absence de rupture brutale, mais aggravation progressive
- Temps vécu marqué par :
 - . répétition de l'impossibilité (« je ne peux pas »)
 - . et la contrainte

- Désaccord entre :
 - . désir projeté (partir, fuir)
 - . et impossibilité de réalisation

Le futur apparaît :

- . envisagé (« je serais sauvé »)
- . mais inaccessible

Spatialité

- Restriction majeure de la mobilité :
 - . impossibilité de quitter le lieu
 - . impossibilité de se lever
- Expérience d'immobilisation dans l'espace :
 - . « rivé à mon siège »
 - . « mon siège adhère au sol »

L'espace devient :

- . contraignant
- . non modulable par l'action
- Déplacements possibles uniquement sous contrainte : aller au jardin sur injonction
- L'espace n'est plus investi librement : il est subi ou imposé

Corporéité

- Corps vécu comme privé de force et d'élan : « ressorts brisés », « muscles relâchés »
- Sensation d'altération globale du corps : « os devenus mous », « chair liquide »
- Corps incapable de se mettre en mouvement volontairement : impossibilité de se lever, de sortir
- Expérience de fixation corporelle extrême :
 - . « rivé à mon siège »
 - . « aucune force ne nous soulèverait »
- Corps soumis à une commande extérieure : mouvements imposés (« il faut que j'aille... et j'y vais »)
- Dissociation entre :
 - . corps qui agit
 - . et sujet qui ne s'en reconnaît pas comme auteur

Altérité

- Présence d'un « autre » interne : « quelqu'un », « il »
- Cet autre est :
 - . invisible
 - . inconnaissable
 - . non localisé
- Relation asymétrique : domination / soumission
- L'autre agit :
 - . comme instance de volonté
 - . comme agent des actes
- Comparaison avec autrui : la cousine « possédée et dominée »
- Absence d'altérité relationnelle classique :
 - . pas d'échange
 - . pas de dialogue
 - . mais rapport de contrôle

Ipséité

- Le sujet ne se vit plus comme origine de ses actes :
 - . « quelqu'un veut pour moi »
 - . « je ne peux plus vouloir »
- Perte du sentiment d'être l'auteur de ses actions, mouvements et pensées : « ordonne tous mes actes... toutes mes pensées »
- Déplacement du centre de l'expérience : le sujet n'est plus au principe de ce qu'il vit
- Position de dédoublement radical :
 - . « je ne suis plus rien en moi »
 - . « spectateur esclave »
- Expérience d'une domination interne : « quelqu'un possède mon âme et la gouverne »
- Le soi apparaît :
 - . non pas aboli
 - . mais dépossédé, soumis, spectateur de lui-même

Mondanéité

- Le monde reste globalement intact : jardin, fraises, maison ...
- Les objets sont accessibles et reconnus : pas de désorganisation perceptive
- Mais le rapport au monde est transformé : les actions dans le monde ne viennent plus du sujet
- Le monde devient le lieu d'exécution d'actes imposés
- Le monde est habité sur un mode contraint
- Le monde n'est pas décrit comme menaçant en soi, mais comme support d'une action non appropriée

3. Tension : vouloir / être agi

L'expérience s'organise autour d'une tension entre :

- un vouloir propre, encore présent (désirer sortir, fuir, se lever)
- et une expérience d'être agi, où les actes, mouvements et pensées semblent déterminés par une instance étrangère

Le sujet ne cesse d'éprouver des intentions (« je désire sortir », « je veux partir »), mais ces intentions ne trouvent plus de prise dans l'action.

À l'inverse, certains actes s'imposent sans être voulus (« il faut que j'aille... et j'y vais »).

L'existence ne se situe ni dans l'absence de volonté, ni dans une action autonome, mais dans un écart entre vouloir et agir, où le sujet éprouve ses propres actes comme non issus de lui.

Déploiement transversal :

- Temporalité : intention orientée vers le futur / impossibilité de réalisation (« je désire fuir... je ne peux pas »)
- Spatialité : mouvement possible / immobilisation imposée (« rivé à mon siège »)
- Corporéité : corps mobilisable / corps contraint (« je ne peux pas me lever » / « j'y vais »)
- Altérité : soi comme agent / présence d'un autre agissant (« il ordonne »)
- Ipséité : être à l'origine / être dépossédé (« quelqu'un veut pour moi »)
- Mondanéité : agir dans le monde / être déplacé dans le monde sans initiative

Ce que cette tension permet :

- maintien d'une certaine continuité de l'existence (le sujet continue à agir, à percevoir, à désirer)
- maintien d'une conscience de l'écart (le sujet perçoit qu'il ne se reconnaît pas dans ses actes)

Limitation existentielle :

- impossibilité d'être à l'origine de ses propres actes
- perte de maîtrise et d'appropriation de l'expérience
- transformation du rapport à soi en position de spectateur
- dépendance à une instance vécue comme étrangère et dominante

Remarque. Cette tension est particulièrement forte car :

- elle ne correspond ni à une simple inhibition
- ni à une simple contrainte externe
- mais à une désorganisation du lien entre vouloir, agir et être soi.

4. Structure de vécu

« L'expérience s'organise autour d'un désaccord profond entre le vouloir, l'agir et le sentiment d'être soi.

Les intentions demeurent présentes, parfois insistantes, mais ne trouvent plus de traduction effective dans l'action, tandis que certains actes s'imposent au sujet sans être reconnus comme issus de lui. Le vouloir ne disparaît pas : il persiste comme visée, mais perd sa capacité d'initiation et d'incarnation.

À l'inverse, l'agir se maintient, mais sur un mode contraint, comme déplacé hors du champ de l'appropriation subjective.

Le corps, bien qu'opérant, apparaît mobilisé sans participation pleine du sujet : tantôt empêché dans ses mouvements, tantôt engagé dans des actions qui ne procèdent pas de lui. Il devient ainsi le lieu d'un agir imposé, plutôt que le support d'une initiative vécue. Le sujet se trouve dès lors en position de spectateur de ses propres gestes, témoin d'un fonctionnement qui lui échappe tout en se déroulant en lui.

Le temps et le monde conservent leur continuité et leur cohérence apparente : les journées s'enchaînent, les lieux et les objets demeurent reconnaissables, les actions s'inscrivent dans un cadre ordinaire.

Mais cette stabilité du monde contraste avec une transformation profonde du rapport à soi, marqué par une difficulté croissante à se reconnaître comme centre de l'expérience.

L'existence se déploie ainsi sur un mode de dépossession progressive : le sujet n'est pas absent de ce qu'il vit, mais il n'en est plus l'origine ni le principe organisateur. Il demeure présent, mais sur un mode distancié, comme déplacé hors de la position d'auteur de son expérience.

L'ensemble dessine une modalité de présence dominée, caractérisée par une rupture du lien entre vouloir, agir et se reconnaître comme soi, où l'expérience se maintient sans effondrement, mais au prix d'une perte d'appropriation du vécu. »

Commentaire clinique transversal

Cette vignette met en évidence une transformation profonde du rapport à soi, caractérisée par une dissociation entre vouloir, agir et se reconnaître comme sujet de son expérience :

- Le sujet continue à percevoir, à désirer et à agir, mais ces différentes dimensions ne s'articulent plus de manière cohérente.
- Le vouloir ne se traduit plus en action, tandis que certains actes s'imposent sans être éprouvés comme issus de lui.
- L'expérience ne correspond pas à une disparition du soi, mais à une dépossession du pouvoir d'agir, accompagnée d'un déplacement de la position subjective vers une posture de spectateur contraint.

- Le corps joue ici un rôle central :
 - il reste opérant
 - mais il n'est plus habité comme support d'une initiative propre
 - il devient le lieu d'un agir imposé plutôt que celui d'une action assumée
 - Le temps et le monde conservent leur continuité, ce qui rend l'expérience d'autant plus marquante :
 - rien ne s'effondre extérieurement
 - mais le lien entre le sujet et ce qu'il vit se défait progressivement
- > La présence d'une instance vécue comme étrangère (« quelqu'un », « il ») ne doit pas être comprise d'emblée comme une entité réelle ou comme une croyance à évaluer, mais comme une modalité d'expérience du décalage entre soi et ses propres actes.

Points de vigilance clinique. Cette vignette montre l'importance de ne pas réduire trop rapidement l'expérience à :

- un diagnostic (psychose, délire d'influence, dissociation pathologique)
- une interprétation explicative (conflit interne, mécanisme psychique)

Elle invite plutôt à décrire :

- une altération du sentiment d'agentivité
- une rupture du lien entre volonté et action
- une expérience de contrainte vécue de l'intérieur

Enjeu clinique. Une telle configuration interroge :

- la manière dont le sujet peut encore se reconnaître comme origine de ses actes
- les conditions nécessaires pour restaurer une continuité entre vouloir, agir et être soi
- et la possibilité de réinscrire l'expérience dans une forme d'appropriation subjective

Conclusion. Cette vignette illustre une forme d'existence où :

- le monde reste stable
- le corps reste fonctionnel
- mais le sujet perd sa position d'auteur

> ce qui transforme radicalement la manière d'habiter son expérience, sans pour autant produire une désorganisation globale du réel.

2.2. *Le Ravissement de Lol V. Stein - Marguerite Duras (1964)*

D'après la « scène du bal » :

« Elle regarde la scène sans intervenir. Elle voit l'homme qu'elle aimait s'éloigner avec l'autre femme, mais rien ne la retient ni ne la pousse à agir.

Elle reste là, comme retirée d'elle-même, présente et absente à la fois.

Elle dit plus tard qu'elle ne ressentait ni jalousie ni colère, seulement une sorte de suspension, comme si ce qui se passait ne la concernait plus entièrement. Le temps continuait, la musique continuait, les gestes continuaient — mais elle ne s'y reconnaissait plus. »

1. *Matériau clinique*

Le vécu exprimé est marqué par :

- position de témoin passif (« elle regarde la scène sans intervenir »)
 - absence d'élan à agir (« rien ne la retient ni ne la pousse à agir »)
 - retrait subjectif (« retirée d'elle-même », « présente et absente à la fois »)
 - neutralisation affective (« ni jalousie ni colère »)
 - tonalité de suspension (« une sorte de suspension »)
 - perte d'implication personnelle (« cela ne la concernait plus entièrement »)
 - continuité du monde (« le temps continuait », « la musique continuait »)
 - non-reconnaissance subjective dans ce qui se déroule (« elle ne s'y reconnaissait plus »)
- > Le récit met en évidence un décalage entre la continuité de la scène et la désinscription du sujet dans cette scène.

2. *Dimensions*

Temporalité

- Le temps se déploie de manière continue, sans rupture ni accélération.
 - Cette continuité est perçue comme se déroulant indépendamment du sujet.
 - Le sujet ne semble plus inscrit dans le flux temporel, mais en position de décalage vis-à-vis de celui-ci.
- > Le temps apparaît ainsi comme extérieur, poursuivant son cours sans être vécu comme porté ou habité.

Spatialité

- Le sujet se tient dans la scène sans s'y engager, en position de retrait stable.
 - L'espace est perçu comme un cadre dans lequel les événements se déroulent, sans appel à l'action.
 - Il n'y a ni mouvement d'approche ni mouvement d'évitement : la position est maintenue mais non investie.
- > L'espace devient ainsi une scène observée, plutôt qu'un milieu dans lequel agir.

Corporéité

- Le corps est présent dans la situation, mais non engagé dans l'action.
 - Il constitue un support de présence perceptive, sans mobilisation motrice ni orientation vers l'agir.
 - L'absence de geste ou de réaction traduit une suspension de la dynamique corporelle.
- > Le corps ne disparaît pas, mais cesse d'être vecteur d'implication dans la situation.

Altérité

- La relation à autrui se poursuit sur un plan objectif, mais sans implication subjective.
 - L'autre n'est ni conflictuel ni investi : il apparaît dans la scène sans susciter de réponse affective.
 - Le lien relationnel se défait sans réaction, dans une forme de désengagement silencieux.
- > L'altérité est ainsi présente, mais désactivée sur le plan de l'implication vécue.

Ipséité

- Le sujet apparaît présent sans coïncider avec ce qu'il vit.
- Le sentiment d'implication dans l'expérience est atténué, comme si ce qui se déroule ne relevait plus entièrement de lui.
- La présence à soi est maintenue, mais sur un mode décentré et affaibli.
- Le sujet ne disparaît pas, mais se retire de la position de centre de l'expérience.
- > L'expérience de soi se caractérise ainsi par une distance interne, sans rupture ni perte de continuité.

Mondanité

- Le monde conserve sa cohérence et sa continuité (sons, gestes, déroulement de la scène).
- Il apparaît cependant désaffecté et non engageant pour le sujet.
- Les éléments du monde sont perçus, mais sans susciter d'adhésion ou de participation.
- Le monde devient une scène qui se déroule, plutôt qu'un milieu vécu de manière impliquée.
- > L'ensemble est marqué par une tonalité de suspension et de désengagement, sans tension manifeste.

3. Tension structurante : présence / désinscription

Polarités :

- Présence physique et perceptive dans la situation
- Désinscription subjective du vécu (« cela ne la concerne plus entièrement »)
- Continuité du monde sans participation du sujet
- Maintien de la scène sans engagement du soi

Cette tension traverse :

- le rapport à soi (être là / absence de reconnaissance de soi dans l'expérience)
- le rapport au monde (scène continue / absence d'adhésion)
- le rapport au temps (continuité objective / absence d'inscription subjective)
- le rapport à l'autre (lien en train de se défaire / absence de réaction affective)

4. Structure de vécu

L'expérience se déploie sur le mode d'un décalage discret entre le déroulement de la scène et la manière dont le sujet s'y trouve engagé.

Les événements se poursuivent sans rupture — gestes, sons, interactions — mais sans susciter de réponse ni d'implication. Le sujet demeure là, percevant ce qui se passe, sans pour autant s'y reconnaître comme concerné. Ce qui advient ne provoque ni élan ni réaction : l'expérience semble glisser à distance, comme si elle ne rencontrait plus de point d'ancrage dans le sujet. Celui-ci ne se retire pas activement, mais cesse peu à peu d'occuper une position centrale dans ce qui se déroule.

La présence se maintient, mais sur un mode atténué, sans initiative ni orientation vers l'action. Les gestes ne viennent pas répondre à la situation, et rien ne vient rompre cette forme de suspension.

Le temps continue de s'écouler, les éléments du monde demeurent ordonnés et reconnaissables, mais ils ne sont plus investis de manière vivante : ils composent une scène qui se poursuit en marge du sujet.

La relation à autrui s'inscrit dans cette même tonalité : elle ne se rompt pas, mais se défait sans tension, sans conflit, comme si le lien se relâchait de lui-même.

L'ensemble dessine ainsi une modalité de présence en retrait, où le sujet assiste à ce qui se déroule sans y prendre part, comme si l'expérience continuait sans lui, tout en le maintenant à sa périphérie.

Cette configuration semble dessiner une manière d'être-au-monde caractérisée par un retrait

discret de l'implication, où l'existence se maintient sans rupture mais sur un mode de participation atténuée, où le sujet se tient en bordure de ce qui advient.

Commentaire clinique

Cette vignette illustre :

- une désinscription subjective sans désorganisation du réel
- une neutralisation affective sans effondrement
- une continuité temporelle conservée
- une présence perceptive maintenue mais non engagée

> il s'agit d'une modalité de vécu ni anxieuse, ni explosive, ni dépendante, mais désengagée et suspendue.

3. Œuvres non narratives

3.1. Haïkus

Haïkus et phénoménologie

Travailler le haïku en phénoménologie :

- Le haïku est une forme poétique très courte, sans explication ni narration.
- > Il donne accès à une expérience vécue minimale, sans psychologie explicite.

C'est un exercice phénoménologique excellent car il oblige à :

- décrire sans interpréter
- repérer une structure de vécu
- travailler l'espace, le temps et le rapport au soi sans diagnostic

Principe de base. En phénoménologie, on ne demande pas :

- « *Que veut dire ce poème ?* »
- > Mais : « *Comment le monde est-il vécu ici ?* »

Même en trois vers, un haïku donne presque toujours accès à plusieurs dimensions du vécu :

- un rapport à l'espace
- un rapport au temps
- un rapport au soi
- un rapport au monde et une tonalité affective

Rapport à l'espace

Questions. L'espace est-il :

- clos ou ouvert ?
- stable, instable, habitable, menaçant ?
- précis (un lieu) ou diffus (une atmosphère) ?
- > ne pas décrire les lieux objectivement, mais comment ils sont vécus.

Rapport au temps

Questions. Le temps est-il vécu comme :

- un instant plein ?
- une succession ?
- un rythme, un cycle ?
- une impermanence ?
- Y a-t-il urgence, lenteur, suspension ?
- > Le temps vécu n'est presque jamais neutre.

Rapport au soi

Questions. Le sujet est-il :

- effacé ?
- affecté ?
- accordé au monde ?
- débordé ?
- > Y a-t-il un « je » explicite ou implicite ?
- > L'absence du « je » est-elle paisible ou inquiétante ?

Rapport au monde / tonalité affective

Repérer :

- calme
 - fragilité
 - paix
 - tension
 - émerveillement, etc.
- > une tonalité n'est pas un symptôme.

Structure de vécu

Une bonne analyse se termine par une formulation synthétique (« Le vécu se caractérise par... »). Cette formulation doit :

- relier espace, temps et soi
- rester descriptive

Erreurs fréquentes à éviter

- Chercher un symbole caché
 - « Psychologiser » l'auteur
 - Expliquer par la culture ou la biographie
 - Plaquer un diagnostic
 - Paraphraser le texte

> On décrit ce qui apparaît, pas ce que l'on pense que cela signifie (le niveau herméneutique est ultérieur)

Déclinaison par niveau

Phase 1 : Initiation : repérer ce qui apparaît

Ce qu'on attend :

- Repérer 2 à 3 éléments de l'expérience (espace, temps ou tonalité affective).
- Décrire ce qui est donné dans l'image (lieu, moment, sensation, atmosphère).
- Rédiger 2–3 phrases descriptives : « Ici apparaît... ».

Ce qu'on valorise :

- Observation attentive du texte.
- Vocabulaire simple et concret.
- Fidélité aux images du haïku.

Ce qu'on évite :

- Interpréter ou expliquer le poème.
- Chercher un symbole caché.
- Paraphraser simplement le texte.

Phase 2 : analyser des dimensions

Ce qu'on attend :

- Repérer 3 dimensions minimum : espace – temps – tonalité affective (le "soi" peut rester implicite).
- Dire ce qui apparaît (images, sensations, rythme), sans symbolisme.
- Écrire une courte synthèse (4–6 lignes) : "le vécu ici ressemble à..."

Ce qu'on valorise :

- Fidélité au texte
- Vocabulaire simple et descriptif (calme, suspendu, fragile, ouvert...).

> Une première distinction : décrire ≠ expliquer.

Ce qu'on évite :

- Interprétations pathologiques ("il est dépressif", "il a un traumatisme").
- Symbolisation ("la branche = le deuil") comme si c'était évident.

Phase 3 – articuler les registres du vécu et dégager une tension

Ce qu'on attend :

- Repérer au moins 4 registres : espace – temps – soi – monde (+ tonalité affective).
- Identifier une tension structurante (ex. permanence / impermanence ; stabilité / fragilité ; distance / immersion).
- Produire une formulation de structure de vécu (6–8 lignes) qui relie les registres.

Ce qu'on valorise :

- Une lecture "transversale" : un même trait (ex. fragilité) se retrouve dans le temps, l'espace, l'affect.
- Une synthèse qui organise (pas une liste).

Ce qu'on évite :

- Jargon non maîtrisé.
- "Analyse littéraire" (figures de style) à la place de l'expérience vécue.

Phase 4 – produire une analyse structurale + rigueur d'époché

Ce qu'on attend :

- Repérage systématique des dimensions
- 1 à 2 tensions clairement formulées, justifiées par le texte.
- Une structure de vécu formulée comme un "mode d'être" claire, cohérente, et non diagnostique.
- Capacité à montrer que l'absence de "je" peut être paisible, accordée, ..., selon la valence.

Ce qu'on valorise :

- La précision (éviter les adjectifs vagues : "bizarre", "triste" sans support).
- La distinction, par exemple, entre :
 - . *effacement du soi* (paisible)
 - . *dissolution/menace* (angoissée)
 - . *dépossession* (hétéronomie)
- La discipline méthodologique : description → tensions → structure.

Ce qu'on évite :

- Diagnostic explicite ou implicite
- Causalité ("il fait un deuil", "c'est l'anxiété") sans appui.

« Le vieil étang » – Matsuo Bashō (1686)

Vieil étang —
une grenouille plonge,
bruit de l'eau.

(松尾芭蕉)
古池や
蛙飛び込む
水の音

Furu ike ya / kawazu tobikomu / mizu no oto

Découpage mot à mot (indicatif) :

古池 (furu ike) : vieil étang

や (ya) : particule de césure/exclamation (kireji)

蛙 (kawazu) : grenouille

飛び込む (tobikomu) : plonger / sauter dedans

水の音 (mizu no oto) : bruit de l'eau

Étape 1 - Repérage "brut"

On relève simplement les éléments du texte :

Lieu : "vieil étang"

Événement : "une grenouille plonge"

Phénomène : "bruit de l'eau"

En filigrane (structure) : silence implicite > action > son

> On évite tout de suite : "ça symbolise..." / "ça veut dire..."

Étape 2 - Description par dimensions du vécu

Rapport à l'espace :

L'espace est circonscrit et minimal : un vieil étang, lieu limité, contenu

L'adjectif "vieil" donne une qualité d'espace : patine, stabilité, familiarité, profondeur tranquille

L'étang n'est pas décoratif : il est habitable, stable, non menaçant, non intrusif.

Le monde spatial est porteur de silence et de profondeur.

L'espace est vécu comme présence, non comme contrainte

> Formulation descriptive : Espace vécu comme stable, délimité, dense (plus qu'ouvert)

Rapport au temps :

Le haïku saisit un instant bref : un événement ponctuel (le plongeon).

Cet instant s'inscrit toutefois dans une continuité paisible, suggérée par le vieil étang, qui évoque durée et lenteur

La temporalité se déploie selon une structure simple : suspension, rupture brève, retombée implicite dans le calme

Le temps n'est ni figé ni précipité : il advient, sans tension

> Formulation descriptive : Temporalité événementielle minimale dans une continuité paisible

Rapport au corps / au sensoriel :

Le corps humain n'est pas mentionné, mais l'expérience est sensorielle : perception d'un lieu, perception d'un mouvement, perception d'un son : un corps attentif et immobile

La perception semble organisée autour de deux modalités sensorielles :

- une perception visuelle implicite (la scène : étang, grenouille) ;
- une perception auditive explicite (le bruit de l'eau).

> L'événement sensoriel (le son) ne traduit pas une émotion particulière : il marque simplement l'apparition d'un phénomène dans un champ perceptif calme

Le bruit de l'eau fait apparaître un monde audible et concret : le réel se donne par la sensation

> Formulation descriptive : Primat de la perception (auditif et visuel implicite) plutôt que de l'affect

Rapport au soi :

Aucun *je* n'apparaît : le sujet est effacé

Cet effacement n'est pas vécu comme *une perte ou une angoisse*, mais comme une *disponibilité*

Le soi ne structure pas le monde : il *laisse* le monde *apparaître*, sans *réflexivité*

> Formulation descriptive : Soi décentré, réceptif, non problématisé

Rapport au monde (tonalité/ambiance) :

Le monde est *simple* et *auto-suffisant* : Il n'y a *ni excès de sens, ni interprétation*

Le réel n'est *ni vide ni débordant* : il est *présent*

L'événement n'est *ni dramatique ni insignifiant* : il est

> *Tonalité générale : calme, sobriété, légère densité*

Étape 3 - Tension ou articulation structurante

Pas une tension dramatique, mais une articulation très nette entre immobilité et micro-événement

« *immobilité / mouvement* » :

stabilité : "vieil étang"

événement : "plonge"

trace : "bruit de l'eau"

ou « *silence (implicite) / son (explicite)* »

Étape 4 - Formulation de la structure de vécu

Le haïku décrit un lieu calme et stable (le vieil étang). Un petit événement arrive (la grenouille plonge) et on entend l'eau. Le temps est celui d'un instant dans un calme plus long. Le « je » n'est pas présent : "on" observe simplement la scène.

L'espace est limité et stable ("vieil étang"), le temps est celui d'un instant ponctuel inscrit dans une continuité silencieuse. Le « bruit de l'eau » désigne une perception sensorielle. Le sujet est effacé, ce qui donne une présence au monde non réflexive. L'articulation structurante est celle d'une stabilité interrompue par un micro-événement qui fait apparaître le réel.

Le poème donne à voir un monde stable et circonscrit, saisi dans le calme d'un espace silencieux (« vieil étang »). Le temps s'y déploie comme une continuité paisible, au sein de laquelle survient un micro-événement (« une grenouille plonge ») qui n'interrompt pas cette stabilité, mais en modifie brièvement l'intensité perceptive.

Le bruit de l'eau fait apparaître le monde dans sa matérialité immédiate, sans médiation réflexive. Le sujet demeure effacé : aucune position de « je » n'est formulée, laissant place à une présence ouverte et réceptive, accordée au rythme du monde.

« Sur la branche morte » – Matsuo Bashō (fin XVIIe)

Sur la branche morte
un corbeau s'est posé —
soir d'automne.

枯枝 に
烏のとまりけり
秋の暮

Kare eda ni / karasu no tomarikeri / aki no kure

Étape 1 - Repérage "brut"

Espace : branche morte, corbeau posé

Temps : soir d'automne

Événement : un corbeau se pose > Structure implicite : immobilité > arrivée > immobilité.

Étape 2 - Description

Rapport à l'espace :

L'espace est *minimal, circonscrit et stable*.

Il ne s'agit pas d'un espace ouvert ou dynamique, mais d'un *lieu précis* : la branche morte. Celle-ci est immobile, dépouillée, sans vitalité apparente.

L'espace n'est ni menaçant ni envahissant : il est *posé*, silencieux, offert à la perception.

Le monde est habité sans effort. Il n'y a ni clôture anxiogène ni effraction.

L'espace est vécu comme *support*, non comme contrainte.

Rapport au temps :

Le temps est celui d'un *instant suspendu*.

Le poème ne raconte pas une succession d'événements, mais un *moment unique*, saisi dans sa plénitude.

Le « soir d'automne » inscrit l'instant dans une temporalité cyclique et saisonnière : le déclin n'est pas une rupture, mais une phase naturelle.

Le temps n'est ni figé ni précipité. Il *s'apaise*.

Rapport au corps :

Le corps humain n'est pas mentionné, mais l'expérience se donne à travers une perception visuelle simple : une branche morte et un corbeau posé.

La scène est immobile et silencieuse : le monde apparaît dans une perception stable, sans action ni mouvement prolongé.

La corporéité est donc implicite : elle correspond à une présence perceptive calme et attentive, tournée vers une image dépouillée.

> Formulation descriptive : corporéité perceptive silencieuse ; primat du regard dans une expérience visuelle stable et minimaliste

Rapport au soi :

Le sujet est *absent du poème*

Il n'y a pas de « je », pas de commentaire, pas de réaction affective explicite

Cette absence n'est pas vécue comme une perte, mais comme un *effacement paisible* : le regard s'accorde au monde sans s'y imposer

Le soi n'est pas au centre ; il est *disponible*, silencieux, réceptif

Rapport au monde :

Le monde est *sobre, dénudé, mais pleinement présent*.

La branche morte et le corbeau ne sont pas chargés symboliquement dans le poème : ils apparaissent tels quels.

Il n'y a ni dramatisation ni interprétation. Le monde n'exige rien, ne menace pas, ne déborde pas.

La tonalité affective est "*mélancolique*", pas douloureuse : il s'agit d'une *mélancolie habitée* (non patho)

Étape 3 - Tension structurante (articulation)

Pas une tension dramatique, mais une articulation nette entre :

« *vie / mort* »

- mort : la branche morte (dénuee de vie, sèche, dépouillée)

- vie : le corbeau (vivant, capable de mouvement)

ou « *mouvement / immobilité* »

- immobilité : "s'est posé" → passage du mouvement à l'arrêt

- temporalité : "soir d'automne" → déclin, phase de transition

ou « *présence / absence* »

- présence : le corbeau arrive, se pose, habite la branche

- absence : la vitalité absente de la branche, l'approche du soir

Étape 4 - Structure de vécu (synthèse)

Version 1 :

Le haïku décrit un lieu dépouillé : une branche morte. Un corbeau vient s'y poser. Le moment est celui d'un soir d'automne, qui évoque le déclin. Le « je » n'apparaît pas : on observe simplement ce qui est. L'ensemble donne une impression de calme mélancolique.

Version 2 :

L'espace est minimal et stable (« branche morte »), déjà marqué par l'absence de vie. Le temps est celui d'un instant saisi dans une phase de déclin (« soir d'automne »). Le corbeau, vivant, vient habiter ce qui est mort : il y a une articulation entre mouvement (le corbeau se pose) et immobilité (la branche). Le sujet est effacé, laissant place à une présence silencieuse et contemplative. La tonalité est mélancolique sans être douloureuse : une forme de paix dans le dénuement.

Version 3 :

Le vécu exprimé se structure autour d'un espace minimal et dépouillé : la branche morte apparaît comme un lieu vidé de vitalité, stable mais sans vie. Le temps s'inscrit dans une phase de déclin naturel — le soir d'automne — qui n'est ni dramatique ni menaçant, mais qui évoque une transition apaisée vers l'obscurité et le repos.

L'articulation structurante tient dans la rencontre entre ce qui est mort (la branche) et ce qui demeure vivant (le corbeau qui s'y pose). Cette présence vivante ne « ranime » pas la branche, mais l'habite sans effort, acceptant le dénuement comme un lieu possible. Le mouvement du corbeau (l'arrivée, la pose) se résout dans l'immobilité.

Le sujet est absent du poème : aucune position subjective explicite n'est formulée. Cette absence n'est pas vécue comme une perte mais comme un effacement paisible : le regard s'accorde au monde sans chercher à le transformer ou à s'y imposer. Le soi reste silencieux, réceptif, disponible à ce qui se donne.

La tonalité affective est celle d'une mélancolie habitée, non pathologique. Le monde apparaît

sobre, dépouillé, mais pleinement présent. Il n'y a ni dramatisation ni excès de sens : les choses sont telles qu'elles sont. Le vécu se déploie dans une forme de sérénité face au déclin, où l'impermanence est reconnue sans résistance.

- > l'effacement du soi n'est pas toujours une perte d'agentivité
- la mélancolie n'est pas nécessairement pathologique
- un monde pauvre en stimuli peut être plein de présence

« Le monde est rosée » – Kobayashi Issa (1819)

Il résume en trois vers la conscience bouddhiste de l'impermanence et la douleur liée à la perte de son enfant :

Ce monde de rosée —
monde de rosée seulement...
et pourtant...

露の世は
露の世ながら
さりながら

Tsuyu no yo wa / tsuyu no yo nagara / sari nagara

Issa a écrit ce poème après la mort de sa fille Sato, c'est-à-dire dans un moment de détresse profonde. Dans la tradition japonaise, la rosée exprime/symbolise la fragilité et la brièveté de la vie. L'œuvre s'inscrit dans la lignée bouddhiste de l'« impermanence ».

Étape 1 - Repérage "brut"

On relève simplement les éléments du texte :

- "monde"
- "rosée"
- "seulement..."
- "et pourtant..."

Ce haïku de Kobayashi Issa contient une tension explicite >

En filigrane : *affirmation* ("monde de rosée") > *réduction* ("seulement") > *résistance* ("pourtant").

Étape 2 - Dimensions existentielles

- Espace :

L'espace n'est pas structuré par des lieux précis. Il est vécu comme atmosphérique, diffus, sans contours nets

La "rosée" évoque une qualité d'espace sans épaisseur, prête à se dissiper

L'espace n'est ni clos ni ouvert : il est instable, comme suspendu

> Formulation descriptive : espace vécu comme léger, précaire, difficile à "tenir"

- Temps :

La rosée est éphémère : elle est déjà du côté de ce qui disparaît.

Il n'y a pas de continuité rassurante ni de projection possible : l'instant est déjà en train de se perdre

Le temps est vécu comme impermanence (l'instant est menacé de se perdre), non cyclique

> Formulation descriptive : temporalité instable, non durable.

- Soi :

Pas de « je », mais le « *et pourtant...* » indique une présence subjective : quelqu'un résiste.

Le dernier vers — « *et pourtant...* » — introduit une faille subjective : quelque chose résiste à l'acceptation de l'impermanence.

Le « je » n'apparaît pas explicitement, mais il est fortement impliqué affectivement

Il y a un reste d'attachement, de douleur ou de non-consentement

> Formulation descriptive : le soi apparaît comme affecté, vulnérable, impliqué affectivement.

- *Monde / tonalité :*

Le monde apparaît fragile, instable, transitoire, mais cela « ne passe pas »

La « rosée » n'est pas un symbole abstrait : elle renvoie à une qualité sensible du monde, éphémère, prête à disparaître.

Cette précarité n'est pas décrite de l'extérieur : elle est éprouvée.

Ce « pourtant » est essentiel : il marque la tension entre lucidité et attachement, entre participation et douleur

> Formulation descriptive : Le monde n'est pas hostile ni écrasant, mais incertain, révocable.

Étape 3 - Tensions structurantes

Tension principale (très lisible) :

- *lucidité / attachement*

- lucidité : "monde de rosée... seulement"

- attachement, résistance : "et pourtant..."

On peut aussi formuler :

- *acceptation / résistance*

Le poème dit :

oui, le monde est rosée

mais...

et ce "mais" est toute l'expérience

- *impermanence / désir de permanence*

Étape 4 - Structure de vécu

- *Version 1 :*

Le poème décrit un monde fragile et passager, comme la rosée. Le temps semble très court, menacé de disparition. Le « et pourtant... » montre qu'il demeure une émotion : on n'accepte pas complètement ce caractère éphémère. L'ensemble donne une impression de mélancolie.

- *Version 2 :*

Le monde apparaît comme précaire ("rosée"), et le temps comme impermanent. Le sujet n'est pas nommé, mais il est présent dans la résistance du « et pourtant ». On observe une tension entre reconnaître le caractère éphémère et fragile du monde et ne pas pouvoir s'y résoudre affectivement. La structure de vécu relie espace (monde sans épaisseur), temps (disparition) et soi (attachement).

- *Version 3 :*

Le poème donne à voir un monde saisi dans sa fragilité même : qualifié de « rosée », il apparaît sans épaisseur, déjà exposé à la dissipation. Le temps s'y présente comme transitoire, et l'espace comme diffus et atmosphérique, sans ancrage stable.

Le sujet n'est pas explicitement nommé, mais une inflexion apparaît dans le « et pourtant... », qui introduit une tension discrète au cœur de cette impermanence. L'ensemble articule ainsi la reconnaissance de la précarité du réel et le maintien d'un rapport qui ne se résout pas entièrement dans la disparition.

« La mer du printemps » – Yosa Buson (XVIII^e)

Mer de printemps —
le jour monte et descend,
monte et descend encore.

与謝蕪村
春の海
ひねもすのたり
のたりかな

Haru no umi / hinemosu notari / notari kana

Découpage indicatif :

春の海 (haru no umi) : mer de printemps

ひねもす (hinemosu) : toute la journée, du matin au soir

のたりのたり (notari notari) : ondulation lente, va-et-vient paisible

かな (kana) : particule finale d'exclamation/émotion contemplative

Étape 1 - Repérage "brut"

On relève simplement les éléments donnés dans le texte :

« mer » (élément naturel, espace)

« printemps » (saison, qualité temporelle)

« toute la journée » (lumière, temporalité)

« ondulation lente » (mouvement, rythme)

« monte et descend encore » (répétition, continuité)

Ce haïku ne présente :

- ni figure humaine

- ni événement ponctuel

- ni rupture

> il donne à voir un mouvement rythmique continu, une oscillation douce.

Étape 2 - Dimensions

Rapport à l'espace :

L'espace est vaste, ouvert, continu.

La mer n'est ni close ni fragmentée ; étendue stable qui accueille le regard.

L'espace l'espace apparaît sans menace, mais sans refuge non plus

> il est simplement là, ample.

Rapport au temps :

Le temps est vécu comme oscillation douce, non comme succession d'instants.

Le « jour » qui monte et descend évoque une temporalité ondulatoire, rythmée, sans rupture ni urgence.

Le temps ne presse pas ; il respire.

Rapport au soi

Le sujet est implicitement présent par la perception du rythme.

Il n'est ni effacé (comme chez Bashō), ni affectivement engagé (comme chez Issa).

> Le soi est accordé au mouvement du monde, dans une posture contemplative.

Rapport au monde :

Le monde apparaît comme harmonique, auto-régulé.

Il n'y a ni excès ni manque : la répétition n'est pas vide, elle est rythme.

> Le réel n'impose rien, ne déborde pas ; il se déploie.

Étape 3 - Tension structurante

Il n'y a pas ici de tension dramatique au sens d'une opposition conflictuelle. On observe plutôt une articulation rythmique :

« permanence / variation »

- permanence : la mer (toujours là), le mouvement continue
- variation : le jour qui monte et descend (oscillation)

ou « continuité / rythme »

- continuité : "monte et descend encore" → le mouvement ne s'arrête pas
- rythme : alternance régulière, pulsation douce

ou « immobilité apparente / mouvement imperceptible »

- l'ensemble donne une impression de calme (« mer de printemps »)
- > mais il y a un mouvement lent, continu (le jour qui oscille)

Cette articulation n'est pas conflictuelle : elle est harmonique. Le vécu n'est pas tendu, mais accordé à une oscillation naturelle.

Étape 4 - Structure de vécu (synthèse)

Version 1 :

Le haïku décrit une mer au printemps. Le jour monte et descend, comme un mouvement de vagues ou de lumière qui se répète. Le temps n'est pas rapide : il semble doux et régulier. Personne n'est nommé, mais on sent une présence qui éprouve ce rythme. L'ensemble donne une impression de calme et d'harmonie.

Version 2 :

L'espace est vaste et ouvert (« mer »), sans limite visible. Le temps n'est pas vécu comme une suite d'instants séparés, mais comme une oscillation douce et rythmée : « monte et descend, monte et descend encore ». Le sujet n'est pas nommé, mais il est implicitement présent comme témoin de ce rythme. Il n'est ni effacé (comme chez Bashō), ni affectivement engagé (comme chez Issa) : il est accordé au mouvement du monde, dans une posture contemplative. Le monde apparaît comme harmonique, autorégulé. La répétition n'est pas vide : elle est rythme, respiration.

Version 3 :

Le vécu exprimé se structure autour d'un espace vaste, continu et ouvert : la mer de printemps apparaît comme une étendue stable qui accueille le regard sans clôture ni limite oppressante. L'espace n'est ni fragmenté ni menaçant : il est ample, habitable, apaisant.

Le temps se donne comme une oscillation rythmique plutôt que comme une succession d'instants distincts. Le « jour » qui monte et descend évoque une temporalité ondulatoire, douce, sans rupture ni urgence. La répétition (« monte et descend encore ») ne marque pas une monotonie vide, mais un rythme naturel, une respiration régulière, qui inscrit l'instant dans une continuité apaisée. Le temps ne presse pas : il respire, se déploie selon un mouvement régulier.

Le sujet n'est pas explicitement nommé, mais il se manifeste par sa perception du rythme. Il n'est ni effacé (comme dans le haïku de Bashō), ni affectivement engagé ou vulnérable (comme chez Issa). Le soi est présent sous la forme d'une attention accordée, contemplative : il se

laisse porter par le mouvement du monde sans chercher à le contrôler ni à s'en détacher. Le sujet habite le rythme sans résistance.

Le monde apparaît comme harmonique et autorégulé. Il n'y a ni excès ni manque : la mer est là, le jour oscille, et cette oscillation n'impose rien, ne déborde pas. Le réel se déploie dans une plénitude tranquille. La tonalité affective est celle d'une sérénité rythmée, d'un accord paisible entre le soi et le monde.

L'articulation structurante n'est pas conflictuelle : elle tient dans l'accord entre une permanence (la mer, toujours là) et une variation douce (le mouvement du jour). Le vécu se caractérise par une immersion paisible dans un monde vaste et continu, où le temps est ressenti comme un rythme oscillant plutôt que comme une fuite ou une menace.

« Sous le ciel bleu glacé » – Mayuzumi Madoka (2014)

Sous le ciel bleu glacé
impossible de fuir
ou de se cacher

寒			晴			の
逃	げ	も	隠	れ		も
できぬ空						

Kanbare no
nige mo kakure mo
dekinu sora

Haïkus du temps présent, Arles, Picquier poche, 2014, p. 149.

Étape 1 - Repérage brut

On relève simplement les éléments présents dans le texte :

- un espace : « le ciel bleu » ;
- une qualité sensible : « glacé » ;
- une impossibilité : « impossible » ;
- deux mouvements empêchés : « fuir » et « se cacher ».

Le haïku présente une scène très minimale :

- ciel ouvert et froid
- > impossibilité de fuir
- > impossibilité de se cacher.

Contrairement aux haïkus précédents, il n'y a pas ici d'animal, de mouvement naturel ou de micro-événement. Le poème donne plutôt accès à une situation d'exposition : quelque chose dans le monde empêche le retrait.

À cette étape, on évite de conclure trop vite : « le sujet est angoissé », « il est persécuté », « il veut disparaître ». On décrit d'abord ce qui apparaît : un ciel ouvert, froid, et l'impossibilité de se soustraire à cette exposition.

Étape 2 - Description par dimensions du vécu

Rapport au temps :

Le temps n'est pas directement nommé

- > Il n'y a ni saison, ni moment précis, ni déroulement narratif.

Mais le mot « impossible » donne une forme d'arrêt

- Il ne s'agit pas d'un temps fluide ou rythmique
- mais d'un temps bloqué par l'impossibilité
- Rien ne se déploie : ni fuite, ni retrait, pas de transformation de la situation.

Temporalité suspendue, immobilisée par l'impossibilité.

Le haïku ne décrit pas une succession d'événements. Il fixe un état : être sous ce ciel, sans pouvoir fuir ni se cacher.

Rapport à l'espace :

L'espace est celui du ciel :

- ouvert, vaste, sans limite immédiatement visible
- ouverture non apaisante (« glacée »)

Un espace d'exposition :

- le ciel ne protège pas, n'abrite pas
- il semble au contraire empêcher toute possibilité de retrait

Les deux verbes « fuir » et « se cacher » indiquent un rapport spatial contrarié.

Fuir supposerait une direction possible ; se cacher supposerait un abri. Or les deux possibilités sont barrées.

> L'espace vécu est :

- ouvert mais non protecteur
- vaste mais sans refuge
- exposant plutôt qu'accueillant

Rapport au corps et au sensoriel :

Le corps n'est pas explicitement décrit, mais il est fortement impliqué par les verbes « fuir » et « se cacher ».

Fuir suppose un corps capable de mouvement. Se cacher suppose un corps capable de se retirer, de se soustraire au regard ou à l'exposition. Or ces deux possibilités sont impossibles.

Le corps apparaît indirectement comme :

- un corps exposé
- empêché dans ses mouvements de retrait
- avec une sensation de froid, de dureté ou de saisissement

> corporéité exposée et immobilisée

= Le corps est sous le ciel, mais il ne peut ni partir ni se mettre à l'abri.

Rapport au soi :

Aucun « je » n'apparaît dans le haïku. Pourtant, contrairement à certains haïkus de Bashō ou de Buson, cet effacement n'est pas paisible.

- Le sujet est présent implicitement à travers l'impossibilité : quelqu'un ne peut ni fuir ni se cacher.
- Le soi apparaît donc non comme une présence contemplative, mais comme une présence exposée.

Il ne se donne pas par un discours intérieur, ni par une émotion explicitement nommée, mais par une limitation existentielle : ne pas pouvoir se soustraire.

> Soi exposé, sans refuge, confronté à l'impossibilité de se retirer du monde.

Rapport au monde et tonalité affective :

- Le monde apparaît ouvert, clair, mais froid.

Le « ciel bleu » pourrait évoquer une image lumineuse ou paisible, mais l'adjectif « glacé » modifie fortement cette tonalité.

- La clarté du monde n'est pas ici rassurante. Elle peut être vécue comme une exposition : sous un ciel clair, rien ne cache, rien ne protège, rien ne permet de disparaître.

Le monde n'est pas décrit comme chaotique ou violent. Il est plutôt trop ouvert, trop visible, trop froid.

Sa menace ne vient pas d'un débordement, mais d'une absence d'abri.

> La tonalité affective peut donc être décrite comme froide, exposée, tendue, sans refuge.

Étape 3 - Articulation structurante

La tension principale peut être formulée ainsi : ouverture / impossibilité du retrait

Elle articule :

- l'ouverture du ciel bleu
- la froideur du ciel glacé
- l'impossibilité de fuir
- l'impossibilité de se cacher

On pourrait également formuler cette tension comme :

exposition / absence d'abri

ou encore : clarté / menace

La clarté du ciel n'est pas vécue comme ouverture heureuse. Elle devient une condition d'exposition : sous ce ciel, le sujet ne peut ni s'échapper, ni se dissimuler.

Cette tension traverse :

- le rapport à l'espace : espace ouvert mais sans refuge ;
- le rapport au corps : impossibilité de fuir ou de se cacher ;
- le rapport au soi : présence exposée, sans retrait possible ;
- le rapport au monde : monde clair, froid, non accueillant ;
- le rapport au temps : immobilisation dans une situation sans issue immédiate.

Étape 4 - Structure de vécu

On peut formuler la structure de vécu de la manière suivante :

Le haïku donne à voir un monde ouvert, clair et froid. Le « ciel bleu » installe d'abord une image d'amplitude, mais l'adjectif « glacé » transforme cette ouverture en espace d'exposition. Le monde n'est pas fermé ; au contraire, il est trop ouvert pour permettre le retrait.

Les verbes « fuir » et « se cacher » indiquent deux possibilités fondamentales de soustraction : partir ou trouver un abri. Or ces deux possibilités sont déclarées impossibles. Le sujet n'est pas explicitement nommé, mais il apparaît dans cette impossibilité même : quelqu'un est exposé sous le ciel, sans pouvoir s'éloigner ni disparaître.

La structure de vécu s'organise ainsi autour d'une tension entre ouverture et impossibilité du retrait. L'espace est vaste, mais il n'est pas habitable comme refuge. Le monde est clair, mais cette clarté ne protège pas ; elle expose. Le vécu se caractérise par une présence contrainte, immobilisée dans un monde froid où aucune échappée ne semble disponible.

Commentaire clinique

Ce haïku permet de rappeler que l'ouverture du monde n'est pas toujours vécue comme liberté.

Dans le haïku de Buson, l'espace ouvert de la mer de printemps était ample, rythmique et apaisant. Ici, l'ouverture du ciel est froide et exposante. Le même type d'espace apparent — un espace vaste, dégagé, lumineux — peut donc correspondre à des structures de vécu très différentes.

Il faut également éviter de psychologiser trop vite le poème. On ne dira pas immédiatement : « le sujet est anxieux », « il veut disparaître », « il est persécuté ». On décrira d'abord la configuration de vécu proposée par le poème : être sous un ciel clair et glacé, sans possibilité de fuite ni d'abri.

Ce haïku montre ainsi que la phénoménologie ne s'intéresse pas seulement aux objets décrits, mais à leur mode d'apparition : ici, le ciel n'est pas seulement un ciel bleu ; il est un ciel sous lequel le sujet se trouve exposé, sans retrait possible.

Comparatif des cinq haïkus

Les cinq haïkus étudiés présentent des éléments apparemment proches : nature, saison, silence, monde non humain, effacement fréquent du sujet. Ils ne donnent cependant pas accès à la même structure de vécu.

L'analyse phénoménologique permet de montrer que ce qui varie n'est pas seulement le contenu du poème, mais la manière dont l'espace, le temps, le soi et le monde se tiennent ensemble dans l'expérience.

Variations transversales

On peut repérer plusieurs variations transversales.

Espace : on passe du circonscrit et dense chez Bashō, au dépouillé dans le haïku du corbeau, puis au diffus et précaire chez Issa, avant de trouver chez Buson un espace vaste, ouvert et ample. Avec Mayuzumi, l'espace est également vaste et ouvert, mais cette ouverture n'est plus apaisante : elle devient exposition, absence d'abri, impossibilité de se cacher.

Temps : on passe de l'instant ponctuel inscrit dans une continuité paisible, à l'instant suspendu du soir d'automne, puis à l'impermanence douloureusement reconnue chez Issa, avant d'arriver au rythme ondulatoire et continu de la mer de printemps. Chez Mayuzumi, le temps semble au contraire immobilisé par l'impossibilité : aucune fuite, aucun retrait, aucune transformation immédiate de la situation ne paraît disponible.

Soi : on observe un effacement paisible chez Bashō, une contemplation silencieuse dans le haïku du corbeau, une implication affective forte chez Issa, puis un accord contemplatif au rythme du monde chez Buson. Chez Mayuzumi, le soi n'est pas explicitement nommé, mais il apparaît comme exposé : quelqu'un se trouve sous ce ciel clair et froid, sans possibilité de fuir ou de se cacher.

Monde :

- Chez Bashō, le monde apparaît stable ou dépouillé, et le soi s'efface paisiblement dans la perception. Le sujet ne s'impose pas au monde ; il laisse apparaître un lieu, un événement minimal, une présence.

Dans le haïku du corbeau, le monde est plus dépouillé et mélancolique, mais il demeure habitable. La branche morte, le corbeau et le soir d'automne composent une expérience de dénuement, sans effondrement.

- Chez Issa, le monde devient fragile et précaire. Le soi, bien que non nommé, apparaît fortement affecté par cette impermanence. Le « et pourtant » marque la persistance de l'attachement au cœur même de la lucidité.

- Chez Buson, le monde est ample, continu et harmonique. Le soi est accordé au rythme du monde, dans une forme de présence contemplative et apaisée.

- Chez Mayuzumi, le monde est également ouvert, mais il n'est pas vécu comme un espace d'accord ou de respiration. Le ciel clair et froid expose le sujet à une impossibilité : il ne peut ni fuir, ni se cacher. L'ouverture du monde devient alors une absence de refuge.

Tableau synoptique :

Haïku	Espace	Temps	Soi	Monde
Bashō — « Vieil étang »	Circonscrit, délimité, dense	Instant ponctuel dans une continuité paisible	Effacé, réceptif	Stable, silencieux, auto-suffisant
Bashō — « Corbeau sur branche morte »	Minimal, localisé, dépouillé	Instant suspendu inscrit dans un déclin saisonnier	Effacé, contemplatif	Dénudé, mélancolique mais habitable
Issa — « Monde de rosée »	Diffus, sans contours, précaire	Impermanent, sans durée stabilisable	Affecté, impliqué, traversé par une tension	Fragile, précaire, exposé à la disparition
Buson — « Mer de printemps »	Vaste, ouvert, continu	Rythmique, ondulatoire, continu	Accordé, contemplatif	Harmonique, autorégulé, apaisant
Mayuzumi — « Sous le ciel bleu glacé »	Vaste, ouvert, exposant, sans abri	Suspendu, immobilisé par l'impossibilité	Exposé, empêché dans le retrait	Clair, froid, non protecteur

Point méthodologique

Ce comparatif montre que l'analyse phénoménologique ne cherche pas seulement à identifier des thèmes : nature, saison, solitude, calme, mélancolie, fragilité ou froideur...

> Elle cherche à comprendre comment les dimensions du vécu s'articulent entre elles.

Ce qui varie d'un haïku à l'autre :

- pas seulement le contenu (étang, rosée, branche, mer, ciel...)

> c'est la structure de vécu :

- . un *monde stable*, silencieux, brièvement intensifié par un son ;
- . un *monde dépouillé*, mélancolique mais habitable ;
- . un *monde fragile*, reconnu comme impermanent mais encore affectivement investi ;
- . un *monde ample*, rythmique et apaisant ;
- . un *monde ouvert*, clair et froid, où le sujet se trouve exposé sans possibilité de retrait.

La comparaison entre Buson et Mayuzumi est particulièrement importante :

- Dans les deux cas, l'espace est vaste et ouvert.
 - mais chez Buson, cette ouverture est vécue comme accord rythmique au monde
 - chez Mayuzumi, elle est vécue comme exposition froide, sans abri possible
- = un même type d'espace apparent peut donc soutenir des structures de vécu très différentes.

Point phénoménologique

La question est la même que dans l'analyse clinique : *Comment le monde est-il vécu ici ?*

Même lorsqu'il n'y a ni plainte, ni récit, ni « je » explicite, le texte donne accès à une *certaine manière d'habiter le temps, l'espace et le monde*.

L'intérêt phénoménologique du haïku tient à sa capacité à faire apparaître une expérience du monde avec très peu d'éléments :

- Il montre comment un monde apparaît dans un champ de présence réduit, souvent silencieux, presque sans explication.
- Il ne cherche pas d'abord à raconter, à expliquer ou à symboliser.
- Il donne à voir une configuration minimale de l'expérience : un espace, un temps, une perception, parfois un événement infime, parfois une impossibilité.

Le silence comme condition de l'apparition

Dans beaucoup de haïkus, le monde apparaît d'abord sur un fond calme, stable ou dépouillé :

- le vieil étang
- la branche morte
- la mer de printemps
- le ciel bleu glacé

Ce fond n'est pas un simple décor. Il correspond à une suspension de l'activité humaine, du commentaire et de l'interprétation.

Phénoménologiquement, cela signifie que le monde est donné dans une disponibilité perceptive : les choses peuvent apparaître parce qu'elles ne sont pas immédiatement recouvertes par l'explication, l'action ou le jugement.

Le silence fonctionne alors comme une condition d'émergence du phénomène. Il rend perceptible ce qui, autrement, passerait inaperçu.

L'événement minimal comme révélation du réel

Dans le haïku du vieil étang, l'événement est presque insignifiant :

- une grenouille plonge
- un bruit d'eau se fait entendre

C'est précisément ce micro-événement qui fait apparaître le monde. Le bruit de l'eau révèle à la fois la présence de l'étang, la profondeur du silence et la densité de l'instant.

Le phénomène n'est pas spectaculaire. Il est minimal, mais suffisant pour rendre le monde présent.

Le haïku montre ainsi que l'expérience du réel n'a pas toujours besoin d'un événement majeur : une variation infime peut modifier l'intensité du monde et le faire apparaître autrement.

L'apparition du monde

On peut décrire cette structure de la manière suivante :

silence → micro-événement → intensification de la présence du monde

Dans cette configuration, le monde est déjà là, mais il devient soudain plus sensible. Le haïku donne accès à l'instant où quelque chose advient dans un champ de perception calme.

Ce qui apparaît n'est pas seulement un objet. C'est la présence même du monde : un lieu, un rythme, une tonalité, une manière d'être là.

Le haïku du vieil étang ne dit donc pas seulement :

- il y a un étang, une grenouille, un bruit d'eau.
- Il donne à éprouver la manière dont un événement minime peut faire surgir la présence du réel.

Une discipline phénoménologique du regard

Dans beaucoup d'analyses spontanées, on cherche immédiatement :

- le sens caché
- le symbole
- l'intention de l'auteur
- l'explication biographique
- l'interprétation culturelle, etc.

Vs : Le haïku invite à faire un autre geste : *laisser apparaître ce qui se donne*.

En ce sens, il constitue un excellent exercice phénoménologique :

- il apprend à suspendre l'interprétation immédiate
- > pour décrire l'apparition du monde dans sa simplicité.

= une forme de réduction phénoménologique poétique :

- réduction de l'expérience à quelques éléments essentiels (espace, temps, perception, tonalité, événement)
- > afin de rendre visible la manière dont le monde se manifeste.

Le haïku ne raconte pas une histoire et ne développe pas une psychologie.

Le haïku montre comment un monde se donne : dans un silence, un rythme, une fragilité, une perception, un événement minuscule, une tonalité ou une impossibilité.

L'analyse phénoménologique du haïku consiste alors à décrire cette configuration : comment l'espace, le temps, le soi et le monde se tiennent ensemble dans l'expérience.

La question centrale reste : comment le monde apparaît-il ici (au sujet) ?

3.2. Poèmes

Poèmes et phénoménologie

Les haïkus travaillent l'apparition minimale du monde ; les poèmes (de Hugo) permettent plutôt de travailler des *mondes vécus plus amples* (monde social écrasant, monde sublime, monde métaphysique saturé de sens).

Il faut donc garder la même méthode, mais adapter l'enjeu : on ne décrit plus seulement une scène brève, mais une *configuration existentielle élargie*.

L'objectif reste donc le même :

- il ne s'agit pas d'abord de chercher un symbole caché, une intention de l'auteur ou une explication biographique
- > il s'agit de décrire :
 - . comment un monde apparaît dans le poème
 - . quelle position subjective ou perceptive y est configurée
 - . et quelles dimensions de l'existence sont mobilisées

On peut donc poser les mêmes questions :

- comment l'espace est-il vécu ?
- comment le temps se déploie-t-il ?
- comment le corps apparaît-il ?
- quelle place occupe le sujet ? (quelle place occupe la voix, le regard ou la présence implicite ?)
- comment le monde se présente-t-il ?
- quelle tonalité affective domine ?
- quelle tension ou quelle structure de vécu se dégage ?

Avec Victor Hugo, ces questions prennent une ampleur particulière :

- les poèmes ne décrivent pas seulement des états intérieurs
- > ils construisent des mondes :
 - . monde social écrasant dans « Melancholia »
 - . monde sublime et océanique dans « Océan »
 - . monde métaphysique et parlant dans « Ce que dit la bouche d'ombre ».

« Melancholia » – Victor Hugo (*Les Contemplations*, 1856)

« Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ?
Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ?
Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules ;
Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement
Dans la même prison le même mouvement.
Accroupis sous les dents d'une machine sombre,
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre,
Innocents dans un baignoire, anges dans un enfer,
Ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer.
Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue.
Aussi quelle pâleur sur la lèvre et la joue !
Leurs regards sont pareils à ceux des vieilles gens ;
Leur front est plissé comme un front de vieillard.
Ô servitude infâme imposée à l'enfant !
Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant
Défait ce qu'a fait Dieu ! »

Étape 1 - Repérage du vécu

Le vécu exprimé est marqué par :

- la présence d'enfants privés de joie : « dont pas un seul ne rit » ;
- une altération corporelle : « la fièvre maigrit », « pâleur », « rachitisme » ;
- une solitude du cheminement : « cheminer seules » ;
- un temps de travail excessif : « quinze heures » ;
- une répétition mécanique : « éternellement / dans la même prison le même mouvement » ;
- un espace d'enfermement : « prison », « baignoire », « enfer » ;
- une machine décrite comme monstrueuse : « machine sombre », « monstre hideux » ;
- une absence de jeu et d'arrêt : « jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue » ;
- un vieillissement prématuré : « regards [...] de vieilles gens », « front de vieillard » ;
- une indignation morale : « servitude infâme imposée à l'enfant ».

Le poème donne accès à une *expérience collective* : celle d'enfants dont le monde est organisé par le travail, l'enfermement, l'usure et la répétition.

Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu

Temporalité :

- Le temps est répétitif et sans ouverture : les enfants travaillent « de l'aube au soir », « quinze heures », dans « le même mouvement ».
- Le temps ne se présente pas comme devenir, apprentissage ou croissance : il est fermé sur la répétition.
- L'enfance, qui devrait être temps du jeu et du possible, devient temps d'épuisement.
- > La temporalité peut donc être décrite comme un temps captif : un temps qui se répète sans avenir.

Spatialité :

- L'espace est fermé, lourd, oppressant : les images de « prison », de « bagné » et d'« enfer » transforment le lieu de travail en espace d'enfermement.
- La machine occupe l'espace comme une présence sombre et menaçante : l'enfant est placé « sous les dents » de la machine, dans une position de soumission et de danger.
- > L'espace n'est donc pas habitable : il est écrasant, mécanique, sans retrait possible.

Corporéité :

- Le corps est central. Il apparaît comme amaigri, pâle, fatigué, vieilli avant l'âge.
- Le corps enfantin, qui devrait être associé au jeu, à la croissance et à l'élan vital, est ici déformé par le travail.
- La machine ne sollicite pas le corps comme puissance d'action, mais comme force exploitée.
- Le corps devient corps d'usure, corps soumis à un rythme mécanique.

Altérité :

- L'altérité apparaît surtout sous la forme d'un monde social injuste : les enfants ne sont pas décrits dans une relation de soin ou de protection, mais dans une relation d'exploitation.
- La société est implicitement présente comme instance qui impose la servitude : l'enfant n'est pas reconnu comme sujet à protéger, mais utilisé comme force de travail.

Ipséité :

- Le sujet n'est pas ici un individu isolé, mais un sujet collectif : les enfants.
- Leur possibilité d'être enfants est atteinte. Ils ne rient pas, ne jouent pas, ne grandissent pas librement. Leur rapport à eux-mêmes est marqué par l'usure précoce : ils portent déjà les signes de la vieillesse.
- L'ipséité collective apparaît donc comme appauvrie : l'enfance est empêchée de se déployer comme enfance.

Mondanéité :

- Le monde apparaît lourd, mécanique, écrasant. Il est fait d'« airain » et de « fer ». Il n'est pas souple, vivant ou accueillant ; il est dur, fermé, industriel.
- Ce monde ne soutient pas la croissance. Il défait ce qui devrait se construire. Il ne permet pas à l'enfant d'habiter le monde comme espace de jeu, d'apprentissage ou de devenir.

Étape 3 - Tension structurante

Passage vers la tension structurante :

- Les différentes dimensions convergent vers une tension entre l'enfance comme puissance de vie et le monde social qui l'écrase.
- Le poème ne décrit pas seulement des enfants pauvres ou fatigués. Il donne à voir une contradiction existentielle :
 - l'enfance devrait être ouverture, jeu et croissance
 - elle est enfermée dans un monde de répétition, de travail et d'usure.

La tension centrale peut être formulée ainsi : *élan vital / écrasement mécanique*

Elle articule :

- l'enfance comme devenir et promesse de vie ;
- le travail comme répétition forcée ;

- le corps vivant comme corps usé ;
- le temps de la croissance comme temps captif ;
- le monde social comme machine d'écrasement.

Cette tension traverse :

- le corps : croissance empêchée, fatigue, pâleur ;
- le temps : enfance transformée en répétition sans avenir ;
- l'espace : prison, bagné, enfer ;
- l'action : mouvement imposé, non approprié ;
- le monde : univers industriel dur, sombre, inhumain.

Étape 4 - Structure de vécu

On peut formuler la structure de vécu de la manière suivante :

Le poème donne à voir un monde social où l'enfance est arrachée à son mouvement propre. Les enfants ne sont pas décrits comme des sujets en croissance, mais comme des corps usés, pâles, vieillissant avant l'âge, soumis au rythme répétitif du travail.

L'espace est fermé et oppressant : prison, bagné, enfer. Le temps est lui aussi captif : de l'aube au soir, le même mouvement se répète, sans jeu, sans pause, sans avenir. La machine transforme le monde en milieu d'écrasement.

La structure de vécu s'organise donc autour d'une tension entre élan vital et écrasement mécanique. Ce qui devrait grandir est usé ; ce qui devrait jouer est contraint ; ce qui devrait s'ouvrir à l'avenir est enfermé dans la répétition.

Le monde décrit par Hugo est un monde inhabitable pour l'enfance : un monde où la vie est présente, mais empêchée de se déployer.

« Océan » – Victor Hugo (La Légende des siècles, 1859)

« L'Océan était sombre, et rugissait.
L'onde immense roulait ses vagues éternelles.
Je regardais.
Tout fuyait, tout montait, tout retombait sans cesse.
Le flot semblait vivant d'une sombre pensée.
L'espace s'ouvrait sans bornes.
Je sentais que mon âme, en face de cet abîme,
Se troublait, se fondait, s'élargissait peut-être.
Je n'étais plus qu'un point dans l'immense rumeur.
Le temps n'était plus fait d'instant,
Mais d'un seul mouvement profond,
Toujours le même, toujours recommencé.
Et je demeurais là,
Petit, silencieux,
Présent à ce qui me dépassait infiniment. »

Étape 1 - Repérage du vécu

Le vécu exprimé est marqué par :

- un monde immense et sombre : « l'Océan était sombre » ;
- un mouvement puissant : « rugissait », « roulait ses vagues » ;
- une position contemplative : « je regardais » ;
- une ouverture sans limites : « l'espace s'ouvrait sans bornes » ;
- une altération du rapport à soi : « mon âme [...] se troublait, se fondait, s'élargissait » ;

- une réduction de la centralité du sujet : « je n'étais plus qu'un point » ;
 - une temporalité profonde et répétitive : « toujours le même, toujours recommencé » ;
 - une présence silencieuse à ce qui dépasse le sujet.
- > Le poème donne accès à une expérience du sublime : le sujet se trouve face à un monde immense, qui le dépasse sans nécessairement le détruire.

Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu

Temporalité :

- Le temps n'est pas constitué d'instants séparés. Il est décrit comme « un seul mouvement profond », « toujours le même, toujours recommencé ».
- La temporalité est cyclique, cosmique, répétitive mais vivante.
- Elle ne correspond pas à la répétition mécanique de « Melancholia ». Ici, la répétition n'écrase pas ; elle ouvre à une profondeur.

Spatialité :

- L'espace est immense, ouvert, sans bornes. L'océan ne constitue pas un lieu circonscrit ; il ouvre sur l'illimité.
- Cet espace n'est pas simplement décoratif. Il transforme la position du sujet : face à l'océan, le sujet se découvre petit, limité, décentré.
- > L'espace est donc vécu comme amplitude et dépassement.

Corporéité :

- Le corps est peu décrit, mais il est impliqué par la posture : « je regardais », « je demeurais là ».
- Il s'agit d'une corporéité contemplative : le corps est présent, immobile, exposé à l'immensité. Il ne cherche pas à agir sur le monde ; il se tient face à ce qui le dépasse.

Ipséité :

- Le soi est relativisé. Le sujet ne disparaît pas, mais il perd sa centralité : « je n'étais plus qu'un point ».
- Cette diminution n'est pas vécue comme un effondrement. Elle peut être associée à un élargissement : « mon âme [...] s'élargissait peut-être ».
- Le soi est donc déplacé : il cesse d'être centre du monde, mais il s'ouvre à une dimension plus vaste.

Mondanéité :

- Le monde apparaît immense, vivant, profond. Il n'est pas hostile au sens strict, même s'il est sombre et puissant.
- L'océan donne accès à une totalité qui dépasse le sujet. Le monde est plus grand que lui, plus ancien, plus profond, plus continu.
- La mondanéité est donc celle du sublime : le monde se donne comme excès, mais un excès que le sujet peut contempler.

Étape 3 - Tension structurante

Passage vers la tension structurante :

- Les dimensions convergent vers une tension entre petitesse du sujet et immensité du monde.
- Le poème ne décrit pas une disparition du sujet, mais une transformation de sa position. Face à l'océan, le sujet se découvre minuscule, mais cette diminution peut devenir ouverture.

La tension centrale peut être formulée ainsi : *petitesse du soi / immensité du monde*

Elle articule :

- l'immensité de l'océan
- la puissance du mouvement
- l'ouverture illimitée de l'espace
- la réduction du sujet à un « point »

- l'élargissement possible de l'âme

Cette tension n'est pas pathologique. Elle permet de travailler une expérience rare dans les vignettes cliniques : l'altération du rapport à soi comme ouverture au sublime.

Étape 4 - Structure de vécu

On peut formuler la structure de vécu de la manière suivante :

Le poème donne à voir un monde immense, sombre et vivant, dont le mouvement dépasse la mesure humaine. L'espace s'ouvre sans bornes, le temps devient mouvement profond, et l'océan apparaît comme une totalité qui enveloppe le sujet.

Face à cette immensité, le soi perd sa centralité. Le sujet se vit comme petit, silencieux, presque réduit à un point. Mais cette réduction ne prend pas la forme d'une disparition angoissée. Elle peut devenir élargissement : le sujet se découvre moins comme centre que comme présence ouverte à ce qui le dépasse.

La structure de vécu s'organise ainsi autour d'une tension entre petitesse du soi et immensité du monde. Le sujet n'est pas détruit par l'océan ; il est décentré, relativisé, peut-être agrandi par l'expérience du sublime.

« Ce que dit la bouche d'ombre » – Victor Hugo (Les Contemplations, 1856)

« Ne dites pas : la mort, le sombre gouffre.

Tout vit.

Ce que vous appelez la nuit

Est une aurore invisible.

L'univers est un temple immense

Où l'ombre pense.

L'homme n'est qu'un point dans l'infini,

Mais ce point sent.

Le vide est plein.

Ce que vous croyez borne est passage.

Rien n'est muet ; tout parle.

La matière est un voile ;

L'esprit souffle partout.

Les mondes se pénètrent.

L'abîme est en vous comme hors de vous.

Vous tremblez parce que vous êtes au seuil.

Le seuil n'est pas la fin,

Mais la métamorphose.

Vous dites : je suis seul.

Vous ne l'êtes jamais.

Vous dites : je tombe.

Vous montez.

L'effroi vient de ce que l'âme

Se sent agrandie.

Ne croyez pas que l'ombre soit l'ennemie.

Elle est la profondeur. »

Étape 1 - Repérage du vécu

Le vécu exprimé est marqué par :

- une transformation de la mort en passage ;
- une inversion de la nuit en aurore invisible ;
- une vision de l'univers comme totalité vivante : « tout vit » ;
- un espace immense et spirituel : « l'univers est un temple immense » ;

- une présence du sens dans toute chose : « rien n'est muet ; tout parle » ;
- une dissolution des frontières : « les mondes se pénètrent » ;
- une articulation du dedans et du dehors : « l'abîme est en vous comme hors de vous » ;
- une expérience de seuil : « vous êtes au seuil » ;
- une transformation de la peur en agrandissement ;
- une solitude niée : « vous ne l'êtes jamais ».

> Le poème donne accès à un monde saturé de sens, où ce qui semblait limite, vide ou mort devient passage, profondeur et métamorphose.

Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu

Spatialité :

- L'espace est illimité, profond, traversable.
 - Les images de gouffre, d'abîme, de seuil et d'infini ne désignent pas seulement des lieux : elles transforment le rapport à l'espace.
 - La borne n'est plus une limite fixe : elle devient passage.
 - Le seuil n'est pas une fin : il ouvre vers une métamorphose.
 - Le dedans et le dehors se répondent : « l'abîme est en vous comme hors de vous ».
- > L'espace vécu est donc celui de la profondeur et du passage.

Temporalité :

- Le temps n'est pas linéaire. La nuit devient « aurore invisible » ; la mort devient métamorphose. Ce qui semblait fin est relu comme transformation.
- La temporalité est donc orientée vers le passage : elle ne se réduit pas à la rupture ou à l'arrêt. Elle ouvre vers une autre forme de devenir.

Altérité :

- L'altérité est ici cosmique ou métaphysique. Le sujet n'est jamais seul, parce que le monde entier est habité, parlant, traversé par « l'esprit ».
- L'autre n'est pas seulement une personne ; il est la profondeur du monde, la voix de l'ombre, la présence du vivant dans l'univers.

Ipséité :

- Le sujet humain est relativisé : « l'homme n'est qu'un point dans l'infini ». Mais ce point sent.
- Le sujet est petit, mais sensible ; limité, mais ouvert à l'infini.
- Cette expérience n'est pas une destruction du soi. Elle est plutôt un agrandissement. L'effroi vient de ce que l'âme « se sent agrandie ».
- Le soi est donc décentré, mais non aboli.

Mondanité :

- Le monde apparaît saturé de sens. « Rien n'est muet ; tout parle. » Le vide est plein, l'ombre pense, la matière est un voile.
- Le monde n'est pas neutre. Il est habité, parlant, spirituel. Il ne se donne pas comme absence de sens, mais comme excès de signification.
- Cette mondanité est très différente de celle du *Horla*
 - . Dans *Le Horla*, l'invisible est vécu comme domination et dépossession
 - . Ici, l'invisible est vécu comme profondeur et métamorphose.

Étape 3 - Tension structurante

Passage vers la tension structurante :

- Les dimensions convergent vers une tension entre limite et passage.
- Le poème transforme les expériences qui pourraient être vécues comme des fins — mort, nuit, gouffre, borne, solitude, chute — en expériences de passage, d'aurore, de profondeur, de présence ou d'élévation.

La tension centrale peut être formulée ainsi : *limite / passage*

Elle articule :

- la mort et la métamorphose ;
- la nuit et l'aurore invisible ;
- la borne et le passage ;
- la chute et l'élévation ;
- la solitude et la présence invisible ;
- l'effroi et l'agrandissement.

Cette tension traverse :

- l'espace : gouffre, abîme, seuil, infini ;
- le temps : fin transformée en devenir ;
- le soi : petit point sensible dans l'infini ;
- le monde : univers parlant, habité, saturé de sens.

Étape 4 - Structure de vécu

On peut formuler la structure de vécu de la manière suivante :

Le poème donne à voir un monde où les limites ne sont pas vécues comme des fermetures, mais comme des passages. La mort, la nuit, le gouffre, la borne et le seuil ne désignent pas seulement la fin ou l'arrêt ; ils deviennent les formes d'une métamorphose.

Le sujet humain est décentré : il n'est qu'un point dans l'infini. Mais ce point sent. Il n'est donc pas annulé par l'immensité du monde ; il est rendu sensible à une profondeur qui le dépasse.

Le monde apparaît saturé de sens : rien n'est muet, tout parle, le vide est plein, l'ombre pense. Cette surabondance de sens peut produire de l'effroi, mais cet effroi est compris comme le signe d'un agrandissement.

La structure de vécu s'organise ainsi autour d'une tension entre limite et passage. Ce qui semblait fin devient transformation ; ce qui semblait vide devient profondeur ; ce qui semblait solitude devient appartenance à un monde habité.

Comparatif des trois poèmes

Les trois textes permettent de travailler **Trois grandes structures de vécu.**

Texte	Espace	Temps	Soi	Monde	Structure dominante
« Melancholia »	Fermé, lourd, carcéral	Répétitif, captif, sans avenir	Sujet collectif usé, enfance empêchée	Monde mécanique, socialement écrasant	Élan vital / écrasement mécanique
« Océan »	Immense, ouvert, sans bornes	Cosmique, cyclique, profond	Soi relativisé, silencieux, élargi	Monde sublime, englobant, vivant	Petitesse du soi / immensité du monde
« Ce que dit la bouche d'ombre »	Profond, traversable, infini	Transformation, métamorphose	Soi décentré mais sensible	Monde parlant, saturé de sens	Limite / passage

Ces trois poèmes montrent que :

- la phénoménologie ne sert pas seulement à décrire des vécus cliniques de souffrance
- elle permet plus largement de comprendre des manières d'habiter le monde.
- Dans « Melancholia », le monde est socialement inhabitable : il détruit l'enfance et transforme le temps en répétition sans avenir.
- Dans « Océan », le monde dépasse le regard humain sans le détruire. Le soi perd sa centralité, mais cette perte peut devenir ouverture au sublime.

- Dans « Ce que dit la bouche d'ombre », le monde est traversé de sens. Les limites deviennent passages, la mort devient métamorphose, l'ombre devient profondeur.

Point méthodologique important :

- une altération du rapport à soi ou au monde n'est pas nécessairement pathologique.
- Se sentir petit, décentré, traversé ou agrandi peut relever d'une expérience poétique, spirituelle ou sublime, et non d'une désorganisation pathologique.
- > L'analyse phénoménologique doit donc rester attentive à la tonalité du vécu : écrasement, ouverture, effroi, agrandissement, paix, contrainte ou passage ne désignent pas la même manière d'être au monde.

3.3. Images, tableaux et estampes

Images et phénoménologie : estampes, tableaux, scènes visuelles

Analyser des configurations de l'être-au-monde sans récit

À la différence d'un entretien clinique ou d'un récit littéraire, l'image ne présente pas nécessairement un sujet qui parle de lui-même. Elle donne plutôt à voir une configuration du monde :

- un espace ;
- un moment ;
- une tonalité ;
- une manière d'être situé ;
- une certaine relation entre présence humaine et monde.

À ce titre, les images prolongent le travail déjà mené sur les haïkus : elles permettent d'apprendre à décrire une expérience sans récit, sans explication et parfois sans figure humaine centrale.

L'enjeu n'est pas de demander immédiatement : *Que représente cette image ?*

> mais plutôt : *Comment le monde apparaît-il ici ?*

> ou encore : *Quelle configuration de vécu cette image rend-elle visible ?*

Le point de départ est descriptif : comment l'image organise-t-elle un rapport à l'espace, au temps, au corps, aux autres, au soi et au monde ?

Entraînement du regard en phénoménologie

Variation des supports :

- dans une *vignette clinique* : l'expérience est souvent donnée par des paroles, des récits, des gestes ou des observations.
- dans un *poème ou un haïku* : l'expérience est donnée par des mots, des rythmes et des images verbales.
- dans une *œuvre visuelle* : l'expérience se donne à travers la composition, les formes, les distances, les orientations, les corps, les lumières, les couleurs, les mouvements suggérés ou les espaces laissés ouverts.

> Cela oblige à *décrire ce qui apparaît avant de l'interpréter*.

Travailler sur des images permet donc de :

- décrire une configuration de vécu sans récit explicite
- analyser l'espace vécu, souvent central dans l'image
- repérer une tonalité affective globale
- penser la place, l'effacement ou l'exposition de la présence humaine
- distinguer perception, interprétation et symbolisation
- exercer l'époche à partir d'un matériau non clinique.

> L'image est un bon support d'apprentissage : elle oblige à ralentir le regard. Elle apprend à ne pas dire trop vite « cela signifie que... », mais à commencer par : « voici comment le monde se donne ici ».

Principe fondamental de l'analyse phénoménologique de l'image

Face à une image, la question phénoménologique est comment le monde se donne-t-il ici à être vécu ?

L'analyse ne cherche donc pas immédiatement :

- le symbole caché
- la signification culturelle
- l'intention de l'artiste
- la biographie du peintre
- la psychologie des figures représentées
- l'émotion personnelle du spectateur.

Elle cherche d'abord à décrire une *manière d'apparaître du monde*. Une image peut ainsi configurer :

- un monde menaçant
- un monde habitable
- un monde ralenti
- un monde socialement animé
- un monde désaffecté
- un monde immense
- un monde enveloppant
- un monde exposant
- un monde fragile ou instable. Etc.

Ce que l'on analyse n'est donc pas la structure psychique de l'artiste, ni celle d'un personnage représenté, ni celle du spectateur empirique :

- > on analyse une *configuration de vécu* rendue visible par l'image.
- > l'image donne accès à une *manière possible d'être-au-monde*.

Ce que toute image donne à analyser

Même sans texte, toute image peut donner accès à plusieurs dimensions du vécu. On peut notamment y repérer :

- un rapport à l'espace
- un rapport au temps
- une certaine implication du corps
- une position du regard
- une place accordée à la présence humaine
- une forme d'altérité
- une tonalité globale du monde.

Ces dimensions ne sont pas ajoutées arbitrairement par l'analyse : elles sont impliquées dans la manière dont l'image organise l'apparition du monde.

Dans les analyses ci-après : une vague immense, un pont sous la pluie, un village enneigé, une surface d'eau couverte de reflets, un bal populaire ou deux figures silencieuses dans un café ne configurent pas le même monde. Chaque image donne à voir une manière différente d'habiter l'espace, le temps, le corps, les autres et le monde.

Axes d'analyse phénoménologique

Rapport à l'espace

L'espace est souvent l'axe central de l'analyse d'image. On peut se demander :

- l'espace est-il ouvert ou fermé ?
- stable ou instable ?
- traversable ou contraignant ?
- vaste ou resserré ?
- habitable ou exposant ?
- y a-t-il des seuils, des limites, des obstacles ?
- le regard est-il surplombant, immergé, distant, frontal, décentré ?
- l'espace invite-t-il à l'action, à la contemplation, au retrait, à la traversée ou à l'immobilité ?

> Il s'agit de comprendre comment l'espace est vécu ou rendu habitable par l'image.

Par exemple, un pont peut configurer un espace de traversée ; une vague peut configurer un espace de puissance et d'exposition ; un café peut devenir un espace social désaccordé ; une surface d'eau peut produire un espace flottant, sans horizon stable.

Rapport au temps

L'image ne raconte pas toujours une histoire, mais elle configure souvent une temporalité. On peut se demander s'il s'agit :

- d'un instant suspendu ?
- d'un moment d'imminence ?
- d'un événement soudain ?
- d'une durée ralentie ?
- d'un temps cyclique ?
- d'une stagnation ?
- d'une continuité paisible ?
- d'une transformation silencieuse ? Etc.

Le temps vécu peut être suggéré par :

- la météo
- le mouvement
- la lumière
- les postures
- l'état des corps
- la présence ou l'absence d'événement
- la tension entre ce qui arrive et ce qui demeure. Etc.

Cf. les exemples ci-dessous :

- dans *La Grande Vague de Kanagawa*, le temps est celui de l'imminence
- dans *Averse soudaine sur le pont Ōhashi*, il est celui d'une urgence ordinaire.
- dans *Neige à Kanbara*, il devient lent et silencieux.
- dans *L'Absinthe*, il semble presque stagnant.

Rapport au corps

Même lorsqu'aucun corps humain n'est représenté, l'image peut engager une corporéité. On peut se demander :

- les corps sont-ils actifs, immobiles, courbés, exposés, protégés, affaissés, dansants ?
- le corps est-il engagé dans l'action, la contemplation, la protection, la fatigue, l'attente ?
- l'image sollicite-t-elle le corps du regardeur : tension, immersion, anticipation, calme, malaise, absorption ?
- le monde impose-t-il un ajustement corporel ?
- le corps est-il vecteur d'élan, de retrait, de protection ou de co-présence ?

Dans une image, le corps n'est pas seulement une forme visible. Il indique une *manière d'être engagé dans le monde*.

Cf. les exemples ci-dessous :

- les silhouettes penchées sous la pluie chez Hiroshige ne disent pas une psychologie individuelle : elles montrent une corporéité ajustée à un événement météorologique.
- les corps dansants et tournés les uns vers les autres chez Renoir montrent une corporéité sociale.
- les corps assis et affaissés chez Degas configurent une présence ralentie, peu mobilisée.

Rapport au soi ou position subjective

Dans l'analyse d'une image, on évitera de parler trop vite du « sujet » comme s'il s'agissait d'un patient ou d'un personnage psychologique. On parlera plutôt de :

- position du regard
- présence implicite
- position subjective configurée par l'image
- place de l'humain dans le monde
- manière possible d'être situé. Etc.

On peut se demander :

- la présence humaine est-elle centrale, marginale, minuscule ou absente ?
- le regard est-il placé en position de maîtrise, d'impuissance, d'immersion ou de contemplation ?
- l'humain apparaît-il comme exposé, accordé, isolé, socialement engagé, décentré ?
- l'image invite-t-elle à se tenir face au monde, dans le monde, au bord du monde, ou parmi les autres ? Etc.

L'effacement du sujet n'est pas nécessairement une perte. Il peut être :

- paisible, contemplatif, accordé au monde
- ou au contraire exposé, empêché, désinscrit.

L'enjeu est de décrire la position (subjective) configurée par l'image, non de supposer une intériorité psychologique.

Rapport à l'altérité

L'altérité peut prendre plusieurs formes dans une image. Elle peut être :

- humaine : personnages, foule, couple, groupe, co-présence ;
- non humaine : nature, mer, montagne, pluie, neige, lumière ;
- sociale : lieu de rencontre, café, bal, rue, pont ;
- anonyme : silhouettes, passants, figures non individualisées ;
- absente : monde sans figures humaines explicites.

On peut se demander :

- les autres sont-ils proches ou lointains ?
- individualisés ou anonymes ?
- soutenant, menaçant, indifférents ou simplement présents ?
- y a-t-il rencontre, juxtaposition, coexistence, foule, isolement ?
- la proximité produit-elle une relation ou reste-t-elle sans échange ?

Cf. les exemples ci-après :

- chez Renoir, l'altérité soutient une sociabilité habitée.
- chez Degas, la proximité physique ne produit pas de rencontre vivante.
- chez Hiroshige, l'altérité est une coexistence ordinaire dans un même événement atmosphérique.

Rapport au monde et tonalité globale

Enfin, il faut dégager la tonalité globale du monde configuré par l'image. On peut se demander :

- le monde apparaît-il habitable ?
- menaçant ?
- harmonique ?
- indifférent ?
- changeant ?
- silencieux ?
- socialement animé ?
- désaffecté ?
- enveloppant ?
- exposant ?
- stable ou instable ? Etc.

La *tonalité* n'est pas une émotion de l'artiste, ni un symptôme, ni une projection personnelle du spectateur. Elle désigne la manière globale dont le monde apparaît dans l'image. Une tonalité peut être :

- calme
- mélancolique
- + tendue

- fragile
- sereine
- exposée
- immersive
- festive
- désaffectée
- silencieuse.

Cette tonalité doit toujours être justifiée par les éléments visibles : composition, lumière, espace, corps, distances, mouvements, figures, atmosphère.

Une structure d'« être-au-monde » possible

L'analyse se conclut par une formulation synthétique de la structure de vécu configurée par l'image.

On évitera la formule : « *Le vécu du sujet se caractérise par...* » car il n'y a pas nécessairement de sujet clinique. On préférera :

- l'image configure une expérience de...
- ou : la structure de vécu rendue visible par l'image peut être décrite comme...
- ou encore : le monde apparaît ici selon une modalité de...

Cette formulation doit :

- articuler espace, temps, corps, soi, altérité et monde ;
- rester descriptive ;
- éviter l'interprétation symbolique immédiate ;
- éviter la psychologisation des figures ;
- montrer ce que cette configuration rend possible ;
- montrer ce qu'elle limite ou empêche.

Ce que l'on entend par « structure de vécu » lorsqu'on analyse une image > il ne s'agit pas :

- de la structure d'existence de l'artiste ;
- de la structure psychique d'un personnage représenté ;
- de la structure émotionnelle du spectateur empirique.

Il s'agit d'une *structure possible d'être-au-monde*, telle qu'elle se donne à apparaître dans l'image. Autrement dit, on n'analyse pas une personne, mais une *configuration de l'existence* :

- une manière dont le monde se donne
- une manière dont une présence humaine peut y être située
- une manière dont l'espace, le temps, le corps et l'altérité s'articulent
- une tonalité globale du champ vécu.

On peut parler :

- d'un « style d'existence »
- d'un « mode de présence »
- d'une « configuration du champ vécu »
- d'une « modalité d'apparition du monde » ...

Exemples :

- Dans le haïku du vieil étang, on ne décrit pas un observateur particulier. On décrit :
 - un monde stable
 - un temps suspendu
 - un soi effacé
 - une présence sensorielle première.
- > il s'agit d'un *être-là* sans position centrale affirmée.

- Dans *La Grande Vague de Kanagawa*, on ne décrit ni « le Japon », ni une croyance, ni la psychologie des rameurs. On décrit :
 - un monde puissant
 - un instant d'imminence
 - une existence fragile
 - une exposition à ce qui dépasse toute maîtrise.
 - > il s'agit d'un *être-là* face à une force plus grande que soi.
- Dans *Les Nymphéas*, on ne décrit ni l'intériorité de Monet, ni l'émotion personnelle du spectateur. On décrit :
 - un espace flottant
 - un temps de variation lente
 - un regard immergé
 - un monde de reflets, sans horizon stable.
 - > il s'agit d'un *être-là* contemplatif, décentré, enveloppé par le champ sensible.
- Dans *L'Absinthe*, on ne diagnostique pas les personnages. On décrit :
 - un espace social devenu pauvre en échange
 - un temps stagnant
 - des corps peu mobilisés
 - une proximité sans rencontre.
 - > il s'agit d'un *être-là* en co-présence isolée.

Enjeu clinique

L'intérêt clinique de ce travail est essentiel. La phénoménologie ne décrit pas seulement des individus ou des symptômes. Elle décrit des formes possibles de l'existence humaine :

- paisibles
- exposées
- accordées
- fragiles
- dominées
- ouvertes
- ralenties
- désaffectées
- socialement soutenues
- silencieusement isolées. Etc.

Ces formes peuvent apparaître dans la clinique, dans l'art, dans la littérature, dans la vie ordinaire.

L'intérêt des images est de permettre de s'exercer à reconnaître ces formes sans les réduire immédiatement à des diagnostics.

La *structure* n'est pas la personne : Elle est une manière dont l'existence s'organise à un moment donné.

Il n'y a donc *pas de structure sans vécu*. Même lorsque le vécu n'est pas dit à la première personne, il peut être donné indirectement :

- dans une posture
- un espace
- une lumière
- un mouvement
- une distance
- une atmosphère
- une composition du monde. Etc.

La *structure de vécu* désigne la *cohérence interne* de cette *configuration*, lorsque celle-ci est décrite rigoureusement.

L'enjeu clinique est alors de revenir aux patients avec un regard plus fin :

- ne pas voir seulement des symptômes
- mais des manières d'habiter le temps, l'espace, le corps, les autres et le monde.

Katsushika Hokusai - La Grande Vague de Kanagawa



Étape 1 - Repérage du matériau phénoménal

Le vécu suscité par l'image est marqué par :

- le surgissement d'une forme massive et mouvante : la vague en train de se lever
- une impression de puissance imminente
- un mouvement courbe, enveloppant, comme si la vague allait se refermer
- la présence de petites embarcations engagées dans la scène
- un contraste d'échelle très fort entre la vague et les bateaux
- une ligne d'horizon relativement stable
- la présence d'un élément lointain, immobile et réduit : le mont Fuji
- la coexistence d'un mouvement violent, celui de la vague, et d'une stabilité silencieuse, celle de la montagne
- une tension entre l'élévation de la vague et l'écrasement possible
- la sensation d'un instant suspendu juste avant l'impact.

L'image donne donc accès à une scène de confrontation entre une force naturelle immense et des présences humaines fragiles.

Eviter :

- « la vague symbolise la mort »
- « les bateaux représentent l'humanité »
- « le mont Fuji représente l'éternité »...

> Ces lectures peuvent venir ensuite. L'analyse phénoménologique commence par la description de ce qui apparaît : une vague immense, des embarcations vulnérables, une montagne stable, un instant d'imminence.

Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu

Spatialité :

- L'espace est structuré par la puissance de la vague. Celle-ci occupe une grande partie de l'image, s'élève, se courbe et semble envelopper la scène. Elle ne constitue pas seulement un élément du paysage : elle organise l'espace par sa forme et par son mouvement.
- Les embarcations apparaissent petites, prises dans un espace instable. Elles ne semblent pas disposer d'un espace libre autour d'elles ; elles sont engagées dans la dynamique de la vague.
- L'arrière-plan introduit un autre registre spatial : le mont Fuji, lointain, immobile, presque minuscule. Il stabilise la profondeur de l'image et contraste avec le mouvement du premier plan.
- > L'espace apparaît donc comme un champ de forces : au premier plan, la menace du mouvement ; à l'arrière-plan, la stabilité silencieuse.

Temporalité :

- L'image saisit un instant critique.
- La vague est représentée au moment où elle s'élève et semble sur le point de retomber. L'événement n'est pas encore accompli, mais il est imminent. Le spectateur voit un moment suspendu, juste avant une possible catastrophe.
- Le présent est donc fortement densifié. Il n'est pas un simple instant neutre ; il contient une attente, une tension, une orientation vers ce qui va arriver.
- La temporalité peut être décrite ainsi : *montée de la vague* → *suspension* → *impact attendu*.
- > Le temps vécu est celui de *l'imminence* : quelque chose va se produire, mais l'image maintient ce moment avant la résolution.

Corporéité :

- Le corps du spectateur est sollicité par la dynamique de l'image.
- La forme courbe de la vague peut produire une sensation d'enveloppement, de bascule ou de chute possible. L'œil suit le mouvement, anticipe la retombée, éprouve une tension.
- Les figures humaines ne sont pas individualisées, mais les embarcations permettent une identification corporelle minimale : être pris dans un mouvement plus grand que soi, devoir tenir dans l'instabilité, être exposé à une force qui dépasse.
- > On peut donc parler d'une corporéité anticipatoire : le corps n'agit pas dans l'image, mais il résonne avec le mouvement perçu.

Altérité :

- Les figures humaines sont présentes, mais elles ne sont pas individualisées. Les rameurs apparaissent comme un collectif engagé dans la situation, sans visage distinct ni histoire personnelle.
- L'altérité humaine est donc discrète et collective. Elle n'apparaît pas sous la forme d'un échange entre personnes, mais sous la forme d'une vulnérabilité partagée.
- L'autre principal, dans l'image, n'est pas une personne. C'est plutôt la nature elle-même : la vague comme force impersonnelle, massive, non intentionnelle, mais puissamment présente.

Ipséité :

- Le spectateur n'est pas acteur de la scène. Il ne peut ni arrêter la vague, ni sauver les embarcations, ni modifier ce qui advient.
- Il se trouve placé dans une position de regard engagé mais impuissant. Il regarde une scène qui le dépasse, mais qui l'implique perceptivement. L'image ne lui donne pas une position de maîtrise ; elle le place face à une force plus grande que lui.
- L'ipséité apparaît donc sur un mode décentré : le sujet ne se vit pas comme centre organisateur du monde, mais comme *exposé* à une puissance qui excède sa prise.

Mondanéité :

- Le monde apparaît à la fois puissant, instable et structuré.

- Il est potentiellement destructeur : la vague domine la scène, menace les embarcations, impose son mouvement.
- Mais il n'est pas chaotique au sens d'un désordre illisible. La composition est très organisée : la vague, les bateaux, l'horizon et le mont Fuji structurent fortement l'image.
- La mondanéité repose donc sur une coexistence de deux registres :
 - . un monde comme force mouvante, instable, débordante ;
 - . un monde comme ordre perceptible, composé, lisible.
- Le monde n'est pas simplement hostile. Il est immense, puissant, ordonné, mais impossible à maîtriser entièrement.

Passage vers la tension structurante :

- Les différentes dimensions convergent vers une tension entre la puissance du monde et la fragilité de l'existence humaine.
- L'image ne montre pas seulement une vague et des bateaux. Elle donne à voir une manière d'être exposé à une force qui dépasse les capacités d'action et de contrôle du sujet.

Étape 3 - Tension structurante centrale

La tension centrale peut être formulée ainsi : *puissance du monde / fragilité de l'existence*

Elle articule :

- la masse de la vague
- la petitesse des embarcations
- l'imminence de l'impact
- l'impossibilité d'intervenir
- la stabilité lointaine du mont Fuji
- l'exposition humaine à une force naturelle.

Cette tension traverse :

- le rapport à *l'espace* : vague dominante, embarcations vulnérables, montagne stable
- le rapport au *temps* : instant suspendu avant la retombée
- le rapport au *corps* : tension, anticipation, sensation de bascule possible
- le rapport à *autrui* : vulnérabilité collective des rameurs
- le rapport à *soi* : position de spectateur affecté, sans maîtrise
- le rapport au *monde* : monde puissant, structuré, mais non maîtrisable.

Ce que cette tension permet :

- Cette organisation produit une forte intensité perceptive. Elle donne accès à un monde plus grand que le sujet, capable de le décentrer et de le mettre en relation avec une échelle qui le dépasse.
- Elle permet aussi de percevoir la puissance du monde sans la réduire à un pur chaos : la vague est menaçante, mais la composition reste ordonnée.

Ce qu'elle limite :

Cette tension limite la possibilité d'action et de maîtrise. Le sujet spectateur ne peut pas intervenir. Les embarcations semblent prises dans une dynamique qui les dépasse.

L'existence apparaît donc vulnérable, exposée à ce qui advient, sans garantie d'équilibre.

Étape 4 - Structure de vécu

On peut formuler la structure de vécu de la manière suivante :

L'image donne à voir une confrontation entre une puissance naturelle immense et des présences humaines fragiles. La vague s'élève, se courbe et semble sur le point de retomber. Les embarcations, petites et engagées dans le mouvement, apparaissent vulnérables face à cette force qui les dépasse.

Le temps est celui de l'imminence : l'impact n'a pas encore eu lieu, mais il est attendu. L'image suspend le moment juste avant la résolution. Cette suspension densifie le présent et place le spectateur dans une expérience d'anticipation tendue.

L'espace est organisé par une tension entre mouvement et stabilité. Au premier plan, la vague domine la scène par sa masse et sa dynamique. À l'arrière-plan, le mont Fuji introduit une stabilité silencieuse, presque immobile. Le monde apparaît donc à la fois instable et structuré, menaçant et lisible.

Le sujet n'est pas en position d'agir, mais d'éprouver. Il assiste à ce qui advient, affecté par la puissance de la vague et par la vulnérabilité des embarcations. L'image ne donne pas une expérience de maîtrise, mais une expérience d'exposition.

La structure de vécu peut donc être décrite comme une exposition à la puissance du monde : l'existence se tient dans un instant suspendu, entre stabilité et basculement, face à une force qui excède toute prise possible.

Point méthodologique

Cette image permet de montrer que l'analyse phénoménologique d'un tableau ne consiste pas seulement à reconnaître des éléments visuels.

Il ne suffit pas de dire : il y a une vague, des bateaux et le mont Fuji.

Il faut décrire comment ces éléments organisent une expérience :

- un espace de force
- un temps d'imminence
- un corps spectateur en tension
- une fragilité humaine
- un monde puissant mais structuré

On évitera donc de commencer immédiatement par une interprétation symbolique. La vague peut certes être interprétée comme symbole de la mort, du danger ou de la puissance de la nature. Mais *l'analyse phénoménologique commence avant cela* > elle décrit

- comment la vague apparaît
- comment elle organise l'espace, le temps, le corps et le rapport au monde.

Utagawa Hiroshige - Averse soudaine sur le pont Ōhashi



Étape 1 - Repérage du matériau phénoménal

On relève d'abord ce qui est immédiatement donné dans l'image :

- un pont disposé en diagonale
- plusieurs silhouettes engagées dans une traversée
- des passants penchés, couverts par des chapeaux, manteaux ou parapluies
- une pluie dense, oblique, qui traverse toute la scène
- un vaste cours d'eau
- une barque sur l'eau
- une berge sombre au loin
- une opposition entre l'espace construit du pont et l'espace ouvert de l'eau
- une impression de mouvement et de passage
- une situation atmosphérique soudaine, à laquelle les corps doivent s'ajuster.

Eviter :

- « la pluie symbolise la tristesse »
- « le pont représente la vie »
- « les passants fuient leur destin ». Etc.

> Ces lectures peuvent éventuellement venir ensuite. L'analyse phénoménologique commence par ce qui apparaît :

- un espace de traversée
- une pluie soudaine
- des corps en déplacement
- un monde ordinaire momentanément intensifié.

Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu

Spatialité :

- L'espace est fortement structuré par le pont : sa diagonale organise le regard et donne à la scène une direction. Le pont n'est pas seulement un élément architectural ; il fonctionne comme un espace de passage, un trajet, une ligne de traversée.
- On peut distinguer deux registres spatiaux :
 - . l'espace praticable du pont, qui permet d'avancer
 - . l'espace vaste de l'eau et du lointain, plus ouvert, plus indifférencié
- Le pont donne une orientation, tandis que l'eau ouvre la scène vers une étendue plus large. L'espace apparaît donc comme à la fois structuré et exposé : il offre un chemin, mais ce chemin reste soumis aux conditions du monde.
- > On peut décrire une spatialité de la traversée : avancer dans un espace orienté, mais sans être protégé de ce qui arrive.

Temporalité :

- Le temps est celui d'un événement soudain.
- L'averse introduit une rupture légère dans le cours ordinaire du trajet. Il ne s'agit pas d'une catastrophe, mais d'une modification brusque de la situation. La pluie oblige les passants à s'adapter immédiatement : se couvrir, se pencher, accélérer, continuer malgré l'inconfort.
- Le temps n'est donc pas dramatique, mais pressant. Il demande une réponse pratique. La traversée continue, mais elle se fait sous la contrainte momentanée de l'événement météorologique.
- La temporalité peut être décrite ainsi : trajet en cours > averse soudaine > adaptation immédiate.
- > Le temps vécu est celui d'une urgence ordinaire : quelque chose advient, sans détruire la continuité de l'action, mais en la modifiant.

Corporéité :

- Les corps sont très importants dans l'image.
- Les silhouettes sont penchées, resserrées, orientées vers l'avant. Elles semblent se protéger de la pluie tout en continuant à avancer. Les corps ne sont pas représentés dans une posture contemplative, mais dans une posture d'ajustement.
- La pluie engage directement le corps : elle mouille, gêne, oblige à se couvrir, à modifier sa posture, à se hâter. Le corps devient réactif aux conditions du monde.
- On peut donc parler d'une corporéité pratique et protectrice : les corps ne cherchent pas à maîtriser l'événement, mais à composer avec lui.

Altérité :

- L'altérité est présente sous forme collective.
- Les passants partagent la même situation atmosphérique. Ils ne semblent pas entrer en relation les uns avec les autres de manière explicite, mais ils sont pris dans un même événement : la traversée sous la pluie.
- Il ne s'agit pas d'une altérité intime, conflictuelle ou dialogique. L'autre apparaît comme compagnon anonyme de situation. Chacun traverse, chacun s'ajuste, chacun est exposé à la même averse.

> L'altérité se donne donc comme coexistence ordinaire dans un monde partagé.

Ipséité :

- Les figures humaines ne sont pas individualisées. On ne distingue pas de visage, d'histoire personnelle ou d'intériorité psychologique.
- La position subjective configurée par l'image est donc impersonnelle. Il ne s'agit pas de suivre le drame d'un individu, mais de percevoir une manière collective d'être en situation : traverser, se protéger, continuer.
- Le soi n'est ni menacé, ni dissous, ni fortement affirmé. Il est impliqué dans une action ordinaire. Il apparaît sous la forme d'une présence fonctionnelle, orientée vers le passage.
- On peut donc décrire une ipséité discrète, située, pratique : une manière d'être là, dans l'événement, sans dramatisation.

Mondanéité :

- Le monde apparaît changeant, mais non hostile.
- La pluie transforme la scène : elle rend le trajet plus difficile, modifie les postures, intensifie la perception du moment. Mais elle ne détruit pas l'organisation du monde. Le pont reste praticable, les passants continuent d'avancer, l'eau et le lointain demeurent lisibles.
- Le monde n'est pas harmonique au sens paisible de Buson, ni menaçant au sens de la vague d'Hokusai. Il est plutôt mobile, variable, soumis à des événements auxquels il faut s'ajuster.
- La tonalité globale peut être décrite comme une sobriété mobile : le monde change, mais la traversée continue.

> Passage vers l'articulation structurante :

- Les différentes dimensions convergent vers une articulation entre traversée et exposition.
- L'image ne montre pas seulement des passants sous la pluie. Elle configure une expérience ordinaire du monde : être engagé dans un trajet, être exposé à un événement soudain, ajuster son corps et continuer malgré la modification des conditions.

Étape 3 - Articulation structurante centrale

L'articulation centrale peut être formulée ainsi : traversée / exposition

Elle articule :

- le pont comme espace orienté
- la pluie comme événement soudain
- les corps penchés et protégés
- la continuité du déplacement
- l'ouverture de l'espace à l'eau et au ciel
- la nécessité d'avancer malgré l'exposition.

On peut aussi formuler cette articulation comme : cheminement / événement

Cette articulation traverse :

- le rapport à l'espace : le pont permet la traversée, mais n'abrite pas
- le rapport au temps : l'averse introduit une urgence brève
- le rapport au corps : les silhouettes s'ajustent, se protègent, avancent
- le rapport aux autres : coexistence anonyme dans une même situation
- le rapport au soi : présence discrète, fonctionnelle, orientée vers l'action
- le rapport au monde : monde changeant, mais encore praticable.

Ce que cette articulation permet :

- Elle permet de décrire une expérience d'ajustement. Les passants ne maîtrisent pas l'averse, mais ils ne sont pas détruits par elle. Ils adaptent leur posture et poursuivent le trajet.
- Elle montre aussi un monde ordinaire intensifié : la pluie rend visible la relation entre les corps, le passage et l'environnement.

Ce qu'elle limite :

- Cette configuration limite le confort, la disponibilité contemplative et la maîtrise complète de la situation. Les corps doivent composer avec l'événement plutôt que choisir librement leur rythme.
- Mais cette limitation ne produit pas une rupture majeure. Elle transforme seulement la manière de traverser.

Étape 4 - Structure de vécu

On peut formuler la structure de vécu de la manière suivante :

L'estampe configure une expérience de traversée dans un monde changeant. Le pont organise l'espace comme trajet : il donne une direction, permet le passage et inscrit les silhouettes dans un mouvement orienté.

Mais ce passage est exposé. L'averse soudaine traverse la scène, modifie les postures et oblige les corps à s'ajuster. Les passants se penchent, se couvrent, se hâtent peut-être, sans cesser d'avancer. Le monde n'est pas hostile, mais il impose une variation à laquelle il faut répondre.

Le temps est celui d'une urgence ordinaire. L'événement météorologique ne détruit pas la continuité du trajet ; il la reconfigure momentanément. La traversée se poursuit, mais autrement, sous la contrainte légère et pressante de la pluie.

La structure de vécu peut donc être décrite comme une traversée exposée : l'existence avance dans un monde praticable mais variable, où l'événement soudain ne suspend pas l'action, mais demande une adaptation immédiate.

Point méthodologique

Cette estampe permet de distinguer une expérience d'exposition ordinaire d'une expérience de menace radicale.

- Dans *La Grande Vague de Kanagawa*, le monde apparaissait comme puissance immense, plaçant l'existence humaine face à une fragilité extrême.
 - Dans *Averse soudaine sur le pont Ōhashi*, le monde est changeant et exposant, mais il reste praticable.
 - La pluie ne doit donc pas être immédiatement interprétée comme symbole de tristesse ou de malheur. Elle configure d'abord une situation : traverser sous une averse, ajuster son corps, continuer malgré l'événement.
- L'analyse phénoménologique d'une image consiste ainsi à décrire comment les éléments visibles organisent une manière d'habiter le monde : ici, non pas la catastrophe, mais l'adaptation ordinaire dans un monde instable.

Andō Hiroshige - Neige à Kanbara (1834)



Étape 1 - Repérage du matériau phénoménal

On relève d'abord ce qui est immédiatement donné dans l'image :

- un paysage nocturne ou crépusculaire ;
- une neige épaisse couvrant les maisons, le sol et les reliefs ;
- des silhouettes humaines petites, courbées, en déplacement ;
- un village ou un hameau presque silencieux ;
- une forte présence du blanc et des zones sombres ;
- des formes simplifiées par la neige ;
- une impression de lenteur ;
- une atmosphère de calme, de froid et de retrait ;
- une réduction des détails du monde ;
- une traversée humaine discrète dans un espace enneigé.

Eviter :

- « la neige symbolise la mort »
- « le blanc représente le vide »
- « les personnages sont seuls ».

L'analyse phénoménologique commence par ce qui apparaît : un monde recouvert, ralenti, silencieux, dans lequel quelques présences humaines avancent avec retenue.

Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu

Temporalité :

- Le temps est celui d'un ralentissement
- Contrairement à *Averse soudaine sur le pont Ōhashi*, où l'événement météorologique imposait une adaptation rapide, la neige donne ici une temporalité plus lente. Elle ne surgit pas comme un choc ; elle recouvre, atténue, suspend.

- Le monde semble saisi dans une durée silencieuse. Les personnages se déplacent, mais leur mouvement paraît lent, prudent, presque absorbé par l'atmosphère générale.
- > La temporalité peut être décrite ainsi : recouvrement → ralentissement → traversée silencieuse.

Spatialité :

- La spatialité est fortement transformée par la neige.
- La neige recouvre les maisons, le sol, les toits et les chemins. Elle unifie les surfaces et atténue les détails. L'espace n'apparaît pas comme ouvert et dynamique, mais comme enveloppé, feutré, presque immobilisé.
- Les silhouettes humaines sont petites dans cet espace. Elles ne dominent pas le paysage ; elles y avancent discrètement. Le monde semble plus vaste qu'elles, mais il ne se présente pas comme menaçant. Il se donne plutôt comme un espace silencieux, froid, lentement traversable.
- L'espace peut donc être décrit comme enveloppant, ralenti, peu différencié, mais encore habitable.

Corporéité :

- Les corps apparaissent courbés, resserrés, protégés contre le froid et la neige.
- Ils ne sont pas engagés dans une action expansive. Ils avancent avec prudence, comme si le monde imposait une réduction du geste et de l'allure. Le corps doit composer avec le froid, l'épaisseur de la neige, la difficulté du déplacement.
- On peut donc parler d'une corporéité retenue et protégée : les corps ne cherchent pas à dominer l'espace, mais à le traverser en s'y ajustant.
- La neige produit une manière d'être au monde plus lente, plus ramassée, plus silencieuse.

Altérité :

- L'altérité est présente à travers les silhouettes humaines, mais elle reste silencieuse et collective.
- Les personnages semblent partager la même condition : avancer dans le froid et la neige. Il n'y a pas d'échange visible, pas de conflit, pas de rencontre dramatique. L'autre apparaît comme une présence parallèle, également engagée dans la traversée du monde enneigé.
- L'altérité prend donc la forme d'une coexistence silencieuse : chacun avance, mais tous appartiennent à la même atmosphère.

Ipséité :

- Les figures humaines ne sont pas individualisées. Elles n'ont pas de visage distinct, pas d'histoire personnelle visible. L'image ne propose pas le vécu psychologique d'un individu, mais une position humaine discrète dans un monde hivernal.
- La position subjective configurée par l'image est donc impersonnelle et humble. L'humain est présent, mais il n'occupe pas le centre du monde. Il traverse un espace qui le dépasse, sans l'affronter frontalement.
- Le soi apparaît comme discret, réduit, ajusté au monde : il ne s'affirme pas, mais il continue d'avancer.

Mondanéité :

- Le monde apparaît calme, froid, recouvert, mais non détruit.
- La neige modifie la visibilité du monde. Elle efface certains détails, simplifie les formes, atténue les contrastes du quotidien. Mais elle ne rend pas le monde inhabitable. Les maisons demeurent, les chemins existent encore, les silhouettes avancent.
- Le monde est donc moins disponible à l'action rapide, mais il reste traversable. Il ne se donne ni comme menace radicale, ni comme harmonie expansive. Il apparaît comme un monde de retrait, de lenteur et de silence.

- La tonalité globale peut être décrite comme une mélancolie calme ou une paix froide : le monde est appauvri en mouvement, mais plein de présence.

Passage vers l'articulation structurante :

- Les différentes dimensions convergent vers une articulation entre recouvrement et traversée.
- L'image ne montre pas seulement un paysage enneigé. Elle configure une expérience du monde ralenti :
 - . la neige recouvre, atténue, suspend
 - . pourtant, les présences humaines continuent d'avancer.

Étape 3 - Articulation structurante centrale

L'articulation centrale peut être formulée ainsi : *recouvrement / traversée*

On peut aussi formuler cette articulation comme : *silence hivernal / mouvement discret*

Elle articule :

- la neige qui recouvre les formes
- le silence du paysage
- le ralentissement du temps
- les corps courbés et protégés
- la persistance d'un déplacement humain
- le maintien d'un monde habitable malgré le retrait

Cette articulation traverse :

- le rapport à l'espace : monde recouvert, mais encore traversable ;
- le rapport au temps : ralentissement, suspension, durée silencieuse ;
- le rapport au corps : corps resserrés, protégés, prudents ;
- le rapport aux autres : coexistence silencieuse ;
- le rapport au soi : présence discrète, non centrale ;
- le rapport au monde : monde atténué, froid, mais habitable.

Ce que cette articulation permet :

- Elle permet de décrire une expérience de ralentissement et de retrait sans effondrement. Le monde devient moins actif, moins différencié, moins disponible à l'action rapide, mais il garde une forme de présence.
- Elle permet aussi de percevoir une continuité minimale : malgré le froid, la neige et l'atténuation du monde, les personnages avancent.

Ce qu'elle limite :

- Cette configuration limite l'expansion, la vitesse et l'initiative. Le corps doit se protéger, réduire ses gestes, accepter un rythme imposé par les conditions du monde.
- Mais cette limitation ne produit pas une crise. Elle produit une manière plus humble, plus lente, plus silencieuse d'habiter l'espace.

Étape 4 - Structure de vécu

On peut formuler la structure de vécu de la manière suivante :

L'estampe configure un monde ralenti par la neige. Les maisons, le sol et les chemins sont recouverts, les détails s'atténuent, les formes se simplifient. Le paysage ne disparaît pas, mais il se retire dans une présence silencieuse et froide.

Dans cet espace enveloppé, les figures humaines apparaissent petites, courbées, discrètes. Elles ne dominent pas le monde ; elles le traversent avec prudence. Le corps se protège, se resserre, ajuste son mouvement à l'épaisseur du climat.

Le temps n'est pas celui de l'urgence, comme dans l'averse soudaine, ni celui de l'imminence menaçante, comme dans la grande vague. Il est celui d'une suspension lente : la neige ralentit le monde sans l'arrêter complètement.

La structure de vécu peut donc être décrite comme une traversée silencieuse du monde recouvert. L'existence se maintient dans un espace froid, atténué, peu expansif, mais encore habitable. Le monde impose le retrait et la lenteur, sans supprimer la possibilité d'avancer.

Point méthodologique

Cette estampe permet de distinguer plusieurs formes d'exposition au monde :

- Dans *La Grande Vague de Kanagawa*, l'exposition était liée à la puissance immense et imminente de la nature.
- Dans *Averse soudaine sur le pont Ōhashi*, elle prenait la forme d'un ajustement pratique à un événement soudain.
- Dans *Neige à Kanbara*, elle devient plus silencieuse : le monde n'agresse pas, mais il ralentit, recouvre et réduit les possibilités d'expansion.

La neige ne doit donc pas être immédiatement interprétée comme symbole de tristesse, de mort ou d'isolement. Elle configure d'abord une manière d'apparaître du monde : un monde froid, enveloppé, ralenti, dans lequel l'humain continue de se déplacer avec discrétion.

L'analyse phénoménologique d'une image consiste ici à décrire cette modification du monde vécu : non pas catastrophe, ni simple paysage, mais expérience d'un retrait habitable.

Claude Monet - Nymphéas (fin des années 1890 à 1926)



Étape 1 - Repérage du matériau phénoménal

On relève d'abord ce qui apparaît dans l'image ou dans la série :

- une surface d'eau
- des nymphéas flottant à la surface
- des reflets de lumière, de ciel ou de végétation
- une absence fréquente de ligne d'horizon nette
- une profondeur difficile à stabiliser
- une confusion douce entre surface et profondeur
- des formes végétales parfois distinctes, parfois presque dissoutes
- une impression d'immersion visuelle
- une absence de figures humaines
- un monde sans événement dramatique
- une variation de couleurs, de lumière et d'atmosphère
- une perception flottante, sans point d'ancrage unique.

Eviter :

- « les nymphéas symbolisent la paix »

- « l'eau représente l'inconscient »
- « Monet peint la disparition du monde ». Etc.
- > Ces lectures peuvent éventuellement être discutées plus tard. L'analyse phénoménologique commence par ce qui apparaît : une surface d'eau, des reflets, des fleurs flottantes, une profondeur incertaine, un monde sans centre stable.

Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu

Temporalité :

- Le temps n'est pas celui d'un événement soudain ou d'un instant critique.
- Il n'y a pas de vague sur le point de retomber, pas d'averse à laquelle il faudrait s'adapter immédiatement, pas de traversée visible. Le temps des Nymphéas est plus diffus : il se manifeste dans les variations de lumière, les reflets, les couleurs, les changements atmosphériques.
- Il s'agit d'un temps lent, presque suspendu, mais non figé. Le monde semble changer par nuances, non par rupture. La temporalité est celle d'une variation continue.

On peut la formuler ainsi :

- surface stable
- > variations de lumière
- > transformation silencieuse de l'atmosphère.

Le temps est donc vécu comme durée sensible : il ne s'impose pas par un événement, mais par une modulation progressive du visible.

Spatialité :

- La spatialité des Nymphéas est particulière, parce qu'elle ne repose pas sur une perspective classique :
 - . l'horizon disparaît ou devient secondaire
 - . le regard n'est plus orienté vers un lointain clairement organisé
 - . il est attiré vers la surface de l'eau, les reflets, les nymphéas, les variations de lumière.
- L'espace n'est donc pas structuré comme un espace de traversée, comme chez Hiroshige, ni comme un espace de confrontation, comme chez Hokusai.
- Il se donne plutôt comme un espace flottant, sans centre fixe, où le haut et le bas, la surface et la profondeur, le ciel et l'eau tendent à se mêler.
- La spatialité peut ainsi être décrite comme une immersion sans horizon stable.

Corporéité :

- Il n'y a pas de corps humain représenté. Pourtant, le corps de l'observateur est fortement impliqué.
- Face aux Nymphéas, le regard ne se fixe pas facilement sur un point central. Il circule, flotte, se laisse absorber par les surfaces, les reflets, les couleurs. La perception devient moins directionnelle, moins orientée vers un objet précis.
- Le corps n'est donc pas sollicité sur le mode de la tension ou de l'anticipation, comme devant La Grande Vague. Il n'est pas non plus engagé dans l'ajustement pratique, comme dans Averse soudaine. Il est plutôt invité à une présence lente, enveloppée, contemplative.
- On peut parler d'une corporéité immersive : le regard et le corps se trouvent enveloppés dans un champ perceptif sans centre dominant.

Altérité

- L'altérité humaine est absente.

- Il n'y a pas de rencontre, pas de visage, pas de relation intersubjective. L'autre n'apparaît pas sous la forme d'une personne. Il apparaît plutôt sous la forme du monde lui-même : l'eau, les plantes, la lumière, les reflets.
- L'altérité est donc ici non humaine. Elle n'est pas menaçante ni dominatrice. Elle se présente comme une altérité silencieuse du visible : quelque chose se donne à voir, change, se reflète, se transforme, sans s'adresser directement au regardeur.

Ipséité :

- Aucune figure subjective n'est représentée dans l'image. Il n'y a ni personnage, ni scène humaine, ni action.
- La position subjective configurée par l'œuvre est donc celle d'un regard décentré. Le regardeur n'est pas placé face à un objet clairement séparé de lui ; il est plutôt pris dans une atmosphère, dans une continuité de reflets et de surfaces.
- Le soi n'est pas menacé, mais il perd une partie de sa position de maîtrise. Il ne domine pas l'espace par une perspective stable. Il se laisse plutôt déplacer par la mobilité du visible.
- On peut donc décrire une ipséité contemplative et décentrée : une présence qui ne cherche pas à saisir le monde comme objet, mais à se laisser affecter par son apparition.

Mondanéité :

- Le monde apparaît comme surface, reflet, variation et atmosphère.
- Il n'est pas organisé autour de l'action humaine. Il ne se donne pas comme un espace à traverser, à maîtriser ou à habiter pratiquement. Il se donne comme un champ sensible dans lequel les limites deviennent incertaines.
- La séparation entre ciel et eau, profondeur et surface, objet et reflet, tend à se brouiller. Le monde n'est pas désorganisé ; il est autrement organisé, par continuité, vibration et modulation.
- La tonalité globale peut être décrite comme une immersion contemplative : un monde sans drame, mais sans contours entièrement stabilisés.

Passage vers l'articulation structurante :

- Les dimensions convergent vers une articulation entre flottement et immersion.
- L'œuvre ne montre pas seulement un bassin avec des fleurs. Elle configure une expérience perceptive dans laquelle le regard perd ses repères habituels de profondeur, d'horizon et de séparation nette entre les choses.
- Il ne s'agit pas d'une menace, ni d'une catastrophe, ni d'une disparition du monde. Il s'agit d'une transformation de la manière dont le monde apparaît : moins comme objet stable devant soi que comme champ sensible enveloppant.

Étape 3 - Articulation structurante centrale

L'articulation centrale peut être formulée ainsi : *flottement / immersion*

Elle articule :

- la surface de l'eau ;
- les reflets du ciel et de la végétation ;
- l'absence ou l'affaiblissement de l'horizon ;
- la difficulté à distinguer surface et profondeur ;
- l'absence de figure humaine ;
- la circulation du regard dans un champ perceptif continu.

Cette articulation traverse :

- le rapport à l'espace : espace sans horizon stable, organisé par surfaces et reflets ;

- le rapport au temps : durée lente, variation lumineuse, transformation par nuances ;
- le rapport au corps : regard enveloppé, perception flottante ;
- le rapport au soi : présence contemplative, décentrée, sans maîtrise ;
- le rapport à l'altérité : absence d'autrui humain, présence silencieuse du monde naturel ;
- le rapport au monde : monde sensible, atmosphérique, sans contours entièrement fixés.

Ce que cette articulation permet :

- Elle permet une expérience de disponibilité perceptive. Le regard n'est pas contraint par un événement dramatique ou par une action à accomplir. Il peut demeurer dans la variation, la nuance, la lenteur.
- Elle permet aussi de montrer qu'un monde sans centre stable n'est pas nécessairement un monde désorganisé ou menaçant. Il peut être habitable sur un mode contemplatif, immersif, atmosphérique.

Ce qu'elle limite :

- Cette configuration limite la maîtrise perspectiviste. Le regard ne peut pas facilement organiser l'image selon un premier plan, un arrière-plan, un horizon et un point de fuite.
- Elle limite aussi l'action : rien n'appelle une réponse pratique. L'expérience n'est pas orientée vers l'agir, mais vers la perception et la présence.

Étape 4 - Structure de vécu

On peut formuler la structure de vécu de la manière suivante :

Les Nymphéas configurent une expérience d'immersion dans un monde de surface, de reflets et de variations lumineuses. L'espace n'est pas organisé par une perspective stable ou par une ligne d'horizon clairement dominante. Le regard circule entre l'eau, les fleurs, les reflets et les profondeurs incertaines.

Le temps n'est pas celui de l'urgence ou de l'événement. Il se donne comme durée sensible, à travers les changements de lumière, les modulations de couleur et les transformations silencieuses de l'atmosphère. Rien ne bascule brutalement ; tout varie par nuances.

Le corps du regardeur est engagé sur un mode contemplatif et immersif. Il n'est ni tendu vers un impact, ni mobilisé vers une action. Il est enveloppé par un champ perceptif qui invite moins à saisir qu'à demeurer.

La structure de vécu peut donc être décrite comme une immersion flottante : le monde apparaît sans centre fixe, sans menace, sans événement majeur, mais dans une continuité sensible où les limites entre surface, profondeur, ciel, eau et végétation deviennent incertaines.

Point méthodologique

Les *Nymphéas* sont particulièrement utiles pour montrer qu'un monde sans contours nets n'est pas nécessairement un monde inquiétant ou désorganisé.

Dans certaines vignettes cliniques, la perte de repères, l'étrangeté du monde ou le flottement du soi peuvent être associés à une souffrance ou à une désorganisation. Ici, au contraire, le flottement prend une tonalité contemplative.

Il faut donc éviter de pathologiser trop vite des formes comme :

- décentrement
- dissolution des limites
- absence de centre
- perte d'horizon
- flottement perceptif

Dans les *Nymphéas*, ces éléments configurent moins une perte qu'une autre manière d'apparaître du monde : un monde atmosphérique, enveloppant, silencieux, offert à une perception lente.

La question phénoménologique n'est donc pas : *Que symbolisent les nymphéas ?*

mais plutôt : Comment le monde apparaît-il lorsque le regard se trouve immergé dans une surface de reflets, de lumière et de variations ?

Auguste Renoir - Le Bal du moulin de la Galette (1876)



Étape 1 - Repérage du matériel phénoménal

On relève d'abord ce qui est immédiatement donné dans l'image :

- une scène collective en plein air
- de nombreux personnages réunis
- des corps assis, debout, tournés les uns vers les autres
- des conversations, des regards, des gestes
- une impression de mouvement social et de proximité
- une scène de danse ou de bal populaire
- une lumière fragmentée, filtrée par les arbres
- une alternance de zones claires et d'ombres
- une atmosphère animée, vivante, festive
- une profondeur occupée par une foule
- une absence de centre unique : le regard circule entre plusieurs groupes
- une scène ordinaire, mais intensément habitée.

Eviter :

- « le tableau représente le bonheur »
- « Renoir peint la joie de vivre »
- « c'est une scène d'insouciance ».

> l'analyse phénoménologique commence par ce qui apparaît : un monde social dense, lumineux, mouvant, dans lequel les présences humaines se répondent.

Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu

Spatialité :

- L'espace est un espace social partagé.
- Contrairement à *La Grande Vague*, où l'espace était dominé par une force naturelle, ou aux *Nymphéas*, où l'espace devenait flottant et immersif, ici l'espace est organisé par les relations entre les corps.
- Les tables, les chaises, les groupes et les danseurs structurent la scène.
- L'espace est rempli de présences, de mouvements, de regards et de proximités. On n'y est pas seul face au monde ; on y est avec d'autres, dans une ambiance collective.
- La profondeur du tableau donne l'impression d'un espace habité jusqu'au fond. Le regard ne se fixe pas sur un point unique : il circule de groupe en groupe, de visage en visage, de geste en geste.
- > On peut donc parler d'une spatialité relationnelle : l'espace existe comme lieu de rencontre, de circulation et de co-présence.

Temporalité :

- Le temps est celui d'un moment partagé.
- Le tableau ne représente pas un instant critique ou menaçant. Il donne plutôt à voir une durée festive : le bal est en cours, les conversations continuent, les corps se déplacent, la lumière varie.
- Le temps est animé, mais non pressant. Il n'est pas celui de l'urgence, comme dans *Averse soudaine sur le pont Ōhashi*, ni celui de l'imminence, comme dans *La Grande Vague*. Il est celui d'une continuité sociale vivante.
- Le temps vécu est un temps de sociabilité : il se déploie dans l'échange, la danse, la conversation et la présence aux autres.

Corporéité :

- Le corps est très présent.
- Les corps sont assis, penchés, tournés, debout, engagés dans la conversation ou dans la danse : ils ne sont ni immobilisés, ni menacés, ni effacés. Ils participent à la scène.
- La corporéité est relationnelle : les postures indiquent des proximités, des orientations, des adresses. Les corps ne sont pas seulement là comme formes visibles ; ils organisent la manière dont les personnages sont ensemble.
- Le corps est aussi sensible à l'ambiance : lumière, chaleur, mouvement, densité de la foule. Il s'inscrit dans un monde social où la présence physique est partagée.
- On peut donc parler d'une corporéité conviviale et située : le corps habite l'espace avec d'autres.

Ipséité :

- Les figures sont individualisées par leurs postures, leurs vêtements, leurs visages ou leurs orientations : le tableau ne construit pas un sujet central unique.
- L'image configure plutôt une pluralité de présences. Chaque figure semble prise dans une situation sociale, mais aucune ne monopolise entièrement le sens de la scène. Le soi apparaît à travers les manières d'être avec les autres : discuter, regarder, danser, écouter, se tenir à table.
- La position subjective proposée par l'image est donc moins celle d'un individu isolé que celle d'une présence parmi d'autres. Être soi, ici, c'est être situé dans un monde partagé, traversé par des relations, des regards et des rythmes sociaux.
- On peut parler d'une ipséité relationnelle : le soi se manifeste dans la co-présence, plutôt que dans le retrait ou l'isolement.

Altérité :

- L'altérité est centrale.
- Les autres ne sont pas lointains, menaçants ou absents. Ils composent la scène elle-même. Les regards, les postures et les conversations indiquent un monde d'interactions.
- L'autre apparaît comme partenaire de proximité, de danse, de conversation ou de présence partagée. L'altérité n'est pas seulement une dimension parmi d'autres ; elle organise l'espace et la tonalité du tableau.
- Il ne s'agit cependant pas d'une fusion. Les groupes restent différenciés. Les personnages occupent des positions distinctes. La scène montre une sociabilité dense, mais structurée par des distances, des orientations et des cercles relationnels.
- L'altérité peut donc être décrite comme co-présence animée : être avec d'autres, dans un espace vivant et partagé.

Mondanité :

- Le monde apparaît habitable, lumineux, socialement animé.
- Il n'est pas menaçant, ni vide, ni trop vaste, ni fermé. Il se donne comme un monde de relations, de mouvements, de loisirs et de partage.
- La lumière fragmentée contribue à cette tonalité : elle ne fixe pas les formes de manière rigide, mais les anime.
- La mondanité du tableau est celle d'un monde convivial : un monde où les corps, les regards, les paroles et les gestes composent une ambiance commune.
- Ce monde n'est pas simplement décoratif. Il soutient la présence des personnes, leur offre des places, des rythmes et des possibilités d'échange.

Passage vers l'articulation structurante :

- Les différentes dimensions convergent vers une articulation entre individualité et monde partagé.
- Le tableau ne montre pas seulement une foule. Il configure une expérience de sociabilité : être présent parmi d'autres, dans un espace commun, sans disparaître dans la masse ni se retirer de la scène.

Étape 3 - Articulation structurante centrale

L'articulation centrale peut être formulée ainsi : *présence individuelle / monde partagé*

Elle articule :

- la pluralité des figures
- les groupes et les conversations
- les corps orientés les uns vers les autres
- la circulation du regard
- la lumière commune
- la densité sociale de la scène.

Cette articulation traverse :

- le rapport à l'espace : espace relationnel, organisé par les groupes et les circulations
- le rapport au temps : durée festive, temps partagé, non urgent
- le rapport au corps : corps orientés, expressifs, engagés dans la sociabilité
- le rapport au soi : présence singulière mais non isolée
- le rapport aux autres : co-présence, conversation, danse, regard
- le rapport au monde : monde habitable, lumineux, socialement animé

Ce que cette articulation permet :

- Elle permet de décrire une expérience de participation. Les figures ne sont pas simplement juxtaposées ; elles composent un monde commun.
- Elle montre aussi que la présence à soi peut se soutenir dans l'altérité. Être avec les autres ne signifie pas nécessairement se perdre dans la foule ; cela peut constituer une manière d'habiter le monde.

Ce qu'elle limite :

- Cette configuration limite la solitude, le retrait et la centralité d'un sujet unique. L'expérience n'est pas organisée autour d'une intériorité isolée, mais autour d'un tissu social partagé.
- Elle peut aussi rendre moins visible la singularité intérieure de chaque personnage : le tableau donne surtout accès à une ambiance collective, plus qu'à un vécu psychologique individuel.

Étape 4 - Structure de vécu

On peut formuler la structure de vécu de la manière suivante :

Le tableau configure une expérience de présence sociale partagée. L'espace est rempli de corps, de regards, de gestes et de conversations. Il ne se présente pas comme un simple décor, mais comme un milieu relationnel où chacun prend place parmi les autres.

Le temps est celui d'une durée festive. Rien ne presse, rien ne menace ; le bal se déroule dans une continuité animée. Les corps parlent, se tournent, dansent, écoutent, se rapprochent. La scène donne à voir un temps vécu comme participation à une ambiance commune.

Le soi n'apparaît pas sous la forme d'une intériorité isolée, mais dans la relation : être assis à une table, parler, regarder, danser, se tenir au milieu des autres. La présence individuelle est soutenue par la co-présence.

La structure de vécu peut donc être décrite comme une sociabilité habitée : l'existence se déploie dans un monde lumineux, dense et partagé, où les corps, les regards et les gestes composent une forme d'accord collectif.

Point méthodologique

- Cette image permet de travailler une dimension essentielle pour la clinique phénoménologique : l'altérité comme milieu d'existence.
- Dans plusieurs vignettes cliniques, la relation à l'autre peut apparaître comme menaçante, instable, absente, intrusive ou difficile à habiter. Ici, au contraire, l'altérité est structurante sans être immédiatement problématique. Elle soutient une ambiance commune.
- Il faut donc éviter de réduire l'altérité à la dépendance, au conflit ou à la menace. L'autre peut aussi être ce qui rend le monde habitable, animé et partageable.
- Le tableau montre également qu'une expérience collective ne supprime pas nécessairement les présences singulières : les figures sont prises dans une foule, mais elles ne disparaissent pas complètement, elles existent dans et par la co-présence.
- La question phénoménologique n'est donc pas (seulement) : *Qui sont ces personnages ?*
> mais plutôt : *Comment l'image configure-t-elle un monde social habitable, où les présences individuelles se soutiennent dans une ambiance partagée ?*

Edgar Degas - L'Absinthe (1876)



Étape 1 - Repérage du matériau phénoménal

On relève d'abord ce qui est immédiatement donné dans l'image :

- deux figures assises à une table
- un espace de café ou de terrasse intérieure
- une femme assise au premier plan, le regard vague ou absent
- un homme assis à côté d'elle, tourné légèrement ailleurs
- une proximité physique entre les deux personnages, mais peu d'échange visible
- des verres posés sur les tables
- une boisson associée au titre : l'absinthe
- une composition décentrée
- des tables qui occupent fortement l'espace du premier plan
- une impression de vide malgré la présence des personnages

- une atmosphère terne, lourde, peu animée
- une scène sociale qui semble privée de sociabilité vivante

Eviter de dire immédiatement :

- « elle est alcoolique »
- « ils sont dépressifs »
- « le tableau dénonce la misère morale ».

> L'analyse phénoménologique commence par ce qui apparaît : deux corps présents, proches, mais séparés ; un espace social peu habité ; une présence silencieuse, lourde, désaccordée.

Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu

Temporalité :

- Le temps paraît ralenti, presque arrêté.
- Il ne s'agit pas d'un instant d'imminence, comme dans *La Grande Vague*, ni d'un moment d'adaptation, comme dans *Averse soudaine*. Le tableau donne plutôt l'impression d'un temps qui stagne.
- Les personnages ne semblent pas engagés dans une action en cours. Rien ne paraît sur le point d'arriver. Le moment semble s'étirer, comme si la scène était prise dans une durée sans événement.
- La temporalité peut être décrite ainsi :
 - . présence assise
 - . attente sans objet
 - > stagnation.
- Le temps vécu est celui d'une suspension lourde : le présent se maintient, mais sans direction claire.

Spatialité :

- L'espace est celui d'un café, donc normalement un lieu de rencontre, de conversation et de sociabilité.
- Mais cet espace ne paraît pas pleinement habité comme un espace relationnel : les deux personnages sont assis à la même table, ou du moins très proches, mais ils ne semblent pas engagés l'un vers l'autre.
- La composition renforce cette impression. Les tables occupent une grande partie du premier plan, créant une distance entre le regardeur et les personnages : l'espace paraît à la fois proche et séparant. Il y a de la proximité physique, mais peu de circulation relationnelle.
- L'espace peut donc être décrit comme un espace social désaccordé : un lieu fait pour la présence aux autres, mais où le lien semble suspendu ou défait.

Corporéité :

- La corporéité est centrale.
- La femme apparaît assise, immobile, les épaules tombantes, le regard dirigé vers le vide ou vers un point qui ne semble pas vraiment l'appeler. Son corps est là, mais il paraît peu mobilisé.
- L'homme, lui aussi, est présent sans être pleinement engagé dans la relation. Sa posture semble orientée ailleurs. Les corps sont proches, mais ils ne composent pas un véritable échange.
- Le corps ne se présente donc pas comme vecteur d'action, de danse, de conversation ou de participation sociale, contrairement à ce que l'on observait chez Renoir. Il apparaît comme un corps alourdi, posé, peu orienté.
- On peut parler d'une corporéité affaissée ou désengagée : le corps soutient la présence, mais ne porte plus d'élan vers le monde ou vers l'autre.

Ipséité :

- L'image ne donne pas accès à l'intériorité psychologique des personnages. Il serait donc imprudent de conclure immédiatement à une tristesse, une honte, une dépendance ou un désespoir.
- Cependant, la position subjective configurée par l'image semble marquée par un retrait. La femme est présente dans la scène, mais elle paraît peu reliée à ce qui l'entoure. Son regard ne semble pas soutenir une adresse vers autrui ou vers le monde.
- Le soi apparaît donc comme présent mais peu engagé. Il ne disparaît pas, mais il semble comme en retrait de la situation, maintenu dans une forme d'isolement intérieur.
- On peut décrire une ipséité en retrait : une présence à soi qui ne trouve pas facilement d'appui dans le monde social environnant.

Altérité :

- L'altérité est présente, mais elle ne prend pas la forme d'un échange vivant.
- Les deux personnages sont proches physiquement. Pourtant, ils ne se regardent pas, ne semblent pas se parler, ne paraissent pas engagés dans une interaction. La proximité ne devient pas relation.
- L'autre est donc là, mais il ne soutient pas véritablement la présence. Il ne relance pas le geste, la parole ou le regard. L'altérité est silencieuse, parallèle, presque juxtaposée.
- On peut parler d'une co-présence sans rencontre : les corps partagent le même espace, mais le lien ne s'actualise pas.

Mondanéité :

- Le monde apparaît terne, lourd, socialement appauvri.
- Le café, qui pourrait être un lieu d'animation, devient ici un espace de stagnation. Les objets — verres, tables, banquettes — ne soutiennent pas une sociabilité vivante. Ils composent plutôt une scène de présence arrêtée.
- Le monde n'est pas chaotique, ni menaçant, ni violemment hostile. Il est reconnaissable, ordonné, socialement situé. Mais il semble appauvri dans sa capacité à mobiliser les personnages.
- La tonalité globale peut être décrite comme une désaffection du monde social : le monde est là, mais il n'appelle plus véritablement à l'échange, au mouvement ou à la participation.

Passage vers l'articulation structurante :

- Les dimensions convergent vers une articulation entre *co-présence et isolement*.
- Le tableau ne montre pas simplement deux personnes assises dans un café. Il configure une expérience dans laquelle la proximité spatiale ne suffit pas à produire une relation vivante. Les personnages sont ensemble, mais chacun paraît séparé dans sa propre présence silencieuse.

Étape 3 - Articulation structurante centrale

L'articulation centrale peut être formulée ainsi : *co-présence / isolement*

Elle articule :

- la proximité physique des personnages
- l'absence d'échange visible
- l'espace social du café
- la lourdeur du temps
- la faible mobilisation corporelle
- l'impression de retrait subjectif
- la pauvreté de la relation au monde environnant

On peut aussi formuler cette articulation comme : *proximité / absence de rencontre*

ou encore : *espace social / désaffection relationnelle*.

Cette articulation traverse :

- le rapport à l'espace : un lieu social devenu séparant
- le rapport au temps : présent ralenti, sans événement ni relance
- le rapport au corps : corps assis, affaissés, peu orientés
- le rapport au soi : présence en retrait, peu engagée
- le rapport aux autres : proximité sans adresse
- le rapport au monde : monde social reconnaissable, mais peu mobilisateur

Ce que cette articulation permet :

- Elle permet de maintenir une présence minimale. Les personnages sont là, assis, inscrits dans un lieu social, entourés d'objets familiers. La scène ne montre pas un effondrement spectaculaire.
- Elle permet aussi de rendre visible une forme discrète de solitude : non pas solitude par absence d'autrui, mais solitude au sein même de la co-présence.

Ce qu'elle limite :

- Cette configuration limite la rencontre, l'échange et la participation. L'espace social ne fonctionne plus comme un monde partagé vivant.
- La proximité des corps ne suffit pas à soutenir une relation. Le monde est habitable au sens matériel, mais faiblement habité au sens existentiel.

Étape 4 - Structure de vécu

On peut formuler la structure de vécu de la manière suivante :

Le tableau configure une expérience de co-présence isolée. Deux figures sont assises dans un espace social, proches l'une de l'autre, mais sans échange visible. Le café, lieu ordinaire de rencontre et de conversation, apparaît ici comme un espace ralenti, lourd, presque silencieux.

Le temps semble stagner. Rien ne paraît sur le point d'arriver ; aucune action ne relance la scène. Le présent se maintient sans orientation claire, dans une durée terne et suspendue.

Les corps sont présents, mais peu mobilisés. Ils ne soutiennent ni la conversation, ni le mouvement, ni la rencontre. La femme semble particulièrement retirée, son regard ne trouvant pas de prise manifeste dans l'espace environnant. L'homme est proche, mais cette proximité ne devient pas adresse.

La structure de vécu peut donc être décrite comme une solitude en co-présence : l'existence se maintient dans un monde social reconnaissable, mais désaffecté, où la proximité spatiale ne suffit plus à ouvrir une rencontre.

Point méthodologique

Ce tableau permet de revenir vers des questions proches de la clinique, tout en restant dans l'analyse d'une œuvre. Il faut éviter de commencer par une conclusion psychologique ou diagnostique :

- « La femme est alcoolique. »
- « Elle est dépressive. »
- « Les deux personnages sont désespérés. »
- « Le tableau représente l'isolement pathologique. » Etc.

Ces formulations peuvent être discutées comme hypothèses interprétatives ou historiques, mais elles ne doivent pas remplacer la description phénoménologique.

L'enjeu est d'abord de décrire comment l'image configure une expérience :

- un espace social qui ne soutient plus vraiment la relation
- un temps ralenti, presque stagnant

- des corps présents mais peu mobilisés
- une proximité sans rencontre
- un monde ordinaire devenu pauvre en possibilités d'échange

Cette image est donc particulièrement utile pour préparer le retour aux observations cliniques. Elle montre qu'il peut y avoir solitude sans isolement objectif, retrait sans disparition, co-présence sans relation vivante.

La question phénoménologique n'est donc pas seulement : *Que leur arrive-t-il ?*

mais plutôt : *Comment l'image configure-t-elle un monde social où l'on peut être proche des autres tout en demeurant profondément séparé ?*

4. Clinique du travail

4.1. Marc, éleveur bovin

Observation

Marc est éleveur bovin depuis une vingtaine d'années. Il a repris l'exploitation familiale et travaille seul la plupart du temps. L'activité se poursuit sans interruption majeure, mais Marc décrit une impression diffuse de fatigue morale et de désengagement, sans plainte aiguë ni effondrement manifeste.

« Je fais ce qu'il y a à faire... les bêtes, il faut s'en occuper. Après, le reste... je ne sais pas trop. »

Étape 1 - Repérage du matériau clinique brut

Le vécu exprimé est marqué par :

- une inscription longue dans l'activité : Marc est éleveur bovin depuis une vingtaine d'années ;
- une continuité familiale : il a repris l'exploitation familiale ;
- un travail réalisé principalement seul ;
- une activité qui se poursuit sans interruption majeure ;
- une fatigue morale diffuse ;
- un désengagement, mais sans plainte aiguë ;
- l'absence d'effondrement manifeste ;
- une formulation centrée sur la nécessité : « je fais ce qu'il y a à faire » ;
- une priorité donnée aux bêtes : « les bêtes, il faut s'en occuper » ;
- une difficulté à dire ce qui se situe au-delà de l'activité nécessaire : « après, le reste... je ne sais pas trop ».

Le matériau clinique ne montre donc pas une rupture brutale de l'activité. Marc continue à travailler, à assurer les tâches, à répondre aux exigences concrètes de l'élevage. Mais cette continuité semble s'accompagner d'une fatigue morale et d'une difficulté à investir ce qui dépasse le strict nécessaire.

Éviter :

- « Marc est dépressif »
- « il est en burn-out »
- « il n'aime plus son métier »
- « il est résigné ». Etc.

> L'analyse phénoménologique commence par décrire la forme du vécu : une activité maintenue, mais portée par la nécessité plus que par un élan ou un horizon de sens.

Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu

Temporalité :

- Le temps de Marc apparaît d'abord comme un temps de continuité.
- L'activité se poursuit « sans interruption majeure ». Marc est installé dans ce métier depuis une vingtaine d'années. Le travail d'élevage impose une régularité forte : les bêtes doivent être nourries, soignées, surveillées ; certaines tâches ne peuvent pas être suspendues sans conséquence.
- La phrase « je fais ce qu'il y a à faire » indique un temps organisé par la tâche. Le présent est structuré par ce qui doit être accompli. Ce n'est pas un temps vide ou désorganisé ; c'est un temps tenu par les nécessités concrètes du travail.
- En revanche, l'avenir apparaît peu élaboré. La formule « après, le reste... je ne sais pas trop » indique une difficulté à ouvrir le temps au-delà de l'obligation immédiate. Le futur n'est pas absent, mais il n'est pas clairement investi.
- La temporalité peut donc être décrite comme une continuité opératoire : le temps avance parce que les tâches se répètent et s'imposent, mais il ouvre faiblement vers un devenir personnellement approprié.

Spatialité :

- L'espace de Marc est centré sur l'exploitation familiale.
- Cet espace n'est pas seulement un lieu de travail. Il est aussi un lieu hérité, repris, habité depuis longtemps. L'exploitation familiale organise probablement une grande partie de son quotidien, de ses déplacements et de son rapport au monde.
- Le matériau indique aussi que Marc travaille seul la plupart du temps. L'espace de travail semble donc peu partagé. Il est structuré par les tâches à accomplir et par la présence des animaux, davantage que par une pluralité d'espaces sociaux ou relationnels.
- L'espace apparaît ainsi comme un espace de maintien : il soutient la continuité de l'activité, mais il semble aussi resserrer l'existence autour du travail nécessaire.

Corporéité :

- Le corps n'est pas décrit directement, mais la fatigue morale diffuse donne une indication importante.
- Dans le travail agricole, le corps est habituellement engagé dans des gestes, des déplacements, des efforts, des soins, une disponibilité quotidienne aux animaux. Ici, le matériau ne décrit pas une incapacité physique, ni une plainte somatique aiguë. Marc continue à faire ce qu'il y a à faire.
- La fatigue morale indique une usure de la disponibilité. Il ne s'agit pas seulement de fatigue physique ; c'est une moindre capacité à investir l'activité comme vivante ou porteuse de sens.
- La corporéité peut donc être décrite comme une corporéité de maintien : le corps reste engagé dans le travail, mais sur un mode d'usure diffuse, sans élan clairement exprimé.

Altérité :

- L'altérité humaine est peu présente dans le matériau.
- Marc travaille seul la plupart du temps. Aucune relation professionnelle, familiale ou amicale n'est décrite de manière précise. Il n'y a pas d'indice de conflit explicite, mais il n'y a pas non plus d'appui relationnel clairement mentionné.
- En revanche, les animaux occupent une place centrale : « les bêtes, il faut s'en occuper ». Ils ne sont pas de simples objets de travail. Ils imposent une responsabilité concrète, quotidienne, non négociable. Leur présence oblige Marc à continuer.
- L'altérité apparaît donc sous deux formes contrastées :
 - . une altérité humaine peu développée dans le discours ;
 - . une altérité animale très structurante, qui maintient l'activité par la nécessité du soin.
- Cette dimension est importante en clinique du travail : l'activité n'est pas seulement orientée vers des tâches abstraites, mais vers des êtres vivants dont il faut répondre.

Ipséité :

- Marc se présente d'abord à travers son activité.
- La phrase « je fais ce qu'il y a à faire » indique une manière de se maintenir comme sujet par le faire. Il ne dit pas : « je veux », « je choisis », « j'ai envie », mais plutôt : « il faut ». Le rapport à soi passe par la continuité de l'obligation professionnelle.
- L'ipséité n'est pas effondrée. Marc ne dit pas qu'il ne se reconnaît plus, ni qu'il ne peut plus agir. Il continue à tenir sa place d'éleveur. Mais cette place semble peu subjectivement habitée au-delà de la nécessité.
- La formule « après, le reste... je ne sais pas trop » signale une difficulté à dire ce qui vaut pour lui en dehors ou au-delà du travail à accomplir.
- On peut donc parler d'une ipséité tenue par le rôle : Marc se maintient comme sujet dans la continuité de son activité, mais peine à élaborer une orientation personnelle plus large.

Mondanéité :

- Le monde de Marc apparaît comme un monde de nécessités concrètes.
- Il ne se présente pas comme un monde vide, chaotique ou désorganisé. Il reste structuré par l'exploitation, les bêtes, les tâches quotidiennes. Le monde appelle encore l'action, mais sous la forme du devoir : il faut s'occuper des animaux, il faut continuer, il faut faire ce qu'il y a à faire.
- Ce monde est donc encore mobilisateur, mais d'une manière particulière : il mobilise par nécessité, non par désir ou par projection.
- La mondanéité peut être décrite comme un monde qui tient Marc autant qu'il le contraint. Il lui donne des tâches, une place, une continuité ; mais il semble faiblement ouvrir vers du sens, de l'élan ou un devenir subjectivement investi.

Passage vers la tension structurante :

- Les différentes dimensions convergent vers une difficulté centrale : l'activité continue à organiser l'existence, mais elle semble de moins en moins soutenue par un sens personnellement investi.
- Marc ne s'effondre pas. Il ne rompt pas avec le travail. Il ne cesse pas d'agir. Mais l'action semble se maintenir principalement par l'obligation concrète : « les bêtes, il faut s'en occuper ».
- La question n'est donc pas seulement : « Marc travaille-t-il encore ? » Il travaille. La question est plutôt : « Comment cette activité continue-t-elle à le tenir, et à quel coût ? »

Étape 3 - Tension structurante centrale

La tension centrale peut être formulée ainsi : *maintien opératoire / appauvrissement du sens*

Elle articule :

- la continuité de l'activité
- la nécessité de s'occuper des bêtes
- le maintien du rôle professionnel
- la solitude du travail
- la fatigue morale diffuse
- la difficulté à dire ce qui se situe au-delà du strict nécessaire.

Cette tension traverse :

- le rapport au temps : continuité du faire, mais avenir peu élaboré
- le rapport à l'espace : exploitation comme lieu de maintien, mais espace de vie resserré
- le rapport au corps : corps encore engagé, mais sur fond d'usure morale

- le rapport à l'autre : solitude humaine, mais responsabilité envers les animaux
- le rapport à soi : maintien dans le rôle d'éleveur, mais difficulté à dire une orientation personnelle
- le rapport au monde : monde structuré par la nécessité, mais faiblement investi comme horizon de sens.

Ce que cette tension permet :

- Cette organisation permet à Marc de continuer.
- Les tâches quotidiennes, la présence des animaux et l'exploitation familiale maintiennent une forme de continuité. Elles donnent une structure au temps, une place dans le monde et une raison concrète d'agir.
- Marc ne s'effondre pas parce que l'activité continue de le tenir.

Ce qu'elle limite :

- Cette même organisation limite l'élaboration subjective du sens.
- Marc fait ce qu'il faut, mais il semble difficile pour lui de dire ce que cette activité représente encore, ce qu'elle ouvre, ce qu'elle vaut pour lui, ou ce qui pourrait exister au-delà du nécessaire.
- Le travail maintient l'existence, mais il peut aussi la réduire à la seule continuité opératoire.

Étape 4 - Structure de vécu

On peut formuler la structure de vécu de la manière suivante :

L'expérience de Marc s'organise autour d'un maintien par l'activité. Le travail se poursuit, les tâches sont accomplies, les bêtes sont prises en charge. Le monde quotidien reste structuré par des nécessités concrètes qui ne peuvent pas être suspendues.

Cette continuité donne à Marc une place et un rythme. Elle lui permet de tenir dans le quotidien sans effondrement manifeste. L'exploitation familiale, la responsabilité envers les animaux et la répétition des tâches organisent encore son rapport au temps, à l'espace et à lui-même.

Mais cette continuité semble s'accompagner d'un appauvrissement du sens. Marc ne formule pas une plainte aiguë, mais une fatigue morale diffuse et un désengagement. Ce qui dépasse le strict nécessaire devient difficile à dire : « après, le reste... je ne sais pas trop ».

La structure de vécu peut donc être décrite comme un maintien opératoire : l'existence continue à tenir par le faire, mais ce faire apparaît faiblement soutenu par un horizon de sens, de désir ou de projection personnelle.

Commentaire clinique transversal

- Cette observation est intéressante parce qu'elle ne montre pas une crise spectaculaire du travail.
- Marc continue à travailler. L'activité n'est pas interrompue. Le quotidien reste organisé. Pourtant, quelque chose semble s'appauvrir dans le rapport au travail et à soi.
- Il ne s'agit donc pas seulement de repérer des signes de fatigue ou de désengagement. Il faut comprendre comment le travail peut fonctionner à la fois comme appui et comme limitation :
 - . appui, parce qu'il structure le temps, donne une place, maintient l'action ;
 - . limitation, parce qu'il peut réduire l'existence au strict accomplissement des tâches nécessaires.
- > La clinique du travail invite ici à être attentif à la différence entre continuer à faire et pouvoir encore habiter ce que l'on fait.

Points de vigilance

Une mauvaise réponse consisterait à dire immédiatement :

- « Marc est en dépression. »

- « Marc est en burn-out agricole. »
- « Il est usé par son métier. »
- « Il n'aime plus son travail. »
- « Il est résigné. »

Ces formulations peuvent éventuellement être discutées dans un second temps, mais elles ne doivent pas remplacer l'analyse du vécu. Elles posent plusieurs problèmes :

- Elles réduisent trop vite l'expérience à une catégorie clinique ou sociale.
- Elles ne décrivent pas suffisamment ce qui maintient Marc dans l'activité : les bêtes, les tâches, l'exploitation, la responsabilité concrète.
- Elles ne distinguent pas assez la continuité opératoire et l'investissement subjectif. Marc ne dit pas qu'il ne fait plus rien ; il dit qu'il fait ce qu'il y a à faire.
- Elles oublient enfin la dimension du « valoir » : ce qui semble atteint n'est pas seulement la capacité d'agir, mais la possibilité de donner sens, valeur ou orientation à ce qui est fait.

Conclusion

Cette observation illustre une forme d'existence où :

- le travail continue
 - le monde reste structuré
 - le corps reste engagé
 - les tâches sont accomplies
- > mais le sens subjectif de l'activité semble s'appauvrir

La structure n'est donc pas celle d'un effondrement, mais d'un maintien coûteux.

Marc tient par le travail, mais ce travail ne semble plus suffisamment ouvrir vers un horizon de sens ou de devenir. L'analyse phénoménologique permet de décrire cette configuration avant de la reprendre, éventuellement, dans une lecture sémiologique ou psychopathologique.

4.2. Caroline, maraîchère bio

Observation

Caroline se présente comme une jeune femme physiquement engagée dans son activité de maraîchage. Son corps apparaît marqué par le travail quotidien : gestes précis, rythme soutenu, contact constant avec la terre, les outils et les cultures.

Elle décrit ses journées comme organisées autour de tâches concrètes : semis, entretien des parcelles, récoltes, préparation des paniers, vente. Les activités s'enchaînent selon un ordre régulier, en lien avec les saisons et les conditions météorologiques. Elle évoque une attention constante portée aux cultures, aux cycles de croissance et aux besoins des plantes.

Le temps de ses journées est rempli, structuré par le travail à accomplir. Elle se lève tôt, travaille en extérieur la majeure partie de la journée, et termine ses tâches en fonction de l'avancement du travail plutôt que d'horaires fixes. Elle mentionne peu de moments de pause prolongée.

L'espace dans lequel elle évolue est principalement celui de la ferme et des parcelles cultivées : champs, serres, espace de stockage, point de vente. Elle décrit ces lieux avec précision, en termes d'usage et d'organisation pratique.

Sur le plan relationnel, Caroline mentionne des contacts réguliers avec les clients lors des ventes, ainsi que des échanges avec d'autres maraîchers ou partenaires locaux. Les interactions sont décrites comme cordiales, souvent centrées sur les produits, les méthodes de culture ou l'organisation du travail. Les relations

amicales apparaissent moins présentes dans son quotidien, en raison du temps consacré à l'activité professionnelle.

Elle parle de son activité avec des termes concrets, décrivant ce qu'elle fait plus que ce qu'elle ressent. Elle évoque son choix de s'installer en maraîchage biologique, son attachement à certaines valeurs liées à l'écologie et au travail de la terre. Elle ne développe pas longuement ses projets à long terme, mais mentionne la poursuite de son activité, l'amélioration de son exploitation et la fidélisation de sa clientèle.

Certaines difficultés apparaissent néanmoins en filigrane : fatigue physique, dépendance aux conditions climatiques, charge administrative et économique vécue comme plus abstraite, peu de place pour le repos, les relations sociales ou les loisirs, et parfois une impression de répétition des journées.

Étape 1 - Repérage du matériau clinique brut

Le vécu exprimé est marqué par :

- un engagement corporel important dans le travail
- des gestes précis et une activité physique soutenue
- un contact constant avec la terre, les outils, les cultures
- des journées organisées par des tâches concrètes : semis, entretien, récoltes, préparation, vente
- une temporalité remplie, réglée moins par l'horloge que par l'avancement du travail
- une forte dépendance aux saisons, à la météo et aux cycles de croissance
- un espace de vie et de travail centré sur l'exploitation : parcelles, serres, stockage, point de vente
- un territoire familier, maîtrisé, praticable
- des relations régulières mais principalement fonctionnelles : clients, partenaires, autres maraîchers
- des relations amicales moins disponibles en raison de la charge de travail
- un discours centré sur ce qui est fait plus que sur ce qui est ressenti
- un attachement à des valeurs écologiques et au travail de la terre
- une projection à long terme peu développée, mais orientée vers la continuité et l'amélioration de l'exploitation
- des difficultés présentes en arrière-plan : fatigue physique, incertitude climatique, charge administrative et économique, manque de pauses, impression de répétition.

Le matériau clinique ne montre pas une rupture ou une désorganisation manifeste. Caroline semble au contraire très engagée dans son activité. Mais cette stabilité repose sur un équilibre exigeant : un corps fortement mobilisé, un temps dense, une dépendance au milieu naturel et une vie largement organisée autour du travail.

Eviter, à ce stade :

- « Caroline est épuisée »
- « elle est en burn-out »
- « elle est enfermée dans son activité »
- « elle se défend par l'action ».

> l'analyse phénoménologique commence par décrire la forme du vécu : *une existence fortement ancrée dans le faire, le corps et les rythmes du vivant.*

Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu

Corporéité :

- La corporéité est une dimension centrale.
- Le corps de Caroline est fortement engagé dans l'activité. Il travaille, se déplace, porte, se penche, ajuste les gestes, manipule les outils, entre en contact avec la terre et les cultures. Il n'est pas seulement présent comme support biologique ; il est l'instrument principal de la relation au monde.

- Le corps est aussi perceptif. Il permet de sentir l'état des cultures, de repérer ce qui doit être fait, de s'ajuster aux conditions du sol, de la météo et des plantes. Il participe à une attention pratique au vivant.
- Mais ce corps est également exposé à l'usure. La fatigue physique, le rythme soutenu et le peu de pauses indiquent que l'équilibre de Caroline repose sur une forte disponibilité corporelle.
- > On peut donc parler d'une corporéité engagée et ajustée : le corps permet l'efficacité, l'ancrage et la continuité, mais il constitue aussi un point de vulnérabilité.

Temporalité :

- Le temps de Caroline est dense, rythmé et rempli.
- Il est organisé par les tâches agricoles : semis, entretien des parcelles, récoltes, préparation des paniers, vente. Les journées ne semblent pas réglées principalement par des horaires fixes, mais par l'avancement du travail.
- Le temps est aussi structuré par les saisons et les conditions météorologiques. Certaines périodes sont anticipées comme plus intenses, notamment les plantations et les récoltes ; d'autres apparaissent plus calmes. Le rythme de l'existence ne dépend donc pas seulement de décisions personnelles, mais du vivant, du climat et des cycles agricoles.
- Cette temporalité est très remplie, mais elle peut devenir répétitive et laisser peu d'espace à la pause ou à d'autres formes de disponibilité.
- > On peut donc décrire une temporalité écologique et opératoire : le temps est réglé par les cycles du vivant et par les tâches à accomplir.

Spatialité :

- L'espace vécu est centré sur l'exploitation.
- Caroline circule entre les champs, les serres, les espaces de stockage et le point de vente. Ces lieux sont décrits de manière précise, en fonction de leur usage. L'espace est familier, organisé, praticable.
- Il ne s'agit pas d'un espace abstrait ou impersonnel. C'est un territoire de travail connu, investi, orienté par l'action. Caroline sait où sont les choses, comment les lieux fonctionnent, où se déplacer et quoi y faire.
- Mais cet espace apparaît aussi relativement circonscrit. Le périmètre de vie est fortement organisé autour de l'exploitation. D'autres espaces — repos, loisirs, relations amicales, vie personnelle — sont moins présents dans le matériau.
- > La spatialité peut donc être décrite comme un espace familier et praticable, mais relativement resserré autour du travail.

Altérité :

- Le rapport à autrui est présent, mais il demeure principalement fonctionnel/professionnel.
- Caroline échange avec les clients, les autres maraîchers et les partenaires locaux. Ces relations sont cordiales et régulières, mais elles sont surtout centrées sur les produits, les méthodes de culture et l'organisation du travail.
- Les relations amicales existent, mais elles sont moins disponibles dans le quotidien, en raison du temps consacré à l'exploitation.
- Il faut aussi noter une autre forme d'altérité : celle du vivant non humain. Les plantes, les cultures, la terre, la météo ne sont pas de simples objets. Elles sollicitent Caroline, exigent une attention, imposent des rythmes et appellent des gestes.
- L'altérité est donc double :
 - . humaine, mais surtout fonctionnelle ;
 - . non humaine, fortement structurante, à travers le rapport aux cultures, à la terre et au climat.

Ipséité :

- Le rapport à soi semble principalement soutenu par l'action.
- Caroline parle davantage de ce qu'elle fait que de ce qu'elle ressent. Cela ne doit pas être compris comme un déficit psychologique. Cela indique plutôt une forme d'existence où le sens passe d'abord par l'activité, la compétence et l'ajustement pratique au milieu.
- Le soi apparaît comme incarné dans le faire : tenir le rythme, organiser les tâches, améliorer l'exploitation, répondre aux besoins des cultures, assurer les ventes.
- Les valeurs écologiques et le rapport à la terre donnent également des repères importants. Caroline ne travaille pas seulement pour produire ; elle semble s'inscrire dans une manière de faire qui a du sens pour elle.
- Cependant, la projection à long terme reste peu développée. L'avenir est évoqué sous la forme de la poursuite, de l'amélioration et de la fidélisation, plus que comme transformation ou ouverture vers d'autres possibles.
- L'ipséité peut donc être décrite comme une ipséité opératoire et incarnée : Caroline se maintient comme sujet par l'action, la compétence et l'inscription dans un milieu vivant.

Mondanéité :

- Le monde apparaît concret, praticable et vivant.
- Il est composé de terre, de cultures, d'outils, de saisons, de météo, de paniers, de clients, de tâches à accomplir. Ce monde ne se donne pas d'abord comme un problème abstrait ; il appelle des gestes.
- La mondanéité est donc fortement écologique et opératoire. Le monde est vécu comme un milieu à cultiver, à entretenir, à ajuster. Il donne des prises immédiates : observer, semer, récolter, préparer, vendre.
- Mais ce monde comporte aussi des incertitudes : climat, charge administrative, contraintes économiques, fatigue, répétition. Il est habitable et porteur de sens, mais exigeant.
- > On peut donc décrire un monde vivant et praticable, mais coûteux à soutenir.

Passage vers la tension structurante :

- Les différentes dimensions convergent vers une même organisation :
 - . Caroline est fortement ancrée dans un monde concret, vivant et praticable.
 - . Son existence est soutenue par le corps, les gestes, les cycles agricoles et les tâches quotidiennes.
 - . Mais cette stabilité repose sur une forte charge : disponibilité corporelle, temps dense, dépendance au climat, répétition, faible espace pour le repos ou pour d'autres registres de vie.
- > La question est « À quelles conditions cet ancrage reste-t-il soutenant, et à partir de quand peut-il devenir limitant ? »

Étape 3 - Tension structurante centrale

La tension centrale peut être formulée ainsi : *ancrage écologique / vulnérabilité à l'usure*

- . On peut aussi formuler cette tension comme : engagement corporel dense / faible espace de dégagement
- . ou encore : *stabilité par l'activité / fragilité en cas d'interruption.*

Elle articule :

- un corps fortement engagé
- un monde concret et praticable

- un temps rythmé par les saisons et les tâches
- un attachement aux valeurs écologiques
- une activité porteuse de sens
- une fatigue physique
- une forte dépendance aux conditions climatiques et économiques
- un horizon de vie relativement resserré autour de l'exploitation.

Cette tension traverse :

- le rapport au corps : le corps soutient l'activité, mais il peut s'user
- le rapport au temps : le rythme est structurant, mais dense et peu interrompu
- le rapport à l'espace : l'exploitation est familière et praticable, mais resserre l'existence
- le rapport à autrui : les relations existent, mais restent souvent fonctionnelles
- le rapport à soi : le soi se soutient dans le faire, mais se met peu en mots
- le rapport au monde : le monde est vivant et porteur de prises, mais dépendant d'aléas extérieurs.

Ce que cette tension permet :

- Cette organisation permet une stabilité existentielle forte.
- Caroline trouve dans son activité une continuité, un ancrage corporel, une orientation concrète et une cohérence pratique. Le travail donne des prises au quotidien et inscrit son existence dans un milieu vivant.
- Elle peut se sentir efficace, compétente, utile et accordée à certaines valeurs.

Ce qu'elle limite :

- Cette même organisation peut limiter l'espace de repos, de recul et d'élaboration subjective.
- Si le corps fatigue, si les conditions climatiques deviennent défavorables, si la charge administrative augmente ou si l'activité doit s'interrompre, l'équilibre peut se fragiliser.
- La stabilité repose fortement sur la possibilité de continuer à faire. Cela rend Caroline potentiellement vulnérable lorsque le faire devient trop coûteux ou impossible.

Étape 4 - Structure de vécu

On peut formuler la structure de vécu de la manière suivante :

L'expérience de Caroline s'organise autour d'un ancrage actif dans un milieu vivant. Le monde quotidien est concret, praticable et orienté par des tâches : semer, entretenir, récolter, préparer, vendre. Il donne des prises immédiates et soutient une présence engagée.

Le corps joue un rôle central. Il est le support de l'action, de l'attention et de l'ajustement au milieu. Par les gestes, les déplacements, le contact avec la terre et l'observation des cultures, Caroline habite son travail de manière incarnée.

Le temps est rythmé par les cycles agricoles, les saisons, la météo et l'avancement des tâches. Il est dense, structuré, souvent rempli. Cette temporalité donne une continuité à l'existence, mais laisse peu de place à la pause ou à d'autres formes de disponibilité.

Le rapport à soi se soutient principalement dans l'action. Caroline parle davantage de ce qu'elle fait que de ce qu'elle ressent. Elle se maintient comme sujet par la compétence, l'efficacité, l'organisation du travail et l'attachement à certaines valeurs écologiques.

La structure de vécu peut donc être décrite comme un ancrage écologique opératoire : l'existence est stabilisée par le corps, le travail et l'inscription dans un milieu vivant. Mais cette stabilité demeure vulnérable à l'usure corporelle, aux aléas climatiques et économiques, et au rétrécissement possible de l'horizon existentiel autour de l'activité.

Commentaire clinique transversal

Caroline paraît tenir dans son travail, et ce travail semble porteur de sens. Le monde est concret, vivant, accessible par les gestes. Le corps est engagé. Le temps est structuré. L'espace est familier. Cette organisation est donc une ressource importante.

Mais cette ressource peut aussi devenir un point de fragilité si elle se rigidifie ou si les conditions changent.

Le cas de Caroline permet de montrer que le travail peut être :

- un support d'identité
- un appui corporel
- une inscription dans un monde porteur de sens
- une source de continuité
- mais aussi un lieu d'usure, de répétition, de dépendance aux aléas et de limitation des possibles.

Ouvertures cliniques et hypothèses possibles

L'analyse phénoménologique permet d'identifier plusieurs points de vigilance, sans les transformer immédiatement en diagnostic.

Risque d'usure corporelle et temporelle : L'existence de Caroline repose fortement sur l'engagement du corps, la répétition des cycles de travail et une temporalité dense. En cas de surcharge saisonnière, de fatigue prolongée, de blessure, de difficultés économiques ou climatiques, cette organisation pourrait exposer à une fatigue chronique ou à un épuisement professionnel.

Faible espace d'élaboration subjective : Le rapport à soi est principalement soutenu par l'action. Caroline parle surtout de ce qu'elle fait. Dans une situation de crise — échec de récolte, arrêt de travail, blessure, difficulté financière — il pourrait être plus difficile d'élaborer subjectivement l'expérience, puisque l'équilibre repose largement sur la continuité de l'activité.

Vulnérabilité aux conditions extérieures : Le monde de Caroline dépend fortement des conditions climatiques, économiques et saisonnières. Cette dépendance constitue à la fois une ressource existentielle, parce qu'elle inscrit son activité dans le vivant, et une source d'incertitude.

Rétrécissement de l'horizon existentiel : L'organisation de la vie autour de l'exploitation produit un espace vécu relativement circonscrit, des relations souvent fonctionnelles et une projection à long terme principalement centrée sur la continuité de l'activité. Cette configuration peut limiter l'accès à d'autres registres d'expérience : repos, loisirs, relations personnelles, transformation de soi.

III. De la clinique à la psychopathologie

1. Présentation

Cette troisième partie prolonge la méthode travaillée précédemment en introduisant une question nouvelle :

Nouvelle question : *À quelle forme de souffrance psychopathologique une organisation du vécu peut-elle être rapportée ?*

1.1. De la structure de vécu à la souffrance psychopathologique

Critères d'appréciation :

Une structure de vécu devient psychopathologiquement pertinente lorsqu'elle ne décrit pas seulement une manière singulière d'habiter le monde, mais *une manière de s'y trouver empêché, enfermé, appauvri ou désorganisé.*

La question centrale devient : *Qu'est-ce qui, dans cette organisation du vécu, fait souffrance ?*

On sera particulièrement attentif :

- à la réduction du champ des possibles (cf. "ce que la tension limite")
- à la rigidification des conduites
- à l'impossibilité d'agir, de choisir, de se séparer ou de se projeter
- à l'appauvrissement du rapport au monde
- à l'altération du rapport au corps, au temps, à l'espace, aux autres ou à soi
- au coût existentiel des stratégies de maintien
- aux motifs cliniques éventuels comme : l'épuisement, le retrait, la désorganisation, le passage à l'acte
- *Une conduite ne sera pas comprise seulement comme un symptôme isolé. Elle sera replacée dans la fonction qu'elle prend pour le sujet.*

C'est ce qui distingue un simple tableau sémiologique d'une étude clinique en bonne et due forme.

Cette fonction a justement été déterminée par l'analyse existentielle, par exemple :

- un *évitement* peut protéger d'une exposition vécue comme insoutenable
- une *vérification* peut tenter de réduire un doute impossible à clore
- un *retrait* peut préserver un périmètre praticable minimal
- une *accumulation* peut protéger contre une expérience de perte
- une *maîtrise* excessive peut permettre de tenir face à un monde vécu comme menaçant. Etc.
- *Mais ces mêmes conduites peuvent aussi devenir coûteuses lorsqu'elles se rigidifient, se répètent et réduisent progressivement la liberté du sujet.*

> C'est le *point d'entrée dans la psychopathologie*

- Dans les parties précédentes, une tension structurante était définie comme une polarité dynamique permettant de comprendre l'organisation du vécu.
- > Dans cette troisième partie, on s'intéressera donc à ce qui se produit lorsque cette tension devient rigide, coûteuse ou désorganisante.

En résumé :

- une tension peut d'abord permettre au sujet de tenir dans son monde

- mais lorsqu'elle se ferme, se répète ou s'intensifie, elle peut devenir (le signe d') un point de fragilité psychopathologique.

Exemples :

- une tension *exposition / maîtrise* peut permettre de rester dans le monde, mais devenir problématique si toute situation doit être contrôlée pour être supportable
- une tension *certitude / doute* peut soutenir un effort de justesse, mais devenir épuisante si aucune action ne peut être considérée comme achevée
- une tension *visibilité / retrait* peut protéger de la honte, mais devenir pathologique si le sujet ne peut plus soutenir le fait d'être vu
- une tension *conserver / perdre* peut préserver un sentiment de continuité, mais devenir envahissante si l'espace de vie est progressivement saturé
- une tension *engagement / retrait* peut protéger d'un monde trop intense, mais devenir souffrante si elle ferme durablement les possibilités relationnelles ou professionnelles.

En reprenant cette formulation générale :

La psychopathologie peut alors être comprise comme une forme de rigidification, d'appauvrissement ou de désorganisation d'une manière d'être-au-monde.

1.2. Du signe clinique à sa fonction existentielle

J'insiste un peu sur cette question :

- La psychopathologie classique repère d'abord des signes : anxiété, tristesse, évitement, fatigue, vérification, rumination, honte, impulsivité, retrait social, perte d'élan, idées suicidaires, accumulation, etc.
- Vs : L'analyse existentielle ne nie pas ces signes : Elle cherche à comprendre quelle fonction ils prennent dans l'organisation globale de l'expérience.

Il faut bien comprendre que :

Un même signe peut avoir des significations différentes selon le cas.

Dans les exemples cliniques qui suivent :

Par exemple l'*évitement* de Léo n'a pas la même valeur que le *retrait* de Chris

- chez Léo, l'*évitement* concerne surtout les situations où le corps pourrait perdre sa tenue, où l'espace pourrait se refermer, ou où le regard d'autrui pourrait rendre visible une perte de contrôle.
- chez Chris, le *retrait* vise surtout à limiter l'exposition d'un visage vécu comme honteux ou monstrueux.
- De même, la *vérification* de Marine n'a pas la même structure que la *vérification* de Chris :
 - chez Marine, *vérifier* vise à réduire le doute et à atteindre une justesse suffisante.
 - chez Chris, *vérifier* au miroir *relance au contraire* la confrontation à une image corporelle insupportable.

On voit la réflexion psychopathologique s'articuler directement à l'analyse existentielle :

- Que permet ce symptôme ?
- Que limite-t-il ?
- Quelle tension cherche-t-il à stabiliser ?
- Quelle souffrance entretient-il ou révèle-t-il ?

1.3. Quatre lectures psychopathologiques complémentaires

Une clinique circonstanciée permet de poser les bases "saines" d'une analyse psychopathologique

Je résume en quelques mots les thèmes centraux de quatre référentiels majeurs :

- la psychopathologie psychodynamique/psychanalytique
- la psychopathologie cognitive
- la psychopathologie anthropo-phénoménologique
- la psychopathologie neuro-phénoménologique

1.3.1. La lecture psychanalytique

La lecture psychanalytique/psychodynamique interroge les angoisses centrales, les défenses, les conflits psychiques, la place de la honte, de la faute, de la perte, du contrôle, de la séparation, etc.

Elle permet de demander :

- quelle angoisse cette organisation cherche-t-elle à contenir ?
- quelles défenses sont mobilisées ?
- que permettent ces défenses ?
- que rigidifient-elles ?
- quel rapport au désir, à la perte, au jugement ou à l'autre se dessine ?

1.3.2. La lecture cognitive

La lecture cognitiviste s'intéresse aux déficits et aux dysfonctionnements, et reste très tributaire de la référence aux mécanismes du conditionnement :

Elle examine :

- les croyances
- les biais attentionnels
- les interprétations négatives/catastrophiques
- les comportements de sécurité
- les cercles de maintien. Etc.

Elle permet de demander :

- sur quoi l'attention se fixe-t-elle ?
- quelles interprétations maintiennent la souffrance ?
- quelles croyances sont renforcées ?
- quels comportements de sécurité diminuent l'angoisse à court terme ?
- comment ces comportements maintiennent-ils le trouble à long terme ?

On peut ajouter à chacun de ces items les termes "faux" ou "inadaptés" : interprétations erronées, comportements "inadaptés, croyances fausses, etc.

1.3.3. La lecture anthropo-phénoménologique

Je détaille un peu plus la lecture anthropo-phénoménologique.

Les auteurs de référence sont Ludwig Binswanger et Georges Charbonneau

La lecture anthropo-phénoménologique reste proche de la phénoménologie clinique, mais elle déplace légèrement la question

- Il ne s'agit plus seulement de décrire l'expérience vécue, ni seulement de discuter un modèle psychopathologique

> Il s'agit de se demander *ce que la souffrance modifie dans les formes fondamentales de l'existence humaine*.

La question n'est donc pas seulement : À quel trouble ce tableau peut-il être rapporté ?

Elle devient aussi :

Questionnement de base : *Quelle possibilité humaine fondamentale se trouve ici fragilisée, entravée ou déformée ?*

La lecture anthropo-phénoménologique s'intéresse ainsi à la manière dont un trouble affecte les grandes coordonnées de l'existence, c'est-à-dire aux altérations de la structure d'existence, ce qui correspond à :

- la possibilité de se tenir dans le monde
- la possibilité d'habiter un espace commun
- la possibilité de se reconnaître comme soi
- la possibilité de rencontrer autrui
- la possibilité d'agir
- la possibilité d'attendre, de se projeter ou de devenir
- la possibilité de partager un monde avec les autres. Etc.

On retrouve en arrière-plan la plupart des existentiels qui ont organisé l'analyse de la structure de l'existence

Elle mobilise également (dans les exemples proposés) :

- Merleau-Ponty pour le corps propre, le « je peux » et l'intentionnalité opérante ;
- Minkowski pour le devenir, l'élan et la temporalité ;
- Tatossian pour le monde vécu, le sens commun pratique et la phénoménologie clinique ;
- implicitement Sartre et Levinas dans certaines analyses du regard et du visage.

Elle ne part donc pas uniquement des symptômes, mais de la forme humaine d'existence que ces symptômes viennent atteindre. Par exemple :

- une conduite d'*évitement* ne sera pas seulement comprise comme un comportement de fuite ou comme un comportement de sécurité : elle pourra être comprise comme une altération de la possibilité d'habiter le monde commun.
- une *vérification* répétée ne sera pas seulement comprise comme une compulsion ou comme une stratégie de contrôle : elle pourra être comprise comme une tentative de restaurer une confiance minimale dans le monde, dans le corps ou dans l'action.

On peut dire que cette perspective anthropo-phénoménologique :

- n'est pas tout à fait équivalente et ne se substitue pas aux trois autres référentiels
- > elle ne se substitue pas à la lecture psychodynamique, à la neurophénoménologie ou à la lecture cognitive.
- > elle ajoute un niveau supplémentaire : celui des conditions anthropologiques de l'existence.

> La psychopathologie n'est alors pas seulement comprise comme un ensemble de symptômes, ni comme un conflit psychique, ni comme une boucle corporelle ou cognitive : elle est comprise comme une altération d'une manière humaine fondamentale d'exister.

Formulation possible :

La lecture anthropo-phénoménologique comprend la psychopathologie comme une atteinte des conditions fondamentales de l'existence humaine. Elle cherche à décrire comment une souffrance modifie la possibilité de se tenir dans un corps, d'habiter un monde, de rencontrer autrui, de se reconnaître comme soi et de s'engager dans une histoire possible.

1.3.4. La lecture neuro-phénoménologique

La lecture neuro-phénoménologique cherche à articuler la description en première personne de l'expérience avec l'étude des dynamiques corporelles, perceptives, affectives et neurobiologiques qui la rendent possible. Elle ne localise pas le trouble dans le cerveau seul : elle l'envisage comme une organisation dynamique du système cerveau-corps-environnement. Dans cette partie, elle sera surtout mobilisée sous sa forme incarnée et éactive, afin de décrire les boucles qui relient sensations, attention, perception, action, espace et habitudes de protection.

Elle permet de demander :

- comment le corps participe-t-il à l'organisation du trouble ?
- quelles situations déclenchent une activation corporelle ?
- comment l'espace, le regard ou les objets sont-ils vécus corporellement ?
- quelles habitudes perceptives et corporelles se stabilisent ?
- comment les conduites de protection renforcent-elles certaines boucles corps-monde ?

Les auteurs de référence sont Merleau-Ponty (historique) et Thomas Fuchs (actuel)

1.4. Progression des situations cliniques

Les situations cliniques qui suivent permettront de travailler ce passage entre clinique existentielle et psychopathologie.

Structure générale de l'étude de cas basée sur l'analyse phénoménologique/existentielle :

- décrire les phénomènes centraux du vécu
- formuler la manière d'être-au-monde
- repérer la tension structurante principale
- identifier ce qui fait souffrance ou limite l'existence
- discuter les hypothèses psychopathologiques possibles
- montrer ce que chaque modèle psychopathologique permet d'éclairer

La question directrice de cette partie peut donc être formulée ainsi : *Comment une manière d'habiter le monde peut-elle devenir une forme de souffrance psychopathologique ?*

La partie clinique sera plus synthétisée que précédemment, pour détailler un peu plus la partie patho.

2. Marine, 36 ans

Premier cas avec une analyse assez simple

2.1. Observation

Marine est une femme de 36 ans, reçue en consultation à la suite d'une recommandation médicale. Elle se présente à l'heure, tenue soignée, attitude réservée. Son discours est précis, détaillé, parfois très élaboré, mais marqué par de fréquentes reprises, reformulations et demandes de clarification, comme si elle cherchait à s'assurer en permanence de l'exactitude de ce qu'elle exprime. Elle s'excuse régulièrement de « ne pas être claire » ou de « trop en dire », témoignant d'un souci constant de ne pas se tromper ou d'occuper une place inadéquate dans l'échange.

Marine décrit un fonctionnement quotidien envahi par une activité mentale intense et difficile à interrompre. Elle évoque des pensées récurrentes, des interrogations persistantes et un besoin fréquent de vérifier, de comparer ou de revenir sur ses décisions, même lorsqu'elles sont mineures. Cette activité mentale lui apparaît à la fois comme une tentative de maîtrise et comme une source d'épuisement, qu'elle décrit comme « tourner en rond dans sa tête ».

Elle rapporte une difficulté marquée à prendre des décisions sans éprouver de doute *a posteriori*. Une fois une action engagée, elle se surprend à revenir mentalement sur les étapes précédentes, s'interrogeant sur ce qui aurait pu être fait autrement ou sur les conséquences possibles de ses choix. Cette rumination peut se prolonger plusieurs heures, voire plusieurs jours, et s'accompagne d'un sentiment de tension intérieure et d'insatisfaction chronique.

Sur le plan corporel, Marine décrit des sensations diffuses de fatigue, de lourdeur et parfois de tension, sans localisation précise. Elle parle d'un corps « lourd à porter », souvent perçu comme ralenti ou peu disponible. Elle mentionne également des difficultés de concentration, une impression de « brouillard mental » et un besoin fréquent de pauses pour tenter de se recentrer. Le sommeil est décrit comme peu réparateur, marqué par des difficultés d'endormissement liées à un flux de pensées incessantes.

Dans les interactions sociales, Marine se montre attentive, investie, mais rapporte un sentiment constant d'inadéquation. Elle craint de mal faire, de mal dire ou de ne pas répondre correctement aux attentes implicites de l'autre. Après les échanges, elle repasse longuement les conversations, analysant ses paroles et celles de ses interlocuteurs, à la recherche d'éventuelles erreurs ou maladresses. Ces reprises mentales sont vécues comme envahissantes et contribuent à une fatigue relationnelle importante.

Sur le plan professionnel, Marine occupe un poste à responsabilités dans le secteur administratif. Elle est reconnue pour sa rigueur et son sérieux, mais décrit une grande difficulté à déléguer et à clore ses dossiers. Elle vérifie longuement son travail, relit de nombreux courriels avant de les envoyer, et peine à considérer une tâche comme suffisamment aboutie. Cette exigence permanente entraîne des dépassements horaires fréquents et un sentiment de ne jamais en faire assez.

Dans sa vie personnelle, Marine vit seule. Elle entretient quelques relations amicales, mais évite les engagements trop rapprochés, qu'elle décrit comme « coûteux mentalement ». Les projets à long terme sont source d'inquiétude, et elle exprime une difficulté à se projeter dans l'avenir autrement que sur un mode prudent, voire contraint. Elle ne rapporte pas d'idées suicidaires, mais évoque un sentiment de lassitude et une impression que « tout demande trop d'efforts ».

Marine attend du suivi un apaisement de cette agitation mentale et le souhait de retrouver une forme de légèreté, de spontanéité et de confiance dans ses actes, sans avoir à tout contrôler ou repenser continuellement.

2.2. Clinique phénoménologique

Marine décrit une expérience dominée par une activité mentale continue, difficile à interrompre, vécue à la fois comme tentative de maîtrise et comme source d'épuisement.

Son vécu est marqué par :

- des pensées récurrentes et des reprises mentales incessantes
- une difficulté à clore les décisions et les actions
- un doute persistant, y compris après avoir agi
- une tendance à revenir continuellement sur ce qui a été dit, pensé ou fait
- une crainte de l'erreur, de l'imprécision ou de l'inadéquation
- des conduites de vérification et de contrôle
- une fatigue diffuse et un ralentissement corporel
- un sentiment de lourdeur psychique et physique
- une difficulté à se projeter de manière spontanée
- une tension relationnelle liée au regard implicite d'autrui.

La pensée apparaît moins comme un outil d'ouverture vers le monde que comme une activité de surveillance permanente.

2.3. Analyse existentielle

L'analyse existentielle proposée ici va être beaucoup plus succincte que précédemment

Manière d'être-au-monde : L'expérience de Marine semble correspondre à une manière d'habiter le monde sous condition de certitude et de contrôle.

Rapport à la pensée

La pensée occupe une place centrale dans l'organisation de l'existence. Elle fonctionne comme :

- outil de vérification
- tentative de sécurisation
- activité de surveillance permanente.

Mais cette activité ne conduit pas à l'apaisement : elle entretient au contraire une circularité mentale et un doute chronique.

Rapport à l'action

J'ajoute ici une petite variante dans les existentiels (cf. notamment l'importance du "valoir", du "pouvoir", etc.

L'action apparaît difficile à achever. Une fois une décision prise :

- Marine revient sur les possibilités non retenues
 - elle réévalue constamment ses choix
 - elle peine à considérer une tâche comme suffisamment terminée.
- > L'action reste ainsi ouverte, inachevée et réversible.

Rapport au corps

Le corps est vécu comme :

- lourd
- ralenti

- fatigué
- difficile à mobiliser

Cette lourdeur traduit une difficulté générale à se laisser porter spontanément dans l'existence.

Rapport au temps

La temporalité est dominée par :

- la reprise
- le retour
- la réévaluation.

Le présent est continuellement réouvert par l'analyse rétrospective.

L'avenir apparaît difficilement habitable autrement que sur un mode prudent et contraint.

Rapport à autrui

Autrui est vécu comme porteur :

- d'attentes implicites
- d'exigences difficiles à saisir complètement
- d'un possible jugement sur la justesse des comportements ou des paroles.

Les interactions deviennent ainsi des espaces d'évaluation permanente.

Tension structurante

L'existence de Marine semble organisée autour d'une tension centrale : **besoin de certitude / impossibilité d'achèvement.**

D'un côté :

- les vérifications
- le besoin de justesse, de cohérence et de maîtrise
- la volonté d'éviter toute erreur

De l'autre :

- l'impossibilité d'obtenir une validation définitive
- la persistance du doute
- l'apparition incessante de nouvelles possibilités
- la reprise de ce qui vient pourtant d'être accompli

Ce que cette tension permet : contenir temporairement l'incertitude et l'anxiété liée à l'erreur. Les vérifications et les reprises mentales donnent à Marine le sentiment de préserver une cohérence interne, une certaine maîtrise et une capacité à poursuivre son action malgré le doute.

Ce qu'elle limite : la capacité à considérer durablement une parole, une décision ou une action comme suffisamment juste et achevée. Elle réduit la spontanéité, maintient le passé récent comme un problème à reprendre et transforme l'avenir en lieu possible de révélation de l'erreur. Elle entretient ainsi une boucle de contrôle, de doute et de réévaluation, au prix d'un épuisement cognitif et corporel.

N/B. :

La **structure de vécu** désigne l'organisation globale et relativement stable de l'expérience : la manière dont le temps, l'espace, le corps, autrui, soi et le monde s'articulent autour de certaines tensions. Elle constitue le résultat principal de l'analyse phénoménologique.

La **formulation existentielle** est la mise en mots synthétique de cette organisation. C'est une phrase clinique qui condense la structure de vécu en montrant :

- comment le sujet se maintient dans l'existence
- ce que cette organisation lui permet
- ce qu'elle limite ou empêche

- quelle tension centrale organise son rapport au monde.

Autrement dit :

Structure de vécu = organisation du vécu.

Formulation existentielle = expression synthétique de cette organisation.

Structure de vécu

L'expérience de Marine s'organise autour d'un doute qui maintient ouverts le temps, l'action et les possibilités. Le contrôle lui permet de préserver une cohérence relative, mais au prix d'un rapport au monde marqué par la reprise, la vigilance et l'épuisement.

Formulation existentielle

L'expérience de Marine s'organise autour d'une recherche de certitude qui vise à préserver sa cohérence et sa maîtrise, mais qui empêche toute clôture durable. Chaque action reste susceptible d'être reprise, vérifiée ou corrigée, maintenant son existence dans une vigilance continue et un doute sans cesse relancé.

2.4. Psychopathologie psychodynamique

Angoisse centrale

L'organisation symptomatique semble structurée autour :

- d'une angoisse de culpabilité
 - d'une peur de l'erreur
 - et d'une difficulté à tolérer l'incertitude.

L'absence de certitude durable apparaît particulièrement menaçante pour l'équilibre psychique.

Fonction des défenses

Les conduites :

- de vérification
- de réassurance
- de contrôle
- de reprise mentale
- de rumination

jouent une fonction défensive importante. Elles permettent :

- de contenir l'angoisse
- de maintenir un sentiment de cohérence (par rapport aux situations, à autrui...)
- et de limiter la possibilité de faute ou d'inadéquation

Mais ces stratégies contribuent progressivement :

- à rigidifier le fonctionnement
- à majorer l'épuisement psychique et physique
- et à réduire la spontanéité

Rapport au jugement et au Surmoi

Dans une lecture psychanalytique, le fonctionnement de Marine peut être compris comme soumis à un Surmoi particulièrement exigeant

- celui-ci ne condamne pas seulement la faute manifeste
- il impose que l'action soit juste, maîtrisée et à l'abri de tout reproche.

Le jugement d'autrui prend alors une valeur surmoïque :

- Marine semble anticiper chez les autres la critique qu'elle s'adresse déjà à elle-même

- le regard extérieur devient le relais d'une instance interne qui examine ses actes, ses paroles et ses décisions.

Cette exigence permanente induit :

- une forte auto-surveillance
- une conflictualité autour de la perfection et de la maîtrise

Le doute ne porte donc pas seulement sur l'exactitude matérielle de l'action :

- il traduit aussi l'impossibilité d'obtenir un acquittement durable de la part du Surmoi
- même lorsqu'une tâche est accomplie, Marine ne peut être certaine d'avoir suffisamment bien fait
- Toute vérification peut faire apparaître une nouvelle erreur possible.

Le contrôle et la vérification permettent alors :

- d'apaiser provisoirement le jugement interne
- de prévenir la culpabilité
- d'éviter la position de celle qui aurait mal fait
- de préserver une image de soi consciencieuse et fiable
- de maintenir à distance ce qui contredirait cette image

La difficulté à déléguer peut également être comprise dans cette perspective. Confier une tâche à autrui oblige Marine à renoncer à la maîtrise du résultat.

L'agressivité surmoïque se retourne contre elle sous la forme :

- d'autocritique
- de culpabilité
- d'exigences excessives
- d'interdiction de l'erreur
- de vérifications épuisantes

Symétriquement, la vérification peut ainsi être comprise comme une formation de compromis. Elle permet :

- de satisfaire partiellement les exigences du Surmoi
- de prévenir la faute et la culpabilité
- de contenir l'agressivité
- de préserver une représentation cohérente de soi
- de différer une décision qui impliquerait un renoncement

Cette solution reste toutefois instable :

- aucune vérification ne peut garantir définitivement l'absence de faute, ni faire taire durablement le jugement interne
- > Plus Marine cherche à atteindre une certitude irréprochable, plus elle renforce l'autorité du Surmoi et la nécessité de contrôler.

Formulation psychodynamique

Les symptômes de Marine peuvent être compris comme des modalités défensives face à des sentiments de culpabilité, d'incertitude et d'inadéquation. Le contrôle, les vérifications et les ruminations visent à contenir ces éprouvés et à maintenir une cohérence psychique et relationnelle, mais au prix d'une vigilance et d'un effort permanents.

2.5. Psychopathologie cognitive

On évalue ici la symptomatologie autour d'une série de biais dans l'évaluation de l'erreur et du risque

Intolérance à l'incertitude

Le fonctionnement de Marine semble marqué par une difficulté importante à tolérer l'incertitude.

Les situations ordinaires de décision, de communication ou de responsabilité déclenchent rapidement :

- un doute persistant
- une anticipation des erreurs possibles
- une difficulté à considérer une réponse comme suffisante
- une impression que quelque chose aurait pu être mieux formulé, mieux fait ou mieux vérifié.

L'incertitude ne reste pas une dimension normale de l'action. Elle devient une menace :

- menace de se tromper
- menace de mal faire
- menace de décevoir
- menace d'occuper une place inadéquate
- menace d'avoir laissé passer une erreur.

Marine cherche donc à réduire l'incertitude par la vérification, la reprise mentale et la recherche de justesse.

Surestimation de l'erreur

Marine semble accorder une importance très élevée à la possibilité de l'erreur. Une erreur, même mineure, peut être anticipée comme ayant des conséquences importantes :

- être mal comprise
- être jugée
- produire une conséquence négative
- révéler une insuffisance
- mettre en cause sa fiabilité.

Cette surestimation de l'erreur alimente la difficulté à clore les actions. Elles restent susceptibles d'être reprises, corrigées ou réévaluées.

Hypervigilance cognitive

Comme une forme de conséquence de l'intolérance à l'incertitude ;

L'attention de Marine semble fortement orientée vers :

- ce qui pourrait être imprécis
- ce qui pourrait être incomplet
- ce qui pourrait être mal formulé
- ce qui pourrait être mal interprété
- ce qui pourrait ne pas correspondre aux attentes d'autrui.

Cette hypervigilance ne porte pas seulement sur les situations extérieures. Elle porte également sur ses propres pensées, paroles et décisions. Marine surveille continuellement :

- ce qu'elle pense
- ce qu'elle dit
- ce qu'elle a dit
- ce qu'elle aurait dû dire
- ce qu'elle aurait pu faire autrement.

L'attention devient ainsi difficile à désengager : elle reste fixée sur les possibles erreurs ou insuffisances.

C'est une sorte de surinvestissement attentionnel

Rumination et réévaluation

Après une action ou une interaction, Marine revient longuement sur ce qui s'est passé. Elle repasse mentalement :

- les conversations
- les décisions prises
- les étapes d'un dossier
- les courriels envoyés
- les réponses données
- les formulations employées.

Cette rumination fonctionne comme une tentative de contrôle rétrospectif. Elle vise à vérifier que l'action était juste, adaptée ou suffisamment correcte. Mais elle produit l'effet inverse :

- elle relance le doute
- elle multiplie les possibilités alternatives
- elle empêche la clôture
- elle entretient la fatigue mentale
- elle renforce l'impression de ne jamais pouvoir être totalement sûre.

Comportements de sécurité

Les conduites de Marine peuvent être comprises comme des comportements de sécurité. Il s'agit notamment :

- des vérifications répétées
- des relectures de courriels
- des demandes de clarification
- des reformulations
- des reprises mentales
- de la difficulté à déléguer
- de la difficulté à clore les dossiers
- de l'évitement des engagements trop coûteux mentalement

Dans une lecture un peu plus fonctionnelle/défensive qui évoque d'ailleurs les tensions existentielles :

Ces comportements permettent :

- de réduire temporairement le doute
- de diminuer momentanément l'anxiété
- de maintenir un sentiment de contrôle
- de limiter la peur de l'erreur

Mais ils empêchent :

- l'apprentissage d'une tolérance à l'incertitude
- la possibilité de constater qu'une action imparfaite peut être suffisante
- l'infirmité des croyances liées au danger de l'erreur
- la restauration d'un rapport plus spontané à l'action.

Cercle de maintien

On trouve également la notion de conditionnement en arrière-plan :

Un cercle auto-entretenu semble progressivement s'installer :

Situation de décision, d'action ou d'échange

> doute

- > anticipation d'une erreur possible
- > tension et inquiétude
- > vérification / rumination / reprise mentale
- > soulagement temporaire
- > relance du doute
- > besoin accru de contrôle

> qui va relancer l'anticipation d'une erreur possible ...

Ce fonctionnement maintient Marine dans une boucle où la recherche de certitude alimente paradoxalement l'incertitude :

- plus elle vérifie, plus l'action semble devoir être vérifiée.
- plus elle cherche à être certaine, plus la certitude devient difficile à atteindre.

Retentissement fonctionnel

Cette organisation cognitive entraîne un coût important dans plusieurs domaines.

Sur le plan professionnel, elle contribue :

- aux dépassements horaires
- à la difficulté à déléguer
- à l'impossibilité de clore certaines tâches
- à l'épuisement lié à la vérification permanente.

Sur le plan relationnel, elle favorise :

- la reprise mentale des échanges
- la crainte de l'inadéquation
- la fatigue relationnelle
- l'évitement de certains engagements.

Sur le plan subjectif, elle entretient :

- une impression d'effort constant
- une perte de spontanéité
- une lassitude
- un sentiment de ne jamais en faire assez.

Formulation cognitive

Les difficultés de Marine peuvent être comprises comme le résultat d'un fonctionnement centré sur l'intolérance à l'incertitude, la surestimation de l'erreur et la recherche de certitude. Les conduites de vérification, de rumination et de reprise mentale réduisent temporairement l'anxiété, mais contribuent progressivement à maintenir le doute, l'épuisement cognitif et la restriction de la spontanéité dans l'action comme dans la relation.

2.6. Psychopathologie anthropo-phénoménologique

L'approche anthropo-phénoménologique ne cherche pas seulement à :

- identifier les pensées, les croyances ou les mécanismes cognitifs qui entretiennent les symptômes
- > elle interroge une transformation plus globale du rapport à l'action, au temps, au possible, à autrui et au monde quotidien.

Chez Marine, le phénomène central n'est pas une incapacité à agir

- elle travaille
- elle décide
- elle communique
- elle assume des responsabilités

La perturbation concerne plutôt la manière dont l'action s'accomplit et acquiert une stabilité dans son expérience

- un acte ordinaire transforme normalement la situation et permet de passer à autre chose.
- Chez Marine, ce qui vient d'être fait reste exposé à la vérification, à la correction et à la réouverture.
- > l'acte a eu lieu objectivement, mais il ne s'impose pas durablement comme accompli.

De l'intentionnalité opérante à la surveillance réflexive

Dans la perspective de Merleau-Ponty, le sujet est d'abord engagé corporellement et pratiquement dans un monde déjà porteur de significations. L'action repose sur un savoir-faire implicite : parler, choisir ou terminer une tâche ne suppose pas de reconstruire consciemment tous les critères qui rendent l'acte valable.

C'est ce qui est appelé l'"évidence naturelle" (du monde, de l'action)

Chez Marine, cette confiance opérante est remplacée par une surveillance réflexive :

L'action est comme dédoublée

- elle ne se contente plus de parler, elle contrôle sa manière de parler ;
- elle ne se contente plus de décider, elle vérifie la validité de sa décision ;
- elle ne se contente plus d'accomplir une tâche, elle examine si celle-ci peut réellement être considérée comme terminée.

Il s'agit d'une *hyperréflexivité corrective et normative* :

- Marine ne perd ni le contact avec la réalité ni le sentiment d'être l'auteur de ses actes.
- elle devient cependant excessivement attentive à ses propres opérations.
- > la réflexion, au lieu d'accompagner ponctuellement l'action, la redouble et la soumet à une validation permanente.

La différence avec la lecture cognitive est importante

- l'approche cognitive étudie principalement les contenus de pensée, les biais d'interprétation, l'intolérance à l'incertitude ou les mécanismes de rumination.
- l'approche anthropo-phénoménologique décrit ici une *altération du pouvoir même de l'acte* : ce n'est pas seulement la pensée qui doute, c'est l'action qui ne parvient plus suffisamment à faire événement.

Affaiblissement du pouvoir de l'acte

Agir ne consiste pas seulement à produire un résultat. L'acte possède un pouvoir instituant

- décider fait passer plusieurs possibilités à une décision effective ;
- parler transforme une intention en parole prononcée ;
- envoyer un courriel fait passer un texte du brouillon au message adressé ;
- terminer une tâche permet de la laisser derrière soi.

Chez Marine, cette force de réalisation est fragilisée

- la décision ne disqualifie pas suffisamment les possibilités écartées.
- le message envoyé reste subjectivement modifiable
- la tâche terminée demeure presque aussi ouverte que lorsqu'elle était en cours.

Marine agit, mais l'action ne tranche pas suffisamment dans le champ des possibles. Les possibilités non choisies restent actives et contestent le réel :

- elle aurait pu répondre autrement ;
- employer un autre mot ;
- mieux vérifier ;
- anticiper une autre conséquence, etc.

La « confiance pratique » est altérée : Marine ne doute pas de la réalité du monde, mais de l'adéquation de son propre geste à la situation.

Le possible n'est plus seulement l'horizon de la liberté : il devient une objection permanente à ce qui a effectivement été réalisé.

Transformation de la temporalité

La temporalité vécue ne désigne pas simplement la succession du passé, du présent et de l'avenir : elle concerne la manière dont l'expérience

- se poursuit
- se termine
- et ouvre sur ce qui vient.

Dans une perspective inspirée de Minkowski, l'existence ne se réduit pas à occuper un présent ponctuel :

- elle comporte un élan vers l'avenir
- une capacité à dépasser ce qui est déjà donné
- et à s'engager dans de nouvelles possibilités.

Cette dynamique peut se modifier dans la psychopathologie. Le passé peut rester anormalement présent, le présent perdre sa capacité de décision ou l'avenir cesser d'apparaître comme ouvert. Le temps n'est alors pas seulement pensé différemment : il est vécu comme ralenti, bloqué, répétitif, suspendu ou privé d'élan.

Chez Marine, la temporalité n'est pas véritablement arrêtée : elle est *capturée par la reprise*.

- le passé récent reste actif comme problème
- le présent devient un temps de contrôle et de réévaluation
- l'avenir apparaît comme le moment possible où l'erreur pourrait être révélée

Ce qui vient d'être accompli est continuellement révoqué.

L'« après » demeure occupé par l'« avant », car l'acte n'a pas acquis une clôture suffisante.

La difficulté à terminer devient ainsi une difficulté à recommencer : le nouveau reste encombré par ce qui n'a pas pu être laissé derrière soi.

Du monde de significations au monde de critères

Le monde quotidien se présente normalement comme un ensemble de situations appelant des réponses souples > Chez Marine, cette souplesse se transforme en problème *normatif*.

Le monde devient un monde de critères :

- critères de précision
- de correction
- de responsabilité
- de complétude
- de bonne formulation
- d'adéquation à autrui

Toute situation se dédouble : à la tâche réelle s'ajoute une scène intérieure où Marine évalue si elle s'est correctement conduite.

Dans la perspective de Tatossian, il ne s'agit pas d'une perte radicale du sens commun. Marine connaît les règles sociales et professionnelles. Ce qui devient incertain est leur application vivante et contextuelle :

- savoir quand une explication est suffisante

- savoir quand une imprécision est acceptable
- ou savoir quand il est simplement possible de poursuivre

Formulation anthropo-phénoménologique

Les difficultés de Marine peuvent être comprises comme une *transformation du rapport à l'action*. L'acte perd :

- une partie de sa force d'accomplissement
- de sa portée temporelle
- et de son évidence intersubjective.

Cette organisation associe :

- le passage d'une intentionnalité opérante à une surveillance réflexive
- une difficulté à laisser les possibles non réalisés perdre leur pouvoir d'appel
- une temporalité dominée par la reprise et la révocation
- une transformation du monde pratique en monde de critères
- une dépendance accrue au jugement possible d'autrui
- une fatigue corporelle liée au travail permanent d'explicitation et de contrôle

La psychopathologie ne réside donc pas seulement dans le doute ou la rumination. Elle concerne la manière dont l'action devient réelle, transforme la situation et permet au sujet de se porter vers la suite.

Marine agit, mais sans pouvoir pleinement se délivrer dans son action : la recherche de certitude vise à consolider le réel, tout en maintenant paradoxalement les possibles ouverts.

2.7. Psychopathologie neuro-phénoménologique

Boucles pensée-corps-fatigue

Les situations impliquant :

- une décision
- une responsabilité
- une interaction sociale
- ou un engagement dans l'action

activent rapidement :

- une activité cognitive intense
- une vigilance réflexive
- une tension corporelle diffuse.

Cette mobilisation prolongée contribue ensuite :

- à la fatigue
- au brouillard mental
- au ralentissement corporel.

La fatigue réduit à son tour les capacités de régulation et augmente le besoin de contrôle, entretenant ainsi une boucle entre pensée, corps et épuisement.

Hyperréflexivité

Les pensées et les actions de Marine deviennent continuellement :

- observées
- réévaluées
- comparées
- corrigées

Cette surveillance réflexive contribue :

- à désautomatiser le rapport au monde
- à diminuer son « évidence pratique »
- et à majorer le sentiment d'effort permanent.

Anticipation corporelle de l'incertitude

Progressivement, certaines situations sont associées :

- au doute
- à la tension
- à l'épuisement
- à la possibilité d'une erreur.

L'organisme anticipe alors l'effort cognitif et la surcharge mentale avant même l'engagement dans l'action.

Charge mentale : quantité de ressources attentionnelles, mnésiques et décisionnelles mobilisées pour réaliser une tâche. Elle comprend notamment le fait de

- maintenir des informations en mémoire
- comparer plusieurs options
- contrôler les erreurs
- inhiber des réponses et prendre une décision.

Réduction de la spontanéité

Les stratégies de contrôle et de vérification permettent une diminution transitoire de l'incertitude.

Mais elles contribuent également :

- à rigidifier les conduites
- à limiter l'engagement spontané
- à réduire la fluidité du rapport au monde

Formulation neuro-phénoménologique

Les difficultés de Marine s'inscrivent dans une dynamique incarnée associant activité réflexive intense, tension corporelle et anticipation de l'erreur. Les vérifications réduisent temporairement l'incertitude, mais entretiennent progressivement une boucle cognitive et corporelle marquée par l'effort, la rigidification des conduites et la fatigue du rapport au monde.

2.8. Psychopathologie différentielle

Les quatre lectures proposées ne correspondent pas à quatre diagnostics concurrents. Elles construisent différemment l'objet psychopathologique à partir d'une même situation clinique.

Le doute, les vérifications, la rumination, la difficulté à clore, la peur de l'erreur, la fatigue et la perte de spontanéité sont présents dans le même tableau clinique. Cependant, chaque référentiel les sélectionne, les organise et les hiérarchise selon une logique propre.

Ce qui change n'est donc pas seulement l'explication du symptôme, mais le statut qui lui est attribué.

Lecture psychodynamique

La lecture psychodynamique interroge la fonction du symptôme dans l'économie psychique.

La question centrale est : *Que permet le symptôme et contre quoi protège-t-il ?*

Chez Marine, le contrôle et les vérifications peuvent être compris comme des modalités défensives qui permettent :

- de contenir la culpabilité et la peur de l'erreur ;
- de prévenir un vécu d'inadéquation ;

- de préserver une cohérence psychique et relationnelle.

Le symptôme constitue ainsi une tentative de solution, ou une formation de compromis, même lorsqu'il devient coûteux.

Lecture cognitive

La lecture cognitive étudie les mécanismes qui entretiennent le trouble.

La question centrale est : *Quels processus maintiennent le doute et empêchent Marine de considérer son action comme suffisamment accomplie ?*

Elle met notamment l'accent sur

- l'intolérance à l'incertitude
- la surestimation de l'erreur et de la responsabilité
- la difficulté de désengagement attentionnel
- la rumination
- les comportements de sécurité
- la difficulté à accepter une réponse simplement suffisante

La vérification réduit temporairement l'anxiété, mais empêche l'apprentissage qu'une action imparfaite peut néanmoins être acceptable. Plus Marine vérifie, plus elle confirme implicitement que l'action exige une vérification.

Lecture anthropo-phénoménologique

La lecture anthropo-phénoménologique interroge la possibilité existentielle atteinte.

La question centrale est : *Qu'est-ce que la souffrance modifie dans la manière d'agir et d'habiter le monde ?*

Chez Marine, l'altération concerne la possibilité :

- d'agir avec une confiance suffisante
- de considérer un acte comme accompli
- de laisser une parole ou une décision se stabiliser
- de clore une situation et de passer à la suivante.

La difficulté ne réside donc pas seulement dans un trouble de la pensée. Elle concerne le pouvoir même de l'action à faire événement et à transformer la situation.

Lecture neuro-phénoménologique

La lecture neuro-phénoménologique étudie la manière dont le trouble s'incarne et se stabilise dans des boucles entre pensée, corps, attention et monde vécu.

La question centrale est : *Comment le doute, le contrôle, la fatigue et la perte de fluidité se renforcent-ils mutuellement dans l'expérience de Marine ?*

Chez Marine :

- l'activité réflexive augmente la tension et la fatigue
- la fatigue réduit la disponibilité et la spontanéité
- cette perte de fluidité renforce à son tour le besoin de contrôle

Le symptôme apparaît ainsi comme une dynamique incarnée, et non comme un contenu mental isolé.

Comparaison synthétique

Les quatre lectures posent donc des questions distinctes :

- *Psychodynamique* : quelle fonction défensive le symptôme remplit-il ?
- *Cognitive* : quels mécanismes et comportements maintiennent le trouble ?
- *Anthropo-phénoménologique* : quelle possibilité fondamentale de l'existence est-elle fragilisée ?

- *Neuro-phénoménologique* : comment le trouble s'incarne-t-il dans des boucles pensée–corps–monde ?

Le statut des symptômes apparaît différent dans chaque perspective

La vérification

Un même phénomène, comme la vérification, peut ainsi être compris :

- comme une défense contre l'angoisse
- comme un comportement de sécurité
- comme une tentative de restaurer la confiance dans l'action
- comme un élément d'une boucle incarnée entre contrôle et fatigue.

La rumination

La rumination peut être comprise :

- *psychodynamiquement* : comme une défense visant à contenir la culpabilité, l'agressivité ou l'ambivalence
- *cognitivement* : comme un processus répétitif difficile à inhiber, qui entretient l'anxiété et empêche la résolution du problème
- *anthropo-phénoménologiquement* : comme l'impossibilité de laisser une situation se déposer dans le passé et de se porter vers la suite
- *neuro-phénoménologiquement* : comme une boucle incarnée entre activité mentale, tension corporelle, troubles du sommeil et fatigue.

L'évitement

L'évitement peut être compris :

- *psychodynamiquement* : comme une protection contre une situation susceptible de réveiller une angoisse ou un conflit interne
- *cognitivement* : comme un comportement de sécurité qui réduit l'anxiété à court terme, mais empêche l'apprentissage que la situation peut être affrontée
- *anthropo-phénoménologiquement* : comme une restriction progressive des possibilités d'habiter le monde, de s'exposer et de s'engager ;
- *neuro-phénoménologiquement* : comme la stabilisation d'une anticipation corporelle de la menace, qui déclenche tension et retrait avant même l'action.

La demande de réassurance

La réassurance peut être comprise :

- *psychodynamiquement* : comme une recherche de soutien externe contre la culpabilité, le doute ou le sentiment d'inadéquation
- *cognitivement* : comme un comportement de sécurité qui apaise momentanément l'incertitude, mais renforce la dépendance à la confirmation
- *anthropo-phénoménologiquement* : comme une tentative d'obtenir d'autrui la validation que l'acte, la parole ou la décision peuvent être considérés comme suffisamment accomplis
- *neuro-phénoménologiquement* : comme un élément d'une boucle où le soulagement corporel transitoire est suivi du retour du doute et d'une nouvelle mobilisation attentionnelle.

La comparaison différentielle montre donc comment chaque référentiel construit autrement :

- ce qui fait symptôme
- ce qui fait souffrance
- ce qui maintient (et parfois ce qui génère) le trouble
- et ce qui limite les possibilités du sujet.

2.9. Hypothèses diagnostiques

Les quatre évaluations proposées ne correspondent pas à quatre diagnostics équivalents. Elles ne portent ni sur le même objet ni sur le même niveau de fonctionnement.

Parmi ces évaluations, seule l'hypothèse cognitive conduit directement à envisager une catégorie syndromique. Les autres proposent des qualifications psychopathologiques portant sur l'organisation psychique, la structure de l'existence ou la dynamique incarnée du trouble.

Évaluation psychodynamique

Organisation névrotique à modalité obsessionnelle

Le diagnostic psychodynamique qualifie une organisation psychique. Chez Marine, il repose sur :

- le maintien du rapport à la réalité
- la cohérence du Moi
- une conflictualité principalement intrapsychique
- une forte exigence surmoïque
- des défenses de contrôle, d'intellectualisation, d'isolation et d'annulation rétroactive

Le tableau évoque ainsi une organisation névrotique obsessionnelle dominée par l'angoisse de faute, de culpabilité et d'inadéquation.

Évaluation cognitive

Fonctionnement obsessionnel-compulsif entretenu par l'intolérance à l'incertitude

Le diagnostic cognitif qualifie principalement des processus de pensée et de maintien du trouble :

- intolérance à l'incertitude
- surestimation de l'erreur et de la responsabilité
- difficulté de désengagement attentionnel
- rumination
- comportements de sécurité
- trouble de la clôture décisionnelle.

L'hypothèse d'un TOC à prédominance de vérifications et de compulsions mentales peut être envisagée, mais elle nécessite de préciser l'intrusivité, l'égodystonie, la ritualisation et le retentissement des conduites.

Évaluation anthropo-phénoménologique

Altération de l'accomplissement de l'action et de la confiance pratique

Cette évaluation ne diagnostique pas d'abord un trouble de la pensée, mais une altération du pouvoir de l'action.

Marine demeure capable de décider, de parler et de travailler. Cependant, l'acte ne s'impose pas durablement comme accompli :

- décider ne clôt pas les possibles
- agir ne permet pas de laisser la situation derrière soi
- terminer ne rend pas disponible pour un nouvel engagement
- le « suffisamment accompli » perd son évidence.

Le diagnostic porte donc sur une fragilisation de la capacité à faire confiance à l'action et à passer spontanément d'un acte au suivant.

Évaluation neuro-phénoménologique

Dynamique obsessionnelle incarnée

Cette évaluation qualifie une boucle fonctionnelle entre activité mentale, corps et environnement :

- la surveillance réflexive augmente la tension et la fatigue
- l'épuisement réduit la fluidité de l'action
- cette perte de spontanéité renforce le besoin de contrôle
- certaines situations sont progressivement anticipées comme coûteuses.

Le trouble est alors décrit comme une dynamique incarnée d'hyperréflexivité, de tension corporelle, de ralentissement et de désautomatisation.

Synthèse comparative

Les quatre évaluations ne sont pas interchangeables :

- la lecture psychodynamique diagnostique *une organisation psychique*
- la lecture cognitive identifie des *mécanismes de pensée et un syndrome éventuel*
- la lecture anthropo-phénoménologique décrit *une altération fondamentale de l'action*
- la lecture neuro-phénoménologique qualifie une *dynamique incarnée pensée–corps–monde*.

Ainsi, le diagnostic cognitif porte surtout sur la manière dont Marine traite l'incertitude, l'erreur et la décision. Le diagnostic anthropo-phénoménologique porte sur autre chose : la difficulté de l'acte à devenir réel, accompli et suffisamment stable pour permettre à l'existence de se poursuivre.

3. Léo, 27 ans

3.1. Observation

C'est un cas assez proche du précédent (Marine) avec certaines variantes.

Léo est un homme de 27 ans, reçu pour un premier entretien à sa demande. Il se présente ponctuel, soigné, mais visiblement préoccupé. Son discours est globalement structuré, bien que ponctué d'hésitations ou d'accélération selon les thèmes abordés.

Dès le début de l'entretien, il repère brièvement les issues et fixe régulièrement son sac posé à ses pieds. Il s'excuse à plusieurs reprises de « prendre du temps », témoignant d'une préoccupation pour la place qu'il occupe dans l'échange.

Il décrit vivre depuis plusieurs années avec une peur envahissante, apparaissant de manière imprévisible et ayant progressivement conduit à une organisation rigide de son quotidien. Cette peur concerne principalement les transports, les lieux bondés ou des situations où la sortie immédiate n'est pas possible. Il planifie systématiquement ses déplacements, privilégie les trajets à pied, évite ascenseurs et centres commerciaux, et choisit toujours des places proches des sorties. Il garde sur lui des objets rassurants : bouteille d'eau, mouchoirs, spray.

Lors de certaines situations, Léo décrit une « montée interne » brutale, une impression de rétrécissement de l'espace, une focalisation immédiate sur les issues et la crainte de ne plus pouvoir se tenir debout. Son corps lui apparaît tour à tour lourd puis trop léger, avec une perte de repères corporels. Ces expériences conduisent à des évitements importants et à une vigilance constante à l'environnement.

Le sommeil est globalement préservé, bien que certaines nuits soient marquées par une tension diffuse et un état d'alerte prolongé. Le matin, il peut éprouver un découragement et une absence d'élan, sans tristesse franche. Il décrit parfois une fatigue intérieure et, par moments, un retrait temporaire du monde, avec baisse de motivation et désinvestissement relationnel, évoluant par épisodes de quelques jours.

Léo rapporte des pensées intrusives centrées sur la peur de perdre le contrôle en public, de s'effondrer ou d'attirer les regards. Ces pensées s'imposent malgré ses tentatives pour les chasser. Il décrit également des conduites de vérification : porte, appareils, apparence, messages. Ces vérifications sont reconnues comme excessives, mais difficiles à interrompre. Elles génèrent de la colère contre lui-même.

L'attention portée aux détails sensoriels et corporels est marquée : bruit, chaleur, position du corps, apparence du visage. Une expérience marquante au collège — un épisode de rougissement en classe — semble avoir inauguré une surveillance accrue de son visage et de son apparence. Il vérifie fréquemment son reflet, ajuste son visage, sa posture ou ses vêtements, prend des photos de lui « pour vérifier », sans recherche esthétique mais dans une visée de contrôle.

Sur le plan professionnel, Léo travaille dans la communication. Il apprécie son travail mais évite les prises de parole en public, préparant excessivement ses interventions. Les réunions sont vécues comme coûteuses, entraînant un épuisement secondaire.

Dans sa vie sociale, il maintient quelques liens anciens mais évite les sorties, préférant recevoir chez lui, où il se sent en maîtrise de l'espace. Les échanges écrits sont également soumis à de nombreuses relectures.

Sa dernière relation amoureuse s'est terminée il y a un an, notamment en lien avec ses difficultés à se laisser aller dans les sorties. Depuis, il évite les engagements affectifs, redoutant l'exposition et le jugement. Il n'exprime pas d'idées suicidaires, mais évoque parfois une indifférence vis-à-vis de l'avenir.

Léo attend du suivi une diminution de la place prise par la peur et les vérifications, ainsi que le souhait de retrouver davantage de spontanéité, sans être en lutte permanente avec son vécu interne.

3.2. Clinique phénoménologique

Léo décrit une expérience dominée par une peur envahissante, imprévisible, qui organise progressivement son rapport au corps, à l'espace, aux autres et au monde.

Son vécu est marqué par :

- une peur qui apparaît de manière brutale et difficilement prévisible
- une anticipation constante des situations potentiellement difficiles
- une vigilance importante portée aux issues, aux trajets et aux possibilités de sortie
- des évitements des transports, ascenseurs, centres commerciaux et lieux bondés
- une organisation rigide des déplacements
- le recours à des objets rassurants
- des épisodes de « montée interne » brutale
- une impression de rétrécissement de l'espace
- la crainte de ne plus pouvoir se tenir debout
- des variations du vécu corporel : corps lourd, corps trop léger, perte de repères
- une surveillance sensorielle et corporelle importante
- des pensées intrusives centrées sur la peur de perdre le contrôle, de s'effondrer ou d'attirer les regards
- des conduites de vérification répétées
- une attention marquée à l'apparence, au visage et à la posture
- une réduction de la spontanéité dans les déplacements, le travail et les relations
- des moments de fatigue intérieure, de retrait et de désinvestissement relationnel.

3.3. Analyse existentielle

Quelle manière d'être-au-monde cela dessine-t-il ?

> L'expérience de Léo semble correspondre à une manière d'habiter le monde sous condition de maîtrise et de possibilité de retrait.

Rapport au corps

Le corps occupe une place centrale dans l'organisation du vécu.

Le corps n'est pas vécu comme un support stable et silencieux de l'existence. Il devient :

- source d'alerte
- lieu de tension interne
- surface d'exposition
- objet de surveillance
- indice possible de défaillance

Léo porte attention :

- à la chaleur
- au bruit
- à sa position

- à son visage
- à son apparence
- aux signes corporels annonçant une perte de contrôle

Le corps est donc doublement problématique :

- de l'intérieur, comme corps instable ou menaçant
- de l'extérieur, comme corps visible et exposé au regard d'autrui.

Rapport à l'espace

L'espace est organisé selon une logique d'échappée.

Certains lieux deviennent particulièrement difficiles :

- transports
- lieux bondés
- ascenseurs
- centres commerciaux
- situations où la sortie immédiate n'est pas possible.

L'espace est habitable lorsque Léo peut :

- repérer les issues
- choisir une place proche de la sortie
- garder son sac à proximité
- prévoir son trajet
- disposer d'objets rassurants
- se sentir capable de quitter la situation

À l'inverse, l'espace devient menaçant lorsqu'il est vécu comme :

- fermé
- saturé
- sans issue immédiate
- trop exposant
- difficile à maîtriser

La spatialité peut donc être décrite comme conditionnelle : Léo peut prendre place dans le monde à condition de pouvoir s'en *dégager*.

Rapport au temps

La temporalité est dominée par l'anticipation : Léo ne rencontre pas les situations seulement au moment où elles se présentent. Il les prépare, les prévoit, les organise et les sécurise à l'avance.

Le temps vécu est marqué par :

- du danger
- la préparation des déplacements
- la prévision des issues
- la crainte d'une montée de peur
- la possibilité d'un débordement imminent

Le présent peut devenir très dense lors des épisodes de peur :

- quelque chose monte (le corps devient incertain, l'espace se rétrécit)
- la sortie doit être immédiatement repérée

L'avenir proche apparaît ainsi comme porteur de risque.

Cette temporalité anticipatoire réduit la spontanéité et transforme l'existence en succession de situations à préparer, à contrôler ou à éviter.

Rapport à autrui

Autrui apparaît principalement comme présence exposante. Le regard d'autrui est redouté parce qu'il pourrait rendre visible :

- une perte de contrôle
- un malaise
- une rougeur
- une maladresse
- une défaillance corporelle
- une inadéquation

Les interactions sociales sont donc coûteuses.

Léo maintient certains liens, mais les sorties et les engagements affectifs deviennent difficiles.

La relation amoureuse passée semble avoir été fragilisée par cette difficulté à se laisser aller dans des situations sociales ou extérieures.

Autrui n'est pas seulement recherché ou évité : il est vécu comme un témoin possible de la perte de maîtrise.

Rapport à soi

Le rapport à soi est marqué par une lutte permanente avec le vécu interne.

Léo reconnaît le caractère excessif de certaines vérifications, mais il ne parvient pas facilement à les interrompre.

Cette impossibilité suscite :

- colère contre soi
- fatigue
- découragement
- sentiment de restriction
- perte de spontanéité

Le sujet ne se vit pas comme totalement désorganisé, mais comme continuellement contraint de se maintenir.

Son identité paraît organisée autour d'un effort de tenue :

- tenir son corps
- tenir son image
- tenir sa place
- tenir la situation
- tenir le regard d'autrui.

Rapport au monde

Le monde apparaît comme potentiellement menaçant, non parce qu'il serait toujours hostile, mais parce qu'il peut devenir rapidement incontrôlable.

Il se donne comme un monde :

- à anticiper
- à cartographier
- à sécuriser
- à surveiller
- à limiter

Léo peut continuer à travailler, maintenir certains liens et s'engager dans certaines situations.

Mais cet engagement se fait au prix d'un effort important de contrôle.

Le monde reste accessible, mais sous conditions.

Tension structurante

L'existence de Léo semble organisée autour d'une tension centrale : *exposition / maîtrise*.

D'un côté :

- l'exposition du corps
- l'exposition au regard d'autrui
- l'exposition à l'imprévisible
- l'exposition à des lieux sans sortie immédiate
- la possibilité d'une perte de contrôle.

De l'autre :

- la planification
- l'évitement
- les vérifications
- les objets rassurants
- le repérage des issues
- la surveillance du corps et de l'apparence.

Ce que cette tension permet :

Elle permet à Léo de rester présent dans des situations qui pourraient autrement devenir insupportables. Les dispositifs de maîtrise maintiennent un sentiment de sécurité, limitent l'angoisse de débordement et préservent une possibilité minimale d'agir, de se déplacer et d'entrer en relation.

Ce qu'elle limite :

Elle rend l'engagement dépendant de conditions de contrôle toujours renouvelées. Elle restreint les déplacements, les relations et les situations imprévisibles, divise l'attention entre la participation et la préparation du retrait, et réduit progressivement la spontanéité, la mobilité et l'ouverture aux possibles.

> Suite :

- La *structure de vécu* doit décrire l'organisation transversale du corps, de l'espace, du temps, d'autrui et du monde.
- La *formulation existentielle* peut ensuite condenser cette organisation en une phrase plus synthétique.

Structure de vécu

L'expérience de Léo s'organise autour d'une articulation fragile entre corporéité, spatialité et altérité. Le corps est vécu à la fois comme moyen d'action et comme source possible de défaillance ; l'espace reste praticable s'il offre une possibilité de dégagement ; autrui peut devenir le témoin d'une perte de maîtrise. Le temps est dominé par l'anticipation de ce qui pourrait survenir. Le monde demeure accessible, mais sous condition de pouvoir contrôler l'exposition et préserver une voie de retrait.

Formulation existentielle

Léo habite le monde sur un mode de présence conditionnelle : il peut s'y engager à condition de conserver la maîtrise de son corps, de son image et des possibilités de retrait. Cette organisation lui permet de tenir dans les situations, mais réduit sa capacité à s'y abandonner, à improviser et à se laisser transformer par elles.

3.4. Psychopathologie psychodynamique

Angoisse centrale

L'organisation symptomatique semble structurée autour :

- d'une angoisse de débordement
- d'une peur de perte de contrôle
- d'une crainte d'effondrement corporel
- et d'une angoisse d'exposition au regard d'autrui.

La peur ne porte pas seulement sur une situation extérieure. Elle porte également sur la possibilité que quelque chose du corps ou du sujet échappe à la maîtrise et devienne visible.

Léo redoute moins un danger objectivable qu'une scène de débordement :

- ne plus pouvoir se tenir
- perdre le contrôle
- être vu
- attirer les regards
- être pris dans un lieu sans issue.

Fonction des défenses

Les conduites :

- d'évitement
- de planification
- de vérification
- de contrôle de l'apparence
- de repérage des issues
- et de recours à des objets rassurants

> jouent une fonction défensive importante.

Elles permettent :

- de contenir l'angoisse
- de maintenir une impression de maîtrise
- de limiter le risque d'exposition
- et de préserver une continuité minimale dans le rapport au monde.

Cependant, ces stratégies contribuent progressivement :

- à rigidifier le quotidien
- à restreindre les déplacements
- à limiter les relations
- à épuiser le sujet
- et à renforcer la dépendance au contrôle.

Rapport au regard et à la honte

Le regard d'autrui semble occuper une place importante dans l'économie psychique de Léo.

L'épisode de rougissement au collège a constitué une scène marquante d'exposition corporelle.

Depuis, le visage, la posture et l'apparence deviennent des lieux de surveillance.

Le regard d'autrui peut être vécu comme :

- révélateur
- jugeant
- humiliant

- susceptible de capter une défaillance.

> Léo tente alors de prévenir la honte possible en contrôlant son corps, son image et les conditions de l'exposition.

Maîtrise et lutte contre la passivité

Les stratégies de contrôle peuvent aussi être comprises comme une lutte contre un vécu de passivité.

Lorsque la peur monte, Léo risque de se sentir soumis à son corps, à l'espace ou au regard.

La planification et les vérifications lui permettent de retrouver une position active.

Elles donnent le sentiment de pouvoir agir avant que la situation ne déborde.

Mais cette maîtrise reste fragile :

- elle doit être constamment reconduite
- elle ne produit pas d'apaisement durable
- elle maintient le sujet dans une anticipation anxieuse.

Dimension dépressive secondaire

Le cas laisse apparaître des moments de découragement, de fatigue intérieure et de retrait temporaire du monde.

Ces éléments ne semblent pas constituer le noyau principal du fonctionnement. Ils peuvent être compris comme effets secondaires :

- de l'épuisement lié au contrôle permanent
- de la restriction progressive du champ des possibles
- de la perte de spontanéité
- et du sentiment de lutte continue avec le vécu interne.

L'indifférence ponctuelle vis-à-vis de l'avenir signale également un coût existentiel important.

Formulation psychodynamique

Les symptômes de Léo peuvent être compris comme des tentatives de défense contre deux angoisses liées : la crainte d'une perte de maîtrise corporelle et celle de voir cette défaillance exposée au regard d'autrui.

Léo redoute que ses sensations corporelles s'intensifient jusqu'à devenir incontrôlables, l'empêchent de tenir debout ou de rester dans la situation, et rendent sa perte de maîtrise visible aux autres.

Les conduites de contrôle, d'évitement et de vérification permettent de contenir temporairement cette angoisse et de rester présent dans certaines situations. Cependant, elles renforcent progressivement la nécessité de surveiller le corps et de maintenir une possibilité de retrait. Elles rigidifient ainsi les engagements, limitent les déplacements et épuisent le sujet.

3.5. Psychopathologie cognitive

Biais attentionnels et hypervigilance

Le fonctionnement de Léo semble marqué par une hypervigilance attentionnelle centrée sur :

- les sensations corporelles
- les signes de perte de contrôle
- les indices environnementaux de danger
- et les réactions possibles d'autrui.

L'attention est rapidement captée par :

- les modifications corporelles

- les variations internes
- les possibilités de sortie
- les regards d'autrui
- ou certains détails sensoriels.

Cette focalisation attentionnelle contribue à amplifier la perception de menace.

Interprétations catastrophiques

Les sensations corporelles sont interprétées comme potentiellement dangereuses :

- vertige -> risque d'effondrement
- rougeur -> humiliation
- tension -> perte de contrôle
- malaise -> incapacité à faire face.

Le sujet développe alors des anticipations catastrophiques concernant :

- l'apparition de sensations corporelles intenses
- la peur que ces sensations deviennent incontrôlables
- le risque de ne plus pouvoir tenir debout, rester dans la situation ou conserver une apparence maîtrisée
- l'exposition de cette défaillance au regard d'autrui
- l'impossibilité de quitter rapidement le lieu ou d'obtenir de l'aide.

Les situations publiques ou sociales deviennent donc menaçantes non seulement parce qu'elles exposent au regard, mais aussi parce qu'elles risquent de rendre plus difficile le contrôle des sensations corporelles et le retrait de la situation.

Comportements de sécurité

Les conduites de :

- vérification
 - préparation
 - évitement
 - anticipation
 - sécurisation de l'espace
- > fonctionnent comme des comportements de sécurité :
- . ils permettent une diminution immédiate de l'anxiété
 - . mais ils empêchent l'infirmité des croyances anxieuses
 - . et maintiennent le système de peur.

Par exemple :

- choisir une place proche de la sortie
- garder des objets rassurants
- éviter certains lieux
- relire excessivement les messages
- vérifier le visage ou la posture.

Cercle anxieux auto-entretenu

Un cercle de maintien semble progressivement s'installer :

- Situation perçue comme menaçante
- > hypervigilance
- > sensations corporelles amplifiées
 - > interprétation anxieuse

- > montée de peur
- > évitement / contrôle
- > soulagement temporaire
- > renforcement des croyances de danger

Les stratégies de contrôle réduisent donc momentanément l'angoisse mais contribuent à maintenir durablement le trouble.

Estime de soi et peur de l'évaluation

Les préoccupations liées au regard d'autrui semblent également associées à :

- une forte sensibilité à l'évaluation sociale
- une peur de l'erreur ou du jugement
- une surestimation des conséquences négatives de l'exposition.

Le sujet développe ainsi une surveillance importante :

- de son apparence
- de ses comportements
- et de ses performances relationnelles.

Formulation cognitive

Les difficultés de Léo peuvent être comprises comme un fonctionnement anxieux auto-entretenu associant hypervigilance corporelle, interprétations catastrophiques des sensations et comportements de sécurité.

Les stratégies d'évitement, de contrôle et de vérification diminuent temporairement l'anxiété, mais empêchent Léo de constater que les sensations peuvent être supportées sans perte de contrôle ni défaillance visible. Elles renforcent ainsi les croyances de danger, la surveillance du corps, la dépendance à une possibilité de retrait et la réduction progressive des déplacements et des engagements.

3.6. Psychopathologie anthro-po-phénoménologique

La lecture anthro-po-phénoménologique ne cherche pas seulement à identifier des symptômes anxieux, agoraphobiques ou sociaux. Elle interroge une transformation plus fondamentale du rapport au corps, à l'espace, au temps, à autrui et aux possibilités d'action.

Chez Léo, le phénomène central n'est pas une impossibilité générale d'agir (comme Martine). Il continue à travailler, à se déplacer et à maintenir certaines relations.

La perturbation concerne plutôt la manière dont une situation devient praticable : pour pouvoir s'y engager, il doit conserver la possibilité de bouger, de sortir ou de réduire son exposition.

Du corps propre au corps surveillé

Dans l'expérience ordinaire, le corps propre constitue l'appui silencieux de l'action. Chez Léo, cette confiance corporelle est fragilisée. Le corps devient à la fois :

- le moyen de l'action
- une source possible de défaillance
- un objet de surveillance
- une surface exposée au regard d'autrui.

Les sensations de chaleur, de lourdeur, de légèreté ou d'instabilité ne restent pas de simples variations corporelles. Elles peuvent annoncer une perte de contrôle, un effondrement ou une défaillance visible.

Fragilisation du « je peux »

Dans la perspective de Merleau-Ponty, le rapport premier au monde repose sur un « je peux » corporel : pouvoir avancer, rester, partir, s'approcher ou se retirer.

Chez Léo, ce « je peux » devient incertain. La question n'est pas seulement : « Un danger va-t-il survenir ? », mais plutôt :

- pourrai-je rester debout ?
- pourrai-je sortir ?
- pourrai-je contrôler ce qui monte en moi ?
- pourrai-je quitter la situation sans être remarqué ?
- pourrai-je me soustraire au regard d'autrui ?

Le monde devient menaçant lorsque les possibilités corporelles de réponse semblent se réduire.

Spatialité de l'échappée

L'espace vécu s'organise selon les possibilités qu'il offre au corps.

Certains lieux permettent de se dégager d'autres semblent retenir, enfermer ou exposer. La sortie ne constitue donc pas seulement un élément matériel : elle garantit que Léo conserve un pouvoir d'action sur la situation :

- repérer une issue, choisir une place proche de la sortie, privilégier la marche ou conserver des objets rassurants rendent temporairement la présence possible

- à l'inverse, un espace devient menaçant lorsqu'il paraît :

- . fermé ou saturé
- . difficile à traverser
- . dépourvu d'issue immédiate
- . trop exposant
- . soumis au rythme ou aux décisions d'autrui.

L'impression de rétrécissement de l'espace traduit ainsi une réduction du champ pratique : les directions possibles diminuent et le monde offre moins de prises à l'action.

La structure centrale peut être formulée ainsi : Léo peut rester à condition de savoir qu'il peut partir.

Temporalité de l'imminence

Dans une perspective inspirée de Minkowski, le temps vécu concerne la manière dont le sujet se porte vers ce qui vient.

Chez Léo, l'avenir proche est principalement investi comme le moment :

- où la peur pourrait monter
- où le corps pourrait devenir instable
- ou où la sortie pourrait ne plus être accessible.

Avant une situation, il anticipe :

- le trajet
- les issues
- les sensations possibles
- la visibilité de son corps
- les réactions d'autrui
- les moyens de se retirer.

Lors des épisodes de peur, le temps se contracte autour de l'urgence immédiate : tenir debout, contrôler ce qui monte, repérer l'issue et éviter d'être vu.

Cette temporalité de l'imminence se distingue de celle de Marine :

- chez elle, le présent était capturé par la reprise du passé récent

- chez Léo, il est capturé par ce qui pourrait survenir dans les instants suivants.

Regard d'autrui et visibilité du corps

Le regard d'autrui ne constitue pas seulement une source de jugement : *il transforme le corps vécu en corps visible.*

L'épisode de rougissement au collège semble avoir participé à cette organisation, sans pouvoir être considéré comme une cause démontrée. Le visage devient le lieu où l'expérience interne pourrait se révéler malgré Léo :

- l'anxiété pourrait devenir visible
- la rougeur pourrait révéler le malaise
- l'instabilité pourrait attirer les regards
- le corps pourrait exposer le sujet avant qu'il puisse maîtriser son image.

Léo ne craint donc pas seulement les sensations corporelles, mais leur visibilité.

Restriction du champ des possibles

Léo continue à agir, mais ses possibilités sont progressivement filtrées par une question : Pourrai-je encore me dégager si mon corps, l'espace ou le regard d'autrui deviennent insupportables ?

Le projet devient préparation le déplacement devient itinéraire sécurisé la rencontre devient gestion de l'exposition.

L'élan vers le monde n'est pas aboli, mais il est freiné par la nécessité de garantir à l'avance les conditions du retrait.

Formulation anthropo-phénoménologique

Les difficultés de Léo peuvent être comprises comme une fragilisation du « je peux » corporel et de l'articulation entre engagement et dégagement.

Le corps ne constitue plus un appui silencieux et fiable : il devient une réalité qu'il faut surveiller. L'espace n'est praticable que s'il préserve une possibilité de sortie. Autrui peut transformer le corps vécu en corps visible et exposer une défaillance redoutée.

Cette organisation associe :

- une spatialité structurée par l'échappée
- une temporalité dominée par l'imminence
- une hyperréflexivité corporelle
- une présence divisée entre engagement et retrait
- une restriction des possibles aux situations maîtrisables.

La psychopathologie ne réside donc pas seulement dans la peur ou l'évitement. Elle concerne la difficulté à habiter une situation sans devoir garantir constamment la possibilité de s'en dégager. En cherchant à préserver sa liberté de partir, Léo perd progressivement la liberté plus fondamentale de s'engager.

3.7. Psychopathologie neuro-phénoménologique

Boucles corps-espace-peur

Les situations impliquant :

- transports
- lieux bondés
- ascenseurs
- centres commerciaux
- prises de parole
- interactions sociales

> déclenchent rapidement :

- une focalisation sur les sensations corporelles
- une tension interne
- une recherche des issues
- une anticipation du regard d'autrui
- une impression de rétrécissement de l'espace.

Cette activation renforce ensuite :

- la perception du danger
- la sensation d'instabilité corporelle
- le besoin de contrôle
- et la nécessité d'évitement.

Corps d'alerte

Le corps de Léo semble fonctionner comme un *système d'alerte*. Certaines sensations deviennent immédiatement significatives :

- lourdeur
- légèreté
- tension
- chaleur
- instabilité
- modifications du visage
- impression de ne plus pouvoir se tenir.

Ces sensations ne restent pas de simples phénomènes corporels. Elles sont rapidement intégrées dans une dynamique de menace :

- risque d'effondrement
- perte de contrôle
- exposition publique
- impossibilité de faire face.

Le corps devient ainsi un lieu d'anticipation du danger.

Spatialité incarnée

L'espace n'est pas seulement perçu visuellement ou objectivement. Il est vécu corporellement.

Un lieu devient difficile lorsqu'il limite :

- la possibilité de mouvement
- la possibilité de sortie
- la capacité à se dégager
- le sentiment de pouvoir tenir debout
- la possibilité de se soustraire au regard.

L'espace se rétrécit dans l'expérience même du corps.

Inversement, la proximité d'une sortie, la possibilité de marcher, la présence d'objets rassurants ou le fait de recevoir chez soi restaurent temporairement un sentiment de maîtrise incarnée.

Mémoire corporelle de l'exposition

L'épisode de rougissement au collège semble avoir laissé une trace importante dans la manière dont Léo habite son visage et son apparence. Progressivement, certaines situations deviennent associées :

- à l'exposition

- à la rougeur
- au regard
- à la possibilité d'être remarqué
- à la honte
- à la perte de maîtrise corporelle

Le corps apprend alors à anticiper les situations sociales comme des situations de visibilité potentiellement dangereuse.

Cette mémoire corporelle contribue à stabiliser une organisation défensive centrée sur la surveillance du visage, de la posture et de l'apparence.

Hyperréflexivité corporelle et désautomatisation

Léo ne peut plus toujours se laisser porter spontanément par son corps. Celui-ci devient :

- observé
- surveillé
- vérifié
- corrigé
- anticipé

Des conduites ordinaires — se déplacer, parler, s'asseoir, envoyer un message, participer à une réunion — perdent leur caractère automatique.

Elles demandent un travail de préparation et de contrôle.

Cette hyperréflexivité désautomatise le rapport au monde et transforme des situations quotidiennes en situations coûteuses.

Intercorporéité et regard

La présence d'autrui augmente l'attention portée au corps. Le regard possible des autres intensifie :

- la surveillance du visage
- la crainte du rougissement
- la peur de paraître instable
- la vérification de l'apparence
- la préparation des interventions.

Le rapport aux autres est donc aussi un rapport intercorporel : Léo ne craint pas seulement ce que les autres pensent, mais la manière dont son corps pourrait apparaître devant eux.

Formulation neuro-phénoménologique

Les difficultés de Léo s'inscrivent dans une dynamique incarnée associant surveillance des sensations corporelles, anticipation du regard d'autrui et organisation de l'espace selon la possibilité de se déplacer ou de partir.

Les sensations corporelles intenses, les situations d'exposition et les lieux dont il paraît difficile de sortir rapidement activent une boucle d'alerte. L'attention se fixe sur le corps et sur l'environnement : Léo surveille les signes d'une perte de maîtrise, repère les issues et anticipe la manière dont une éventuelle défaillance serait perçue par les autres.

Les conduites de contrôle, de vérification et d'évitement réduisent temporairement l'angoisse. Elles renforcent cependant l'association entre sensations corporelles, impossibilité de partir et danger. Léo devient ainsi de plus en plus dépendant de la surveillance de son corps, du contrôle de sa position et du maintien d'une possibilité immédiate de retrait.

Cette boucle incarnée limite progressivement les déplacements, rend les engagements plus difficiles à maintenir et transforme certaines situations ordinaires en conditions permanentes d'alerte.

3.8. Psychopathologie différentielle

La peur, l'évitement, le contrôle, la surveillance corporelle et le repérage des issues sont présents dans le même tableau. Cependant, chaque référentiel leur attribue un statut différent et les inscrit dans une organisation spécifique.

Ce qui change n'est donc pas seulement l'explication du trouble, mais la nature même de ce que chaque lecture cherche à comprendre.

Lecture psychodynamique

La lecture psychodynamique interroge la fonction des symptômes dans l'économie psychique.

La question centrale est : *Que permet le symptôme et contre quoi protège-t-il ?*

Chez Léo, les conduites de contrôle et de retrait peuvent être comprises comme des modalités défensives permettant :

- de contenir une angoisse de désorganisation et de honte liée à la crainte que le corps échappe au contrôle du Moi
- de lutter contre un vécu de passivité
- de prévenir une exposition honteuse
- de maintenir une impression de maîtrise et de continuité psychique.

Le symptôme constitue ainsi une tentative de maintien : Léo contrôle les conditions de son exposition pour pouvoir rester présent dans le monde.

Lecture cognitive

La lecture cognitive étudie les processus qui déclenchent et entretiennent le système anxieux.

La question centrale est : *Quels mécanismes maintiennent la peur malgré l'absence de catastrophe ?*

Cette lecture met l'accent sur l'articulation entre :

- orientation de l'attention vers la menace
- interprétation anxieuse des sensations
- anticipation d'une catastrophe
- recours à des conduites de sécurité
- soulagement temporaire
- confirmation des croyances de danger.

Le trouble est donc compris comme un *système auto-entretenu* : les conduites qui protègent Léo à court terme empêchent la modification durable de ses anticipations anxieuses.

Lecture anthropo-phénoménologique

La lecture anthropo-phénoménologique interroge la possibilité fondamentale de l'existence qui se trouve fragilisée.

La question centrale est : *Qu'est-ce que la souffrance modifie dans la manière de prendre place et de s'engager dans le monde ?*

Chez Léo, la difficulté concerne l'articulation entre :

- la confiance dans le corps comme pouvoir d'action
- l'engagement dans une situation
- l'exposition au regard d'autrui
- la possibilité de modifier sa position ou de se retirer.

Il ne souffre donc pas seulement d'avoir peur de certains lieux. Il souffre de ne plus pouvoir habiter spontanément une situation sans devoir préserver les conditions de son interruption.

Lecture neuro-phénoménologique

La lecture neuro-phénoménologique étudie la manière dont la peur s'incarne et se stabilise dans les relations entre le corps, l'espace, la perception et l'action.

La question centrale est : *Comment le trouble se constitue-t-il dans des boucles réciproques entre corps et environnement ?*

Dans cette perspective

- l'état corporel modifie la perception de l'espace et des possibilités d'action
- réciproquement, un espace perçu comme fermé ou difficile à quitter renforce l'état d'alerte corporel.

La peur apparaît ainsi comme une dynamique incarnée dans laquelle sensations, attention, espace vécu et conduites de retrait se renforcent mutuellement.

Synthèse comparative

Les quatre lectures construisent donc des objets psychopathologiques distincts :

- la lecture *psychodynamique* étudie une fonction défensive
- la lecture *cognitive* décrit un système de traitement et de maintien de la menace
- la lecture *anthropo-phénoménologique* met en évidence une fragilisation du pouvoir corporel de s'engager
- la lecture *neuro-phénoménologique* analyse une dynamique incarnée entre corps, espace et action.

L'évitement

L'évitement peut être compris :

- *psychodynamiquement* : comme une défense contre le débordement et l'exposition honteuse
- *cognitivement* : comme une conduite de sécurité qui empêche la révision des croyances de danger
- *anthropo-phénoménologiquement* : comme une restriction des possibilités de prendre place et de s'engager
- *neuro-phénoménologiquement* : comme une régulation incarnée réduisant temporairement l'état corporel d'alerte.

Le repérage des issues

Le repérage des issues peut être compris :

- *psychodynamiquement* : comme une lutte contre la passivité et la perte de maîtrise
- *cognitivement* : comme une conduite confirmant que la situation exige une possibilité de fuite
- *anthropo-phénoménologiquement* : comme la condition permettant à l'espace de demeurer praticable
- *neuro-phénoménologiquement* : comme une orientation perceptive organisant conjointement l'attention, le corps et l'espace autour du dégagement.

La surveillance du corps

La surveillance corporelle peut être comprise :

- *psychodynamiquement* : comme une défense contre la visibilité d'une défaillance interne
- *cognitivement* : comme une hypervigilance qui amplifie les sensations et leur interprétation anxieuse
- *anthropo-phénoménologiquement* : comme la transformation du corps propre en corps observé, fragilisant le « je peux »
- *neuro-phénoménologiquement* : comme une boucle d'amplification entre sensations, attention corporelle et perception du danger.

La comparaison différentielle montre ainsi comment chaque référentiel définit autrement :

- ce qui fait symptôme
- ce qui protège provisoirement le sujet

- ce qui entretient le trouble
- ce qui fait souffrance
- et ce qui limite les possibilités d'action et d'engagement.

3.9. Hypothèses diagnostiques

Les quatre évaluations diagnostiques qu'elles n'ont pas le même statut :

- la psychodynamique formule un diagnostic d'organisation psychique
- la cognitive peut conduire à un diagnostic syndromique classique
- l'anthropo-phénoménologique formule une qualification structurale de l'existence
- la neuro-phénoménologique formule une qualification de la dynamique incarnée.

Les quatre lectures aboutissent à des formulations diagnostiques différentes. Elles ne portent toutefois ni sur le même objet ni sur le même niveau de diagnostic.

Évaluation diagnostique psychodynamique

Organisation névrotique anxieuse à dominante phobique

Le diagnostic psychodynamique qualifie une organisation psychique.

Chez Léo, plusieurs éléments orientent vers un fonctionnement névrotique :

- le rapport à la réalité reste préservé
- le discours demeure cohérent
- l'insertion professionnelle et relationnelle est maintenue

Léo reconnaît le caractère excessif de certaines conduites. La conflictualité apparaît principalement intrapsychique.

La dominante phobique se manifeste dans la localisation de l'angoisse sur certaines situations spatiales et sociales. Léo redoute moins les lieux en eux-mêmes que la possibilité d'y être débordé, passivé ou exposé devant autrui.

Les modalités de contrôle, de vérification et de préparation présentent une tonalité obsessionnelle, mais elles semblent principalement mises au service de la défense contre l'angoisse phobique.

Formulation psychodynamique

Le tableau évoque une organisation névrotique anxieuse à dominante phobique, associée à des modalités de contrôle obsessionnelles et à une sensibilité importante à la honte. Les symptômes protègent contre une angoisse de débordement corporel, de perte de maîtrise et d'exposition devant autrui.

Évaluation diagnostique cognitive et syndromique

Fonctionnement panique-agoraphobique

Le diagnostic cognitif et syndromique porte sur la nature du syndrome anxieux et sur les mécanismes qui le maintiennent.

Le tableau évoque principalement un fonctionnement panique-agoraphobique, possiblement compatible avec :

- un trouble panique
- une agoraphobie
- une anxiété sociale associée
- des manifestations obsessionnelles-compulsives à explorer.

L'hypothèse d'un trouble panique repose sur les montées de peur brutales, les sensations corporelles intenses et la crainte de s'effondrer ou de perdre le contrôle. Elle demanderait toutefois de préciser :

- la fréquence et la durée des épisodes
- leur caractère attendu ou inattendu
- les manifestations somatiques associées
- la peur persistante de leur réapparition.

L'hypothèse d'une agoraphobie paraît soutenue par la peur des situations dont il serait difficile de sortir ou dans lesquelles une aide pourrait ne pas être immédiatement disponible.

Une anxiété sociale est également plausible, en particulier autour de la crainte de rougir, d'être observé ou de rendre visible une défaillance corporelle.

Les vérifications pourraient enfin évoquer des manifestations obsessionnelles-compulsives. Les données restent cependant insuffisantes pour affirmer un TOC autonome.

Formulation cognitive et syndromique

Le tableau évoque principalement un fonctionnement panique-agoraphobique, possiblement compatible avec un trouble panique associé à une agoraphobie. Une anxiété sociale associée est probable. Des manifestations obsessionnelles-compulsives doivent être explorées, sans qu'un TOC autonome puisse être affirmé.

Évaluation diagnostique anthropo-phénoménologique

Altération de la réversibilité pratique de la présence

L'évaluation anthropo-phénoménologique ne cherche pas à attribuer une catégorie syndromique. Elle qualifie la transformation fondamentale de la manière dont Léo prend place dans une situation.

Chez Léo, la perturbation ne porte pas principalement sur l'accomplissement de l'action (possibilité de clôturer l'acte), comme chez Marine. Elle concerne la possibilité de demeurer dans une situation lorsque celle-ci ne peut plus être immédiatement modifiée ou interrompue.

Dans l'expérience ordinaire, le sujet peut rester quelque part sans devoir maintenir activement la possibilité de partir. Il peut s'engager sans surveiller constamment les conditions de son retrait.

Chez Léo, cette réversibilité pratique perd son évidence. Une situation devient menaçante lorsqu'il ne peut plus immédiatement :

- changer de place
- rejoindre une sortie
- interrompre l'échange
- diminuer son exposition
- se soustraire au regard d'autrui
- agir sur ce qui arrive à son corps.

L'espace est ainsi organisé moins selon une opposition entre lieux sûrs et lieux dangereux que *selon la possibilité de modifier sa manière d'y être* :

- une sortie proche, un trajet à pied ou une place périphérique maintiennent la situation ouverte et réversible
- à l'inverse, la foule, l'ascenseur ou le transport imposent de rester selon un rythme et des conditions qui ne dépendent plus entièrement de lui.

La présence de Léo devient alors divisée :

- il est dans la situation, mais surveille déjà sa sortie
- il s'engage, mais conserve une réserve de retrait
- il prend place, mais sans pouvoir laisser cette place devenir contraignante
- il rencontre autrui, mais reste attentif à la possibilité de réduire son exposition.

Le regard d'autrui renforce cette difficulté, car il peut fixer Léo dans une apparence qu'il ne maîtrise pas. Rougir, paraître instable ou manifester son malaise signifierait ne plus pouvoir corriger immédiatement la manière dont il apparaît.

Formulation anthropo-phénoménologique :

On avait chez Marine une difficulté de la clôture de l'acte.

Le tableau de Léo correspond à une exigence excessive de réversibilité. Il ne redoute pas seulement certaines sensations ou certains espaces : il redoute de ne plus pouvoir modifier

immédiatement sa position dans la situation.

Il peut rester à condition de pouvoir partir, s'exposer à condition de pouvoir se retirer et s'engager à condition que cet engagement puisse être interrompu sans délai.

La possibilité de retrait, normalement disponible à l'arrière-plan, doit donc rester constamment présente et contrôlable. Elle devient une condition préalable à toute participation.

La difficulté ne réside pas dans une absence de réversibilité, mais dans l'impossibilité de s'engager sans en garantir en permanence le maintien.

Évaluation diagnostique neuro-phénoménologique

Dynamique panique-agoraphobique incarnée

L'évaluation neuro-phénoménologique ne cherche pas seulement à repérer des sensations anxieuses, des pensées catastrophiques ou des évitements. Elle décrit la manière dont le trouble se stabilise dans une boucle entre l'état corporel, l'attention, la perception de l'espace, le regard d'autrui et les possibilités d'action.

Chez Léo, une sensation corporelle inhabituelle ne reste pas un événement localisé. Elle attire immédiatement l'attention et prend la valeur d'un signe d'alerte. Le corps cesse alors d'être le support discret de l'action : il devient ce qu'il faut surveiller, contrôler et empêcher de défaillir.

Cette surveillance modifie la perception de l'espace. Un lieu devient menaçant lorsqu'il ne permet pas de :

- changer rapidement de position
- s'asseoir ou s'appuyer
- rejoindre facilement une sortie
- interrompre la situation
- se retirer sans attirer l'attention.

L'espace n'est donc pas dangereux par lui-même. Il le devient lorsque Léo ne peut plus garantir qu'il pourra adapter immédiatement sa conduite si les sensations augmentent.

Le regard d'autrui renforce cette dynamique. Léo ne redoute pas seulement l'intensité des sensations il craint qu'elles deviennent visibles et qu'elles révèlent une perte de maîtrise. Il doit alors surveiller simultanément :

- ce qui se passe dans son corps
- la possibilité de quitter le lieu
- la manière dont il apparaît aux autres
- les signes qui pourraient annoncer une défaillance.

Cette multiplication des contrôles augmente la tension et rend les sensations encore plus présentes. Le corps, l'espace et le regard se renforcent ainsi mutuellement.

La boucle peut être formulée de la manière suivante :

- sensation corporelle
 - > focalisation de l'attention sur le corps
 - > anticipation d'une perte de maîtrise
 - > perception réduite des possibilités de retrait
 - > augmentation de l'alerte
 - > contrôle, évitement ou départ
 - > soulagement temporaire
 - > renforcement du besoin futur de surveiller et de pouvoir partir.

Les conduites de sécurité ont donc un double effet. Elles permettent à Léo de rester dans certaines situations ou d'en sortir avant que l'angoisse ne devienne trop forte. Mais elles confirment aussi que sa présence dépend du contrôle de son corps, de l'espace et des possibilités de retrait.

À force de répétition, cette dynamique se stabilise dans des habitudes :

- attentionnelles, par la surveillance constante des sensations

- corporelles, par le maintien d'un état d'alerte
- spatiales, par le repérage systématique des issues
- comportementales, par l'évitement et le retrait
- relationnelles, par la crainte que la défaillance soit vue.

Formulation neuro-phénoménologique

Le tableau évoque une dynamique panique-agoraphobique incarnée dans laquelle les sensations corporelles, la perception de l'espace et le regard d'autrui se modifient réciproquement.

Une sensation devient rapidement un signal de perte de maîtrise l'espace paraît alors moins modifiable et le retrait plus difficile cette réduction des possibilités d'action augmente à son tour l'alerte corporelle. Le regard d'autrui ajoute la crainte que la défaillance devienne visible.

Les conduites de contrôle, d'évitement et de retrait réduisent temporairement l'angoisse, mais stabilisent progressivement la dépendance à une surveillance du corps et à une possibilité immédiate de sortie. Le trouble ne tient donc pas seulement à la peur des sensations ou des lieux : il se maintient dans une boucle incarnée où Léo ne peut rester engagé qu'à condition de pouvoir contrôler en permanence son état corporel et sa possibilité de retrait.

Synthèse comparative des quatre évaluations

Les quatre formulations diagnostiques ne sont pas interchangeables :

- Psychodynamique : organisation névrotique anxieuse à dominante phobique, dans laquelle le symptôme protège contre le débordement, la passivité et la honte.
- Cognitive et syndromique : fonctionnement panique-agoraphobique, possiblement compatible avec un trouble panique et une agoraphobie, avec anxiété sociale associée et manifestations obsessionnelles à explorer.
- Anthro-po-phénoménologique : altération de la réversibilité pratique de la présence, avec difficulté à rester engagé lorsque la possibilité de modifier ou d'interrompre la situation n'est plus immédiatement garantie.
- Neuro-phénoménologique : dynamique incarnée entre corps d'alerte, spatialité menaçante, regard d'autrui et conduites de retrait.

> Les quatre lectures convergent vers une même situation clinique, mais elles ne produisent ni le même diagnostic ni le même niveau de diagnostic :

- la première qualifie une organisation psychique.
- la deuxième identifie un syndrome clinique possible.
- la troisième décrit une transformation fondamentale de la manière de prendre place et de demeurer dans une situation.
- la quatrième qualifie une stabilisation incarnée du trouble dans les boucles corps-espace-action.

4. Chris, 31 ans

4.1. Observation

Chris est un homme de 31 ans, menuisier, hospitalisé après une tentative de suicide par asphyxie avec un sac plastique. Il demande à rencontrer la psychiatre dans une pièce aux fenêtres occultées. Il porte une casquette de base-ball enfoncée presque jusqu'aux yeux et garde le regard baissé.

Il annonce qu'il n'a pas d'amis, qu'il vient d'être renvoyé de son travail et que sa petite amie l'a récemment quitté. Il explique avec difficulté que son problème concerne son nez : « C'est mon nez qui pose problème. »

Il décrit des « énormes marques de vérole » sur son nez, qu'il juge « grotesques ». Il affirme : « J'ai l'air d'un monstre. Je suis aussi affreux qu'Elephant Man. »

Il pense à ces marques toute la journée depuis quinze ans, en fait des cauchemars, et croit que tout le monde peut les voir. Il porte une casquette pour cacher son visage et demande une pièce peu éclairée pour éviter d'être vu.

La psychiatre ne constate pas les marques décrites. Chris reconnaît par moments qu'il déforme peut-être la réalité, mais cette mise en doute disparaît lorsqu'il se regarde dans le miroir. Dans ces moments, il est convaincu que les pores de sa peau sont énormes et affreux, et que les autres se moquent de lui.

Il passe plusieurs heures par jour à regarder son visage dans le miroir, demandait des réassurances très fréquentes à sa petite amie, évite les sorties, se confie chez lui, et a perdu son travail en raison de ses absences répétées. Il a tenté de cacher son visage par une casquette, du maquillage ou un masque. Le seul moment où il s'est senti vraiment à l'aise est celui où il portait un masque de Batman à Halloween.

Chris a consulté des dermatologues pour faire traiter ces marques. L'un a refusé, ne voyant rien à traiter, un autre a accepté une intervention, qui n'a pas soulagé Chris. Il rapporte deux tentatives de suicide, la plus récente ayant été déclenchée après s'être regardé dans le miroir.

4.2. Clinique phénoménologique

Chris décrit une expérience entièrement organisée autour d'un défaut corporel qu'il considère comme monstrueux, bien que celui-ci ne soit pas objectivable par autrui.

Son vécu est marqué par :

- une préoccupation envahissante centrée sur son nez et ses « marques de vérole »
- une honte massive liée à la possibilité d'être vu
- une conviction fluctuante concernant la réalité de son défaut
- une attention constante portée à son visage
- des heures passées devant le miroir
- des tentatives répétées de camouflage
- une surveillance permanente du regard d'autrui
- des évitements sociaux importants
- un retrait progressif du monde
- une souffrance morale intense accompagnée d'idées suicidaires et de passages à l'acte.

Le visage cesse progressivement d'être vécu comme un support ordinaire de présence : il devient un objet central de surveillance et de menace.

4.3. Analyse existentielle

L'expérience de Chris semble correspondre à une manière d'habiter le monde sous condition de retrait et de camouflage.

Rapport au temps

La temporalité est dominée par :

- la répétition
- la rumination
- et le retour incessant au miroir.

Le présent est continuellement capturé par la préoccupation corporelle.

L'existence se trouve progressivement rétrécie autour d'une scène unique : celle de l'apparence et du regard.

Rapport à l'espace

L'espace est organisé selon une logique de visibilité.

Certaines situations deviennent particulièrement menaçantes :

- lumière
- immobilité
- proximité
- exposition faciale
- attente sous le regard d'autrui.

Inversement, certains dispositifs procurent un soulagement relatif :

- obscurité
- masque
- casquette
- retrait.

L'expérience est ainsi structurée par :

- une surexposition vécue du visage
- une captation de l'attention par le défaut corporel
- et une tentative permanente de réduire la visibilité de soi.

Le monde cesse ainsi d'être immédiatement habitable : il devient scénographie potentielle d'exposition.

Rapport au corps

Le corps — et plus particulièrement le visage — cesse d'être vécu comme :

- familier
- habité
- transparent à l'existence.

Le visage devient :

- objet de surveillance
- foyer de honte
- surface exposée au regard.

Le sujet ne s'éprouve plus d'abord comme présence incarnée, mais comme objet visible.

Rapport à autrui

Autrui apparaît principalement comme :

- observateur
- juge

- témoin potentiel de la difformité vécue.

Le regard de l'autre devient :

- envahissant
- impossible à neutraliser
- humiliant
- difficilement supportable

Les relations se réduisent progressivement sous l'effet :

- de la honte
- de l'évitement
- et de la peur d'être vu

Rapport à soi

L'ipséité est profondément fragilisée par l'identification du sujet à son défaut supposé. Chris ne se vit plus seulement comme une personne ayant un visage jugé imparfait : il se définit globalement comme « grotesque » ou « monstrueux ».

Le miroir ne lui restitue pas une image familière de lui-même :

- il renforce au contraire une non-reconnaissance de soi et fixe son identité sur le visage perçu comme difforme
- le doute reste parfois possible, mais il disparaît devant l'image spéculaire.

Le rapport à soi est marqué par :

- une réduction de soi à l'apparence du visage
- une dévalorisation globale
- une dépendance au miroir et à la réassurance d'autrui
- une difficulté à maintenir une image de soi stable
- un sentiment de soi devenu presque inhabitable

L'ipséité peut donc être décrite comme une *identité envahie par l'image corporelle*, dans laquelle le sujet ne parvient plus à se reconnaître au-delà du défaut vécu.

Tension structurante

L'existence de Chris semble organisée autour d'une tension centrale : *se montrer / se sentir réduit à son apparence monstrueuse*

D'un côté :

- le désir de rencontrer autrui
- la possibilité d'être reconnu
- le besoin de travailler, d'aimer et de participer au monde commun
- la nécessité inévitable de montrer son visage

De l'autre :

- la conviction que le visage révèle une difformité
- la crainte d'être immédiatement réduit à cette apparence
- la honte et l'humiliation anticipées
- le risque d'être fixé comme objet sous le regard d'autrui

Ce que cette tension permet : Le camouflage réduit la visibilité du visage et peut préserver une possibilité minimale de présence. Le retrait diminue plus radicalement l'exposition, mais au prix d'une absence de la situation. En diminuant la visibilité de son visage, il peut momentanément échapper à l'impression d'être

entièrement défini par son apparence. Le masque illustre cette fonction paradoxale : en cachant son visage propre, il lui permet de participer plus librement à une situation sociale.

Ce qu'elle limite : Cette organisation rend toute relation dépendante d'une réduction préalable de la visibilité. Elle empêche Chris de faire l'expérience d'être reconnu à travers ses paroles, ses gestes, ses qualités ou son histoire. Le camouflage protège contre le regard, mais confirme progressivement que le visage ne peut être montré. Il réduit ainsi les possibilités de relation, de travail et d'engagement, tout en renforçant l'identification du sujet à son défaut supposé.

Structure de vécu

L'expérience de Chris s'organise autour d'une rupture entre la présence vécue et l'image visible de soi. Le visage ne constitue plus le support ordinaire de l'expression et de la rencontre : il devient une surface supposée révéler une vérité monstrueuse sur l'ensemble du sujet.

L'espace se distribue selon des degrés de visibilité ; autrui est anticipé comme celui qui voit, dévoile et juge ; le miroir fixe l'identité sur un détail facial ; le temps revient continuellement à la même scène spéculaire. Chris ne se vit donc plus comme un sujet visible parmi d'autres, mais comme un sujet menacé d'être entièrement absorbé par ce que son visage donnerait à voir.

Formulation existentielle

Chris ne redoute pas seulement d'être regardé : il redoute que son visage parle à sa place et révèle aux autres une monstruosité qui définirait tout ce qu'il est. Il ne peut apparaître qu'en limitant ce qui est visible de lui. Cette organisation le protège momentanément de la honte, mais l'empêche progressivement d'être reconnu au-delà de son image et de prendre place dans le monde commun comme sujet.

4.4. Psychopathologie psychodynamique

Angoisse centrale

L'organisation symptomatique semble structurée autour :

- d'une honte anxieuse
- d'une fragilité narcissique majeure, continuellement réactivée par le miroir
- et d'une peur de dévalorisation sous le regard d'autrui.

Le défaut corporel devient progressivement le support condensé d'une souffrance identitaire globale.

Fonction des défenses

Les conduites :

- de camouflage
- de vérification
- d'évitement
- de réassurance
- et de retrait social

> jouent une fonction défensive importante. Elles permettent :

- de limiter l'exposition
- de réduire temporairement l'angoisse
- et de maintenir une cohérence narcissique minimale.

Mais ces stratégies contribuent progressivement :

- à l'isolement

- à la rigidification symptomatique
- et à l'appauvrissement relationnel.

Rapport au miroir et au regard

Le miroir occupe une place centrale dans l'économie psychique de Chris :

- il ne rassure pas
- il réactive la conviction d'être monstrueux
- il intensifie la honte
- il alimente le désespoir.

Le regard d'autrui apparaît comme :

- persécuteur
- révélateur
- humiliant.

Le sujet se vit comme continuellement exposé à une *disqualification narcissique*.

Dépendance à la réassurance

Les demandes répétées adressées à la partenaire ou aux médecins traduisent une recherche constante de réassurance. Cependant :

- aucune validation extérieure ne stabilise durablement le sentiment de soi
- le doute réapparaît rapidement
- la souffrance persiste malgré les tentatives de correction corporelle.

Dimension dépressive et suicidaire

L'envahissement progressif de l'existence par la préoccupation corporelle conduit :

- au retrait relationnel
- à la perte du travail
- à la rupture affective
- et à une perte de sens globale.

Les passages à l'acte suicidaire peuvent être compris en lien avec :

- le sentiment d'impasse ;
- l'impossibilité de se dégager de la scène spéculaire ;
- un effondrement aigu de la représentation de soi.

Formulation psychodynamique

Les symptômes de Chris peuvent être compris comme des tentatives de défense contre une fragilité narcissique majeure et une angoisse de honte liée au regard d'autrui. Le camouflage, les vérifications, la réassurance et l'évitement visent à limiter l'exposition et à préserver une représentation de soi encore supportable, mais renforcent progressivement l'isolement, la dépendance au contrôle de l'image et le désespoir.

4.5. Psychopathologie cognitive

Hyperfocalisation attentionnelle sur le visage

Le fonctionnement de Chris semble marqué par une attention sélective excessive portée :

- aux détails de son visage
- aux imperfections perçues
- aux réactions d'autrui

- et aux indices de jugement social.

L'attention est rapidement captée par :

- le miroir
- les pores de la peau
- les regards
- ou toute situation d'exposition.

Distorsions cognitives et croyances dysfonctionnelles

Chris développe des croyances fortement négatives concernant son apparence :

- « je suis monstrueux »
- « tout le monde voit mes défauts »
- « les gens se moquent de moi ».

Ces croyances s'accompagnent :

- d'une surestimation de la visibilité du défaut
- d'une interprétation négative du regard d'autrui
- et d'une catastrophisation des conséquences sociales.

Insight fluctuant

Le sujet oscille entre :

- des moments de doute (« peut-être que je déforme »)
- et des moments de conviction quasi absolue.

Le miroir agit alors comme puissant renforçateur de la croyance anxieuse (dysmorphique).

Comportements de sécurité

Les conduites de camouflage, de réassurance, d'évitement et de retrait social fonctionnent comme des comportements de sécurité. Elles réduisent temporairement la honte et l'anxiété en limitant l'exposition du visage ou en recherchant une confirmation extérieure.

La vérification dans le miroir remplit une fonction différente : elle vise à obtenir une certitude sur l'apparence, mais elle augmente souvent la focalisation sur les détails du visage et renforce la conviction du défaut.

Ces conduites contribuent ainsi à maintenir le trouble en empêchant :

- la remise en question des croyances dysmorphiques ;
- l'expérience d'une exposition sans rejet ;
- et la diminution spontanée de l'attention portée au visage.

Cercle de maintien

Un cercle auto-entretenu semble progressivement s'installer :

- Focalisation sur le visage
 - > perception amplifiée d'un défaut
 - > interprétation dysmorphique et anticipation du jugement
 - > honte et anxiété
 - > vérification, réassurance, camouflage ou évitement
 - > apaisement bref ou intensification de la focalisation
 - > renforcement de la conviction dysmorphique.

Formulation cognitive

Les difficultés de Chris peuvent être comprises comme le résultat d'un fonctionnement centré sur l'hypervigilance corporelle, les croyances dysmorphiques et l'interprétation négative du

regard d'autrui. Les conduites de vérification, de camouflage et d'évitement réduisent momentanément l'angoisse mais contribuent progressivement à maintenir la préoccupation corporelle et le retrait social.

4.6. Psychopathologie anthropo-phénoménologique

La lecture anthropo-phénoménologique ne cherche pas seulement à décrire une préoccupation excessive pour l'apparence ou une peur du jugement. Elle interroge la transformation du visage comme lieu d'expression, de reconnaissance et d'apparition devant autrui.

Chez Chris, le phénomène central n'est pas simplement : « mon nez est laid ». Le jugement porté sur une partie du visage devient un jugement sur l'ensemble du sujet : « je suis monstrueux ». Le défaut supposé ne demeure donc pas localisé ; il acquiert la valeur d'une vérité identitaire.

L'expérience peut ainsi être comprise comme une *crise de l'apparition de soi* : Chris ne peut plus se présenter à autrui sans craindre que son apparence visible résume et définisse tout ce qu'il est.

Du visage expressif au visage objectivé

Dans une perspective inspirée de Merleau-Ponty, le corps vécu est le corps à partir duquel le sujet perçoit, agit et rencontre autrui :

- il ne constitue pas d'abord un objet que le sujet doit examiner
- il demeure habituellement à l'arrière-plan de l'action et de la relation.

Chez Chris, cette relation spontanée au visage se rompt. Le visage ne soutient plus simplement l'expression et la rencontre : il devient un objet visible qui semble précéder le sujet et déterminer d'avance la manière dont il sera perçu.

Avant même de parler ou de rencontrer quelqu'un, Chris anticipe ce que l'autre verra de son nez et la manière dont cette apparence pourrait le disqualifier

- il ne se vit plus d'abord comme celui qui regarde, parle et répond
- > mais comme celui dont le visage est regardé et jugé.

En reprenant l'analyse de Thomas Fuchs, on peut dire que le corps vécu tend ici à être recouvert par le corps objectivé, c'est-à-dire par le corps tel qu'il est supposé apparaître à autrui. Chris adopte continuellement sur lui-même le point de vue qu'il attribue aux autres. Son visage devient alors une réalité à :

- inspecter
- comparer
- cacher
- faire valider
- corriger
- ou tenter de réparer

Fuchs, T. (2002). « The Phenomenology of Shame, Guilt and the Body in Body Dysmorphic Disorder and Depression. » *Journal of Phenomenological Psychology*, 33(2), 223–243.

Le problème ne tient donc pas seulement à une insatisfaction concernant un détail du visage. Chris se trouve progressivement assigné à l'image qu'il pense offrir :

- il ne vit plus simplement son visage comme le lieu de son expression
- > il se voit depuis l'extérieur et tente de maîtriser l'objet qu'il suppose exposer au regard d'autrui.

Du détail visible à l'identité dévoilée

Le miroir ne sert pas seulement à vérifier l'état du nez. Il transforme progressivement un détail localisé en vérité supposée sur l'ensemble du sujet :

- un détail du nez est isolé
- il envahit la perception du visage
- le visage finit par résumer l'apparence entière

- cette apparence devient la définition de ce que Chris croit être.

La vérification ne peut donc produire de réponse stable. Chris ne cherche plus seulement à savoir comment est son nez, mais ce que son visage révèle de lui.

Le regard d'autrui prolonge cette totalisation. Être vu signifie :

- que le défaut sera découvert
- que Chris sera réduit à cette apparence
- et que ses paroles ou ses qualités ne pourront plus modifier l'impression produite.

La rencontre paraît ainsi décidée avant même de commencer : autrui est supposé voir, dévoiler et juger, tandis que Chris se trouve fixé dans la position de celui dont l'apparence a déjà parlé à sa place.

Une spatialité organisée selon un gradient de visibilité

L'espace de Chris est structuré selon la quantité de visibilité qu'il impose au visage.

Un lieu devient menaçant en fonction :

- de son éclairage
- de la proximité des personnes
- de la durée d'exposition
- de la possibilité de masquer le visage
- du risque d'être observé sans pouvoir réduire cette visibilité

Cette spatialité se distingue de celle de Léo :

- chez Léo, l'espace dépend de la possibilité d'en modifier les conditions ou de partir
- chez Chris, il dépend de la possibilité de contrôler ce qui peut être vu de lui.

Le masque comme médiation paradoxale

Le masque de Batman possède une fonction particulièrement révélatrice. Il ne sert pas seulement à disparaître : il permet à Chris de participer à une situation sociale.

En cachant son visage propre, il suspend momentanément l'idée que l'apparence révèle son identité intime. Sous le masque, l'apparence redevient rôle, jeu et médiation.

Le paradoxe est donc le suivant : Chris doit soustraire son visage au regard pour pouvoir réapparaître comme sujet.

Il ne cherche pas nécessairement l'invisibilité absolue, mais une forme de visibilité qui ne prétende pas dire toute la vérité sur lui.

Temporalité de la fixation spéculaire

Le temps de Chris revient continuellement à la même scène. Depuis quinze ans, chaque vérification promet une réponse définitive, mais relance la préoccupation.

Le futur est suspendu à une condition préalable : le visage devrait être corrigé avant que la vie puisse véritablement reprendre. Mais ni la réassurance ni l'intervention dermatologique ne modifient durablement l'expérience.

Le travail, les relations et les projets sont ainsi reportés derrière une correction impossible. Lorsque le miroir précipite le passage à l'acte suicidaire, l'image présente semble abolir toute possibilité d'un avenir différent.

Formulation anthropo-phénoménologique

Les difficultés de Chris correspondent à une crise de l'apparition de soi. Le visage ne fonctionne plus comme médiation expressive entre soi et autrui : il devient une image objectivée supposée révéler l'identité entière.

Le corps vécu est envahi par le corps vu ; un détail facial totalise le sujet ; le miroir donne à cette image une évidence presque absolue ; le regard d'autrui devient pouvoir de dévoilement et de disqualification. L'espace se distribue selon les degrés de visibilité, tandis que l'avenir

reste suspendu à une correction corporelle qui ne suffit jamais.

Chris ne souffre donc pas seulement de croire son nez difforme. Il souffre de ne plus pouvoir apparaître sans se sentir immédiatement réduit à cette difformité. Le camouflage suspend momentanément cette assignation, mais au prix d'un effacement progressif de la relation, du travail et de l'avenir.

4.7. Psychopathologie neuro-phénoménologique

Boucles visage–regard–angoisse

Les situations impliquant :

- la lumière
- la proximité
- le miroir
- l'exposition du visage
- le regard d'autrui

déclenchent rapidement :

- une focalisation attentionnelle sur le visage
- une montée de honte et d'angoisse
- une hyperconscience corporelle
- une intensification de la perception du défaut.

Cette activation augmente ensuite le besoin de vérifier, de contrôler l'image, de se camoufler ou de se retirer.

Hyperréflexivité corporelle

Le visage cesse d'être vécu de manière immédiate et relativement silencieuse. Il devient :

- scruté
- comparé
- corrigé
- anticipé
- mis en scène.

Cette hyperréflexivité transforme le visage en objet permanent d'attention et désautomatise la présence à autrui. Chris ne peut plus simplement parler ou rencontrer quelqu'un : il doit simultanément surveiller la manière dont son visage pourrait apparaître.

Mémoire corporelle de l'exposition

Certaines conditions de visibilité s'associent progressivement :

- à la honte
- à l'humiliation
- à l'intensification de la conscience du visage
- au danger supposé d'être remarqué.

L'organisme anticipe alors plus rapidement les situations de lumière, de proximité ou de regard comme des situations menaçantes. Le camouflage et le retrait réduisent temporairement l'activation, ce qui renforce l'association entre visibilité et danger.

Le monde vécu tend ainsi à se réorganiser autour :

des conditions de moindre visibilité

des distances protectrices

des possibilités de dissimulation

des dispositifs permettant de contrôler l'exposition du visage.

Intercorporéité et regard

Le regard d'autrui agit comme un amplificateur de la conscience corporelle. Être vu :
augmente l'attention portée au visage
intensifie la perception du défaut
accroît la honte et l'anxiété
favorise le camouflage ou le retrait.

La présence d'autrui modifie donc immédiatement la manière dont Chris éprouve son propre visage. La relation devient dominée par la régulation de l'exposition corporelle plutôt que par l'échange lui-même.

Boucle de stabilisation

La dynamique peut être formulée ainsi :

situation de visibilité

> focalisation sur le visage

> intensification perceptive du défaut

> honte et anxiété

> vérification, camouflage ou retrait

> aggravation de la focalisation ou réduction temporaire de l'activation

> renforcement de l'association entre visibilité et menace.

Formulation neuro-phénoménologique

Les difficultés de Chris s'inscrivent dans une dynamique incarnée associant hyperfocalisation sur le visage, amplification de la conscience corporelle sous le regard d'autrui et anticipation de la honte. Les vérifications au miroir renforcent souvent la perception du défaut, tandis que le camouflage et l'évitement diminuent temporairement l'activation. Ces conduites contribuent ensemble à stabiliser une dynamique corporelle, perceptive et intercorporelle dans laquelle la visibilité du visage devient progressivement synonyme de menace.

4.8. Psychopathologie différentielle

Les quatre lectures portent sur la même situation clinique, mais elles ne construisent pas le même objet psychopathologique. Le camouflage, le miroir, la conviction de difformité et le retrait changent de statut selon le référentiel mobilisé.

La psychopathologie différentielle montre ce que chaque lecture considère comme le noyau du trouble, ce qu'elle cherche à comprendre et le type de transformation qu'elle met au premier plan.

Lecture psychodynamique

La lecture psychodynamique interroge la fonction des symptômes dans l'économie psychique.

La question centrale est : *Contre quelle expérience psychique le symptôme protège-t-il ?*

Chez Chris, le défaut corporel supposé condense une souffrance narcissique plus globale. La crainte n'est pas seulement d'avoir un nez disgracieux, mais d'être révélé comme grotesque, indigne ou fondamentalement disqualifié sous le regard d'autrui.

Le camouflage, le retrait, la vérification et la recherche de réassurance permettent provisoirement :

- de limiter l'exposition à la honte
- de préserver une représentation de soi encore supportable
- d'éviter une dévalorisation narcissique aiguë
- de maintenir une cohérence psychique minimale.

Le miroir constitue ici une scène narcissique particulière : il réactive une image de soi vécue comme insupportable et peut précipiter un effondrement de l'estime de soi.

Cette lecture construit donc le trouble comme une tentative de protection contre la honte, la disqualification et l'effondrement narcissique.

Lecture cognitive

La lecture cognitive construit le trouble comme un système de traitement et de maintien de l'information dysmorphique.

La question centrale est : *Quels processus renforcent la conviction du défaut et empêchent sa révision ?*

Elle met en évidence :

- la sélection attentionnelle des détails faciaux jugés anormaux
- l'amplification perceptive produite par l'observation prolongée
- la surestimation de la visibilité du défaut
- l'interprétation négative des réactions d'autrui
- la difficulté à désengager l'attention du visage
- les conduites qui empêchent la remise en cause des croyances.

La vérification au miroir augmente la saillance des détails cutanés et renforce la conviction dysmorphique.

Le camouflage et l'évitement empêchent, quant à eux, l'expérience d'une visibilité qui ne conduirait ni à la moquerie ni au rejet.

La réassurance apporte un soulagement bref, mais entretient la dépendance à une validation extérieure.

Cette lecture construit donc le trouble comme un cercle de maintien entre focalisation, interprétation dysmorphique et comportements de sécurité.

Lecture anthropo-phénoménologique

La lecture anthropo-phénoménologique interroge la transformation du visage comme modalité d'apparition de soi.

La question centrale est : *Comment Chris peut-il encore apparaître devant autrui lorsque son visage lui semble révéler une monstruosité qui définit toute sa personne ?*

Le phénomène spécifique est une *crise de l'apparition de soi*. Le visage ne soutient plus l'expression et la rencontre : il semble précéder Chris, parler à sa place et déterminer d'avance la manière dont il sera reconnu.

Le trouble concerne précisément :

- l'envahissement du corps vécu par le corps vu
- la totalisation de l'identité à partir d'un détail facial
- la transformation du regard en pouvoir de dévoilement
- la rupture de la réciprocité entre regarder et être regardé
- l'organisation de l'espace selon un gradient de visibilité
- la suspension de l'avenir à une correction corporelle qui ne suffit jamais.

Le masque possède ici une fonction paradoxale. Il soustrait le visage propre au regard, mais permet à Chris de redevenir visible sous une apparence qui ne prétend plus révéler son identité entière.

Cette lecture construit donc le trouble comme l'impossibilité d'apparaître sans être immédiatement réduit à une image corporelle supposée monstrueuse.

Lecture neuro-phénoménologique

La lecture neuro-phénoménologique étudie la stabilisation incarnée du trouble dans les boucles entre perception, attention, corps et environnement.

La question centrale est : *Comment certaines situations rendent-elles le visage immédiatement saillant et menaçant ?*

La lumière, le miroir, la proximité et le regard d'autrui déclenchent une focalisation sur le visage. Cette focalisation intensifie la perception du défaut, la honte et l'angoisse, puis appelle la vérification, le camouflage ou le retrait.

Le trouble se stabilise ainsi dans des habitudes :

- attentionnelles
- perceptives
- corporelles
- spatiales
- intercorporelles.

La visibilité est progressivement anticipée comme une menace avant même qu'un jugement explicite ne soit formulé. Les vérifications peuvent renforcer immédiatement la perception du défaut, tandis que le camouflage et le retrait réduisent temporairement l'activation et consolident l'association entre visibilité et danger.

Cette lecture construit donc le trouble comme une dynamique incarnée dans laquelle visage, regard, perception et honte se renforcent mutuellement.

Synthèse comparative

Les quatre lectures construisent des objets psychopathologiques distincts :

- *psychodynamique* : une défense contre la honte, la disqualification et l'effondrement narcissique
- *cognitive* : un système de croyances dysmorphiques, de focalisation attentionnelle et de comportements de maintien
- *anthropo-phénoménologique* : une crise de l'apparition de soi dans laquelle le visage précède le sujet et totalise son identité
- *neuro-phénoménologique* : une boucle incarnée entre visibilité, hyperconscience faciale, honte et retrait.

Statut comparé des principaux phénomènes

Le camouflage

Le camouflage peut être compris :

- *psychodynamiquement* : comme une protection contre l'exposition honteuse et la dévalorisation narcissique
- *cognitivement* : comme un comportement de sécurité empêchant la révision de la croyance selon laquelle le visage ne peut être montré
- *anthropo-phénoménologiquement* : comme la création d'une forme de visibilité médiatisée permettant à Chris d'apparaître sans que son visage propre soit vécu comme la révélation de son identité entière
- *neuro-phénoménologiquement* : comme une régulation corporelle et spatiale réduisant temporairement l'activation liée à la visibilité.

Le miroir

Le miroir peut être compris :

- *psychodynamiquement* : comme une scène narcissique où se réactive une image insupportable de soi
- *cognitivement* : comme un dispositif qui augmente la focalisation sur les détails et renforce la conviction dysmorphique
- *anthropo-phénoménologiquement* : comme l'opérateur d'une totalisation identitaire dans laquelle un détail facial acquiert la valeur d'une vérité globale sur le sujet
- *neuro-phénoménologiquement* : comme un déclencheur perceptif qui intensifie la boucle entre visage, honte, attention et contrôle.

Le regard d'autrui

Le regard d'autrui peut être compris :

- *psychodynamiquement* : comme une menace de disqualification et de blessure narcissique
- *cognitivement* : comme une information ambiguë interprétée à partir des croyances de rejet et de monstruosité
- *anthropo-phénoménologiquement* : comme un pouvoir de dévoilement qui fixe Chris dans la position de l'objet visible et rompt la réciprocité de la rencontre

- *neuro-phénoménologiquement* : comme un amplificateur immédiat de la conscience du visage, de la honte et du besoin de réduire l'exposition.

Ces quatre lectures ne sont pas interchangeables. Elles diffèrent par ce qu'elles considèrent comme le noyau du trouble, mais convergent sur la gravité du retrait, du désespoir et du risque suicidaire.

4.9. Hypothèses diagnostiques

Les quatre lectures aboutissent à des formulations diagnostiques différentes, mais elles ne portent ni sur le même objet ni sur le même niveau de diagnostic.

- La *lecture psychodynamique* qualifie une organisation psychique et la fonction des symptômes.
- La *lecture cognitive et syndromique* conduit directement à une catégorie nosographique classique.
- La *lecture anthropo-phénoménologique* décrit une transformation de la manière d'apparaître à soi et à autrui.
- La *lecture neuro-phénoménologique* précise comment le trouble se stabilise dans des boucles corporelles, perceptives et intercorporelles.

Ces formulations sont complémentaires, mais elles ne sont pas interchangeables.

Évaluation diagnostique psychodynamique

Fragilité narcissique à expression dysmorphophobique

Dans une perspective psychodynamique, le défaut facial supposé concentre une dévalorisation qui concerne l'ensemble de la personne. Chris ne se représente pas seulement comme imparfait : il se vit comme grotesque ou monstrueux, sous la menace constante d'une disqualification par le regard d'autrui.

Les conduites de camouflage, de vérification et de retrait peuvent être comprises comme des défenses contre la honte et contre un effondrement de l'estime de soi. Elles rendent momentanément l'image de soi plus supportable, mais renforcent la dépendance au contrôle de l'apparence et l'isolement.

Les crises suicidaires peuvent survenir lorsque ces défenses ne suffisent plus et que Chris se trouve entièrement identifié à l'image monstrueuse qu'il attribue à son visage.

Formulation psychodynamique : Le tableau évoque une fragilité narcissique sévère à expression dysmorphophobique, dominée par la honte, la crainte d'une disqualification sous le regard d'autrui et le risque d'un effondrement aigu de l'estime de soi.

Évaluation diagnostique cognitive et syndromique

Trouble dysmorphique corporel sévère, à insight faible ou fluctuant

Le tableau est fortement compatible avec un trouble dysmorphique corporel centré sur un défaut facial absent ou peu perceptible pour autrui. La durée de la préoccupation, les vérifications répétées, le camouflage, les demandes de réassurance, les évitements et le retentissement majeur soutiennent cette hypothèse.

L'insight est faible et fluctuant : Chris peut parfois reconnaître qu'il déforme son apparence, mais cette distance critique disparaît notamment devant le miroir. La conviction peut alors devenir presque absolue, sans imposer pour autant un diagnostic distinct de trouble délirant somatique lorsqu'elle reste entièrement liée à la préoccupation dysmorphique.

La gravité est majeure en raison du retentissement social, professionnel et affectif, ainsi que des idées suicidaires et des passages à l'acte.

Formulation cognitive et syndromique : Le tableau est compatible avec un trouble dysmorphique corporel sévère, à insight faible ou fluctuant, entretenu par la focalisation sur le défaut supposé, les interprétations négatives du regard d'autrui et les conduites de vérification, de camouflage et d'évitement.

Évaluation diagnostique anthropo-phénoménologique

Crise de l'apparition de soi et totalisation de l'identité par l'image faciale

L'évaluation anthropo-phénoménologique ne cherche pas à attribuer une catégorie syndromique. Elle qualifie la transformation du visage comme lieu d'expression, d'adresse et de reconnaissance.

Chez Chris, le visage ne demeure plus en retrait dans la rencontre. Il paraît précéder sa parole et déterminer d'avance ce qu'autrui pourra reconnaître de lui. Chris ne se vit plus principalement comme celui qui regarde, parle et répond, mais comme celui dont l'apparence est déjà observée et jugée.

Le corps vécu est ainsi envahi par le corps vu. Le miroir isole un détail du nez, lui confère une évidence presque absolue et transforme cette partie du visage en vérité globale de l'identité. Chris ne pense plus seulement posséder un défaut : il se définit à partir de lui.

La réciprocité du regard se rompt : autrui est supposé révéler et juger, tandis que Chris se trouve immobilisé dans la position de l'objet visible.

Le camouflage ne sert toutefois pas seulement à éviter l'exposition. Le masque montre qu'une autre forme d'apparition demeure possible. Chris peut être visible lorsque l'apparence redevient rôle et médiation plutôt que preuve immédiate de ce qu'il est.

Formulation anthropo-phénoménologique : Le tableau correspond à une crise de l'apparition de soi. Le visage ne fonctionne plus comme médiation expressive entre soi et autrui : il précède le sujet et paraît révéler son identité entière. Le corps vécu est envahi par le corps vu, un détail facial totalise l'image de soi et le regard d'autrui devient pouvoir de dévoilement et de disqualification. Chris ne peut plus apparaître sans craindre d'être entièrement réduit à ce que son visage donnerait à voir.

Évaluation diagnostique neuro-phénoménologique

Dynamique dysmorphique incarnée centrée sur la menace de visibilité

L'évaluation neuro-phénoménologique décrit une dynamique dans laquelle certaines conditions de visibilité — miroir, lumière, proximité et regard d'autrui — augmentent rapidement la conscience du visage et l'intensité perçue du défaut.

La honte et l'anxiété conduisent alors à vérifier, dissimuler ou éviter l'exposition. Ces conduites diminuent temporairement l'activation, mais renforcent progressivement l'association entre visibilité et menace.

Formulation neuro-phénoménologique : Le tableau évoque une dynamique dysmorphique incarnée dans laquelle la visibilité du visage active une boucle entre focalisation attentionnelle, amplification perceptive du défaut, honte et conduites de dissimulation ou de retrait. Cette boucle stabilise progressivement un rapport au corps et à autrui dominé par la menace d'être vu.

Synthèse comparative des quatre évaluations

Les quatre formulations diagnostiques ne sont pas interchangeables :

- *Psychodynamique* : fragilité narcissique à expression dysmorphophobique, dans laquelle les symptômes protègent contre la honte, la disqualification et l'effondrement de l'image de soi.
- *Cognitive et syndromique* : trouble dysmorphique corporel sévère à insight faible ou fluctuant, entretenu par l'hyperfocalisation faciale, les croyances dysmorphiques et les conduites de sécurité.
- *Anthropo-phénoménologique* : crise de l'apparition de soi, caractérisée par la totalisation de l'identité à partir d'un détail facial et par la transformation du regard en pouvoir de dévoilement.
- *Neuro-phénoménologique* : dynamique incarnée de menace liée à la visibilité, stabilisée dans les boucles entre visage, attention, perception, honte et retrait.

Registres de l'évaluation :

- La première qualifie une organisation narcissique.
- La deuxième identifie un syndrome clinique classique.
- La troisième décrit une transformation du rapport entre visage, identité et apparition.
- La quatrième précise la stabilisation corporelle et perceptive du trouble.

Quelle que soit la lecture mobilisée, les deux tentatives de suicide, le retrait massif, la rupture affective et la perte de l'emploi imposent de considérer le risque suicidaire comme une dimension clinique prioritaire.

5. M. Wolfe

Ce quatrième cas permet de travailler une autre modalité psychopathologique :

- non plus la peur de l'exposition, le doute ou l'image corporelle
- > mais l'impossibilité de se séparer, avec envahissement progressif de l'espace de vie.

5.1. Observation

M. Wolfe se présente aux urgences d'un hôpital en se plaignant de malaises, de fièvre et de toux. Un diagnostic d'infection des voies respiratoires hautes est établi. Alors que le médecin rédige son ordonnance, M. Wolfe se met à pleurer en expliquant qu'il n'a nulle part où aller, et qu'il pense que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue.

Au cours du mois précédent, M. Wolfe a vécu dans le sous-sol de son immeuble. Il prend ses repas dans divers restaurants et se douche dans un centre de remise en forme. Son appartement est tellement encombré de journaux, de magazines et de livres qu'il ne peut plus en franchir le seuil. Pourtant, il ne parvient pas à se débarrasser de ses objets.

Depuis l'âge de douze ans, M. Wolfe collectionne des objets : cartes de base-ball, livres, magazines, journaux. Il explique qu'il ne peut pas jeter un journal ou un magazine parce qu'« il peut y avoir quelque chose d'intéressant écrit dessus ». L'idée de jeter quelque chose le rend extrêmement anxieux.

Cette accumulation a entraîné de nombreux conflits familiaux, professionnels et conjugaux. Il a été renvoyé de plusieurs emplois parce qu'il stockait des objets sur son lieu de travail. Sa femme l'a quitté, ne pouvant plus supporter sa conduite. Son fils le voit rarement.

Après son divorce, M. Wolfe a transporté une partie de sa collection dans son nouvel appartement et loué un box pour le reste. Peu à peu, son appartement s'est rempli de journaux, de magazines et de livres, au point qu'il est devenu difficile d'accéder à son lit. Après s'être blessé à l'épaule en essayant de déplacer ses objets, il a quitté son appartement pour dormir dans le sous-sol de l'immeuble.

M. Wolfe a conscience que son incapacité à jeter est irrationnelle. Mais à la simple idée de le faire, l'angoisse le submerge.

5.2. Clinique phénoménologique

M. Wolfe décrit une expérience dominée par une impossibilité à se séparer de certains objets, malgré les conséquences majeures que cette accumulation entraîne dans sa vie quotidienne.

L'expérience rapportée par M. Wolfe est marquée par :

- une incapacité persistante à jeter des journaux, des magazines, des livres et d'autres objets collectionnés
- la conviction qu'un journal ou un magazine pourrait contenir « quelque chose d'intéressant »
- une angoisse extrême à la simple idée de jeter
- une accumulation ancienne et progressive dans les lieux de vie et de travail
- un encombrement tel que le seuil de l'appartement ne peut plus être franchi
- la nécessité de dormir dans le sous-sol de l'immeuble, de prendre ses repas au restaurant et de se doucher dans un centre de remise en forme
- une blessure à l'épaule survenue en essayant de déplacer les objets
- des conséquences familiales, conjugales et professionnelles majeures
- un isolement relationnel important

- une souffrance actuelle marquée par les pleurs, le sentiment de ne plus avoir de lieu où aller et l'idée que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue.

M. Wolfe reconnaît le caractère irrationnel de son incapacité à jeter, sans parvenir pour autant à s'en dégager. Les objets accumulés occupent progressivement l'espace disponible et empêchent son usage ordinaire. L'appartement devient inaccessible, tandis que les lieux de travail ont également été investis par le stockage.

5.3. Analyse existentielle

Rapport au temps

La temporalité semble organisée autour :

- de la conservation
- du maintien
- et du refus de la perte.

Les objets gardent toujours une possibilité future :

- « cela pourrait servir »
- « il peut y avoir quelque chose d'intéressant ».

Le présent demeure ainsi ouvert sur un futur hypothétique qui empêche la clôture et la séparation.

Rapport à l'espace

L'espace de vie cesse progressivement d'être structuré autour de l'habitation humaine. Il devient :

- saturé
- encombré
- difficilement traversable.

L'appartement n'est plus un espace de circulation ou de repos : il devient essentiellement lieu de stockage et de conservation.

Le sujet finit même par quitter cet espace devenu pratiquement inhabitable.

Rapport à autrui

Les relations deviennent progressivement conflictuelles autour de la question des objets.

Autrui apparaît souvent :

- comme celui qui veut jeter
- supprimer
- ou faire disparaître.

Les conflits avec :

- les parents
- les collègues
- le personnel d'entretien
- puis sa femme

semblent progressivement renforcer le besoin de conservation.

Rapport aux objets

Le monde semble réduit à un ensemble d'objets

Les objets occupent une place centrale dans l'organisation de l'existence. Ils apparaissent :

- difficilement remplaçables
- porteurs de potentialités
- investis d'une valeur dépassant leur usage immédiat.

Jeter un objet ne constitue pas un acte banal : cela prend la valeur d'une perte potentiellement irréversible et anxiogène.

Tension structurante

L'existence de M. Wolfe semble organisée autour d'une tension centrale : *garder / abandonner*.

D'un côté :

- le besoin de conserver
- la peur de jeter
- le souci de préserver ce qui pourrait encore servir
- la volonté d'éviter une perte définitive.

De l'autre :

- la nécessité de trier
- de renoncer à certains objets
- de libérer de l'espace
- et d'accepter qu'une chose puisse disparaître sans que tout soit perdu.

Ce que cette tension permet : La conservation réduit temporairement l'anxiété liée à la perte. Elle permet à M. Wolfe de maintenir les objets à proximité et de préserver l'idée qu'ils pourront encore être utiles, relus ou récupérés. Garder lui évite ainsi d'avoir à décider qu'une chose ne compte plus.

Ce qu'elle limite : Cette organisation empêche progressivement toute sélection. Chaque objet conserve une importance possible et devient difficile à abandonner. L'accumulation réduit alors les passages, l'accès au lit, l'usage des pièces et la possibilité de recevoir autrui. En voulant éviter la perte des objets, M. Wolfe perd peu à peu l'usage de son logement, ses relations et sa liberté de mouvement.

Structure de vécu

L'expérience de M. Wolfe s'organise autour d'une difficulté à abandonner les objets sans vivre leur disparition comme une perte menaçante.

Les choses ne sont pas seulement conservées pour leur utilité actuelle. Elles restent porteuses d'une valeur ou d'un usage possible, ce qui rend leur abandon difficile. Le temps est dominé par le report du tri l'espace est progressivement occupé par ce qui ne peut pas être jeté autrui apparaît souvent comme celui qui risque d'imposer une séparation.

Le logement cesse ainsi d'être organisé autour de la vie quotidienne. Il devient un espace de conservation auquel M. Wolfe doit lui-même s'adapter.

Formulation existentielle

M. Wolfe maintient les objets présents pour éviter l'anxiété de leur perte. Cette conservation lui permet de différer l'abandon, mais elle envahit progressivement son espace et désorganise sa vie. En cherchant à ne rien perdre, il perd peu à peu la possibilité d'habiter son propre logement et de faire place à autre chose.

5.4. Psychopathologie psychodynamique

Angoisse centrale

L'organisation symptomatique semble structurée autour :

- d'une angoisse de perte
- d'une difficulté de séparation
- et d'une insécurité interne importante.

Les objets semblent progressivement investis d'une fonction de continuité et de stabilisation psychique.

Fonction des défenses

Les conduites :

- d'accumulation
- de conservation
- de refus de jeter
- et de récupération des objets

jouent une fonction défensive importante.

Elles permettent :

- de limiter l'angoisse de perte
- de maintenir un sentiment de continuité
- et de lutter contre des éprouvés de vide ou de désorganisation.

Cependant, ces stratégies contribuent progressivement :

- à l'envahissement de l'espace psychique et matériel
- à l'isolement
- et à la désorganisation de la vie quotidienne.

Signification des objets

Les objets semblent acquérir une valeur dépassant largement leur fonction pratique. Ils deviennent :

- supports de mémoire
- garanties contre le manque
- éléments de sécurité psychique.

L'histoire familiale marquée par la pauvreté et la nécessité de conserver les choses semble avoir participé à cette organisation.

L'épisode où les parents jettent la collection apparaît particulièrement important :

- l'expérience de perte y semble vécue comme effraction ou dépossession
- la récupération des objets dans les débris marque un moment de fixation important.

Dimension dépressive

L'histoire clinique fait également apparaître :

- des épisodes de ralentissement majeur
- une perte d'élan vital
- un désinvestissement de l'existence.

L'accumulation peut alors également fonctionner comme tentative :

- de maintien
- de remplissage
- ou de lutte contre le vide dépressif.

Formulation psychodynamique

Les symptômes de M. Wolfe peuvent être compris comme des tentatives de défense contre une angoisse de perte, de séparation et de vide interne. L'accumulation et la conservation des objets permettent de maintenir une continuité psychique mais contribuent progressivement à l'envahissement du monde vécu et à l'isolement relationnel.

5.5. Psychopathologie cognitive

Croyances liées à la perte et à l'utilité

Le fonctionnement de M. Wolfe semble marqué par des croyances persistantes telles que :

- « cela pourrait servir un jour »
- « il peut y avoir quelque chose d'important dedans »
- « jeter serait une erreur ».

Les objets sont perçus comme :

- potentiellement utiles
- irremplaçables
- ou porteurs de valeur future.

Intolérance à la perte et à l'incertitude

Le sujet semble présenter une forte difficulté :

- à accepter l'incertitude
- à renoncer
- ou à prendre le risque de perdre quelque chose d'important.

Jeter un objet implique :

- une perte définitive
- et une impossibilité de revenir en arrière.

Cette irréversibilité devient particulièrement anxiogène.

Comportements de sécurité

Les conduites :

- d'accumulation
- de conservation
- d'évitement du tri
- et de récupération

> fonctionnent comme des comportements de sécurité.

Elles réduisent momentanément l'anxiété mais empêchent :

- l'infirmité des croyances de perte
- et l'apprentissage de la tolérance au renoncement.

Cercle de maintien

Un cercle auto-entretenu semble progressivement s'installer :

Objet rencontré :

- > pensée de possible utilité
- > anxiété à l'idée de jeter
- > conservation de l'objet
- > soulagement temporaire
- > renforcement du besoin de garder

Retentissement fonctionnel

L'accumulation entraîne progressivement :

- une désorganisation de l'espace
- des conflits relationnels
- des difficultés professionnelles
- et une réduction importante de la qualité de vie.

Malgré cela, le sujet reste incapable d'interrompre durablement le comportement d'accumulation.

Formulation cognitive

Les difficultés de M. Wolfe peuvent être comprises comme un fonctionnement centré sur la surestimation de la valeur potentielle des objets, l'intolérance à l'incertitude et à l'irréversibilité, ainsi que la difficulté à hiérarchiser et à prendre une décision de tri. La conservation et l'évitement du tri réduisent temporairement l'anxiété, mais empêchent M. Wolfe de faire l'expérience qu'une séparation peut être supportable. Ces conduites maintiennent ainsi l'accumulation et aggravent progressivement le retentissement résidentiel, relationnel et professionnel.

5.6. Psychopathologie anthropo-phénoménologique

La lecture anthropo-phénoménologique ne s'intéresse pas seulement à la quantité d'objets accumulés, à l'incapacité de trier ou à l'angoisse provoquée par le fait de jeter. Elle cherche à comprendre comment se transforment, chez M. Wolfe, le rapport aux objets, au temps, à l'absence et à l'espace domestique.

Le phénomène central peut être formulé ainsi :

- presque aucun objet ne devient assez secondaire pour pouvoir être abandonné
- un journal, un magazine ou un livre conserve toujours une valeur possible : il pourrait contenir une information intéressante, être relu, servir ultérieurement ou prendre une importance nouvelle.

L'objet n'est donc pas nécessairement utile au présent, mais il ne devient jamais suffisamment inutile pour pouvoir disparaître.

La présence matérielle est une garantie

Des objets qui ne deviennent plus abandonnables

Dans l'expérience ordinaire, les objets s'inscrivent dans des usages. Un journal est lu, un livre consulté, un outil employé. Lorsque l'usage est terminé, l'objet peut être rangé, donné, oublié ou jeté. Il perd progressivement son actualité et rejoint l'arrière-plan du monde quotidien.

Chez M. Wolfe, ce passage s'interrompt. Même lorsqu'un objet n'est plus utilisé, il reste porteur d'une possibilité future. Il n'est plus vraiment actif dans la vie présente, mais il ne peut pas davantage être considéré comme terminé.

Son statut demeure indécis :

- il appartient au passé, mais pourrait encore servir
- il n'est plus utilisé, mais pourrait redevenir utile
- son contenu est connu, mais pourrait receler une information négligée
- sa valeur paraît faible, mais pourrait être réévaluée plus tard

M. Wolfe ne peut donc pas conclure qu'il en a fini avec l'objet.

Une hiérarchie pratique qui ne s'établit plus

La vie quotidienne suppose que toutes les choses ne conservent pas la même importance. Certains objets doivent rester accessibles, tandis que d'autres peuvent devenir secondaires, remplaçables ou indifférents.

Chez M. Wolfe, cette hiérarchie tend à s'aplatir. Un vieux journal peut devenir aussi difficile à jeter qu'un document important dès lors qu'il pourrait contenir quelque chose d'intéressant. Une possibilité abstraite suffit à maintenir l'objet au premier plan.

La difficulté porte ainsi sur la capacité à distinguer :

- l'essentiel de l'accessoire
- une possibilité importante d'une possibilité négligeable ;
- ce qui doit rester disponible de ce qui peut être abandonné
- ce qui mérite une place de ce qui peut retourner à l'arrière-plan.

Lorsque presque tout objet peut encore compter, presque tout objet doit être conservé. Le monde se remplit alors de choses qui continuent à réclamer une attention et une place.

Une temporalité dominée par l'ajournement

La relation de M. Wolfe aux objets s'organise également autour du report. Le journal pourra être relu plus tard, le livre consulté un autre jour, le tri effectué dans un moment futur.

Le présent ne décide pas : il conserve en attente.

Jeter introduirait au contraire une séparation irréversible. Une fois l'objet disparu, il ne serait plus possible de revenir sur la décision, de vérifier son contenu ou de retrouver son éventuel usage.

L'acte de séparation est donc continuellement différé afin que la possibilité de conserver reste ouverte.

Cette structure se distingue de celle de Marine :

- chez Marine, une action déjà accomplie ne parvient pas à se stabiliser comme terminée et doit être reprise.
- chez M. Wolfe, l'acte de séparation n'advient pas : il est repoussé avant même de pouvoir être accompli.

De l'espace disponible à l'espace entièrement occupé

Habiter suppose que l'espace ne soit pas intégralement rempli. Des passages doivent rester libres, les pièces doivent conserver des fonctions distinctes et certaines surfaces doivent demeurer disponibles pour circuler, dormir, se reposer ou recevoir quelqu'un.

Ces espaces libres ne sont pas inutiles. Ils permettent au corps de se déplacer, aux activités de se succéder et aux situations nouvelles de prendre place. Faire place consiste donc moins à produire du vide qu'à maintenir une disponibilité.

Chez M. Wolfe, cette disponibilité devient difficile à préserver. Libérer une place exige de se séparer d'objets encore chargés de possibilités. L'espace libre paraît alors moins représenter une nouvelle possibilité d'usage que la trace de ce qui aurait pu être conservé.

À mesure que les objets s'accumulent, l'espace perd sa différenciation pratique :

- les passages se ferment
- le lit devient inaccessible
- les pièces cessent de remplir leur fonction
- les gestes quotidiens doivent s'adapter à l'encombrement
- la possibilité de recevoir, de circuler ou de se reposer disparaît.

Les objets ne sont plus simplement contenus dans le logement. Leur présence organise progressivement l'ensemble de l'espace.

Le rapport entre l'habitant et son environnement finit ainsi par se renverser. M. Wolfe conserve les objets afin qu'ils restent disponibles, mais l'espace cesse d'être disponible pour lui. Il possède encore un appartement, mais ne peut plus y entrer, y dormir ni y vivre comme habitant.

Formulation anthropo-phénoménologique

Les difficultés de M. Wolfe peuvent être comprises comme une impossibilité de limiter la présence des objets.

Chaque objet demeure chargé d'une valeur future qui l'empêche de devenir secondaire, terminé ou abandonnable. Jeter introduirait une séparation irréversible, tandis que conserver maintient ouvertes des possibilités hypothétiques.

Cette organisation entraîne un aplatissement de la hiérarchie entre les objets, une temporalité dominée par l'ajournement et une occupation progressive de tout l'espace disponible.

En cherchant à ne rien perdre, M. Wolfe conserve les possibilités attachées aux objets, mais perd progressivement la possibilité d'organiser son espace, d'habiter son logement et de faire place à autre chose.

5.7. Psychopathologie neuro-phénoménologique

Boucle objets–anxiété–conservation

Les situations impliquant :

- de jeter
- de trier
- de donner
- de se séparer d'un objet
- ou de réduire l'accumulation

déclenchent rapidement :

- une montée d'angoisse
- une tension corporelle
- l'anticipation d'une perte irréversible
- une urgence à conserver ou à récupérer l'objet.

Cette activation conduit M. Wolfe :

- à garder l'objet
- à éviter ou à reporter le tri
- à interrompre la tentative de séparation
- ou à récupérer ce qui a été jeté.

La conservation diminue temporairement l'angoisse. Ce soulagement renforce progressivement l'association entre séparation et danger, ainsi que le recours automatique à la conservation.

Stabilisation corporelle de la peur de perdre

À force de répétition, les situations de tri et de séparation sont de plus en plus rapidement associées à une réaction corporelle d'alarme. L'organisme associe progressivement :

- le fait de jeter à une perte menaçante
- l'irréversibilité à un risque difficilement supportable
- la conservation à une diminution de la tension
- la présence des objets à une forme de sécurité.

La réponse d'accumulation ne dépend donc plus seulement d'un raisonnement explicite sur l'utilité des objets. Elle se stabilise dans des habitudes corporelles et pratiques : conserver devient la réponse la plus immédiatement disponible lorsque l'angoisse apparaît.

Saillance attentionnelle des objets

Les objets conservent une forte capacité à attirer et à retenir l'attention.

Un journal, un livre ou un magazine n'apparaît pas comme un élément banal. Il active immédiatement :

- la possibilité d'une information importante
- l'idée d'un usage futur
- le risque d'un regret
- la crainte de jeter quelque chose d'irremplaçable.

L'attention reste ainsi fixée sur ce que l'objet pourrait encore contenir ou permettre. Cette saillance rend difficile le désengagement attentionnel nécessaire au tri.

L'objet ne peut pas être simplement écarté comme sans importance : il reste présent dans l'attention jusqu'à ce qu'il soit conservé.

Transformation corporelle et pratique de l'espace

L'espace domestique se réorganise progressivement autour des objets accumulés. M. Wolfe adapte :

- ses déplacements
- ses gestes quotidiens
- son accès aux pièces
- sa manière de dormir
- ses possibilités de repos
- et finalement son lieu de vie.

À mesure que l'accumulation augmente, les passages se rétrécissent, certaines fonctions des pièces disparaissent et le corps doit contourner les amas ou renoncer à circuler.

L'espace n'est donc pas seulement encombré matériellement. Il est vécu et pratiqué selon les contraintes imposées par les objets. L'accumulation modifie simultanément les possibilités corporelles, les habitudes et l'usage du logement.

Boucle de stabilisation

La dynamique générale peut être formulée ainsi :
objet rencontré

- > activation de son utilité ou de sa valeur possible
- > anticipation de la perte ou du regret
- > montée de l'angoisse et de la tension corporelle
- > conservation, récupération ou évitement du tri
- > soulagement temporaire
- > renforcement de la saillance de l'objet et de la peur de jeter.

À mesure que cette boucle se répète, les objets deviennent plus difficiles à abandonner, tandis que l'espace disponible et les possibilités d'action diminuent.

Formulation neuro-phénoménologique

Les difficultés de M. Wolfe s'inscrivent dans une dynamique incarnée associant forte saillance des objets, anticipation corporelle de la perte, montée d'angoisse et soulagement par la conservation.

Les conduites de conservation, de récupération et d'évitement du tri diminuent temporairement l'activation, mais renforcent progressivement l'association entre abandon et danger. Cette boucle transforme les habitudes attentionnelles, corporelles et spatiales, jusqu'à organiser les déplacements, le sommeil et l'usage du logement autour de l'accumulation.

5.8. Psychopathologie différentielle

La situation de M. Wolfe comprend plusieurs éléments : difficulté à jeter, accumulation importante, angoisse à l'idée de perdre un objet, croyance qu'il pourrait encore servir, envahissement du logement, conflits relationnels, difficultés professionnelles et souffrance dépressive.

Lecture psychodynamique

La question centrale est : *Que lui permet de supporter le fait de conserver ?*

Dans cette lecture, les objets protègent M. Wolfe contre la perte, la séparation et le vide. Ils peuvent devenir :

- des supports de mémoire
- des repères de continuité
- des garanties contre le manque
- des éléments de sécurité psychique.

Jeter ne signifie donc pas seulement se débarrasser d'une chose inutile. Cela peut être vécu comme une perte plus large : perte d'un souvenir, d'une possibilité, d'une partie de son histoire ou de son équilibre.

La conservation réduit temporairement cette angoisse. Elle permet de maintenir les objets à proximité et de différer la séparation.

Cette lecture comprend donc l'accumulation comme une protection contre la perte.

Lecture cognitive

La question centrale est : *Qu'est-ce qui maintient la difficulté à trier et à jeter ?*

Cette lecture met en avant :

- la surestimation de la valeur possible des objets
- l'idée qu'ils pourraient servir plus tard
- la peur du regret
- l'intolérance à l'incertitude
- la difficulté à prendre une décision définitive
- la difficulté à distinguer l'essentiel de l'accessoire.

La conservation fonctionne comme un comportement de sécurité. Elle diminue rapidement l'angoisse liée au jet.

Mais elle empêche M. Wolfe de constater :

- qu'un objet peut être jeté sans conséquence grave
- qu'une information peut être perdue
- qu'un regret éventuel peut être supporté
- que toutes les possibilités n'ont pas besoin de rester ouvertes.

Le trouble se maintient donc dans un cercle :

- objet rencontré
- > idée qu'il pourrait servir
- > peur de perdre quelque chose
- > anxiété à l'idée de jeter
- > conservation
- > soulagement temporaire
- > renforcement du besoin de garder.

Lecture anthropo-phénoménologique

La question centrale est : Comment M. Wolfe organise-t-il encore son monde lorsque presque aucun objet ne peut devenir secondaire ?

Chez lui, chaque chose reste porteuse d'une valeur possible. Un journal ancien peut encore contenir une information, un livre peut être relu, un objet peut servir plus tard.

La difficulté porte sur la capacité à :

- décider ce qui mérite de rester présent
- laisser certaines choses devenir secondaires
- accepter qu'un objet puisse ne plus servir
- abandonner une possibilité
- libérer une place.

La hiérarchie entre les objets s'efface. Ce qui est nécessaire et ce qui est accessoire deviennent presque également difficiles à jeter.

Cette difficulté se traduit directement dans l'espace. Les objets occupent les passages, le lit et les pièces. Ils ne sont plus disposés selon les besoins de M. Wolfe c'est lui qui adapte ses déplacements et son sommeil à leur présence.

Cette lecture comprend donc le trouble comme une impossibilité de limiter la présence des objets.

Lecture neuro-phénoménologique

La question centrale est : *Comment la rencontre avec un objet déclenche-t-elle une réaction de conservation de plus en plus automatique ?*

Un objet attire l'attention parce qu'il pourrait avoir une utilité ou une valeur future. L'idée de le jeter déclenche :

- une montée d'angoisse
- une tension corporelle
- la peur d'une perte définitive
- une urgence à le garder ou à le récupérer.

La conservation diminue rapidement cette activation. Ce soulagement renforce progressivement le lien entre abandon et danger.

À mesure que cette boucle se répète :

- les objets attirent davantage l'attention
- le tri devient plus anxiogène
- la conservation devient plus automatique
- les gestes et les déplacements s'adaptent à l'encombrement
- les possibilités d'action diminuent.

Cette lecture décrit donc une boucle entre objets, attention, angoisse, conservation et transformation de l'espace.

Synthèse comparative

Les quatre lectures construisent des objets différents :

- *psychodynamique* : les objets protègent contre la perte, la séparation et le vide
- *cognitive* : des croyances sur la valeur des objets et des comportements de sécurité maintiennent l'accumulation
- *anthropo-phénoménologique* : aucun objet ne devient assez secondaire pour pouvoir céder sa place
- *neuro-phénoménologique* : la conservation se stabilise dans une boucle entre attention, activation corporelle et soulagement.

Statut comparé des principaux phénomènes

La conservation

Elle peut être comprise :

- *psychodynamiquement* : comme une protection contre la perte
- *cognitivement* : comme un comportement de sécurité
- *anthropo-phénoménologiquement* : comme le maintien d'objets qui ne peuvent devenir secondaires
- *neuro-phénoménologiquement* : comme une réponse renforcée par le soulagement de l'angoisse.

L'impossibilité de jeter

Elle peut être comprise :

- *psychodynamiquement* : comme la difficulté à supporter une séparation
- *cognitivement* : comme l'effet de la peur du regret, de l'incertitude et de la surestimation de la valeur
- *anthropo-phénoménologiquement* : comme l'impossibilité de décider qu'un objet peut cesser de compter
- *neuro-phénoménologiquement* : comme une situation qui déclenche une réaction corporelle d'alarme.

L'encombrement

Il peut être compris :

- *psychodynamiquement* : comme l'effet concret d'une protection devenue envahissante
- *cognitivement* : comme le résultat répété des décisions de conserver

- *anthropo-phénoménologiquement* : comme la conséquence d'un monde où aucun objet ne peut céder sa place
- *neuro-phénoménologiquement* : comme une transformation progressive des gestes, des trajets et de l'usage de l'espace.

Ces lectures ne sont pas interchangeables. Elles convergent cependant sur la gravité de la situation : M. Wolfe ne peut plus vivre dans son appartement, ses relations et son travail sont fortement touchés, et son désespoir doit être évalué en priorité.

5.9. Hypothèses diagnostiques

Les quatre lectures ne proposent pas le même type de diagnostic.

- La lecture psychodynamique précise ce que la conservation permet de supporter.
- La lecture cognitive et syndromique identifie un trouble clinique classique.
- La lecture anthropo-phénoménologique décrit la manière dont les objets cessent de pouvoir devenir secondaires.
- La lecture neuro-phénoménologique montre comment l'angoisse et la conservation se renforcent dans le temps.

Évaluation psychodynamique

La conservation comme modalité de défense psychique

L'hypothèse principale est que la conservation des objets protège M. Wolfe contre un vécu de dépossession et d'impuissance. Jeter signifie perdre définitivement la maîtrise du destin de l'objet : il ne sera plus possible de le récupérer, d'en vérifier le contenu ou de lui découvrir ultérieurement une valeur.

La séparation risque d'être éprouvée comme une décision irréversible qui lui retire quelque chose sans possibilité de retour. En conservant l'objet, M. Wolfe maintient au contraire une position active : il décide que celui-ci reste présent et que son sort demeure en suspens.

Les objets peuvent également soutenir un sentiment de continuité personnelle. Certains constituent des traces de son histoire, des supports de souvenirs ou des repères reliant le présent au passé. Leur disparition peut alors être vécue comme l'effacement d'une partie de ce qui a été vécu, et non comme le simple abandon d'un bien devenu inutile.

La conservation remplit ainsi plusieurs fonctions défensives liées :

- éviter la passivité d'une séparation subie
- préserver la maîtrise du devenir de l'objet
- empêcher qu'une disparition devienne définitive
- maintenir des traces de l'histoire personnelle
- soutenir un sentiment de continuité malgré les pertes.

L'épisode au cours duquel ses parents jettent sa collection peut être compris comme une scène significative. En récupérant les objets, M. Wolfe reprend le contrôle face à une séparation décidée par autrui.

L'accumulation, le refus de jeter et la récupération permettent donc de différer la séparation et de réduire temporairement l'angoisse. Tant que l'objet demeure présent, la perte n'est pas entièrement accomplie et la décision peut toujours être remise à plus tard.

Cette défense produit cependant un effet paradoxal. En cherchant à éviter la dépossession et à préserver la continuité, M. Wolfe provoque progressivement d'autres pertes : conflits familiaux, rupture conjugale, éloignement de son fils, difficultés professionnelles, isolement et perte de l'usage de son logement.

Dans ce contexte, la conservation peut prendre une importance croissante. Les pertes relationnelles et professionnelles renforcent probablement le besoin de maintenir les objets à proximité, tandis que l'accumulation contribue elle-même à produire de nouvelles ruptures. La défense et ses conséquences s'entretiennent ainsi mutuellement.

Formulation psychodynamique : Les symptômes de M. Wolfe peuvent être compris comme une défense contre le vécu de dépossession, de passivité et de rupture de continuité associé à une séparation irréversible

et un mouvement dépressif. Conserver lui permet de garder la maîtrise du devenir des objets, de maintenir des traces de son histoire et de différer l'accomplissement de la perte. Cette défense réduit temporairement l'anxiété, mais contribue progressivement aux pertes relationnelles, professionnelles et résidentielles qu'elle devait précisément permettre d'éviter.

Évaluation cognitive et syndromique

Trouble d'accumulation pathologique sévère, avec insight partiellement préservé

Le tableau est fortement compatible avec un trouble d'accumulation pathologique. L'incapacité persistante à jeter, l'anxiété intense associée à la séparation, l'encombrement majeur du logement et le retentissement familial, professionnel et résidentiel soutiennent cette hypothèse.

Sur le plan cognitif, le trouble semble principalement entretenu par la valeur possible attribuée aux objets, la crainte de perdre une information ou une ressource utile, et la difficulté à prendre une décision irréversible.

La conservation et le report du tri réduisent temporairement l'anxiété, mais renforcent le besoin de garder.

M. Wolfe reconnaît le caractère irrationnel de son comportement. Son insight paraît donc partiellement préservé, sans être suffisant pour modifier ses conduites lorsque l'anxiété apparaît.

La gravité est élevée en raison de la perte de l'usage du logement, de l'isolement et des conséquences familiales et professionnelles.

Formulation cognitive et syndromique : Le tableau est compatible avec un trouble d'accumulation pathologique sévère, avec insight partiellement préservé. Il est entretenu par la surestimation de la valeur possible des objets, la difficulté à accepter une décision irréversible et le soulagement temporaire produit par la conservation.

Évaluation anthropo-phénoménologique

Persistance de la valeur possible des objets, ajournement de la séparation et saturation de l'espace

L'évaluation anthropo-phénoménologique décrit une transformation conjointe du rapport à la valeur, au temps et à l'espace.

- Sur le plan de la valeur, presque aucun objet ne devient suffisamment secondaire pour pouvoir être abandonné. Même inutilisé, il conserve une importance possible : il pourrait encore servir, contenir une information ou acquérir ultérieurement une nouvelle valeur.
- Sur le plan temporel, cette possibilité reste ouverte indéfiniment. L'objet n'est ni réellement utilisé ni définitivement écarté. Son devenir est ajourné, car le jeter supprimerait toute possibilité de revenir sur la décision.
- Sur le plan spatial, les objets ne peuvent plus céder leur place. Leur maintien progressif occupe les passages, modifie la fonction des pièces et réduit les usages possibles du logement. L'espace est de moins en moins organisé selon les activités de l'habitant et de plus en plus selon la présence des objets conservés.

La difficulté de hiérarchisation relie ces trois dimensions : M. Wolfe ne parvient plus à déterminer quelle valeur peut devenir négligeable, quelle possibilité peut être abandonnée et quel objet peut laisser place à un autre usage.

Formulation anthropo-phénoménologique : Le tableau correspond à une impossibilité de limiter la présence des objets. Chaque chose conserve une valeur future possible, ce qui ajourne indéfiniment la séparation et l'empêche de devenir secondaire. Les objets ne pouvant plus céder leur place, ils saturent progressivement l'espace et en déterminent les usages au détriment des activités de l'habitant.

Évaluation neuro-phénoménologique

Dynamique incarnée de conservation et de réorganisation de l'espace autour des objets

L'évaluation neuro-phénoménologique décrit la manière dont le trouble se stabilise dans les relations entre :

- la saillance des objets
- l'activation corporelle

- les gestes de conservation
- et l'organisation concrète de l'environnement.

Chez M. Wolfe, la rencontre avec un objet mobilise rapidement l'attention et s'accompagne d'une tension liée à la possibilité de le perdre ou de regretter sa disparition. La conservation, la récupération ou le report du tri diminuent momentanément cette activation.

Ce soulagement renforce progressivement les conduites de conservation. À mesure qu'elles se répètent, les objets attirent plus facilement l'attention, les situations de tri déclenchent plus rapidement l'anxiété et les gestes consistant à garder ou à différer deviennent plus habituels.

Cette dynamique ne concerne pas seulement l'expérience interne. Elle modifie également les conduites corporelles et l'environnement : les déplacements s'adaptent à l'encombrement, certains gestes deviennent difficiles et l'espace est progressivement réorganisé autour des objets accumulés.

La boucle entre saillance de l'objet, activation anxieuse, conservation et soulagement temporaire constitue ainsi l'un des mécanismes par lesquels cette dynamique se maintient.

Formulation neuro-phénoménologique : Le tableau évoque une dynamique incarnée dans laquelle l'attention portée aux objets, l'anxiété suscitée par leur possible disparition et les gestes de conservation se renforcent mutuellement. La répétition de ces conduites stabilise progressivement des habitudes attentionnelles et corporelles, tandis que l'espace et les possibilités d'action se réorganisent autour des objets accumulés.

Synthèse comparative des quatre évaluations

Les quatre formulations ne sont pas équivalentes :

- *Psychodynamique* : les objets sont conservés pour protéger M. Wolfe contre la perte, la séparation et le vide.
- *Cognitive et syndromique* : trouble d'accumulation pathologique sévère, avec insight partiellement préservé.
- *Anthropo-phénoménologique* : aucun objet ne devient assez secondaire pour pouvoir céder sa place.
- *Neuro-phénoménologique* : la conservation se renforce dans une boucle entre attention, activation corporelle et soulagement.

Perspectives :

- La première décrit ce que les objets permettent de supporter.
- La deuxième identifie le syndrome et ses mécanismes de maintien.
- La troisième décrit la manière dont la hiérarchie entre les objets disparaît.
- La quatrième montre comment la difficulté à jeter devient une réponse de plus en plus automatique.

Quelle que soit la lecture mobilisée, l'impossibilité de vivre dans le logement, l'isolement, les pertes professionnelles et l'idée que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue imposent une évaluation prioritaire de la dépression et du risque suicidaire.

6. Synthèse épistémologique et méthodologique

Un diagnostic gagne en précision lorsqu'il repose d'abord sur une description de l'expérience du sujet : son rapport au corps, au temps, à l'espace, aux autres, à l'action et aux objets.

La psychopathologie ne remplace pas cette description. Elle l'interroge autrement : qu'est-ce qui, dans cette manière de vivre une situation, devient rigide, coûteux, souffrant ou désorganisant ?

De la structure de vécu au problème psychopathologique

Une structure de vécu n'est pas en elle-même un trouble. Elle devient cliniquement préoccupante lorsqu'une seule manière de répondre à la difficulté s'impose, se répète malgré son coût et finit par désorganiser l'action, les relations ou la vie quotidienne.

L'analyse peut alors prendre appui sur la tension propre à chaque cas :

- besoin de certitude et relance du doute chez Marine
- engagement et possibilité immédiate de retrait chez Léo
- apparition comme sujet et fixation dans une image monstrueuse chez Chris
- conservation et abandon chez M. Wolfe.

La psychopathologie étudie ainsi la manière dont certaines organisations du vécu deviennent rigides et finissent par produire de la souffrance, de la dépendance ou de la désorganisation.

Le symptôme en contexte

On ne passe pas directement d'un symptôme à un diagnostic.

La vérification, l'évitement, le retrait, le camouflage ou l'accumulation ne prennent leur sens qu'à partir de la situation dans laquelle ils apparaissent et du modèle utilisé pour les comprendre.

La démarche clinique consiste notamment à demander :

- dans quelles situations le symptôme apparaît
- quelle fonction il remplit
- ce qu'il réduit ou évite temporairement
- quels mécanismes le maintiennent
- ce qu'il limite progressivement
- à quel moment il devient dangereux ou désorganisant.

Un même comportement peut donc recevoir plusieurs statuts. Par exemple, la vérification peut être comprise comme :

- une défense
- un comportement de sécurité
- une tentative de terminer une action
- ou un élément d'une boucle entre doute, tension et soulagement.

Les modèles psychopathologiques ne constituent pas des diagnostics concurrents. Ils construisent des objets différents à partir des mêmes faits cliniques.

Quatre niveaux de lecture

- La *lecture psychodynamique* cherche à comprendre la fonction du symptôme, l'angoisse à laquelle il répond et l'équilibre psychique qu'il contribue éventuellement à maintenir.
- La *lecture cognitive* analyse les croyances, les biais attentionnels, les interprétations, les difficultés de décision, les comportements de sécurité et les cercles qui maintiennent le trouble.
- La *lecture anthropo-phénoménologique* décrit la transformation spécifique du rapport au monde :
 - une action ne parvient pas à se stabiliser comme terminée chez Marine
 - une situation ne peut être investie que si le retrait reste immédiatement possible chez Léo
 - le visage risque de résumer toute l'identité chez Chris

- aucun objet ne devient assez secondaire pour pouvoir être abandonné chez M. Wolfe.
- La *lecture neuro-phénoménologique* montre comment le trouble se stabilise dans des boucles entre attention, perception, activation corporelle, comportement et environnement :
 - doute, vérification et épuisement chez Marine
 - sensations corporelles, alarme et contrôle chez Léo
 - visage, regard, honte et camouflage chez Chris
 - objet, angoisse, conservation et soulagement chez M. Wolfe.

Ces lectures sont complémentaires, mais elles ne se situent pas au même niveau.

Le diagnostic comme hypothèse située

Le diagnostic reste indispensable. Il permet d'évaluer la gravité, de communiquer entre professionnels, d'orienter les soins, de repérer les risques et de choisir des interventions adaptées.

Il ne constitue cependant pas une compréhension complète du cas :

- dire que Marine présente un fonctionnement obsessionnel ou anxieux ne suffit pas à comprendre comment le doute empêche une action accomplie de se stabiliser comme terminée.
- dire que Léo présente des attaques de panique et des évitements agoraphobiques ne suffit pas à comprendre pourquoi il ne peut rester engagé que si la possibilité de modifier sa position ou de partir demeure disponible.
- dire que Chris présente un trouble dysmorphique corporel sévère ne suffit pas à comprendre pourquoi il ne peut montrer son visage sans craindre d'être entièrement défini par ce qu'il donne à voir.
- dire que M. Wolfe présente un trouble d'accumulation ne suffit pas à comprendre pourquoi presque aucun objet ne devient assez secondaire pour pouvoir être écarté.

Le diagnostic doit donc être pensé comme une hypothèse située : il vient après la description du vécu et reste articulé à la structure propre du cas.

Des stratégies qui finissent par enfermer

Comprendre cliniquement signifie tenir ensemble deux aspects :

- ce qui permet temporairement au sujet de tenir
- ce qui finit par le faire souffrir.

Notamment :

- Marine vérifie et reprend pour atteindre une certitude suffisante et pouvoir considérer son action comme terminée.
- Léo contrôle son corps, l'espace et les issues pour rester présent tout en gardant une possibilité immédiate de retrait.
- Chris se cache pour pouvoir apparaître sans se sentir entièrement défini par son visage.
- M. Wolfe conserve pour ne pas subir une perte qu'il vit comme définitive.

Ces conduites ne sont donc pas simplement absurdes. Elles ont une fonction. Mais leur coût augmente lorsqu'elles deviennent la seule manière disponible de faire face à la situation :

- chez Marine, les actions ne se terminent plus et la pensée s'épuise.
- chez Léo, les déplacements et les relations dépendent du contrôle et de la possibilité de partir.
- chez Chris, la présence sociale devient dépendante du camouflage et du retrait.
- chez M. Wolfe, les objets ne peuvent plus être hiérarchisés et finissent par déterminer l'organisation de l'espace.

Une solution initialement protectrice finit ainsi par produire le problème qu'elle cherchait à éviter :

- la recherche de certitude entretient le doute
- le contrôle entretient l'anticipation du danger
- le camouflage confirme que le visage ne peut être montré

- la conservation destinée à éviter la perte produit des pertes concrètes.

La psychopathologie apparaît lorsque les stratégies qui permettent temporairement de tenir deviennent rigides et produisent à leur tour de la souffrance, de la dépendance ou de la désorganisation.

Conclusion

La méthode peut être résumée ainsi :

- décrire avant de diagnostiquer
- repérer la structure propre du vécu
- comprendre la fonction et le coût des conduites
- comparer ce que chaque modèle construit comme objet psychopathologique
- distinguer le diagnostic syndromique des formulations psychodynamiques, anthropo-phénoménologiques et neuro-phénoménologiques
- évaluer le retentissement, la gravité et les risques.

Comprendre un cas ne consiste donc pas seulement à nommer un trouble. Il s'agit de montrer comment une manière de faire face devient progressivement la source même de l'empêchement.

7. Prolongement clinique : de l'entretien à la formulation du cas

L'analyse phénoménologique et existentielle peut orienter :

- la conduite de l'entretien
- la formulation du cas
- la discussion psychopathologique
- les hypothèses de prise en charge
- l'articulation avec la sémiologie psychiatrique classique.

Elle ne remplace pas le diagnostic. Elle permet de mieux comprendre comment les symptômes s'organisent dans l'expérience du sujet et pourquoi certaines conduites persistent malgré leurs conséquences.

Conduire l'entretien : explorer une expérience située

Dans un entretien clinique, il ne suffit pas de recueillir une liste de symptômes. Il faut également comprendre comment la personne vit ce qui lui arrive.

On ne demande donc pas (seulement) :

- avez-vous des attaques de panique ?
- avez-vous des pensées obsessionnelles ?
- évitez-vous certaines situations ?
- depuis quand êtes-vous déprimé ?

Il est utile de demander :

- comment cela commence-t-il pour vous ?
- que se passe-t-il dans votre corps ?
- qu'est-ce qui devient difficile à supporter ?
- que craignez-vous à ce moment-là ?
- que faites-vous pour vous rassurer ou vous protéger ?
- qu'est-ce qui vous permet de rester dans la situation ?
- qu'est-ce qui devient impossible ?
- que se passe-t-il ensuite ?
- comment les autres interviennent-ils dans cette expérience ? Etc.

L'objectif n'est pas d'abandonner la sémiologie, mais d'ajouter une question essentielle :

Comment ce symptôme est-il vécu dans une situation précise ?

Écouter les mots du patient

Certains mots employés par le patient donnent directement accès à son expérience. Ils ne doivent pas être pris comme de simples illustrations ni interprétés trop rapidement.

- Marine dit qu'elle « tourne en rond dans sa tête », qu'elle a besoin de vérifier et qu'elle voudrait retrouver de la légèreté.
- Léo parle d'une « montée interne », de la peur de ne plus pouvoir tenir debout et d'un espace qui se rétrécit.
- Chris dit qu'il ressemble à un « monstre » et que son visage est impossible à montrer.
- M. Wolfe explique qu'il ne peut pas jeter un objet parce qu'il pourrait contenir « quelque chose d'intéressant ».

Le clinicien peut reprendre ces expressions pour demander des précisions :

- quand vous dites que vous tournez en rond, à quel moment la pensée devrait-elle normalement s'arrêter ?
- quand vous dites que l'espace se rétrécit, qu'est-ce qui change autour de vous ?
- quand vous dites que votre visage est impossible à montrer, que craignez-vous que l'autre voie ?

- quand vous dites que cet objet pourrait contenir quelque chose d'intéressant, que risqueriez-vous de perdre en le jetant ?

Il s'agit d'aider le patient à décrire son expérience sans confirmer automatiquement ses croyances et sans les contredire trop vite.

Décrire des situations plutôt que des généralités

Une difficulté fréquente consiste à rester à un niveau trop général. Le patient peut dire :

- je suis anxieux
- je doute tout le temps
- je ne supporte pas le regard des autres
- je n'arrive pas à jeter
- je suis épuisé. Etc.

Ces formulations sont importantes, mais elles ne montrent pas encore comment la difficulté se déroule.

Le clinicien peut demander une situation récente :

- où étiez-vous ?
- avec qui ?
- que faisiez-vous juste avant ?
- qu'est-ce qui a attiré votre attention ?
- qu'avez-vous ressenti dans votre corps ?
- qu'avez-vous pensé qu'il allait se passer ?
- qu'avez-vous fait pour vous protéger ?
- quel soulagement avez-vous obtenu ?
- quelles ont été les conséquences ? Etc.

La situation concrète permet de repérer une dynamique :

- Chez Marine, l'envoi d'un courriel ou la fin d'un dossier permet d'observer comment le doute entraîne une nouvelle vérification et empêche l'action de se stabiliser comme terminée.
- Chez Léo, un trajet ou une réunion permet de comprendre qu'il peut rester engagé tant qu'il garde la possibilité de modifier sa position, de contrôler son corps ou de partir.
- Chez Chris, la scène du miroir, de la lumière ou du regard d'autrui permet de comprendre comment un détail du visage finit par définir toute son identité.
- Chez M. Wolfe, la décision de jeter un journal permet d'observer comment un objet apparemment secondaire reste chargé d'une valeur possible et devient impossible à abandonner.

Formuler un cas : du diagnostic à la logique clinique

La formulation de cas consiste à organiser les informations cliniques de manière intelligible.

Une formulation limitée à une liste diagnostique peut être utile :

- fonctionnement obsessionnel, anxiété et épuisement
- attaques de panique et évitements agoraphobiques
- trouble dysmorphique corporel et risque suicidaire
- trouble d'accumulation et souffrance dépressive.

Elle ne montre cependant pas encore comment les phénomènes s'articulent.

Une formulation clinique cherche à répondre à plusieurs questions :

- quel phénomène organise principalement l'expérience ?
- dans quelles situations apparaît-il ?
- quelle réponse le sujet met-il en place ?
- que lui permet cette réponse ?
- que finit-elle par limiter ?

- quels facteurs entretiennent le trouble ?
- quels risques et quel retentissement faut-il évaluer ? Etc.

Lorsque plusieurs modèles psychopathologiques sont mobilisés, la formulation doit préciser le niveau de lecture :

- la fonction défensive du symptôme
- les croyances et les mécanismes qui le maintiennent
- la transformation précise du rapport au monde
- les boucles entre attention, corps, comportement et environnement.

Formulations cliniques

Chez Marine, l'expérience est organisée par le besoin de vérifier pour pouvoir considérer une action comme terminée. La vérification réduit momentanément le doute, mais relance la recherche de certitude et épuise la pensée.

Chez Léo, l'engagement dans une situation reste possible tant qu'une possibilité immédiate de retrait demeure disponible. Le contrôle du corps, de l'espace et des issues lui permet de rester présent, mais entretient l'anticipation du danger.

Chez Chris, le visage semble révéler toute la vérité de son identité. Le camouflage réduit momentanément la honte et lui permet parfois d'apparaître, mais confirme progressivement que son visage propre ne pourrait pas être montré.

Chez M. Wolfe, presque aucun objet ne devient assez secondaire pour pouvoir être abandonné. La conservation réduit l'angoisse de perte, mais empêche toute hiérarchie entre les choses et conduit à leur accumulation.

Ces formulations n'excluent pas le diagnostic. Elles montrent la logique clinique qui relie les symptômes entre eux.

Construire une formulation de cas

Une formulation peut être organisée autour de quelques éléments simples.

La demande actuelle

Il faut d'abord préciser :

- pourquoi la personne consulte maintenant
- ce qui a changé récemment
- ce qui n'est plus supportable
- qui demande de l'aide
- quel événement a déclenché la consultation
- quels risques imposent une réponse rapide.

Les phénomènes centraux

Il faut ensuite repérer les éléments qui structurent l'expérience, sans multiplier les symptômes secondaires :

- chez Marine : doute, vérification, reprise mentale et difficulté à terminer.
- chez Léo : montée corporelle, anticipation du danger, contrôle et nécessité de pouvoir partir.
- chez Chris : honte, miroir, visibilité du visage et sentiment d'être réduit à son apparence.
- chez M. Wolfe : valeur possible des objets, peur de jeter, absence de hiérarchie et accumulation.

La réponse du sujet

La formulation doit montrer ce que le sujet fait pour tenir :

- Marine vérifie et reprend
- Léo contrôle et évite
- Chris se cache et se rassure
- M. Wolfe conserve et reporte le tri.

Ces réponses ont un effet protecteur immédiat, mais elles participent aussi au maintien du trouble.

Le coût et les risques

Il faut enfin préciser ce que ces conduites désorganisent :

- l'action et la pensée
- les déplacements
- les relations
- le travail
- le logement
- la santé physique
- la sécurité
- la possibilité de demander de l'aide...

La formulation doit toujours intégrer la gravité du tableau et les risques suicidaires lorsqu'ils sont présents.

Orienter les hypothèses de prise en charge

La formulation de cas ne constitue pas un programme thérapeutique. Elle aide à déterminer ce qui doit être travaillé et avec quelles précautions :

- chez Marine, il ne s'agit pas seulement de supprimer les vérifications, mais de travailler la possibilité de considérer une action comme suffisamment accomplie malgré une part d'incertitude.
- chez Léo, demander simplement l'arrêt des évitements ne suffit pas. Il faut travailler la possibilité de rester dans une situation sans devoir contrôler en permanence le corps, les issues ou la possibilité de partir.
- chez Chris, le camouflage et le retrait protègent contre une honte massive. Leur réduction doit tenir compte de cette fonction et s'accompagner d'une évaluation stricte du risque suicidaire.
- chez M. Wolfe, jeter n'est pas un simple acte de rangement. Le tri doit être progressif et tenir compte de l'angoisse liée à l'abandon, des risques matériels de l'encombrement et du besoin de soutien concret.

L'objectif clinique dépend donc du mécanisme propre à chaque cas :

- terminer sans devoir reprendre
- rester sans devoir préparer constamment le retrait
- apparaître sans être entièrement réduit à son image
- laisser certains objets devenir assez secondaires pour être abandonnés.

Une posture clinique

L'analyse phénoménologique invite à ne pas répondre trop vite par la correction, l'explication ou la réassurance.

- dire à Léo qu'il ne risque rien ne suffit pas à modifier la manière dont son corps et l'espace deviennent menaçants.
- dire à Marine qu'elle réfléchit trop ne tient pas compte du rôle de la vérification dans sa recherche de certitude.
- dire à Chris que son visage est normal ne transforme pas nécessairement ce qu'il voit dans le miroir.
- dire à M. Wolfe qu'il suffit de jeter ne tient pas compte de la perte qu'il associe à l'abandon de l'objet.

La posture clinique consiste à comprendre la logique du vécu sans confirmer naïvement les croyances du patient et sans les rejeter brutalement.

Elle doit tenir ensemble deux exigences :

- décrire ne signifie pas retarder indéfiniment le diagnostic
- diagnostiquer ne signifie pas réduire le sujet à une catégorie.

Conclusion

La méthode peut être résumée ainsi :

- décrire avant d'expliquer
- partir de situations concrètes
- écouter les mots du patient
- relier les symptômes à une organisation du vécu
- comprendre la fonction et le coût des conduites
- différencier les niveaux de lecture psychopathologique
- distinguer le diagnostic de la formulation clinique
- évaluer la gravité, le retentissement et les risques.

La formulation de cas cherche ainsi à comprendre comment le sujet fait face à sa difficulté, comment cette réponse devient progressivement coûteuse et quelles transformations peuvent être envisagées. Elle maintient la singularité du patient tout en organisant avec précision les phénomènes cliniques.

Annexes

Bibliographie

- Binswanger, L. (1971). *Introduction à l'analyse existentielle*. Paris : Éditions de Minuit.
- Binswanger, L. (2016). *Phénoménologie, psychologie, psychiatrie*. Paris : Vrin.
- Depraz, N. (2006). *Comprendre la phénoménologie : Une pratique concrète*. Paris : Armand Colin.
- Depraz, N., Varela, F., & Vermersch, P. (2011). *À l'épreuve de l'expérience : Pour une pratique phénoménologique*. Bucarest : Zeta Books.
- Fuchs, T. (2026). *L'écologie du cerveau. Phénoménologie et biologie de la cognition incarnée* (É. Boulil, trad.). Bucarest : Zeta Books.
- Giorgi, A. (2009). *The descriptive phenomenological method in psychology : A modified Husserlian approach*. Pittsburgh, PA : Duquesne University Press.
- Jaspers, K. (2000). *Psychopathologie générale*. Paris : Bibliothèque des Introuvables.
- Merleau-Ponty, M. (1945). *Phénoménologie de la perception*. Paris : Gallimard.
- Minkowski, E. (1933). *Le temps vécu. Études phénoménologiques et psychopathologiques*. Paris : D'Artrey.
- Stanghellini, G., Broome, M. R., Fernandez, A. V., Fusar-Poli, P., Raballo, A., & Rosfort, R. (dir.). (2018). *The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology*. Oxford : Oxford University Press.
- Van Manen, M. (1990). *Researching Lived Experience : Human Science for an Action Sensitive Pedagogy*. Albany : SUNY Press (2e éd., 2015, Left Coast Press).
- Van Manen, M. (2014). *Phenomenology of Practice : Meaning-Giving Methods in Phenomenological Research and Writing*. Walnut Creek : Left Coast Press (2e éd., 2023, Routledge).
- Van Manen, M. (2017). *Phenomenology in Its Original Sense*. *Qualitative Health Research*, 27(6), 810-825.
- Vermersch, P. (2012). *Explicitation et phénoménologie*. Paris : Presses Universitaires de France.
- Waldenfels, B. (2004). *Introduction à la phénoménologie* (P. Cabestan, trad.). Paris : Éditions du Cerf.

Glossaire

Altérité (rapport à l'autre) : Manière dont l'autre est vécu : présence, distance, menace, soutien, reconnaissance. Elle inclut la façon dont la relation affecte la continuité du soi.

Analyse phénoménologique : Démarche visant à décrire l'expérience telle qu'elle se donne au sujet, avant de mobiliser des explications causales ou des catégories diagnostiques. Elle cherche à préciser comment une situation est vécue dans le rapport au corps, au temps, à l'espace, aux autres et au monde.

Cohérence interne : Logique propre à l'expérience du sujet, indépendamment de sa conformité à une norme ou à un modèle théorique. Une structure de vécu peut être cohérente tout en étant source de souffrance.

Compréhension clinique : Forme de savoir clinique qui vise à rendre intelligible la logique du vécu du sujet, sans la réduire à une cause, un diagnostic ou une interprétation théorique unique.

Continuité / Discontinuité : Modalités selon lesquelles l'expérience se maintient ou se fragmente dans le temps. La continuité n'implique pas l'absence de souffrance, mais la possibilité de relier les moments du vécu.

Corporéité vécue : Manière dont le sujet éprouve son corps de l'intérieur, comme support de perception, d'action et de relation. Le corps vécu se distingue du corps observé ou représenté comme un objet, même si ces deux dimensions peuvent se modifier mutuellement.

Corps vécu / corps vu : Le corps vécu est le corps à partir duquel le sujet agit et perçoit sans devoir constamment l'observer. Le corps vu est le corps pris comme objet du regard, de l'évaluation ou de la représentation.

Désaccordage : Perte de synchronie entre le sujet, son corps, le temps ou le monde. Le désaccordage peut être partiel, progressif et non spectaculaire.

Description phénoménologique : Travail de mise en mots rigoureuse de l'expérience vécue, appuyée sur le texte ou le discours du sujet, attentive aux modalités (rythme, intensité, continuité, étrangeté) plutôt qu'aux causes ou aux explications.

Diagnostic (au sens clinique) : Catégorie clinique visant à identifier un trouble à partir de critères définis. Dans une démarche phénoménologique, le diagnostic n'est pas refusé, mais distingué du travail descriptif et articulé à la singularité du cas.

Dimensions du vécu : Axes fondamentaux selon lesquels l'expérience peut être décrite et organisée : temporalité, spatialité, corporéité, ipséité, altérité, mondanéité. Ces dimensions ne sont pas des catégories séparées, mais des points d'entrée analytiques.

Épochè (suspension) : Suspension provisoire des jugements théoriques, explicatifs ou diagnostiques afin d'examiner plus précisément la manière dont l'expérience apparaît au sujet. Elle ne supprime pas les exigences de diagnostic, de sécurité ou de prise en charge.

Être-au-monde : Manière globale dont un sujet existe dans le monde, en relation avec le temps, l'espace, le corps, les autres et lui-même. Il ne s'agit pas d'un contenu psychique, mais d'une forme d'existence.

Expérience vécue : Ensemble des manières dont une situation est ressentie, perçue, comprise et habitée par le sujet. L'expérience vécue ne se réduit ni aux comportements observables ni aux contenus verbaux isolés.

Fonction existentielle du lien : Rôle que joue la relation à l'autre dans le maintien de l'existence du sujet (sécurisation, régulation affective, support identitaire).

Herméneutique : Travail d'interprétation qui cherche à dégager le sens et l'organisation d'une expérience à partir de sa description, de son contexte et du discours du sujet. Elle intervient après ou au sein du travail descriptif, sans se réduire à une explication causale.

Ipséité (rapport à soi/tenue de soi) : Expérience d'être soi et de vivre ses pensées, ses perceptions et ses actes comme les siens. Elle concerne le sentiment de présence à soi, avant même la représentation réfléchie ou narrative de son identité.

Monde commun : Ensemble des significations, usages et évidences pratiques partagés avec autrui. Il permet de reconnaître, par exemple, ce qui est pertinent, secondaire, utilisable ou abandonnable dans une situation donnée.

Mondanéité (rapport au monde) : Manière dont le monde apparaît comme familier, habitable, menaçant, vide ou porteur de sens. Elle concerne l'évidence du monde et la possibilité d'y prendre place.

Organisation existentielle : Manière relativement stable dont un sujet organise son rapport au corps, au temps, à l'espace, aux autres, à l'action et aux objets. Elle comprend les tensions qui reviennent, les réponses habituellement mobilisées et les conditions dont le sujet dépend pour maintenir un équilibre supportable. Elle ne désigne pas une personnalité figée ni une cause cachée, mais une manière récurrente de faire face aux situations.

Pathologisation : Attribution trop rapide ou insuffisamment justifiée d'un caractère pathologique à une expérience, un comportement ou une différence, sans prise en compte suffisante de son contexte, de sa fonction et de son retentissement.

Polarité : Couple de pôles opposés mais indissociables, entre lesquels l'expérience du sujet oscille. La polarité exprime un mouvement, non une alternative figée.

Posture clinique : Manière dont le clinicien se situe dans la relation : rythme, présence, distance, cadre. Elle découle de la compréhension du vécu, et non d'un protocole standardisé.

Régulation existentielle : Manière dont le sujet tente de maintenir un équilibre viable dans son existence (par la relation, le retrait, le contrôle, la coupure, etc.). Les comportements sont compris comme des tentatives de régulation, non comme des symptômes isolés.

Spatialité vécue : Manière dont l'espace est éprouvé et pratiqué : ouvert ou resserré, accessible ou menaçant, traversable ou bloqué, permettant ou non la proximité, le retrait et l'action.

Structure de vécu : Organisation d'ensemble d'une expérience clinique telle qu'elle apparaît dans une situation ou un cas précis. Elle relie les phénomènes observés, les dimensions du vécu, la tension centrale et les réponses du sujet, afin de montrer comment ces éléments prennent sens les uns par rapport aux autres. (La structure de vécu correspond à la configuration clinique que l'on décrit à partir d'une situation donnée. L'organisation existentielle désigne la manière plus générale et plus durable dont cette configuration tend à se répéter dans différents domaines de l'existence. On peut ainsi repérer chez Marine une structure de vécu particulière lors de l'envoi d'un courriel : doute, vérification, soulagement bref et reprise. Lorsque cette même logique apparaît dans le travail, les décisions, les paroles et les relations, elle peut être décrite comme une organisation existentielle centrée sur la recherche de certitude et la difficulté à considérer une action comme terminée).

Temporalité vécue : Manière dont le temps est éprouvé : continu ou discontinu, accéléré ou ralenti, orienté ou figé. La temporalité vécue ne se confond pas avec le temps chronologique objectif.

Tension existentielle : Polarité dynamique Rapport dynamique entre des exigences ou deux orientations difficiles à concilier, qui organise plusieurs dimensions de l'expérience. Elle ne constitue ni un symptôme ni une simple opposition entre deux choix (ex. proximité / éloignement, intensité / effondrement) qui organise l'expérience du sujet à travers plusieurs dimensions du vécu. Une tension n'est ni un thème ni un symptôme, mais une dynamique structurante.

Psychopathologie neuro-phénoménologique et cognition incarnée

1. Idée générale

La psychopathologie neuro-phénoménologique cherche à articuler :

- le vécu subjectif
- le corps vécu
- les dynamiques cérébrales
- les émotions
- l'environnement
- les interactions avec autrui.

Elle cherche à dépasser deux réductions :

- le « neurocentrisme », qui considère le trouble comme un simple dysfonctionnement cérébral
- une conception du psychisme séparée du corps, du monde et des relations.

Le sujet est ainsi pensé comme un être *incarné, situé et relationnel*.

Le cerveau n'est pas envisagé comme un centre isolé produisant à lui seul l'expérience psychique : il participe à des dynamiques qui associent le corps, l'environnement, les habitudes, l'histoire vécue et les relations.

2. Origines théoriques

Cette approche se situe au croisement de plusieurs courants :

Courant	Auteurs principaux
Phénoménologie	Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty
Psychopathologie phénoménologique	Binswanger, Minkowski, Straus
Cognition incarnée et énaactive	Varela, Thompson, Rosch, Noë
Neurophénoménologie	Francisco Varela
Approches contemporaines de l'incarnation	Thomas Fuchs, Shaun Gallagher
Neurosciences affectives et corporelles	Antonio Damasio
Esprit étendu	Clark et Chalmers

Ces courants ne forment pas une doctrine unique. Ils partagent toutefois l'idée que la cognition ne peut pas être comprise indépendamment du corps et de l'environnement.

3. La cognition est incarnée

Le cognitivisme classique a souvent décrit la cognition comme un traitement interne de l'information réalisé par le cerveau.

Les approches incarnées soutiennent au contraire que penser dépend :

- du corps
- de la perception
- de l'action
- des émotions
- du contexte
- des interactions avec l'environnement.

Les approches dites « 4E » regroupent plusieurs thèses proches, mais distinctes :

- incarnée (*embodied*) : la cognition dépend des capacités et des états corporels ;
- située (*embedded*) : elle se déroule dans un environnement qui participe à l'activité ;
- énaactive (*enactive*) : la perception et le sens émergent du couplage entre l'organisme et son milieu ;
- étendue (*extended*) : certaines activités cognitives peuvent s'appuyer sur des éléments extérieurs, comme les outils, les notes ou les technologies.

Ces positions ne sont pas toujours défendues ensemble.

L'autopoïèse, développée par Maturana et Varela, désigne la capacité du vivant à maintenir et à renouveler sa propre organisation. Dans l'approche éactive, la cognition est liée à cette activité autonome de l'organisme dans son milieu.

Thomas Fuchs propose une conception écologique et incarnée du cerveau. Celui-ci est intégré :

- au corps
- au monde
- aux relations
- aux habitudes
- à l'histoire vécue.

Le cerveau participe donc à une boucle dynamique entre organisme et environnement plutôt qu'à une causalité allant uniquement du cerveau vers le comportement.

4. Concepts fondamentaux

Le corps vécu

La phénoménologie distingue :

- le corps biologique ou objectivé, parfois désigné par le terme allemand *Körper*
- le corps vécu, ou *Leib*.

Le corps vécu est le corps à partir duquel nous percevons, agissons et entrons en relation. Il constitue notre point d'ancrage dans le monde.

Dans certains troubles, le corps peut devenir :

- étranger
- anormalement présent
- difficile à contrôler
- objet de surveillance
- source d'inquiétude ou de honte.

Hyperréflexivité

L'hyperréflexivité désigne une attention excessive portée à des processus corporels ou mentaux normalement vécus de manière implicite.

Elle a été particulièrement développée par Louis Sass dans l'étude de la schizophrénie, mais elle peut aussi servir, avec prudence, à décrire certaines formes d'autosurveillance. Elle peut concerner :

- le visage
- le rythme cardiaque
- la respiration
- les pensées
- les gestes
- les sensations corporelles.

Le corps, habituellement vécu comme support de l'action, devient alors anormalement présent comme objet d'attention.

Boucles perception–affect–action

L'expérience psychique peut être comprise comme une dynamique circulaire entre :

- perception
- activation corporelle
- affect
- interprétation

- action
- environnement.

Ces éléments se modifient mutuellement. Il n'existe pas toujours un point de départ unique.

Dans le trouble panique, par exemple :

- sensation corporelle
 - > attention accrue portée au corps
 - > montée de peur
 - > augmentation de l'activation corporelle
 - > évitement ou recherche de sécurité
 - > soulagement temporaire
 - > renforcement de la peur future.

Cette boucle ne constitue pas une simple suite linéaire. L'attention, les sensations, les émotions et l'action se renforcent réciproquement.

Intercorporéité

Le rapport à autrui passe par :

- les regards
- les postures
- les gestes
- les rythmes
- la voix
- + les affects.

L'intercorporéité désigne cette dimension corporelle et souvent pré-réflexive de la relation.

Dans certains troubles, la présence d'autrui peut devenir :

- envahissante
- menaçante
- difficile à interpréter
- désorganisatrice.

La relation ne se réduit donc pas à une représentation mentale de l'autre. Elle implique une régulation corporelle réciproque.

Mémoire corporelle

Les expériences répétées stabilisent des habitudes :

- motrices
- émotionnelles
- relationnelles
- attentionnelles
- posturales.

La mémoire corporelle ne désigne pas seulement un souvenir stocké puis récupéré. Elle apparaît dans :

- la manière de se tenir
- de réagir
- de percevoir une situation
- ou d'anticiper un danger.

Certaines expériences peuvent ainsi se réactiver sous forme de réponses corporelles et affectives avant même qu'un souvenir explicite ne soit formulé.

On peut distinguer plusieurs formes de mémoire corporelle :

Type	Description
Mémoire habituelle	Gestes automatisés et savoir-faire
Mémoire situationnelle	Reconnaissance corporelle implicite d'une situation
Mémoire intercorporelle	Manières habituelles d'entrer en relation
Mémoire de la douleur	Réactivation de douleurs ou d'hypersensibilités
Mémoire traumatique	Réponses corporelles et affectives liées à une expérience passée

5. Vision psychopathologique

Dans cette perspective, la psychopathologie étudie des modifications durables :

- du rapport au corps
- du rapport au monde
- du rapport à autrui
- des habitudes perceptives et motrices
- des dynamiques entre organisme et environnement.

Le symptôme n'est pas seulement un signe isolé ni le produit d'un mécanisme cérébral unique.

Certains symptômes peuvent être compris comme des réponses qui réduisent temporairement une instabilité corporelle, affective ou relationnelle, tout en contribuant parfois à maintenir le trouble.

La prise en charge peut alors chercher à agir sur plusieurs niveaux :

- biologique
- corporel
- attentionnel
- émotionnel
- relationnel
- environnemental.

Elle ne consiste pas à opposer traitement médicamenteux et approche incarnée. Elle cherche plutôt à comprendre comment différentes interventions peuvent modifier les boucles qui entretiennent le trouble.

6. Exemples d'applications cliniques

Les formulations suivantes sont des angles de lecture possibles et non des définitions complètes des troubles.

Trouble ou situation	Angle de lecture incarné
Trouble panique	Perte de confiance dans les sensations corporelles et boucle sensation-alarme-évitement
Dysmorphophobie	Attention excessive portée au corps ou au visage, renforcée par le miroir et le regard
TOC	Boucles entre doute, tension, vérification et soulagement
Dépression	Ralentissement du corps, réduction de l'élan et diminution des interactions avec l'environnement
Psychose	Modification du sentiment de soi, de l'évidence du monde et de la relation à autrui
Trouble de l'accumulation	Boucle entre saillance des objets, angoisse de perte, conservation et soulagement

7. La notion de boucle chez Thomas Fuchs

Contre une causalité uniquement linéaire

Une conception strictement linéaire pourrait être représentée ainsi :

- stimulus extérieur
- > traitement cérébral
- > représentation mentale

> comportement.

Dans ce modèle, le cerveau risque d'être conçu comme un centre de commande, tandis que le corps et l'environnement deviennent secondaires.

Fuchs propose plutôt une causalité circulaire. Le cerveau, le corps et le monde se modifient continuellement dans des boucles de rétroaction.

Boucle sensori-motrice

La perception et l'action se construisent ensemble.

Saisir une tasse ne consiste pas seulement à exécuter un programme cérébral. La main s'ajuste à la forme, au poids et à la résistance de l'objet, tandis que ces informations modifient continuellement le mouvement.

Le schéma corporel désigne cette organisation pré-réflexive de l'action.

Dans certaines situations psychopathologiques, cette fluidité peut être perturbée :

- les gestes peuvent sembler étrangers
- le corps peut paraître lourd ou difficile à mobiliser
- l'action peut devenir excessivement contrôlée
- l'environnement peut perdre son caractère immédiatement praticable.

Boucle affectivo-corporelle

Les émotions ne sont pas seulement des états mentaux accompagnés de réactions physiques. Elles engagent simultanément :

- la posture
- la respiration
- le tonus
- les viscères
- l'attention
- la perception du monde.

Dans la dépression, par exemple, le ralentissement, la fatigue et la réduction de l'activité peuvent modifier la manière dont le monde apparaît. En retour, un environnement vécu comme vide ou sans appel peut renforcer le retrait et la lourdeur corporelle.

Boucle intercorporelle

Les relations reposent sur une coordination entre les corps :

- ajustement des postures
- rythme des échanges
- expressions faciales
- tonalité de la voix
- distance
- résonance affective.

Ces processus participent à la compréhension immédiate d'autrui.

Dans certains troubles, cette coordination devient difficile, coûteuse ou menaçante. La difficulté relationnelle ne relève alors pas uniquement d'une erreur de raisonnement, mais aussi d'une perturbation de la synchronisation corporelle et affective.

8. Boucles et stabilisation du trouble

Les boucles répétées peuvent se stabiliser sous forme d'habitudes.

Une situation déclenche une réponse corporelle et émotionnelle le sujet agit pour diminuer cette activation le soulagement renforce ensuite la même réponse.

Par exemple :

- objet perçu
- > anticipation d'une perte
- > montée d'angoisse
- > conservation
- > soulagement
- > renforcement du besoin de garder.

La plasticité cérébrale peut être comprise comme l'un des niveaux biologiques sur lesquels s'inscrivent ces expériences répétées. Elle ne constitue toutefois pas une explication suffisante à elle seule.

Le trouble engage donc plusieurs niveaux en même temps :

- cerveau
- corps
- habitudes
- attention
- relations
- environnement.

9. Différences avec d'autres modèles

Modèle	Question principale
Phénoménologie	Comment cela est-il vécu ?
Analyse existentielle	Quelle manière d'être au monde organise l'expérience ?
Psychodynamique	Quelle fonction le symptôme remplit-il et à quelle angoisse répond-il ?
Cognitif	Quelles croyances, interprétations et conduites maintiennent le trouble ?
Neuro-phénoménologique	Comment le corps, le cerveau, l'action et l'environnement participent-ils ensemble à l'expérience ?

Ces modèles ne sont pas nécessairement concurrents. Ils portent sur des niveaux différents et peuvent être articulés dans une formulation clinique.

Conclusion

La psychopathologie neuro-phénoménologique considère les troubles psychiques comme des dynamiques incarnées et situées.

Elle montre que :

- le cerveau ne fonctionne pas indépendamment du corps et du monde
- la perception, l'émotion et l'action se modifient mutuellement
- les relations ont une dimension corporelle
- les expériences répétées peuvent se stabiliser en habitudes
- certains symptômes réduisent temporairement l'angoisse tout en renforçant le trouble.

Son intérêt clinique est de décrire comment une difficulté se maintient dans des boucles entre le corps, l'attention, l'action, les relations et l'environnement, puis d'envisager des interventions à plusieurs niveaux.

Références principales

- Fuchs, T. (2005). Corporealized and disembodied minds. *Philosophy, Psychiatry & Psychology*, 12(2), 95–107.
- Fuchs, T. (2012). The phenomenology of body memory. In S. Koch et al. (dir.), *Body Memory, Metaphor and Movement*. Amsterdam : John Benjamins.
- Fuchs, T. (2018). *Ecology of the Brain : The Phenomenology and Biology of the Embodied Mind*. Oxford : Oxford University Press.
- Fuchs, T., & De Jaegher, H. (2009). Enactive intersubjectivity : Participatory sense-making and mutual incorporation. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 8, 465–486.
- Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1993). *L'inscription corporelle de l'esprit*. Paris : Seuil.

Table des matières

SOMMAIRE.....	2
INTRODUCTION.....	3
I. LA DÉMARCHE EN CLINIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE PHÉNOMÉNOLOGIQUES.....	4
Présentation.....	4
De la démarche à la méthode.....	4
Le cas de Louise : fil rouge.....	4
1. L'expérience vécue.....	4
1.1. Décrire le vécu.....	4
Principe de l'« epochè ».....	5
Ce que l'on relève dans le texte.....	5
Ce que l'on écarte provisoirement.....	5
1.2. Le cas de Louise.....	6
2. Les dimensions de l'existence.....	6
2.1. Le rapport au temps : temporalité.....	7
Le temps vécu.....	7
Indices cliniques de la temporalité.....	7
Temporalité et organisation du vécu.....	7
Tensions temporelles.....	7
Situation clinique : Louise.....	7
2.2. Le rapport à l'espace : spatialité.....	8
L'espace vécu.....	8
Indices cliniques de la spatialité.....	8
Spatialité et organisation du vécu.....	8
Tensions spatiales.....	8
Situation clinique : Louise.....	9
2.3. Le rapport au corps : corporéité.....	9
Le corps vécu.....	9
Indices cliniques de la corporéité.....	9
Corporéité et organisation du vécu.....	9
Tensions corporelles.....	10
Situation clinique (Louise).....	10
2.4. Le rapport à l'autre : altérité.....	10
L'altérité vécue.....	10
Indices cliniques de l'altérité.....	10
Altérité et organisation du vécu.....	10
Tensions relationnelles.....	11
Situation clinique : Louise.....	11
2.5. Le rapport à soi : ipséité.....	11
Le soi vécu.....	11
Indices cliniques de l'ipséité.....	11
Ipséité et organisation du vécu.....	12
Tensions du rapport à soi.....	12
Situation clinique : Louise.....	12
2.6. Le rapport au monde : mondanéité.....	12
Le monde vécu.....	12
Indices cliniques de la mondanéité.....	12
Mondanéité et organisation du vécu.....	13
Tensions globales du monde vécu.....	13
Tonalité existentielle.....	13

Situation clinique : Louise.....	13
2.7. Le cas de Louise : première synthèse clinique.....	14
Remarque méthodologique (rappel).....	14
Synthèse des descriptions existentielles (rappel).....	14
Le monde vécu.....	14
Articulations avec les existentiels.....	15
3. Les tensions structurantes.....	16
3.1. Définition.....	16
3.2. Identification.....	16
3.3. Tensions structurantes et conflits psychiques organisateurs.....	16
3.4. Exemples.....	17
Engagement / Retrait.....	17
Maîtrise / Débordement.....	18
Continuité / Menace de rupture.....	20
Protection / Exposition.....	21
Engagement / Dispersion.....	23
Appartenance / Autonomie.....	25
Intensité / Neutralisation.....	27
3.5. Le cas de Louise.....	28
Tension 1 : Engagement / Retrait.....	28
Tension 2 : Continuité / Transformation.....	29
Articulation des deux tensions.....	29
4. La structure de vécu.....	29
Travail de synthèse.....	30
Le cas de Louise.....	30
5. Résumé de la méthode d'analyse phénoménologique.....	31
II. EXEMPLES (CORPUS D'OBSERVATIONS ET D'ANALYSES).....	33
1. Observations cliniques.....	33
1.1. Observation 1.....	33
Étape 1 : repérage du vécu.....	33
Étape 2 : organisation selon les dimensions du vécu.....	33
Temporalité.....	33
Spatialité.....	33
Corporéité.....	33
Ipséité.....	33
Altérité.....	33
Mondanéité.....	34
Étape 3 : tension structurante centrale.....	34
Étape 4 : structure de vécu.....	34
1.2. Observation 2.....	35
1. Repérage du vécu.....	35
2. Organisation selon les dimensions du vécu.....	35
Altérité.....	35
Ipséité.....	35
Temporalité.....	35
Spatialité.....	35
Mondanéité.....	35
3. Tension structurante centrale.....	36
4. Structure de vécu (formulation synthétique).....	36
5. Comparaison observations 1 et 2.....	36
1.3. Observation 3.....	38
1. Repérage du vécu.....	38
2. Organisation selon les dimensions du vécu.....	38
Rapport au temps.....	38
Rapport au monde.....	38
Rapport à soi.....	38

Rapport à l'espace.....	39
Rapport aux autres.....	39
3. Tension structurante centrale.....	39
4. Structure de vécu (formulation synthétique).....	39
1.4. Observation 4.....	40
1. Repérage du vécu.....	40
2. Organisation selon les dimensions du vécu.....	40
Altérité.....	40
Ipséité.....	40
Temporalité.....	40
Spatialité.....	40
Mondanéité.....	41
3. Tension structurante centrale.....	41
4. Structure de vécu.....	41
1.5. Comparatif des observations.....	43
2. Textes narratifs.....	44
2.1. Le Horla - Guy de Maupassant (1887).....	44
1. Matériau clinique.....	45
2. Dimensions.....	46
Temporalité.....	46
Spatialité.....	46
Corporéité.....	46
Altérité.....	46
Ipséité.....	47
Mondanéité.....	47
3. Tension : vouloir / être agi.....	47
4. Structure de vécu.....	48
Commentaire clinique transversal.....	49
2.2. Le Ravisement de Lol V. Stein - Marguerite Duras (1964).....	50
1. Matériau clinique.....	50
2. Dimensions.....	50
Temporalité.....	50
Spatialité.....	50
Corporéité.....	50
Altérité.....	50
Ipséité.....	51
Mondanéité.....	51
3. Tension structurante : présence / désinscription.....	51
4. Structure de vécu.....	51
Commentaire clinique.....	52
3. Œuvres non narratives.....	53
3.1. Haïkus.....	53
Haïkus et phénoménologie.....	53
Rapport à l'espace.....	53
Rapport au temps.....	53
Rapport au soi.....	53
Rapport au monde / tonalité affective.....	54
Structure de vécu.....	54
Erreurs fréquentes à éviter.....	54
Déclinaison par niveau.....	54
« Le vieil étang » – Matsuo Bashō (1686).....	56
Étape 1 - Repérage "brut".....	56
Étape 2 - Description par dimensions du vécu.....	56
Étape 3 - Tension ou articulation structurante.....	57
Étape 4 - Formulation de la structure de vécu.....	57
« Sur la branche morte » – Matsuo Bashō (fin XVIIe).....	58
Étape 1 - Repérage "brut".....	58
Étape 2 - Description.....	58
Étape 3 - Tension structurante (articulation).....	59
Étape 4 - Structure de vécu (synthèse).....	59
« Le monde est rosée » – Kobayashi Issa (1819).....	61

Étape 1 - Repérage "brut".....	61
Étape 2 - Dimensions existentielles.....	61
Étape 3 - Tensions structurantes.....	62
Étape 4 - Structure de vécu.....	62
« La mer du printemps » – Yosa Buson (XVIII ^e).....	63
Étape 1 - Repérage "brut".....	63
Étape 2 - Dimensions.....	63
Étape 3 - Tension structurante.....	63
Étape 4 - Structure de vécu (synthèse).....	64
« Sous le ciel bleu glacé » – Mayuzumi Madoka (2014).....	64
Étape 1 - Repérage brut.....	65
Étape 2 - Description par dimensions du vécu.....	65
Étape 3 - Articulation structurante.....	66
Étape 4 - Structure de vécu.....	66
Commentaire clinique.....	66
Comparatif des cinq haïkus.....	67
Variations transversales.....	67
Point méthodologique.....	68
Point phénoménologique.....	68
Le silence comme condition de l'apparition.....	68
L'événement minimal comme révélation du réel.....	69
L'apparition du monde.....	69
Une discipline phénoménologique du regard.....	69
3.2. Poèmes.....	70
Poèmes et phénoménologie.....	70
« Melancholia » – Victor Hugo (Les Contemplations, 1856).....	70
Étape 1 - Repérage du vécu.....	70
Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu.....	71
Étape 3 - Tension structurante.....	72
Étape 4 - Structure de vécu.....	72
« Océan » – Victor Hugo (La Légende des siècles, 1859).....	72
Étape 1 - Repérage du vécu.....	73
Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu.....	73
Étape 3 - Tension structurante.....	74
Étape 4 - Structure de vécu.....	74
« Ce que dit la bouche d'ombre » – Victor Hugo (Les Contemplations, 1856).....	74
Étape 1 - Repérage du vécu.....	75
Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu.....	75
Étape 3 - Tension structurante.....	76
Étape 4 - Structure de vécu.....	76
Comparatif des trois poèmes.....	77
3.3. Images, tableaux et estampes.....	78
Images et phénoménologie : estampes, tableaux, scènes visuelles.....	78
Analyser des configurations de l'être-au-monde sans récit.....	78
Entraînement du regard en phénoménologie.....	78
Principe fondamental de l'analyse phénoménologique de l'image.....	78
Ce que toute image donne à analyser.....	79
Axes d'analyse phénoménologique.....	79
Rapport à l'espace.....	79
Rapport au temps.....	80
Rapport au corps.....	80
Rapport à l'altérité.....	81
Rapport au monde et tonalité globale.....	82
Une structure d'« être-au-monde » possible.....	82
Enjeu clinique.....	83
Katsushika Hokusai - La Grande Vague de Kanagawa.....	85
Étape 1 - Repérage du matériau phénoménal.....	85
Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu.....	85
Étape 3 - Tension structurante centrale.....	87
Étape 4 - Structure de vécu.....	88
Point méthodologique.....	88
Utagawa Hiroshige - Averse soudaine sur le pont Ōhashi.....	89
Étape 1 - Repérage du matériau phénoménal.....	89
Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu.....	90
Étape 3 - Articulation structurante centrale.....	91

Étape 4 - Structure de vécu.....	92
Point méthodologique.....	92
Andō Hiroshige - Neige à Kanbara (1834).....	93
Étape 1 - Repérage du matériau phénoménal.....	93
Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu.....	94
Étape 3 - Articulation structurante centrale.....	95
Étape 4 - Structure de vécu.....	96
Point méthodologique.....	96
Claude Monet - Nymphéas (fin des années 1890 à 1926).....	97
Étape 1 - Repérage du matériau phénoménal.....	97
Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu.....	98
Étape 3 - Articulation structurante centrale.....	99
Étape 4 - Structure de vécu.....	100
Point méthodologique.....	100
Auguste Renoir - Le Bal du moulin de la Galette (1876).....	101
Étape 1 - Repérage du matériau phénoménal.....	101
Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu.....	102
Étape 3 - Articulation structurante centrale.....	104
Étape 4 - Structure de vécu.....	104
Point méthodologique.....	105
Edgar Degas - L'Absinthe (1876).....	106
Étape 1 - Repérage du matériau phénoménal.....	106
Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu.....	107
Étape 3 - Articulation structurante centrale.....	109
Étape 4 - Structure de vécu.....	109
Point méthodologique.....	110

4. Clinique du travail.....110

4.1. Marc, éleveur bovin.....	110
Observation.....	110
Étape 1 - Repérage du matériau clinique brut.....	110
Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu.....	111
Étape 3 - Tension structurante centrale.....	113
Étape 4 - Structure de vécu.....	114
Commentaire clinique transversal.....	114
Points de vigilance.....	114
Conclusion.....	115
4.2. Caroline, maraîchère bio.....	115
Observation.....	115
Étape 1 - Repérage du matériau clinique brut.....	116
Étape 2 - Organisation selon les dimensions du vécu.....	116
Étape 3 - Tension structurante centrale.....	119
Étape 4 - Structure de vécu.....	120
Commentaire clinique transversal.....	120
Ouvertures cliniques et hypothèses possibles.....	120

III. DE LA CLINIQUE À LA PSYCHOPATHOLOGIE.....122

1. Présentation.....122

1.1. De la structure de vécu à la souffrance psychopathologique.....	122
1.2. Du signe clinique à sa fonction existentielle.....	122
1.3. Quatre lectures psychopathologiques complémentaires.....	123
1.3.1. La lecture psychanalytique.....	123
1.3.2. La lecture cognitive.....	123
1.3.3. La lecture anthropo-phénoménologique.....	123
1.3.4. La lecture neuro-phénoménologique.....	124
1.4. Progression des situations cliniques.....	124

2. Marine, 36 ans.....125

2.1. Observation.....	125
2.2. Clinique phénoménologique.....	126
2.3. Analyse existentielle.....	126

Rapport à la pensée.....	126
Rapport à l'action.....	126
Rapport au corps.....	126
Rapport au temps.....	126
Rapport à autrui.....	127
Tension structurante.....	127
Structure de vécu.....	127
Formulation existentielle.....	127
2.4. Psychopathologie psychodynamique.....	127
Angoisse centrale.....	127
Fonction des défenses.....	128
Rapport au jugement et au Surmoi.....	128
Formulation psychodynamique.....	129
2.5. Psychopathologie cognitive.....	129
Intolérance à l'incertitude.....	129
Surestimation de l'erreur.....	129
Hypervigilance cognitive.....	130
Rumination et réévaluation.....	130
Comportements de sécurité.....	130
Cercle de maintien.....	131
Retentissement fonctionnel.....	131
Formulation cognitive.....	131
2.6. Psychopathologie anthropo-phénoménologique.....	132
De l'intentionnalité opérante à la surveillance réflexive.....	132
Affaiblissement du pouvoir de l'acte.....	132
Transformation de la temporalité.....	132
Du monde de significations au monde de critères.....	133
Formulation anthropo-phénoménologique.....	133
2.7. Psychopathologie neuro-phénoménologique.....	134
Boucles pensée-corps-fatigue.....	134
Hyperréflexivité.....	134
Anticipation corporelle de l'incertitude.....	134
Réduction de la spontanéité.....	134
Formulation neuro-phénoménologique.....	135
2.8. Psychopathologie différentielle.....	135
Lecture psychodynamique.....	135
Lecture cognitive.....	135
Lecture anthropo-phénoménologique.....	135
Lecture neuro-phénoménologique.....	136
Comparaison synthétique.....	136
La vérification.....	136
La rumination.....	136
L'évitement.....	137
La demande de réassurance.....	137
2.9. Hypothèses diagnostiques.....	137
Évaluation psychodynamique.....	137
Évaluation cognitive.....	138
Évaluation anthropo-phénoménologique.....	138
Évaluation neuro-phénoménologique.....	138
Synthèse comparative.....	138
3. Léo, 27 ans.....	140
3.1. Observation.....	140
3.2. Clinique phénoménologique.....	141
3.3. Analyse existentielle.....	141
Rapport au corps.....	141
Rapport à l'espace.....	142

Rapport au temps.....	142
Rapport à autrui.....	142
Rapport à soi.....	143
Rapport au monde.....	143
Tension structurante.....	143
Structure de vécu.....	144
Formulation existentielle.....	144
3.4. Psychopathologie psychodynamique.....	145
Angoisse centrale.....	145
Fonction des défenses.....	145
Rapport au regard et à la honte.....	145
Maîtrise et lutte contre la passivité.....	146
Dimension dépressive secondaire.....	146
Formulation psychodynamique.....	146
3.5. Psychopathologie cognitive.....	146
Biais attentionnels et hypervigilance.....	146
Interprétations catastrophiques.....	147
Comportements de sécurité.....	147
Cercle anxieux auto-entretenu.....	147
Estime de soi et peur de l'évaluation.....	148
Formulation cognitive.....	148
3.6. Psychopathologie anthropo-phénoménologique.....	148
Du corps propre au corps surveillé.....	148
Fragilisation du « je peux ».....	148
Spatialité de l'échappée.....	149
Temporalité de l'imminence.....	149
Regard d'autrui et visibilité du corps.....	150
Restriction du champ des possibles.....	150
Formulation anthropo-phénoménologique.....	150
3.7. Psychopathologie neuro-phénoménologique.....	150
Boucles corps-espace-peur.....	150
Corps d'alerte.....	151
Spatialité incarnée.....	151
Mémoire corporelle de l'exposition.....	152
Hyperréflexivité corporelle et désautomatisation.....	152
Intercorporéité et regard.....	152
Formulation neuro-phénoménologique.....	152
3.8. Psychopathologie différentielle.....	153
Lecture psychodynamique.....	153
Lecture cognitive.....	153
Lecture anthropo-phénoménologique.....	153
Lecture neuro-phénoménologique.....	154
Synthèse comparative.....	154
L'évitement.....	154
Le repérage des issues.....	154
La surveillance du corps.....	155
3.9. Hypothèses diagnostiques.....	155
Évaluation diagnostique psychodynamique.....	155
Évaluation diagnostique cognitive et syndromique.....	156
Évaluation diagnostique anthropo-phénoménologique.....	156
Évaluation diagnostique neuro-phénoménologique.....	157
Synthèse comparative des quatre évaluations.....	159
4. Chris, 31 ans.....	160
4.1. Observation.....	160
4.2. Clinique phénoménologique.....	160
4.3. Analyse existentielle.....	160

Rapport au temps.....	160
Rapport à l'espace.....	161
Rapport au corps.....	161
Rapport à autrui.....	161
Rapport à soi.....	162
Tension structurante.....	162
Structure de vécu.....	163
Formulation existentielle.....	163
4.4. Psychopathologie psychodynamique.....	163
Angoisse centrale.....	163
Fonction des défenses.....	163
Rapport au miroir et au regard.....	163
Dépendance à la réassurance.....	164
Dimension dépressive et suicidaire.....	164
Formulation psychodynamique.....	164
4.5. Psychopathologie cognitive.....	164
Hyperfocalisation attentionnelle sur le visage.....	164
Distorsions cognitives et croyances dysfonctionnelles.....	164
Insight fluctuant.....	165
Comportements de sécurité.....	165
Cercle de maintien.....	165
Formulation cognitive.....	165
4.6. Psychopathologie anthropo-phénoménologique.....	165
Du visage expressif au visage objectivé.....	166
Du détail visible à l'identité dévoilée.....	166
Une spatialité organisée selon un gradient de visibilité.....	167
Le masque comme médiation paradoxale.....	167
Temporalité de la fixation spéculaire.....	167
Formulation anthropo-phénoménologique.....	167
4.7. Psychopathologie neuro-phénoménologique.....	168
Boucles visage-regard-angoisse.....	168
Hyperréflexivité corporelle.....	168
Mémoire corporelle de l'exposition.....	168
Intercorporéité et regard.....	169
Boucle de stabilisation.....	169
Formulation neuro-phénoménologique.....	169
4.8. Psychopathologie différentielle.....	169
Lecture psychodynamique.....	169
Lecture cognitive.....	170
Lecture anthropo-phénoménologique.....	170
Lecture neuro-phénoménologique.....	171
Synthèse comparative.....	171
Statut comparé des principaux phénomènes.....	171
Le camouflage.....	171
Le miroir.....	172
Le regard d'autrui.....	172
4.9. Hypothèses diagnostiques.....	172
Évaluation diagnostique psychodynamique.....	172
Évaluation diagnostique cognitive et syndromique.....	173
Évaluation diagnostique anthropo-phénoménologique.....	173
Évaluation diagnostique neuro-phénoménologique.....	174
Synthèse comparative des quatre évaluations.....	174
5. M. Wolfe.....	175
5.1. Observation.....	175
5.2. Clinique phénoménologique.....	175
5.3. Analyse existentielle.....	176

Rapport au temps.....	176
Rapport à l'espace.....	176
Rapport à autrui.....	176
Rapport aux objets.....	176
Tension structurante.....	176
Structure de vécu.....	177
Formulation existentielle.....	177
5.4. Psychopathologie psychodynamique.....	177
Angoisse centrale.....	177
Fonction des défenses.....	177
Signification des objets.....	178
Dimension dépressive.....	178
Formulation psychodynamique.....	178
5.5. Psychopathologie cognitive.....	178
Croyances liées à la perte et à l'utilité.....	178
Intolérance à la perte et à l'incertitude.....	179
Comportements de sécurité.....	179
Cercle de maintien.....	179
Retentissement fonctionnel.....	179
Formulation cognitive.....	179
5.6. Psychopathologie anthropo-phénoménologique.....	180
Des objets qui ne deviennent plus abandonnables.....	180
Une hiérarchie pratique qui ne s'établit plus.....	180
Une temporalité dominée par l'ajournement.....	181
De l'espace disponible à l'espace entièrement occupé.....	181
Formulation anthropo-phénoménologique.....	181
5.7. Psychopathologie neuro-phénoménologique.....	182
Boucle objets-anxiété-conservation.....	182
Stabilisation corporelle de la peur de perdre.....	182
Saillance attentionnelle des objets.....	182
Transformation corporelle et pratique de l'espace.....	183
Boucle de stabilisation.....	183
Formulation neuro-phénoménologique.....	183
5.8. Psychopathologie différentielle.....	183
Lecture psychodynamique.....	184
Lecture cognitive.....	184
Lecture anthropo-phénoménologique.....	184
Lecture neuro-phénoménologique.....	185
Synthèse comparative.....	185
Statut comparé des principaux phénomènes.....	185
La conservation.....	185
L'impossibilité de jeter.....	186
L'encombrement.....	186
5.9. Hypothèses diagnostiques.....	186
Évaluation psychodynamique.....	186
Évaluation cognitive et syndromique.....	187
Évaluation anthropo-phénoménologique.....	188
Évaluation neuro-phénoménologique.....	188
Synthèse comparative des quatre évaluations.....	189
6. Synthèse épistémologique et méthodologique.....	190
De la structure de vécu au problème psychopathologique.....	190
Le symptôme en contexte.....	190
Quatre niveaux de lecture.....	190
Le diagnostic comme hypothèse située.....	191
Des stratégies qui finissent par enfermer.....	191

Conclusion.....	192
7. Prolongement clinique : de l'entretien à la formulation du cas.....	193
Conduire l'entretien : explorer une expérience située.....	193
Écouter les mots du patient.....	193
Décrire des situations plutôt que des généralités.....	194
Formuler un cas : du diagnostic à la logique clinique.....	194
Formulations cliniques.....	195
Construire une formulation de cas.....	195
La demande actuelle.....	195
Les phénomènes centraux.....	195
La réponse du sujet.....	196
Le coût et les risques.....	196
Orienter les hypothèses de prise en charge.....	196
Une posture clinique.....	197
Conclusion.....	197
ANNEXES.....	198
Bibliographie.....	198
Glossaire.....	199
Psychopathologie neuro-phénoménologique et cognition incarnée...202	
1. Idée générale.....	202
2. Origines théoriques.....	202
3. La cognition est incarnée.....	202
4. Concepts fondamentaux.....	203
Le corps vécu.....	203
Hyperréflexivité.....	203
Boucles perception–affect–action.....	204
Intercorporéité.....	204
Mémoire corporelle.....	204
5. Vision psychopathologique.....	205
6. Exemples d'applications cliniques.....	205
7. La notion de boucle chez Thomas Fuchs.....	206
Contre une causalité uniquement linéaire.....	206
Boucle sensori-motrice.....	206
Boucle affectivo-corporelle.....	206
Boucle intercorporelle.....	206
8. Boucles et stabilisation du trouble.....	207
9. Différences avec d'autres modèles.....	207
Conclusion.....	207
Références principales.....	208
Table des matières.....	209

